

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 王维宁

针 灸 名 师
临 床 笔 记 丛 书

心脑血管证卷

XIN NAO BING ZHENG JUAN

汇集临床经验案
汇聚特色疗法

中国医药科技出版社

策划编辑\白极
责任编辑\白极

封面设计\山设计

针灸名师
临床笔记丛书

心脑血管证卷

XIN NAO BING ZHENG JUAN



上架建议 中医·针灸

ISBN 978-7-5067-3938-2



9 787506 739382 >

定价：35.00元

总主编 周丽莎 朱书秀
主编 朱书秀 王维宁

针灸名师
临床笔记丛书

心脑血管证卷

XIN NAO BING ZHENG JUAN

中国医药科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

针灸名师临床笔记丛书. 心脑血管证卷/朱书秀, 王维宁主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3938 - 2

I. 针... II. ①朱... ②王... III. 心脏血管疾病—针灸疗法②脑血管疾病—针灸疗法 IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143199 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62250159 发行: 010 - 62227427

网址 www.cspyp.com.cn

规格 958 × 650mm¹/₁₆

印张 19³/₄

字数 287 千字

印数 1—5000

版次 2008 年 9 月第 1 版

印次 2008 年 9 月第 1 次印刷

印刷 北京市通州皇家印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3938 - 2

定价 35.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



《心脑血管病证卷》编委会

- 主 编

朱书秀 王维宁

- 副主编

张 英 付 蔷

- 编 委 (以姓氏笔画为序)

王维宁 付 蔷 刘体军

朱书秀 张 英 杨济宁

高 晋 谢良军

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

• 总 主 编

周丽莎 朱书秀

• 副总主编 (以姓氏笔画为序)

马 骏 王维宁 孔立红 付艾妮
苏 飞 吴绪平 张 英 涂 乾
梁 忠

• 编 委 (以姓氏笔画为序)

马 利 马 骏 王小月 王 芳
王维宁 孔立红 付艾妮 付 蓓
冯美果 朱书秀 朱青艳 全国芳
苏 飞 杜艳军 吴绪平 张 英
周丽莎 孟培燕 涂 乾 望庐山
梁 忠 褚 伟

• 主 审

孙国杰

博采众长
拓業岐黃

李维衡

二〇〇七年九月

中国针灸学会会长 李维衡

荟萃數百匠家之經驗

驅除千萬患者之痼疾

石學敏

2007.9.

中國工程院院士 石學敏

孙 序

针灸是中医学中的一颗璀璨明珠，几千年来为我国人民的健康、保健做出了巨大贡献。从公元 6 世纪传到朝鲜、日本以后，又传到了东南亚、欧洲等许多国家。针灸医学已在全球范围内得到了广泛的推广和运用，为世界人民的防病治病做出了卓越贡献。

早在 20 世纪 80 年代，世界卫生组织原总干事中岛宏博士就指出：“中国传统医学能够治疗西洋医学束手无策的许多疾病”，“针灸已成为世界通行的一门新的医学科学”。针灸医学有着悠久的历史，在历史长河中形成了完整的理论体系，积累了丰富的临床经验，发明创造了多种行之有效的操作技术。我坚信它必将成为世界主流医学的一个组成部分。

针灸医学在我国的疾病预防、治疗和康复中，以简、便、验、廉和疗效显著而被广泛运用，每年发表的有关针灸基础研究和临床运用的论文有 2000 篇左右。其中临床报道占了大多数。但不少医家的学术思想、治疗方法、临床经验未能很好地得到发扬和推广。为此，周丽莎教授组织有关专家学者，查阅历代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、先进性，注重实用性的同时，将散在各医家宝贵的针灸临床经验精华，编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。丛书编写注重于临床，着重总结医家的学术思想、临床特色、治疗方法，并附典型病例加以佐证，是广大医务人员临床工作的重要的案头参考书。

《针灸名师临床笔记丛书》，经过参编专家的艰苦努力，即将付梓问世，这必将能嘉惠医林，启迪后学，造福民众。值该书出版之际，欣然作序、以表祝贺。

中国针灸学会副会长

孙国杰

2007 年 10 月 8 日

前

针灸是中医学宝库中一门独特的遗产，是中医学的重要组成部分。几千年来，针灸学经历代医家不断发展、完善，已成为一门独立的学科，获得国内外医学界的广泛重视和赞誉。近年来，随着高科技手段在针灸领域的运用，扩大了针灸治疗的范围，提高了治疗效果，使这门学科更加丰富、更臻完善。

随着健康保健知识的日益普及，人们对化学合成药品不良反应的担心日渐增加，相反，对针灸外治等自然疗法越来越愿意接受。因此，具有验、便、廉和独特效果的针灸治疗方法，在治疗各种疾病方面不断取得新的突破性发展。

近年来，大量针灸医学的书籍、期刊出版发行，对指导临床研究和推广、普及针灸医学知识起到了积极深远的影响。然而，不少医家的学术思想、新的疗法和宝贵的经验，仍然只是散见于文献刊物之中，且缺乏系统的整理与分类，使学者不易领会，研究者搜寻亦难，难以最大限度地满足广大医务工作者学习和借鉴的需要。有鉴于此，我们组织有关专家，查阅收集了近现代医籍、医学刊物和临床专著，在重视科学性、实用性的同时，将各医家散在的针灸临床治疗方法和经验编撰成《针灸名师临床笔记丛书》。

该套丛书注重于临床，在病种选录上，力求收集针灸科常见、且疗效显著的疾病种类，在内容上，突出每一种病证的独到的针

灸治疗精法验案，同时又百花齐放，竞显各家学说的光彩，并且在每一个治疗经验前，都以一句精炼的标题概括其与众不同的特点，旨在两意：一是尊重各个第一作者的学术成就；二是方便读者理解。丛书分为《妇儿病证卷》、《心脑血管证卷》、《肺系病证卷》、《筋伤病证卷》、《皮肤病证卷》、《脾胃病证卷》、《肾膀胱病证卷》、《内分泌代谢病证卷》共8个分册。可供针灸教学、临床、科研人员及在校中医专业学生参考使用。

编写该套丛书工作量繁重，由于人员分散，缺乏经验，虽做了极大努力，但限于水平，缺点和疏漏在所难免，恳请读者赐教与指正。

此书在编写过程中，承蒙中国针灸学会会长李维衡教授指点与题词，中国工程院院士石学敏教授题词并提出宝贵意见，中国针灸学会副会长、博士生导师孙国杰教授为本书写序言并赠墨宝，在此一并表示谢意。

《针灸名师临床笔记丛书》编委会

2008年1月

编写说明

本书是《针灸名师临床笔记丛书》中的一个分册。随着人们物质生活水平的不断提高，生活、工作环境的改变，工作压力的加大，心脑血管证已成为严重影响人们生活的重大疾病，也是给人们带来致命威胁的疾病。多年来，医学界对该类疾病的研究取得了重大的进展，针灸医学由于在该领域治疗效果独特、迅速、操作简便、适应症广泛、无毒性及不良反应等，受到广大患者的欢迎。有鉴于此，我们组织了有关专家学者，收集了诸多有关心脑血管病的文献资料，荟萃了各家的证治经验，在重视科学性、实用性的同时，试图从多方位、多层次来反映中医针灸在心脑血管证方面的经验精华，融古汇今，力求其系统完整，经过仔细遴选，汇编成书。

本书注重于临床，以收集针灸科常见的心脑血管病的各医家临床治验或特色治疗为原则。对中风后遗症、郁证、眩晕、胸痹、心悸、头痛、失眠、神经衰弱、三叉神经痛、偏头痛、震颤麻痹、脑瘫、面瘫、面肌痉挛、老年痴呆、高血压病、癫痫、多动症等 18 种疾病进行了分述。在每种病（证）之前均有内容提要，简要介绍该病证的病因病机、治疗原则以及各医家的诊治特点，便于读者选择应用。在每位医家的经验之中，重点介绍个人的辨治方法，经穴配方的运用与具体操作技巧，以求实用，切合临床。每种病证中收录了多种治疗方法，诸如毫针法、头针法、耳针法、梅花针法、电针法、穴位注射法、三棱针等。总之，在治疗方法上，仁者见仁，智者见智，各有千秋，别具特色。

此书虽广集历代学术理论和各名家之诊疗精华，但由于我们的经验不足，加之时间仓促，还有许多好的经验未能收入，致有遗珠之憾，同时在内容的广度和深度方面亦有未尽人意之处，热切期望广大读者批评指正。

本书在编写过程中，得到了许多著名专家教授的悉心指导帮助，在此表示衷心感谢。并向为本书编辑、出版、发行做出了辛勤劳动的人士表示谢忱。

《心脑血管证卷》编委会

2008年1月

目 录

CONTENTS

中风后遗症

1-18

- 一、头针为主 施以抽添法 / 2
- 二、风府-哑门 振奋督脉阳气 / 3
- 三、阳经经穴为主 长针透刺 / 4
- 四、随症选穴 接气通经 / 5
- 五、泻火补虚 针药并用 / 6
- 六、治分三步 综合运用 / 9
- 七、头体针并用 随症取穴 / 10
- 八、头穴为主 配以腰骶腧穴 / 11
- 九、风池为主 随症配穴 / 12
- 十、人迎为主 气至病所 / 13
- 十一、辨证选经 排列针刺 / 14
- 十二、梅花针为主 配以多针刺 / 14
- 十三、醒脑开窍 重在手法 / 15

郁 证

19-33

- 一、头穴为主 配导引吐纳 / 19
- 二、辨证分型 重用督脉经穴 / 21
- 三、证分四型 分期治疗 / 22
- 四、针药并用 疏调肝脾肾 / 23
- 五、互动式针刺 贵在调神 / 24
- 六、针刺为主 解郁调神 / 25
- 七、针刺夹脊配耳压 疏肝解郁 / 26
- 八、体耳针并用 疏肝宁心 / 27

- 九、大调神 开四关 / 28
- 十、电针智三针 配小柴胡汤 / 29
- 十一、八脉交会穴为主 调理脑神 / 30
- 十二、针刺天谷八阵 调神解郁 / 31

眩 晕

34 - 44

- 一、头穴为主 矩阵针刺 / 34
- 二、主穴二个 调督益肾 / 35
- 三、平肝潜阳 熄风开窍 / 36
- 四、调补髓海 重镇止晕 / 37
- 五、传统针刺 标本兼治 / 38
- 六、定眩舒肝 重在手法 / 39
- 七、实眩十法 虚眩五法 / 40
- 八、滋阴潜阳 化痰降冲 / 42
- 九、项丛刺配穴注 标本兼治 / 43

附：颈性眩晕

45 - 56

- 一、辨证取穴 疏通经络 / 45
- 二、温针颈夹脊 温阳补气 / 47
- 三、针刺配刺络拔罐 行气活血 / 47
- 四、针推并用 宣通气血 / 48
- 五、小醒脑针法 祛痛止晕 / 49
- 六、傍刺天柱 疏调营卫气血 / 50
- 七、经络辨证 局部取穴 / 51
- 八、独取大椎 重在手法 / 52
- 九、针刺配穴注 随证施治 / 52
- 十、综合治疗 功效卓著 / 53
- 十一、独取大杼 温针灸 / 55

胸 痹

57 - 65

- 一、证分三型 辨证取穴 / 57
- 二、辨证分型 据证选穴 / 58
- 三、艾灸膻中 择时施治 / 59
- 四、针灸并用 立时见效 / 60
- 五、针内关膻中 加然谷放血 / 61
- 六、穴位旋转走罐 通经活络 / 62
- 七、补泻兼施 标本兼治 / 62
- 八、丘墟为主 辨证配穴 / 63
- 九、益心气 通心阳 / 64

心 悸

66 - 72

- 一、穴取心包经 气至病所 / 66
- 二、三阴交 - 内关 先后针刺 / 67
- 三、缓慢进针 控制针感 / 68
- 四、经验选穴 眼针心区 / 69
- 五、独取内关 调整心率 / 70
- 六、安神镇惊 养血宁心 / 71
- 七、辨证施治 标本兼顾 / 71

头 痛

73 - 96

- 一、大椎为主 刺血拔罐 / 74
- 二、刺血为主 辨证施治 / 75
- 三、辨证合辨病 针刺加埋针 / 77
- 四、四关为主 辨证配穴 / 78
- 五、远近配穴 重针刺方向 / 78
- 六、风池百会 通络止痛 / 79
- 七、辨经与辨证并重 随证取穴 / 81
- 八、梅花针叩刺 痛减症除 / 82

- 九、育俞-合谷-风池 顺序进针 / 84
- 十、风池-太冲 随因配穴 / 85
- 十一、辨证分型 循经刺血 / 86
- 十二、哑门深刺为主 随症加减 / 87
- 十三、针刺四关 配通天刺 / 88
- 十四、针药并用 通络止痛 / 89
- 十五、辨证分型 锋勾针施治 / 90
- 十六、头皮针为主 配导引吐纳 / 91
- 十七、温针穴注 疏通经络 / 93
- 十八、辨证取穴 针灸并用 / 94

失 眠

—97-112

- 一、背俞穴为主 重手法 / 97
- 二、针药并用 平调阴阳 / 98
- 三、艾灸涌泉 取效迅速 / 99
- 四、艾灸配捏脊 协调阴阳 / 99
- 五、主穴两个 大陵-失眠 / 100
- 六、辨证分型 巧用对穴 / 101
- 七、耳穴贴压 镇静安神 / 102
- 八、六交会穴为主 辨证加减 / 104
- 九、芒针透刺 交通阴阳 / 104
- 十、皮内针埋针 调整脏腑 / 105
- 十一、温针灸 调阴阳 / 106
- 十二、补阴抑阳 平衡跷脉 / 107
- 十三、治疗失眠 重在调治内脏 / 108
- 十四、头五针为主 辨证取穴 / 108
- 十五、证分五型 取穴各异 / 109
- 十六、穴注与艾灸 两法合用 / 111

- 一、矩阵针刺 镇静安神 / 113
- 二、少阳经枢转 揉抹点穴为主 / 114
- 三、头部分区 循经取穴 / 116
- 四、养心健脑 随症取穴 / 117
- 五、治神十法 因症而施 / 117
- 六、体耳针并用 安心神 / 119
- 七、补心宁神 平衡阴阳 / 120
- 八、四神聪为主 针刺配心理治疗 / 121
- 九、取穴头腹足 辨证加减 / 122
- 十、体穴百会风池 耳穴随症加减 / 123
- 十一、梅花针浅刺 辅以心理开导 / 125
- 十二、内关-三阴交 随症配穴 / 126
- 十三、随证取穴 中药穴敷 / 127

三叉神经痛

- 一、叉三针为主 随症加减 / 129
- 二、按部取穴 通络止痛 / 130
- 三、病位取穴 龙虎交战 / 131
- 四、透针法 强刺激重手法 / 132
- 五、独取阳明 通经络 / 133
- 六、辨证取穴 虚补实泻 / 134
- 七、下关-合谷 随症配穴 / 135
- 八、深刺强刺激 配穴注 / 136
- 九、深刺太阳 随症配穴 / 138
- 十、针药并用 辨证施治 / 139
- 十一、独取颞髂 针灸并用 / 140
- 十二、特定穴 清热降火 / 141
- 十三、针刺透穴 导气直达病所 / 141
- 十四、针刺配中药 通络止痛 / 142

- 十五、透刺强针感 配耳压 / 143
- 十六、针刺为主 配刺络拔罐 / 144
- 十七、耳体穴并用 强刺激 / 145

偏头痛

147 - 163

- 一、率谷为主 三针齐刺 / 147
- 二、深刺风池 立竿见影 / 148
- 三、针刺耳压 平肝泻胆 / 149
- 四、颈夹脊为主 随症配穴 / 150
- 五、曹氏额区调控点 沿皮针刺 / 151
- 六、针刺为主 辅以推拿 / 152
- 七、独取太冲 重刺激 / 153
- 八、疏风平肝 通络止痛 / 153
- 九、按部取穴 顺序针刺 / 154
- 十、审因辨证 随证取穴 / 155
- 十一、远近配穴 呼吸补泻 / 156
- 十二、单针浅刺 配合叩打 / 157
- 十三、华佗夹脊 补泻并用 / 158
- 十四、刺血为主 辅以针刺 / 159
- 十五、穴位注射 重在疏通 / 159
- 十六、头穴为主 辨证加减 / 160
- 十七、风池为主 气至病所 / 161
- 十八、太阳 - 率谷为主 长针透刺 / 162

震颤麻痹

164 - 176

- 一、以补为主 益精养血 / 165
- 二、辨证施治 针灸并用 / 166
- 三、合穴为主 头针腕踝针并用 / 167
- 四、综合治疗 息风镇颤 / 168
- 五、行气开郁为主 平肝风滋肝阴 / 169

- 六、肢体躯干肌群 梅花针轻叩 / 170
- 七、补益肝肾 健脑安神 / 171
- 八、滋肾益肝 养血祛风 / 173
- 九、督脉为主 豁痰息风 / 173
- 十、头针合四关 息风通络 / 174
- 十一、头体针并用 息风解痉 / 175

脑 瘫

177 - 193

- 一、阳经为主 合靳氏理筋术 / 177
- 二、头体针并用 配运动疗法 / 179
- 三、针药并用 辨证施治 / 180
- 四、风府-哑门 随症加减 / 182
- 五、舌针为主 配头体针 / 183
- 六、三穴为主 随症加减埋线 / 186
- 七、头针滞针 醒脑开窍 / 186
- 八、针推穴注 综合治疗 / 188
- 九、风府哑门为主 针刺配刮痧 / 190
- 十、针刺夹脊 解痉挛 / 191
- 十一、夹脊穴为主 随症加减 / 191

面 瘫

194 - 212

- 一、分期治疗 方法各异 / 194
- 二、梅花针叩刺 辅以隔姜灸 / 195
- 三、水沟承浆 平衡阴阳 / 196
- 四、穴注为主 配合体针 / 198
- 五、远近结合 深透刺 / 198
- 六、针刺合谷 气至病所 / 200
- 七、顽固难症 独用灸法 / 201
- 八、左右交替针刺 通调气血 / 201
- 九、半刺法 调整阳经气血 / 203

- 十、面瘫三针方 顿退六部法 / 203
- 十一、针刺效点 补虚泻实 / 204
- 十二、三步疗法 分期施治 / 205
- 十三、从经筋论治 标本兼顾 / 207
- 十四、分期辨证 加减配穴 / 207
- 十五、辨证治面瘫 以补为主 / 209
- 十六、腹针为主 通调气血 / 210

面肌痉挛

213 - 231

- 一、主穴三个 吊针配刺络拔罐 / 213
- 二、依经筋论治 多针浅刺 / 215
- 三、挂针为主 配辨证取穴 / 216
- 四、齐刺 - 浮刺 - 直刺 三法结合 / 217
- 五、辨证取穴 头体针并用 / 218
- 六、辨证取穴 补益气血 / 219
- 七、针刺配穴注 辨证施治 / 219
- 八、四关为主 辨证分型取穴 / 221
- 九、透刺为主 一针两穴 / 222
- 十、循经远取 长留针 / 223
- 十一、取阳明为主 浅刺久留针 / 224
- 十二、耳穴治疗 调十二经经气 / 226
- 十三、健脾疏肝 标本兼顾 / 226
- 十四、病分四型 辨证取穴 / 227
- 十五、四关血海 辨证施治 / 229

痴 呆

232 - 250

- 一、醒脑通络针法 健脑养神 / 232
- 二、穴位注射 调补先后天 / 233
- 三、头部围刺 直指病灶 / 234
- 四、药氧针刺 通补兼施 / 235

- 五、原络配穴 辨证施治 / 235
- 六、综合治疗 阴阳平衡 / 236
- 七、头部电针为主 辅以体针 / 237
- 八、针药合用 醒脑益智 / 238
- 九、智三针 - 四神聪 电针治疗 / 239
- 十、益元聪神 祛风火痰瘀 / 240
- 十一、从虚瘀论治 辨证取穴 / 241
- 十二、调神益智针法 化痰祛湿 / 242
- 十三、益肾醒脑针法 益肾填髓 / 243
- 十四、头三神为主 辨证加减 / 244
- 十五、补下清上 调神益智 / 245
- 十六、补肾为主 配以对症治疗 / 245
- 十七、醒神开窍 补肾填精 / 246
- 十八、十二井 大接经 / 247
- 十九、电针调髓海 穴取头部为主 / 248

高血压病

251 - 263

- 一、百会 - 神阙 - 涌泉 上中下相配 / 252
- 二、清上补下 辨证取穴 / 252
- 三、耳尖放血 取效迅速 / 253
- 四、独取足三里 温针降血压 / 253
- 五、四穴相配 平肝潜阳 / 254
- 六、体针配耳压 整体调治 / 255
- 七、辨证分型 耳穴贴压 / 256
- 八、针刺扶突 调阳明气血 / 257
- 九、泻阳亢为主 阴阳虚实兼顾 / 257
- 十、针药并用 控制血压 / 258
- 十一、辨病辨证相合 平衡阴阳 / 259
- 十二、针药并用 调补阴阳 / 259
- 十三、刺方氏头穴 灵活加减 / 260
- 十四、穴位按摩 调和阴阳 / 261

癲 病

264 - 277

- 一、药线埋植 辨证取穴 / 265
- 二、皮内针埋植 配以耳穴 / 266
- 三、三棱针刺长强 通调阳气 / 266
- 四、头皮针平刺 益肾健脑 / 267
- 五、发作与间歇 刺络以放血 / 268
- 六、小针刀配拔罐 辅以埋线 / 269
- 七、穴位埋线 息风涤痰 / 270
- 八、针刺华佗夹脊 重调脏腑气机 / 271
- 九、针刺为主 配神阙敷贴 / 272
- 十、通督开窍 醒脑安神 / 272
- 十一、辨证分型 从阳引阴 / 273
- 十二、副哑门-腰奇 毫针深刺 / 274
- 十三、独取督脉 穴分四组 / 275

多动症

278 - 287

- 一、针罐并用 收神制动 / 278
- 二、耳穴治疗 整体调节 / 279
- 三、耳针加体针 平肝熄风镇静 / 280
- 四、推拿及耳穴贴敷 调阴阳 / 281
- 五、针刺加耳穴 辨证施治 / 281
- 六、头针配中药 取效明显 / 283
- 七、针刺加中药 宁心安神 / 283
- 八、头穴为主 随症加减 / 284
- 九、针药结合 补益后天 / 285
- 十、综合治疗 标本兼顾 / 286

【中风后遗症】

中风是以突然昏倒、不省人事，伴口角喎斜、语言不利、半身不遂，或不经昏仆仅以口歪、半身不遂为临床主症的疾病。因发病急骤，病情变化迅速，与风之善行数变特点相似，故名“中风”、“卒中”。相当于西医学的急性脑血管病，如脑梗死、脑栓塞、脑出血、蛛网膜下腔出血等，总体上可分为缺血性和出血性两类。

中风的发生是多种因素所导致的复杂的病理过程，风、火、痰、瘀是其主要病因。有的因肝肾阴虚，水不涵木，肝风妄动；有的因五志过极，肝阳上亢，引动心火，风火相煽，气血上冲；有的因饮食不节，恣食厚味，痰浊风生；有的因气机失调，气滞而血运不畅，或气虚推动无力，日久血瘀；风、火、痰浊、瘀血等病邪上扰清窍，导致“窍闭神匿，神不导气”时，则发生中风。

对本病的治疗，有的以梅花针为主；有的采用头针快速捻转；有的采用毫针配合穴位注射；有的采用针药并用等。从取穴来看，大多以阳明经和头穴为主。对本病治疗内容丰富，方法繁多，各有特色。

一、头针为主 施以抽添法

王桂荣以头针施用抽添法治疗中风半身不遂，疗效满意。

取穴：取患肢对侧头部运动区，肢体酸痛麻木者加感觉区，失语或舌謇语涩者加语言区。配穴：在第二疗程开始，配取患侧手足阳明经穴及手足少阳经穴，如肩髃、曲池、外关、髀关、伏兔、足三里、阳陵泉、解溪。

操作：选30号1.5寸毫针，从头顶向颞部快速进针，沿头皮平行刺入1寸深，施以抽添法，即先用捻转法促使得气后，再向周围做多向提插，行针过程中嘱患者运动患侧肢体。不能做自立运动者，可嘱患者意识运动，结合术者帮助的被动运动。配以体针者，针刺得气后，接电针，采用疏密波及断续波各15min。每日1次，10次为1个疗程。每个疗程间隔3~5天。

王桂荣认为：以头针施用抽添法治疗中风后遗症具有良好的疗效，其作用机制是：通过针刺头部的特定部位，施用特定手法，可以达到疏通经络、调节气血、平衡阴阳的作用，从而改善临床症状，促进瘫痪肢体的功能恢复。《金针赋》曰：“抽添之诀，瘫痪疮癰，取其要穴。使九阳得气，提按搜寻。大要运气周遍，扶针直插，复向下纳，回阳倒阴”。故用头针加抽添法，则效得益彰。

王某，男，64岁，干部，于1992年11月17日初诊。1个月前突发右侧肢体瘫痪，曾在外院内科诊断为脑梗死，西医治疗1个月，肢体瘫痪症状未见减轻，故来我科就诊。查体：右侧半身不遂，肢体麻木，上下肢肌力Ⅱ级，舌质淡，苔白腻，脉沉无力。诊断：中风（中经络），遂采用上述方法治疗。第一疗程，选取头部运动区、感觉区，用抽添法操作5~10min，留针8~12h，每日1次；第二疗程，头部与第一疗程相同，配体针。取穴：肩髃、曲池、外关、髀关、伏兔、足三里、解溪等，针刺得气后，分别在肩髃、曲池、髀关、足三里等4个穴位上加电针，运用疏密波，断续波各15min，第三疗程与第二疗程相同。该患者经过以上3个疗程治疗痊愈出院，半年后随访无复发。

二、风府 - 哑门 振奋督脉阳气

李秀华采用针刺风府、哑门为主治疗中风后遗症，收到较理想疗效。

取穴：风府、哑门。意识障碍者加百会、人中；闭证配井穴放血；脱证配灸足三里、百会；高血压配曲池、大冲；失语配金津、玉液；大小便障碍加阴陵泉；四肢瘫加曲池、内关、极泉；下肢瘫加环跳、阳陵泉、委中。

操作：风府、哑门两穴交替使用。严格消毒后，选用1.5寸毫针，直刺或向喉结方向针刺，进针深度可按山西中医学院李定明教授风府哑门穴进针深度，以得气为准，不提插、不捻转、不留针。其他穴位常规针刺，每日1次，10次为1个疗程。

风府、哑门穴均系奇经八脉里督脉穴位。督脉总一身之阳气，其循行背部正中，上至头面。诸阳经均来交会，故有“阳脉之海”之称，具有调全身诸阳经经气作用。《针灸甲乙经》上记载风府主治“头痛项急，不得倾倒，目眩，鼻不得喘息，舌急难言”。《备急千金要方》风府主治“舌缓，不能言”。《类经图翼》哑门主治“中风尸厥，暴死不省人事”。中风病，中医认为是本虚标实之证。本虚为肝肾亏虚，标实为风、火、痰、瘀。脑脉瘀阻，气滞血瘀是主要病因。针刺风府哑门穴可以振奋督脉阳气，使经脉气血疏通，因而具有改善脑部供血，促进堵塞的脑血管再通的作用。

李某，女，51岁，1997年9月5日早晨起床后，突感右侧肢体麻木，手足失灵，言语不清，口角流涎，即刻诊治，诊为脑血栓形成，CT片示：左侧基底节脑梗死。体检：昏睡状态，肌力0级，布氏征（+），舌体向右侧偏斜，右口角流涎，鼻唇沟变浅。治疗：先经神经内科常规治疗，液体滴毕，即刻采用针刺风府、哑门穴方法，配合针刺人中、百会，严格消毒后风府穴缓慢进针得气后，不提插，不捻转，不留针，患者针后神志清醒，5min后活动下肢，即刻能抬高30°，肌力达三级以上，以后每天风府哑门二穴交替针刺，上肢配曲池、内关、极泉；下肢配环跳、委中、阳陵泉，1周后患者即可右侧搀扶行20m，3周后可独立行走，开始缓缓而行，举步艰难，以后

行走力量渐增且灵活，如是治疗1个月，基本痊愈出院。

三、阳经经穴为主 长针透刺

手指拘挛性瘫痪是中风所致半身不遂后遗症中的常见症状之一，其主要表现为上肢肌张力增强，上肢屈曲难伸，手指掌屈、挛急不开。张艳在临床上采用长针透穴治疗该病。

取穴：主穴：合谷、鱼际，每次每穴必用。配穴：曲池和手三里、二间和三间、八邪和精灵、威灵，均交替使用。

操作：针刺部位常规消毒之后，选用3寸长针，合谷穴直刺深透直达后溪穴；鱼际向拇指末端沿皮透刺，直达少商穴；曲池穴直刺深透直达少海穴；手三里直刺深透直达对侧皮下；二间或三间向食指末端沿皮透刺，直达商阳穴；八邪向腕关节透刺；精灵、威灵则行对刺法。在施行二间或三间透刺商阳、鱼际透刺少商的过程中，应提捏针刺所过部位的皮肤和表浅肌肉组织，使透针顺利并减轻疼痛。留针30min，隔日1次，10次为1个疗程。

手指拘挛性瘫痪依据经络学说的理论属“阳缓而阴急”之因所致，取穴重点应放在阳经经穴上，以振奋阳经经脉的牵拉作用，纠正局部肌肉、肌腱和有关韧带的拮抗失衡状态，恢复经脉的相对平衡。故经穴选用手阳明之合谷、曲池、手三里、二间、三间及手太阴之鱼际，经外奇穴则选用位于阳面的八邪和精灵、威灵，用长针透刺可以扩大刺激面积，增加针刺强度或使针感易于扩散传导，即“经脉所过，主治所及”，以达到缓阴经之急，使经络功能趋于阴平阳秘之功效。

患者，男，65岁，教师。2001年3月12日初诊。左侧肢体活动不利4月余。查左侧肢体肌张力增高，左肘关节屈曲难伸，手指严重掌屈，拘挛不开，尤以拇、食两指为甚，左上、下肢均能抬离床面。患者于2000年10月下旬因脑出血致左侧肢体瘫痪，经某院西医治疗病情好转，但肢体功能活动恢复欠佳，遂转为针灸治疗。经用上述治疗10次后，拘挛、掌屈症状明显缓解，上肢肌张力基本恢复正常，肘关节伸屈自如，五指可全部伸张开来。经针刺20次后，原来僵直的拇食二指可以屈伸活动，并有一定的握力，临床治愈。嘱患者进一步加强左侧手指功能锻炼，以巩固疗效。

四、随症选穴 接气通经

郑魁山认为中风急性期，取十二井点刺放血，丰隆、三阴交用泻法，留针 30min。以平肝泻热，祛痰降逆。当急性期已过，血压渐趋稳定，遗留头痛、肢体瘫痪、语言失灵等症者，应及时治疗。

肢体瘫痪，用“接气通经法”，从上向下按顺序取穴，使针感传到手足末端。针上肢先取大椎、大杼、风门，用热补法，不留针，以振奋阳气。再用同样手法针患侧肩髃、曲池、中渚、外关、合谷。下肢先取肾俞、关元俞、秩边，用热补法，不留针，以补肾培元。再用同样手法针环跳、风市、阳陵泉、足三里、绝骨、三阴交，留针 10min，或做穴位埋线，以益肾健脾，活血通络。肘关节拘急配天井、肘髎，手指拘急配三间，膝关节拘急配（膝）阳关、曲泉，用平补平泻法，留针 20~30min，以疏筋利节。肌肉和关节痛，配痛处附近穴位，留针或加灸 10~15min，以温通经络。足内翻配申脉，足外翻配照海，用补法，以扶正补虚。口喎，配风池、颊车透地仓，用平补平泻法，留针 10~20min，以散风活络。大便秘结，配天枢、丰隆，用凉泻法，留针 10~20min，以祛痰通便。舌强不语，配风府、上廉泉，用泻法，不留针，金津、玉液，用速刺法出血，以散血凉血，清热开窍。口角流涎，配翳风、列缺、照海，用平补平泻法，以行气利湿。吞咽困难，配风府、风池，不留针。廉泉、天突、阳溪，用平补平泻法，留针 10min，以祛风开窍。目闭鼻塞，配上迎香，用速刺法，以取嚏开窍。脉弦舌赤，配内关、足三里，用泻法，以开胸降逆，平肝泻火。肩关节下垂，配天宗、肩髃、肩髃、臑会、臂臑，用补法，以升举阳气。手足麻木，配中脘、气海、后溪、申脉，针后加灸 10~20min，以培本振阳。肌肉萎缩，在萎缩部位施灸 10min，以温经活络。二便失禁，配气海、关元、腰俞、会阳，针后加灸 10~20min，以温固下元。心悸气短，配巨阙、内关，用补法，留针 5~10min，以养心安神。

莫某，女，61岁，农民。因左半身不遂，失语8天，在医疗站治疗无效而来住院。检查：嗜睡，神志恍惚，语言不清，面红，瞳孔左略大于右，左侧上下肢不能活动，膝反射减弱，血压 210/116mmHg，脑脊液呈血性。因患者口张不大，未看舌苔，脉弦

有力。西医诊为高血压、脑溢血。针十二井放血，太冲、三阴交、丰隆，用泻法，留针20min。以吸氧辅助。次日二诊，神志清楚，反应迟钝，声音低微，能进少量饮食，头痛，左侧上下肢不能活动，血压190/70mmHg，苔黄腻，舌质淡红，脉弦数，针刺取穴手法同前，加双风池、百会、上廉泉、左曲池、合谷、环跳。治疗5次时，头痛大减，言语清楚，伸舌仍偏向左，左鼻唇沟仍浅，左侧上肢和下肢能抬起，左手握力仍差，血压150/60mmHg，苔脉同前。停止吸氧。针左肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、风市、阳陵泉、足三里、悬钟，用平补平泻法，留针20min。又针12次，头已不痛，精神好，饮食增加，两侧鼻唇沟无明显差异。左手握力增加，能握住别人三指，左手能抬高至头，能步行，但左腿力量较差，迈步时抬不高。血压160/80mmHg。出院后到门诊针治15次，左手能抬高过头，腿力好，步行端正，能承担家务劳动。

五、泻火补虚 针药并用

于书庄认为诱发中风之因有二：一为火，火盛则伤阴（津液），阴伤则血液黏稠度增加，血流郁滞，故而形成血栓。火盛则迫血妄行，故而出血；二为虚，虚指气虚，气虚则推动血液运行之力不足，血流缓慢，故而多在休息（睡眠）时形成血栓。气虚则摄血无权，故而引起出血。但无论出血性中风或缺血性中风，发病后皆形成瘀血，以及瘀血痹阻不同经脉，而出现肢体运动、感觉、语言障碍等不同症状。

风、痰不是直接诱发本病的原因，因火盛则生风，风是火衍生的。痰之生成，一因五志化火，水谷精微为火煎灼，炼灼成痰；二因脾失健运，瘀而成痰，故有“治痰不理脾胃，非其治也”的论断。

急性期，应从发病至病情稳定为限，而不应以日期为限。此期是治疗本病的关键，如治疗得当，此期可以缩短，此期愈短病情愈轻，故而预后愈良。反之，如治疗不当，则急性期可以延长，病情愈重，故预后愈差。因此，医者必须本“急则治标”的原则，辨证求因，集中力量清除其发病诱因，控制其发展，则是当务之急。

（1）实火证 火为阳邪，具有其性上炎，耗伤阴津，火盛生风，火扰神明等特性，故除见不同程度半身不遂、口眼喎斜、语言不利

外，必见面色潮红，目赤，唇红而干，躁动不安，头痛眩晕，恶心呕吐，大便干，口臭或口苦，口噤，舌强，舌质红绛，苔黄腻或黄干，脉弦数或弦滑有力。

大便干、口臭、苔黄干者为胃火；头痛眩晕、目赤、口苦，切其耳门、颌厌脉盛者为肝胆火旺；口噤、项强、头痛眩晕者为肝阳化风；舌强语謇、舌下静脉充盈者为心火盛。若见神昏，则为闭证。

治法：潜阳降火，养阴顺气。缺血性者加以活血化瘀；出血性者加以凉血止血。若喉中痰鸣佐以清热化痰；若见风证，则佐以熄风。

针刺放血：①手十井（少商、商阳、中冲、关冲、少泽）；②手十宣。均采用三棱针点刺出血，每日1次，两组穴交替取用。

头痛眩晕明显者，加刺太阳、百会放血。舌强、呕吐者加刺金津、玉液出血。

取穴：手与足十二针（内关、三阴交，取柔和酸胀针感。曲池、合谷、足三里、阳陵泉取较强酸胀针感）。口噤取颊车；饮水作呛取翳风、完骨、风池，均双侧，针尖刺向结喉1.5~2.0寸，每穴捻针1~2min。

放血法不仅用于治疗中脏腑的闭证，而且对于中经络的实证也有卓效。急性期一日针刺2次（一次放血，一次针刺），一般放血2次；火热渐熄，病情稳定，即可停止放血，改为一日针刺2次。

中药用潜阳药：生石决、生龙牡、珍珠母、紫贝齿、生赭石等，用量宜重，每味不少于30g。降火药，胃火者用大黄面、元明粉、甘草面各10g，分两次冲服，服后腑气已通，即可停服；肝胆火旺者，用龙胆泻肝丸12g包煎；心火盛者，用大黄、黄连；育阴用生地、元参、麦冬、白芍之类；熄风用天麻、菊花、夏枯草、僵蚕、全蝎、羚羊角等；顺气用枳壳，化痰用天竺黄、胆星、条芩、竹沥水之类。缺血性中风加桃仁、红花、益母草。出血性中风加三七、大小蓟、白茅根、侧柏炭之类。在缺血、出血不明时，则活血及止血药不用，称为中性治疗。神昏加安宫牛黄丸或局方至宝丹，每服1丸，日2服。上述诸药，应结合具体病情选择使用。

患者刘某，男，57岁，脑出血（右大脑半球）。5天前晨起大便后，突然左半身无力摔倒，即刻不头痛，不吐，自行爬起，步行不

远，复坐在地，随即神志不清。送某院急诊，查：血性脑脊液，压力130mmHg。患者精神呆滞，目不欲睁，左侧偏瘫，时两颞疼痛，头晕耳鸣，纳呆，进食呛咳，口干，烦躁，夜寐不安，语言不清。高血压病史十余年。检查：体壮、面赤、口臭，舌左偏，伸舌不灵，苔黄厚腻，脉弦滑。血压190/110mmHg，左上肢肌力0级，巴氏征(+)，颈抵抗(+)，额胸距四横指，克氏征(+)。辨证：五志化火，火盛生风，风火相煽，迫血妄行。治以潜阳降火，止血育阴。刺十宣放血，下午针合谷、太冲、涌泉。次日上午刺手十二井放血，下午针穴同前。配服汤药：生石决明、生龙牡各30g（先煎），大黄10g（后下），元明粉10g（分冲），甘草6g，大蓟、小蓟各30g，侧柏炭10g，桔梗10g，枳壳10g，生地30g，元参15g，麦冬10g。水煎分2次服，日1剂，大便通后减元明粉，停大黄后下。输液加入止血敏500mg、安络血10mg，口服复降片1片，芦丁20mg，维生素C0.2mg。日3服。经针刺，放血2次，服中药4剂，患者神清语言清楚，烦躁不安消失，上肢肌力1级，下肢2级，颈强，胸额距三横指，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。证系风火渐熄，病情得到控制。

(2) 气虚证 除见半身不遂，口眼喎斜，语言謇涩外，必见神疲懒言，气短乏力，语声低怯，或自汗，或四肢欠温，或纳呆，或尿频，或大便无力，或大便溏，或心悸失眠，面黄或苍白，舌体胖边见齿痕，舌质淡、苔薄白，脉细弱或结代，若见神昏，多为脱证。

治法：补益正气。若属血栓者，加以活血化瘀；若属出血者，加以止血。

①针灸中脘、气海、足三里、内关、三阴交、百会、人中，施徐疾补泻之补法，气海加灸。喉痹取穴同实火证。急性期一日针灸2次。

②中药治疗血栓，当益气活血，方用补阳还五汤，气虚甚者加人参。治疗出血，当益气止血，方用人参归脾汤加三七。

(3) 虚火证 除见半身不遂、口眼喎斜、语言不利外，伴有面黄或萎黄，或淡红，语声低微，神疲嗜睡，头痛头晕，小便频或失禁，大便干或大便无力，烦躁易怒，失眠多梦，心悸，肢麻，流涎，舌质红绛或暗红，或嫩红，舌中裂，少苔或薄黄、黄厚，脉弦滑或弦细数。若见神昏，多为闭脱并见证。平素常有头晕头痛，耳鸣目

糊，腰酸腿软，失眠多梦等症状。

治法：益气清火，临症时要辨清孰轻孰重，以权衡补泻之宜。治疗血栓加活血化瘀。治疗出血加以止血。

①针刺：曲池、阳陵泉（双侧）、内关、合谷、足三里、三阴交（病侧）。气虚、气阴两虚加中脘、气海。肾气虚、肝肾阴虚加关元。取柔和酸胀针感，气海及关元施徐疾补泻之补法。头痛头晕明显者加百会、风池。

②中药：治疗血栓，用补阳还五汤加生地、丹皮、白芍、元参之类。治疗出血，以归脾汤加三七、生地、丹皮、白芍、阿胶之类。

张某，男，67岁。有高血压病史多年。1980年病中风，出现右半身不遂，即去某院诊治，给予静点及服药（药物不详），病情逐渐加重，现右半身不遂两周，语言不利，饮水呛，不自主哭笑。查：精神不振，面黄，舌质淡、苔白，脉沉细数，气海压痛（++），血压130/80mmHg，右上下肢肌力3级，腱反射亢进，左掌颌反射（+），双巴氏征（+）。辨证：气虚络阻，髓海失养。治以益气补髓。针百会、风府、人中、内关、中脘、气海、足三里，施补法。予补阳还五汤三剂，两日服完。第三日复诊，患者精神好转，饮水呛减轻，不自主哭笑亦好转，右半身较前有力，病情得到控制。

六、治分三步 综合运用

中风是一种发病率高、病死率高、致残率高的严重疾病，绝大多数患者都不同程度地丧失了生活自理能力或劳动能力，生活质量普遍低下，给病人及家属带来了极大的精神痛苦和经济负担。于晓刚在临床工作中发现运用头穴、体穴与功能训练相结合，将针刺的过程分三步进行，能明显提高病人的康复速度和水平。

取穴：主穴为百会、曲差、神庭，上肢取肩髃、肩髃、曲池、外关、合谷、中渚；下肢取环跳、足三里、阳陵泉、悬钟、丘墟、解溪、侠溪、太冲；语言不利配风池、风府透哑门、廉泉；手不能握配八邪；足内翻配照海、昆仑；足外翻配申脉、太溪。

操作：

（1）头针选用1.5寸毫针，自百会向双侧太阳透刺，曲差、神庭前后平刺，得气后行快速小幅度提插捻转（200转/min），捻转

3~5min,病人行自主功能锻炼 10min,再行捻转 3~5min,病人再行功能锻炼活动 10min,留针 10min。

(2) 病人侧卧位行体针,选用 1.5~3.0 寸毫针,行提插与捻转手法。

(3) 行针期间,肩髃、曲池、足三里、解溪接 G6805 脉冲治疗仪,强度 1~2V、频率 2~3Hz,留针 20~30min。每日 1 次,以 10 天为 1 个疗程,每个疗程之间休息 2 天。

三步针法是在总结前人运用针刺治疗中风病的经验基础上产生的,以取头穴为主,将头穴针刺的即刻效应与机体的功能训练相结合,将头针、体针、脉冲治疗分三步进行,此方法的目的在于使针刺的效应产生叠加,在病人的机体中产生最大的作用效果,即达到激发脑神经细胞完成其重组和再塑的功能,从而使患者的脑神经功能得到最大程度的恢复。

针刺的作用在于调整气血阴阳,阴平阳秘,精神乃治。气血通畅,邪去正安,经筋的功能才得以恢复正常。督脉为阳脉之海,统领一身之阳气,头为诸阳之会,百会又为督脉与足太阳经的交会穴,因此三步针法以百会穴为主穴。在运用头穴针刺达到最佳效果的基础上,再予以体穴针刺,并将康复锻炼融入其中,使针刺真正发挥其起效快的优势,并在中风病的治疗过程中得到有机的组合。

七、头体针并用 随症取穴

中风是临床常见病,多发病。中风经过救治,神智清醒后,多留有后遗症,如半身不遂,言语不利,口眼喎斜等。方立新用头体针结合治疗中风后遗症,疗效较佳。

取穴:头针:以患肢对侧运动区、足运感区为主,命名性失语加言语二区,感觉性失语加言语三区(运动性失语已在言语一区——即运动区下 2/5 处治之)。体针:以患者手足阳明经经穴为主,上肢瘫痪取肩髃、曲池、手三里、外关、合谷;下肢瘫痪取环跳、阳陵泉、足三里、三阴交、解溪;口眼喎斜取迎香、颊车、地仓;言语不利取廉泉、哑门、通里。

操作:头针:用 30 号 1.5 寸毫针刺入刺激区 0.5~1.5 寸,然后留针 40min。体针:以上穴位每次选用上下肢各 3 个穴,头面部 2

个。用30号1.5寸毫针刺入0.5~1.5寸，均匀地提插、捻转，得气后留针20min。留针期间行针3次。

头针留针时间宜长，且不用其他手法，因为头皮肌层薄，用提插捻转等强刺激手法容易产生恶性刺激，而留针则是良性刺激，适当的留针，病人仅有胀、沉的感觉，消除了患者对刺痛所产生的恐惧心理，使针感较长时间地、不断地传入大脑皮层，有利于神经功能不断恢复和巩固。

根据“治痿独取阳明”、“阳主动”的原则，体针取穴常以阳明经穴为主，辅以太阳、少阳经穴，因为阳明为多气多血之经，阳明经气通畅，正气扶助，使肢体功能逐渐恢复。

黄某，男，61岁。患者于1994年9月10日因右侧肢体乏力，言语不利到本院急诊室留观，后收入神经内科治疗。发病时血压210/135mmHg，经CT确诊为左基底节区脑梗死。经神经内科治疗病情稳定后于1994年9月19日开始针刺治疗。当时患者右上肢肌力0级，右下肢肌力Ⅰ级，采用头体针结合按前述的方法予以治疗，每天针刺1次，两周后瘫痪体征基本消失，说话吐字渐清。一个多月后右上肢肌力恢复至Ⅳ级，右下肢肌力恢复到Ⅴ级，言语恢复正常，生活基本能自理。

八、头穴为主 配以腰骶腧穴

郑宗昌运用头穴配腰骶部腧穴为主治疗中风后遗症，取得较好的效果。

取穴：头穴：运动区上1/5（双），血管舒缩区上1/5（双）。体穴：主穴：肾俞（双）、关元俞（双）；配穴：手三里、足三里、髀关，均取患肢。精神障碍者加风池（双）、内关（双）、神门（双）、风府。大小便失禁者加次髎（双）、白环俞（双）、三阴交（双）。语言不利加外金津、外玉液、上廉泉上1寸、风池（双）、内关（双）。髋关节松弛加白环俞（双）、秩边、环跳、居髎、髀关均取患侧。患肢痉挛性瘫加髃俞、少海下1寸，箕门、血海、阴陵泉均取患侧。

操作：头针：用2寸毫针，在选定的刺激区上经消毒后于该区上1/5处向双侧各进针1支，沿皮刺入1~1.5寸，然后将针接上电

针治疗仪，选用可调波，频率为每分钟240~360次，电流强度以患者能耐受为限，每次时间为15~20min，15次为1个疗程。两区交替使用。体针常规针刺，每天针1次，每次取2~3穴，留针15~20min，得气以酸、胀、麻为佳，针感应向患肢远端传，除痉挛性瘫用泻法外，其他各型均用平补平泻手法。

头穴位于头顶，头为诸阳之会，针刺该区有行气活血，疏通经络气血，醒脑之功；从现代医学角度看，头穴接近于病灶，针刺该区能反射性增加脑的血流量，利于侧支循环的建立，促进病灶的修复和周围区域脑细胞的代偿作用。而针腰骶部的肾俞、关元俞，肾俞为肾之背俞穴，腰为肾之府，针刺该两穴有补益肝肾、强腰健膝之功效，配合下肢穴位达到疏通经络气血，与头穴配合使患者能坐能站，早日恢复行走。

中风属现代医学脑血管意外，从神经解剖学上是属于上运动神经元性瘫痪，由于患者长期卧床缺乏活动，使患肢呈痉挛性屈曲状态。头穴加腰骶腧穴或其他针刺疗法虽然能促进患肢运动功能的恢复，但对于痉挛状态，只有通过患者主动或被动锻炼才能解决。临床观察显示，患者锻炼积极者，患肢运动功能恢复快，活动更灵活，而不重视锻炼者，肢体活动恢复慢又不灵活。因此，鼓励患者加强锻炼。对于全瘫病人，要指导家属及陪护人员给患者做按摩及瘫痪肢体的被动活动。根据病情，鼓励患者多坐、站及学行走。这是提高疗效的一个不可忽视的环节。

九、风池为主 随症配穴

王格红采用以风池穴为主的针刺方法治疗中风后遗症，取得了满意的疗效。

取穴：主穴：取双侧风池。配穴：上肢瘫取肩髃、曲池、合谷、外关、中渚；下肢瘫取大肠俞、环跳、伏兔、足三里、阳陵泉、悬钟、太冲、三阴交；言语不清、吞咽困难取人迎、廉泉、内关；手足肿胀、屈伸不利取八邪、十宣放血；二便失禁、遗尿取肾俞、关元、中极、次髎；面瘫加下关、地仓、鱼腰、颊车等；肘部拘挛加尺泽、曲泽，腕部拘挛加大陵、腕骨，手指拘挛加八邪；踝部拘挛加太溪、照海；足趾拘挛加八风、涌泉；口舌喎斜加下关、地仓、

颊车；言謇或不语加廉泉、通里。

操作：常规针刺双侧风池穴，用捻转提插补法，强刺激，持续15~30s，要求针感向前额部放射。其他穴位施以合谷刺，针刺得气后，将针体提出2/3，向前后左右四个方向深刺，上下提插，针感强烈并向肢体远端放射。每次留针20~30min，中间施行手法1次，每日治疗1次，10次为1个疗程，疗程间休息5天。

风池穴具有祛风通络、改善脑血管供血之功用，故临床上以此穴为主穴，配以手足三阳经穴，尤以手足阳明经穴为主，主要是针对中风患者半身不遂、偏身麻木等主证，这些腧穴不仅起到局部、邻近的治疗作用，更重要的是腧穴配合使用具有协同作用，并发挥某些腧穴的整体治疗作用。如肩髃、曲池、手三里、合谷均属手阳明大肠经，又分别位于肩、肘、手部，皆主治中风半身不遂，其中曲池系大肠经合穴，合谷是大肠经原穴，诸穴共用，有调和气血，扶助正气的整体效用，特别是合谷穴，还可以兼顾中风后所见口眼喎斜、口不能言、口噤不开等症，作用全面。因此，主方各穴选用，相互配合，突出强调其整体作用。

十、人迎为主 气至病所

马云生用针刺人迎穴为主加透刺治疗中风后遗症，疗效显著。

取穴：人迎穴（位于喉结旁开1.5寸）为主，肩髃透极泉、曲池透少海、三阳络透郄门、外关透内关、合谷透少府，承扶透五里、殷门透箕门、阳关透曲泉、阳陵泉透阴陵泉、条口透承山、悬钟透三阴交、内庭透涌泉。随症加穴：若失语、言语不清加廉泉、通里；中枢性面舌瘫加下关、地仓；大小便失禁加关元、足三里等穴。

操作：先取人迎穴，患者平卧，常规消毒后，以左手食、中指摸着颈动脉，避开浅静脉，右手持30号2.5寸毫针快速刺入真皮，再缓慢进针，进针1.5~2.0寸，等患者感到有酸、麻、胀、沉时，用小幅度捻转，得气后，针感除局部外，并可传向四肢等部位；大多数患者得气后经调整针感，可使气至病所；少数患者开始针感只在局部，经多次治疗后，针感逐步传向病所，一般捻转约1~2min即可将针拔出。再针透穴先泻后补或平补平泻，各穴进针得气后均匀提插捻转，每5~10min运针1次，每日1次，留针30min，15天

为1个疗程，休息2~3天再进行第2个疗程。

人迎穴，出自《灵枢·本输》，属足阳明胃经。《针灸聚英》谓“足阳明少阳之会”，是“气海”所出之门户，与“胸气街”及肾、脾、肺、肝、心、三焦、胆、小肠、冲脉、任脉、阴阳跷脉等咽喉有关经脉相通，并能“候五脏气”（《针灸甲乙经》），是重要的经穴之一，因此针刺人迎穴有调节机体阴阳平衡，疏通多条经脉气血功能。再加上透刺以一针双穴贯透二经，阳经透阴经，能疏通经脉，通经活络，舒筋利节，故对治疗中风后遗症有明显疗效。

十一、辨证选经 排列针刺

任淑芳在临床实践中，总结出一套治疗中风后遗症的针刺方法，即“排刺”以辅助肢体康复。

操作：“排刺”，顾名思义，就是沿经脉线排列针刺，不仅仅局限于穴位。同时还要辨证选经。比如，下肢抬腿不能，取血海和梁丘两穴以上沿脾经和胃经排刺。因其两经正好在股四头肌上，此肌肉收缩可使大腿抬高；足内翻选足少阳胆经的阳辅穴以下排刺，其位正好是腓肠肌走向，而腓肠肌收缩可纠正足内翻；腕下垂选阳溪、阳池、阳谷，即三阳排刺，此部位恰好刺到腕长伸肌和腕短伸肌上。如此类推，至于排列的针距和针数那就要根据病情而定。初病肌力弱者，排列要密，针距小针数就多；肌力强者，排列就疏，针距大，针数就少。全用排刺疗法治疗，10天为1个疗程

此法既利用了中医学的经络学说，又结合了现代医学神经系统和运动系统的相关理论。因为肢体的活动离不开肌肉的收缩和舒伸。沿经脉线排列在某个肌群上，可使该肌收缩，肌力迅速提高，以利其所支配肢体的活动能力。

十二、梅花针为主 配以多针刺

师怀堂在运用新九针治疗中风及其后遗症的长期临床实践中，逐步摸索出一套以梅花针为主的独特且行之有效的治疗方法。它起到了调节脏腑功能，平衡阴阳，祛邪及通经活络的作用，尤对脑血栓形成早期（发病1~2天）者，可起到立竿见影的效果。现详述如下：

先用梅花针对患侧肢体及健侧头部循经重叩，叩刺重点是健侧头三阳经及患侧十二井穴。继用毫针针刺健侧头部胆经穴位及患侧十二井穴为主，取穴：率谷、天冲、悬颅、浮白、悬厘、窍阴、脑空、曲鬓、听宫、风池、风府、风门、百会、曲池、秩边、十二井穴等，也可用三棱针点刺井、原、络穴，并可根据“上病下取”、“下病上取”等配穴原则灵活选穴。若伴口眼喎斜可加用梅花针叩患侧阳白、承泣、牵正、颊车、地仓、下关、迎香，毫针：颊车透地仓，下关透迎香，阳白透鱼腰、牵正、太阳、攒竹、印堂等，并运用滞针手法；若畏寒怕冷则加用火针；若舌强语謇可加用锋勾针勾刺天柱、大椎、哑门、风府、风池、脑空、承光、通天，并可配承灵、百会、隐白、三阳络等。另外对后遗症患者还需加用磁圆针重叩健侧风池、风府。以上治疗均隔日1次，疗程则根据病情的轻重不同而长短不一。

王某，女，53岁。右半身不遂两天。发病当日即送当地医院就诊，诊为脑血栓形成。次日慕名前来求治，来时被人抬入病房。检查：右腿抬举不能，右手臂伸举困难，卧位可抬至腹部，轻度语言不利。遂给予治疗，梅花针重叩健侧头三阳经及患侧十二皮部，井穴，叩后右腿即能抬至60°，手臂也觉有力了。再加毫针，取风池、印堂、太阳、承泣、外关、合谷、后溪、血海、阳陵泉、足三里、公孙、十二井穴。照此治疗，隔日1次，治疗3次后，患者即可下床行走，再针3次，患者已基本痊愈，只感肩腰部酸困怕冷，又局部加火针2次，症状消失，已如常人。

十三、醒脑开窍 重在手法

王秀丽在临床上运用醒脑开窍针刺法配合头皮针治疗中风后遗症，具有较明显的临床疗效。

取穴：醒脑开窍针刺法主穴：内关、人中、三阴交。配穴：极泉、尺泽、委中。加减：语言障碍及吞咽困难者加风池、翳风、完骨、廉泉、金津、玉液及舌面咽后壁点刺。口眼喎斜者加地仓、颊车、颧髎；上肢拘急抬举无力者加肩髃、曲池、外关；手挛萎缩者加合谷及八邪穴；腕下垂加刺阳池；足内翻加刺阳陵泉、丘墟；下肢肌肉萎缩配足阳明经排刺。头皮针：取对侧运动区。

操作：先刺双侧内关，直刺0.5~1.0寸，采用提插捻转结合的泻法，施手法1min，继刺人中，向鼻中隔方向斜刺0.3~0.5寸，采用雀啄手法（泻法），以眼睛流泪或眼球湿润为度，再刺三阴交，沿胫骨内侧缘与皮肤呈45°角斜刺，进针0.5~1.0寸，采用提插补法以下肢抽动3次为度。极泉穴，原穴沿经下移2寸的心经上取穴，避开腋动脉，用手固定患者肘关节，使其外展直刺进针0.5~0.8寸，用提插泻法，患者有手麻并抽动的感觉，以患肢抽动3次为度。尺泽穴取法屈肘为内角120°，直刺进针0.5~0.8寸，用提插泻法，针感从肘关节传到手指或手动外旋，以手动3次为度。委中穴，仰卧位抬起患肢取穴，用左手握住患肢踝关节，肘部顶住患肢膝关节，刺入穴位后针尖向外15°，进针1.0~1.5寸，用提插泻法，以下肢抽动3次为度。风池穴刺向喉结，约2~2.5寸，施以小幅，高频捻转3min。翳风、完骨刺入2~2.5寸，捻转补法施术1~3min。翳风穴疼痛敏感者，可隔日1次或每周2次。廉泉刺入1.5~2寸，使针感到舌根部。金津、玉液，用手以消毒纱布固定患者舌体，提出并上翻，用三棱针点刺，刺后令患者闭唇缩舌，吸吮则出血较多。舌面点刺，患者张口，用针快速点刺舌面十余下，以微见小出血为宜。合穴于第二掌侧中点桡侧取穴后，先向后溪针刺，再向拇指、食指以提插泻法针刺，以手指抽动为度，然后向三间穴方向进针1寸。八邪穴上1寸为上八邪，针刺进针0.5~1.0寸，针尖指向指缝，提插补法以与针刺穴位相邻的两指抽动为度，下肢足阳明经排刺，从足三里开始，间隔1寸，刺入1支，深1~1.5寸，排刺4~6支。丘墟透照海，刺入1.5~2寸，针尖不透于皮外，但可触及，施捻转泻法1min。

头皮针取对侧运动区。分别在运动区上1/5处，中2/5处，下2/5处进3针，选28~32号长1.2~2寸的毫针，与头皮呈30°角快速将针刺入头皮下，当针达到帽状腱膜下层时，指下感到阻力减少，然后使针与头皮平行继续捻转进针，进针后捻转1min，然后根据治疗目的不同在主要穴区通电，频率可用200~300次/min，亦可用较高的频率，刺激强度以患者能耐受为度。

以上治疗每日1次，每次30min，30天为1个疗程。休息1周后可进行第二个疗程。

《灵枢·本神第八》云：凡刺之法，必先本于神。醒脑开窍针刺法立足于醒神、调神。主穴中内关为八脉交会穴之一，通于阴维，属厥阴心包经之络穴，有养心安神，疏通气血之功。人中为督脉，手足阴阳之合穴。督脉起于胞中，上行入脑达巅，故泻人中可调督脉，开窍启闭以健脑宁神。三阴交是足太阴脾、足厥阴肝、足少阴肾经之交会穴，该穴有补肾滋阴生髓的功能。内关、人中、委中、极泉、尺泽等穴可开窍醒神通络，补三阴交即可生髓补脑，又可滋水熄风，补泻兼施，则收到标本兼顾，相得益彰之效。本法治疗中风后遗症中假球麻痹所表现的言语障碍及吞咽困难，具有独特的治疗效果，但取穴必须掌握针刺方向，注重手法。风池穴的针感要求达到咽喉部，产生麻胀感，廉泉穴针感达舌根，以麻胀为度。头皮针加上电针，由于直接作用于头部，通过不断的刺激，可促使损伤部位的血流量增加，促进和加强病灶周围脑神经细胞功能的代偿作用。

参 考 文 献

- [1] 王桂荣, 邹然, 苏颖. 头针施用抽添法治疗中风半身不遂 70 例. 长春中医学院学报. 1997, 13 (64): 26~27
- [2] 李秀华, 靳玉学, 李亲长. 针刺风府哑门穴治疗中风后遗症 50 例疗效观察. 针灸临床杂志. 2005, 21 (1): 52~53
- [3] 张艳. 针刺透穴治疗中风后手指拘挛性瘫痪 32 例. 上海针灸杂志, 2004, 23 (7): 28
- [4] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 7
- [5] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 12
- [6] 于晓刚, 张丽, 王国华. 三步针法治疗中风偏瘫的疗效观察. 中国针灸, 2004, 24 (4)
- [7] 方立新. 头体针结合与单纯体针治疗中风后遗症 283 例疗效对比. 河北中医, 1996, 18 (3): 18~19
- [8] 郑宗昌. 头穴配腰骶俞穴治疗中风后遗症 634 例. 上海针灸杂志, 1996, 15 (5): 15~16
- [9] 王格红, 郝重耀, 贾运滨. 针灸治疗中风后遗症 60 例临床观察. 中西医结合心脑血管病杂志, 2005, 3 (8): 740~741

- [10] 马云生. 针刺人迎穴为主治疗中风后遗症 100 例疗效观察. 中国针灸, 1999, (12): 721 ~ 722
- [11] 任淑芳. 排刺治疗中风后遗症 200 例. 上海针灸杂志, 2004, 23 (8): 20
- [12] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 18
- [13] 王秀丽. 醒脑开窍针刺法配合头皮针治疗中风后遗症 35 例. 内蒙古中医药, 2003, (4): 25 ~ 26

【郁 证】

郁证是因情志不舒、气机郁滞而致病，以抑郁善忧、情绪不宁或易怒善哭为主症。本病临床甚为常见，以女性发病居多，并多有郁怒、多虑、悲哀、忧愁等情志所伤史。可兼有精神不振，胸闷胁胀，善太息，不思饮食，失眠多梦等多种症状。

郁证的发生，因郁怒、思虑、悲哀、忧愁七情所伤，导致肝失疏泄，脾失运化，心神失常，脏腑阴阳气血失调而成。初病因气滞而挟湿痰、食积、热郁者，则多属实证；久病由气及血，由实转虚，如久郁伤神，心脾俱亏，阴虚火旺等均属虚证。

针灸在治疗该病时，取穴及治疗方法较丰富，有取头穴、四关、督脉穴及八脉交会穴、天谷八阵、夹脊穴等，在治疗方法上有的配合耳压，有的配以中药，均取得较理想疗效，但治疗同时应嘱患者调情志，保持心情舒畅。

一、头穴为主 配导引吐纳

孔尧其运用头穴针刺，配合导引吐纳治疗郁证，其法简便，其效亦显。

(1) 郁生诸病，顺气为先 《丹溪心法·六郁》谓：“气血冲和，万病不生，一有拂郁，诸病生焉”。《证治汇补·郁证》云：“郁病虽多，

皆因气不周流，法当顺气为先。”顺气之法，首责于肝，肝失条达，气失疏泄，治以疏肝理气，即《素问·六元正纪大论》所谓“木郁达之”之意。

头穴额旁2线可治中焦疾患，有疏肝和胃、利胆清肠之功。额旁2线位于头临泣穴向下1寸，属足少阳胆经。因肝位在右，故应用缪刺法而刺其左，以疏肝理气。肝气条达，情志舒畅，诸证悉除。

(2) 神郁互变，因果同治 孔尧其认为，在针刺治疗郁证的同时，必兼治神，这样，既对因，又对证，既治标，又治本，相得益彰，实可收事半功倍之效。而治神之穴，多选额中线、顶中线。额中线位于神庭穴向下1寸，属督脉，有宁神、定惊、止晕、开窍之功；顶中线即百会穴至前顶穴，也属督脉，有平肝潜阳，益气升阳，疏通经络之效。同时，也可配额旁2线（右），以健脾补气、益血宁神；配额旁1线（右），以宁心安神，额旁1线位于眉冲穴向下1寸，归属足太阳膀胱经。以上诸穴相配，尚可辅佐主穴，活血、痰、湿、热、食诸郁。

(3) 刺以抽添补泻，配合导引吐纳 在头穴针刺时，孔尧其惯用《针灸大成》之抽添法补泻。其具体操作要领是，抽提要掌握“数”与“拔”，添按要把握“数”与“推”，即速度要快，力度要猛。当针进腱膜下层后，可将针体平缓入1寸左右，然后，用暴发力向外速提或向里速插，反复多次，每次一般不能超过1分左右。若手法熟练，则可看不出针体有任何出入。此法属提插补泻手法，以抽为泻，以添为补，其特点是刺激量大，省时、省力、痛微、效捷，操作简便，易于掌握，十分适宜于头穴针刺。

郁证往往因情志不遂而起病，故少有急症，但移情易性也不易一针见效，故头穴针刺宜长时间留针和间歇运针，以延长得气时间，增强针刺效应。同时，在运针、留针期间，须配合导引吐纳。以激发经气和引导经气至患部，并能起到怡情宽怀，养心安神，增强战胜疾病信心的作用。治疗郁证的导引吐纳配合，一般在引针时，令患者闭目端坐，全身放松，意守丹田，腹式呼吸，并可按摩胀痛的胸胁。在留针期间，可做太极拳、气功等活动，要求意气相随。

赵某某，女，65岁。1987年11月27日初诊。患者近日心情不遂，晚饭后突然感到左胁疼痛，呈胀痛和刺痛，逐渐加剧，以至不

能俯仰转侧，经按摩揉搓均无效。查：面色潮红，烦躁，左侧第九、第十肋间疼痛拒按，舌质红，苔薄黄，脉弦数，系肝郁气结胁痛，取额旁2线（右）、额中线，引抽气法，并按摩胁部疼痛部位。在行针中，疼痛逐步减轻，直至消失。随访无复发。

金某某，女，34岁。1987年9月18日初诊。近年消瘦乏力，失眠，头昏头痛，精神恍惚，哭笑无常，哭多于笑，哭前有预兆，哭时泪溢、抽搐，3~5min即停，日发作10余次，舌淡、苔薄白，脉弦细，诊断为痞病（脏燥）。取额旁2线（左）、额中线、顶中线，引抽气法，留针24h。行针时，配合腹式呼吸，意守丹田。针后症状得到控制，当日仅发作1次，隔日1次续针10次，病症告愈。

二、辨证分型 重用督脉经穴

任建宁采用针灸治疗抑郁症患者，获得良好疗效。

取穴：百会、上星、前庭、安眠、印堂、内关、神门、中脘、气海、关元、丰隆、三阴交、照海、太冲、心俞、肝俞、脾俞。每次取5~6穴，两侧穴位同时使用。肝郁喜太息者加膏肓俞；焦虑者加膻中；易怒者加悬钟；记忆衰退者加四神聪；气郁痰滞伴强迫思维者加强间；纳呆体重下降者加太白；自卑者加太渊；恐惧者加肾俞；气滞血瘀伴疼痛者加四关穴；中焦胀满者加天枢；气血两虚伴神疲者加足三里、血海、心俞；肢冷恶寒加关元俞、膈俞、肾俞。

操作：选取1~1.5寸毫针，严格消毒诸穴，百会、上星、前庭针刺时针尖向后刺入0.5~0.8寸，安眠垂直刺入0.5寸，印堂针尖向下刺入0.5寸，内关针尖向上透间使刺入1寸，神门向桡骨茎突透刺1寸，中脘、气海、关元、丰隆、三阴交直刺1~1.5寸，照海、太冲直刺0.3~0.5寸，心俞、肝俞、脾俞向脊柱方向斜刺0.5~0.8寸，平补平泻，留针40min，留针期间每10min行针1次，1周针刺2次，10次为1个疗程。

《素问·上古天真论》曰：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”可见情绪在日常生活中占有重要的地位，良好的心情使人精神振奋，精力充沛。相反，低落的情绪则使人焦虑、忧愁、悲观、失望，抑郁甚至走向自杀之路。正如《景岳全书·杂证谟·不寐》云：“盖寐本乎阴，神其主之，神安则寐，神不安则不寐。其所

以不寐者，一由邪之所扰，一由营气不足耳，有邪者多实证，无邪者多虚证。”众所周知，针刺具有调节神经功能的作用，对压力的调节和缓解作用尤其明显。任建宁采用辨证分型，重用督脉经穴佐以阴经之穴，从阴引阳，从阳引阴来平衡阴阳，从而获得良好疗效。

患者，女，38岁，公司职员，患者平素少言寡语，性格内向，不善交际。常独自下班后闭门饮酒抽烟，自闭倾向日渐加重，1997年初在被确诊为抑郁症。2003年初经友人介绍来诊所接受耳针系统治疗。查身高体瘦，目光呆滞，纳呆，夜寐失调，便秘，舌质暗红，苔薄黄，脉弦涩。症为气滞血瘀。治法：活血化瘀，软坚散结。针取：百会、上星、前庭、安眠、神门、气海、关元、子宫、照海、三阴交。平补平泻。留针40min，经过2个月治疗后，情绪明显舒畅并乐意与人交流。

三、证分四型 分期治疗

郁证是由于情志不舒，气机郁滞所引起的一类病证。根据郁证的分型和发展，谢潇侠采用了分期治疗的方法，即早期行气解郁、中期下气开结和后期益气宁神，治疗效果满意。

取穴：阳明热盛：金津、玉液、风池、曲池、偏历、合谷、丰隆。心火炽盛：人中、劳宫、涌泉、舌尖点刺、天容、郄门、通里。气虚挟湿：上星透百会、印堂、前顶、后顶、通天、头临泣、率谷、风池、完骨、内关、神门、前廉泉、舌尖点刺。气虚阳阻：百会、四神聪、风池、曲池、手三里、外关、阳池、中渚、太溪、太冲。

操作：用30号1.5寸毫针，主穴用提插配捻转补泻。人中用雀啄泻法，以眼球湿润为度。金津、玉液及舌尖点刺以出血为度，留针30~60min，视病情而定。每日1次，10次为1个疗程。

谢潇侠认为，郁证的病机在于人体气机郁滞，升降失司，少阳之气不得宣发，故而身呆气逆，表现为各项功能失于和畅。虚者清阳不升，神怠抑郁；实者郁浊不降，扰神逆乱，治疗的关键在于辨证施治。

在郁证的治疗中，根据不同分型采用不同的治疗方法。阳明热盛型，治以清泻阳明。金津、玉液为经外奇穴，点刺有祛瘀、清热散结、通络开窍之功效；风池疏泄清窍；曲池、偏历、合谷分别为

手阳明之合穴、络穴及原穴，丰隆为足阳明经络穴，主升清。诸穴配伍，具有清泻阳明之功效。心火炽盛型，治以清心泻火。人中、劳宫、涌泉共为五心穴，具有开窍醒神、清心泻火之功效；舌尖属火，点刺可清心泻火；天容为小肠经穴借以通腑；郄门为心包经之郄穴，具有宁心安神之效；通里为心经络穴，泻心火。气虚挟湿型，治以益气化湿，清疏上焦。上星透百会与印堂、前顶、后顶、通天相互配伍，起通督调神之功效；头临泣醒神宽胸；率谷有升清降浊之功；风池、完骨有升清之功；内关有宽胸下气之作用；神门安神宁心，通经活络；前廉泉可宣通窍络，畅阴化湿。气虚阳阻型，治以温阳通经，疏理少阳。百会配四神聪镇静安神；风池具有清泄少阳之功；曲池、手三里、外关、阳池、中渚配合，共凑建中益气通阳之功；太溪、太冲相配益肾疏肝。

在治疗郁证时，除辨证分型外，还应根据郁证的发展，采取分期治疗的方法：早期用行气解郁法，取穴：上星透百会、外关、中渚、四关等；中期用下气开结法，取穴：颌厌、曲池、偏历、合谷、丰隆、内庭等；后期用益气宁神法，取穴：百会、四神聪、内关、神门、曲池、手三里、足三里、太冲等。

王某，女，28岁，工人。患者因失恋受刺激后，声高气涌，语言滔滔不绝，逢人便诉说失恋之苦，后来发展到独自表白，暴饮暴食，便秘。曾在其他医院诊治，疗效不佳，遂来本院诊治。诊见精神亢奋，舌红，苔黄，脉弦数。诊断：郁证，属阳明热盛型。治宜清泻阳明。取金津、玉液点刺出血；风池用捻转补法；曲池、偏历、合谷、丰隆均用提插泻法。经上法治疗2次后，情绪趋于稳定，2个疗程后痊愈，随访3个月未复发。

四、针药并用 疏调肝脾肾

郁证病人皆因精神受创伤而致善思多虑，精神抑郁，情绪不宁而发病，病程较长，病史大多在3个月以上。姜秀国用针药并举治疗郁证，收效较佳。

取穴：主穴：三阴交、神门、心俞、中脘。配穴：四神聪、内关、太冲。

操作：手法用平补平泻，每日1次，留针30min，10次为1个

疗程，间隔2~3天，再进行下1个疗程。

中药：药用归脾汤加减：党参、白术、茯苓、甘草以补气健脾，脾为后天之本，气血生化之源，脾胃强健则气血自生；当归、黄芪补气生血；枣仁、远志、龙眼肉补心益脾，安神定志；木香理气醒脾，使补而不滞。心胸郁闷精神不舒者加郁金、佛手理气开郁，对病程长症状重者加用琥珀、磁石以镇肝熄风，安神定志。

从辨证上看，郁久则伤及心脾，心脾不运，气血生化不足，故出现心脾两虚。心失所养则致心悸胆怯，失眠健忘，脾失健运则面色不华，舌淡脉细等。从治疗上看，针对病人病情复杂，思想负担重，用针药并举治疗郁证，三阴交穴为三阳经之交会穴，以疏调肝脾肾三经之气，神门为心经俞穴，可清心安神、除心中郁结之气，心俞善治悲愁恍惚，四神聪为奇穴，能清利头目，醒脑开窍，内关、太冲善治胸满气郁，气机不畅。

女性，66岁。表现为焦虑、失眠、纳差3个月，加重10天来诊，既往有高血压、糖尿病史5年。于3个月前因忧思多虑后出现头晕神疲，心悸胆怯，舌淡，脉细弱，西医诊断：焦虑性神经症，经用上述针刺三阴交、神门、心俞、内关、中脘、四神聪配用归脾汤加减治疗2周后，症状明显好转，3周后症状完全消失，随访两年未再复发。

女性，李某，25岁。表现头晕不寐，心烦纳差，反应迟钝，因5个月前失恋后出现头胀头痛，咽部有异物，吐之不出，咽之不下，经口腔科会诊未见异常。查体：舌淡暗，苔薄白，脉沉细，西医诊断：咽喉神经症，经用针刺、归脾汤治疗1周后症状消失，巩固治疗1周后，症状完全消失，随访一年未复发。

五、互动式针刺 贵在调神

抑郁症是指一种持久的心境低落状态，常伴有焦虑、躯体不适感和睡眠障碍，已为影响人类生存质量的最严重的精神疾患之一。孟向文采用互动式针刺法治疗，疗效尚可。

取穴：主穴取内关。心脾两虚者加足三里，心肾两虚者加三阴交。

操作：患者取仰卧位，内关用1.5寸毫针直刺进针0.5~1寸，

得气后，行小幅度捻转平补平泻法，持续 2min，同时嘱患者守神，深吸气时用力收腹，每分钟 12~14 次，持续 2min。留针期间腹式呼吸与休息每间隔 2min 交替进行，留针 30min。足三里、三阴交采用 1.5 寸毫针提插、捻转补法 1min，留针 30min。隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

抑郁症属郁证范畴，其主要病机是气机运动失常，从而导致心、肝、脾三脏功能失调。“互动式针刺法”中的深呼吸运动可以有效地改善人体的气机郁滞，从根本上调节脏腑功能，尤其是心主血脉、心主神明的功能，有利于郁证的恢复。针刺要穴内关为手厥阴心包经的络穴，八脉交会穴之一，通于阴维脉。此穴具有宁神镇痛、理气宽胸的功能，能主治阴维脉的病证，而阴维脉的主要病候之一即为忧郁。“互动式针刺法”的关键之一在于针刺的同时令患者作深呼吸运动，以调节患者“守神”的积极性和患者自身调节气机、协调阴阳的潜能。

六、针刺为主 解郁调神

李世君以针灸为主要的治疗手段，探索出解郁调神法针刺治疗郁证，取得较好疗效。

取穴：解郁调神法：风池、安眠、四神聪、印堂、百会、神门、间使、合谷、太冲、三阴交、丘墟、率谷、足三里。根据伴发躯体焦虑症状的不同而配穴：心悸、胸闷、气短者加内关、膻中；失眠严重者加耳穴心、神门；胃肠道症状，食欲差者加中脘；大便不畅者加天枢。

操作：以 2.5~3 寸毫针。上述穴位基本施以捻转法，其中神门进针手法宜轻柔稍做捻转即可，中脘行呼吸泻法；印堂、百会给以电针刺激，刺激量以患者自我感到舒适可耐受为度，行针时令患者闭目，调匀呼吸，放松。针刺后留针 30min，每天针刺治疗 1 次，2 周为 1 个疗程。

郁证患者以情绪低落为核心，临床症状庞杂繁多，但其病因病机基本点是因情志不遂而致病，因此以“肝郁”为核心，因肝郁气滞引发气机不利，经络失和；因肝郁引发木郁土壅，肝脾失和、心神困扰，神不守舍，由此，患者产生一系列精神和躯体症状群。因

而，李世君采用解郁调神法针刺治疗，此即针刺治疗的选穴依据。

七、针刺夹脊配耳穴 疏肝解郁

抑郁多因郁怒、思虑、悲哀、忧愁七情之所伤，导致肝失疏泄，脾失化运，心神失常，脏腑阴阳气血失调而成，其中心（脑）神受损尤为重要。故治当疏肝理气解郁，健脾益气，醒脑宁神，养心安神为要，熊学琼采用针刺夹脊穴为主配合耳穴压丸的方法治疗。

取穴：主穴：华佗夹脊穴（肺、心、肝、脾、肾夹脊）；配穴：百会、神庭、内关、太冲、三阴交。

操作：病人先取俯坐位，用一次性1~1.5寸毫针，先依次针刺肺、心、肝、脾、肾夹脊穴，行平补平泻手法，得气后出针，病人再取仰卧位，针刺百会等配穴其中3个穴位，行平补平泻手法，留针30min。出针后用王不留行籽贴压心、神门、皮质下、脑、肝、脾等耳穴，左右耳穴交替，嘱患者每天按压耳豆至少3次，每次至少15min，保持3天以上。针刺和换耳穴压丸均每周2次。

夹脊穴分布于脊柱两旁，与督脉关系密切，因督脉循行于脊里，入络于脑，正如《难经·二十八难》所言：“督脉者，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑。”夹脊穴与督脉经穴异穴而同功，且针感放射更强，能达气至病所之效。其次，夹脊穴与足太阳膀胱经之经气密切相关，正如《灵枢·经筋篇》指出的“膀胱足太阳之脉，……挟脊抵腰中，……其之者，从腠内左右别下贯胛，挟脊内……”。“足太阳之筋，起于足小趾上，……其别者，……上挟脊上项。”因而夹脊穴与足太阳膀胱经之经气相通，夹脊穴具有背俞穴之功而针刺时较之更安全。而“脑为元神之府”，“心主神明”，“心藏神，肺藏魂，肝藏魄，脾藏意，肾藏志”，故取肺、心、肝、脾、肾夹脊穴为主治疗抑郁症，配以督脉经穴百会、神庭，足三阴经之会三阴交，肝经之原穴太冲，心包络穴内关，诸穴共奏疏肝理气解郁，健脾益气，醒脑宁神，养心安神之效，加上耳穴压丸，补充每周两次针刺之不足，以增强巩固疗效。

患者，女，19岁，学生。于2003年4月12日初诊，患抑郁症2月余。2个多月前，因父母离异后（和父亲生活在一起）发病，初为心境低落、沮丧，孤独感、做事无兴趣，失眠，疲乏，不愿出门，

病情逐渐加重，中断学习。半月来，悲伤易哭，或烦躁，害怕恐惧，不敢一人独自在家，失眠多梦，极度疲乏，胸胁胀满，纳呆腹胀，面白少华，舌淡苔薄白，边有齿痕，脉沉细弦。证属肝气郁结，心脾两虚。治当舒肝理气解郁，健脾益气，养心宁心安神。如法针刺上述夹脊穴（双）、内关、太冲、百会，出针后给以耳穴压丸治疗。三天后复诊，自述心情平静许多，恐惧感稍减轻，睡眠稍有改善，守前法治疗（针刺配穴选用内关、三阴交、神庭）。第三次就诊时，自述整体情况较前改善，信心增加，坚持治疗。第五次就诊时，脸上有了笑容，诸症状明显改善，有时已能独自在家而不害怕，守前法继续治疗。第八次来诊时，自述诸症基本消失，但有时稍有心境低落，第九次就诊时，自述已康复，无特殊不适，10次治疗后痊愈恢复上学。

八、体耳针并用 疏肝宁心

抑郁症是指因情志因素致肝气郁结、心神失养所引起的一种精神疾患。历代文献记载的奔豚气、梅核气、脏躁等均为本病的证候类型。王振萍采用针刺治疗抑郁症患者，取得比较满意的疗效。

取穴：主穴：合谷、太冲、人中；配穴：三阴交、关元、百会。

操作：先刺双侧合谷，直刺0.5~1寸，用捻转提插泻法，施术1min；继刺双侧太冲，直刺0.5~1寸，行捻转提插泻法，施术1min；再刺人中，向鼻中隔方向斜刺0.3~0.5寸，用雀啄泻法至目睛湿润为度；取双侧三阴交，直刺1寸，行捻转补法，施术1min；关元直刺进针2.5~3寸，施捻转补法，使针感传至小腹。百会沿皮直刺0.5寸，行平补平泻法，施术1min。隔日针灸1次，10次为1个疗程。

耳穴：神门、内分泌、皮质下、肝。先以酒精棉球擦拭耳部皮肤，再用干棉球擦净，于耳穴处放王不留行籽，胶布固定，每天按压3次，每次1~2min。以局部热胀感为度，隔日更换1次。

《证治汇补·郁证》提出治疗郁证的大法，谓：“郁病虽多，皆因气血不周流，法当顺气为先”。取合谷、太冲两穴可调心神、启窍闭、疏肝解郁，两穴配合可达开“四关”之效。人中为督脉要穴，可醒神利脑窍。三阴交刺之可补肝益肾，健脾生血。关元可补气调

气。百会刺之可平肝降气，开窍醒神。诸穴配合，共奏调神理气之功。加之耳穴可调节人体内分泌系统而提高疗效。为了加强疗效，在治疗中应针对患者发病原因进行心理治疗，使患者能够移情易性，认识到郁证的病因，克服心理障碍，从而提高疗效。

九、大调神 开四关

更年期抑郁症是更年期综合征的并发病。相当于中医学的郁病和绝经前后诸证。患者往往表现为心境低落，对外界事物失去兴趣，语言动作减少，生活质量下降，虽无器质性病理改变，但精神负担十分沉重，甚至有自杀倾向。魏晓萍采取醒神开四关法治疗更年期抑郁症，收到了满意的疗效。

大调神法：即取内关、人中、百会、四神聪。患者仰卧，皮肤常规消毒，先刺双侧内关穴，直刺1~1.5寸，采取捻转提插相结合的泻法，每穴施术行针1~2min后留针。继刺人中，针尖向上与皮肤成45°角刺入鼻中隔约0.5~1寸，将针体向同一方向捻转180°，使肌纤维充分缠绕针体，然后行雀啄手法，至流泪或眼球周围充满泪水为度。百会穴针向前刺，用迎随补法。四神聪采取四穴依次相互透刺，操作时应先斜刺进针至皮下疏松结缔组织，然后徐徐入内，否则引起剧烈的痛疼而使病人拒绝针刺治疗。

开四关：“四关，合谷、太冲是也”。即取双侧合谷、太冲。患者姿势及皮肤消毒同前，两穴均直刺1~1.5寸，用捻转泻法，施术1~2min，然后留针。

以上诸穴均留针30min，留针期间每10min运针1次。每日1次，连续治疗7次为1个疗程，2个疗程间隔3天。

《灵枢》：“凡刺之法，先必本于神。”内关为八脉交会之一，通于任维，属手厥阴经之络穴，有养心安神、疏通气血之功。人中为督脉穴位，刺之可调督脉，开窍启闭以健脑宁神。百会为“诸阳之会”，能疏通诸阳的气滞、清头醒目。四神聪为经外奇穴，有清头目、安神健脑、益智的作用。诸穴相配能醒神、宁心安神、定志。合谷为大肠经原穴，属阳，主气；太冲为肝经原穴，属阴，主血。两穴一阴一阳，一升一降，开关宣窍，可谓气化功能之关键，气血通行之要塞。合谷调气中之血，太冲理血中之气，气血调和则诸病

自愈。开合谷、太冲又泻阳明及肝阳偏亢之阳，从而达到协调阴阳平衡。

陈某，女，53岁，棉纺厂工人。自述平素性格爽快好动，近半年却不想和人说话，对工作和吃饭都失去兴趣，自觉无用，经河南医学院一附院诊断为更年期抑郁症，用西药治疗（具体用药不详）1月余疗效欠佳。2002年4月20日来针灸科初诊，诊断同前。用醒神开四关法针治1次，自觉诸症明显好转。2个疗程症状即基本消失。3个疗程后，精神饱满，谈笑风生。随访至今情志正常。

王某某，女，48岁，农民。自述不想言语，悲伤欲哭2月余。表情淡漠，善叹息，经服调节神经类药及安神类中药治疗无效，曾有自杀倾向，于2002年10月15日来就诊。诊为更年期抑郁症。用醒神开四关法针治1个疗程，诸症逐渐好转，2个疗程后症状消失，一切如常人。随访无复发，恢复田间劳作。

十、电针智三针 配小柴胡汤

庄子齐以电针智三针为主合小柴胡汤加减治疗中风后肝郁脾虚型抑郁症，取得一定疗效。

取穴：智三针（本神双，神庭）、内关、公孙、太冲、肩髃、曲池、手三里、外关、合谷、环跳、阳陵泉、足三里、解溪、昆仑、头针取对侧运动区。

操作：智三针以1寸不锈钢针沿头皮成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 角向百会方向进针0.5~0.8寸，快速捻转60次/min，1min后接G6805型电针仪，密波，频率80~100次/min，通电30min；内关直刺约1寸，公孙向太白透刺1寸，太冲直刺约1寸，得气后行导气法1min，接电针仪，疏波，通电15min；上肢取患侧肩髃、曲池、手三里、外关、合谷，下肢取患侧环跳、阳陵泉、足三里、解溪、昆仑，头针取对侧运动区，得气后接电针仪，疏波，通电20min。隔日1次，15次为1个疗程。

中药：小柴胡汤加减：柴胡20g，枳壳12g，黄芩12g，法半夏10g，白芍20g，大枣5枚，郁金10g，百合15g，远志12g，茯神15g，丹参30g，酸枣仁15g，炙甘草6g。水煎服，每日1剂。

抑郁焦虑症属于中医郁证、失眠的范畴，中医认为本症多为肝

郁、心脾两虚、心肾不交所致，治宜舒肝解郁、健脾养心、安神定志，智三针（神庭、本神双）均位于前额，为与神志有关的穴位，头为精明之府，诸阳之神气皆上合于头，神庭为督脉脉气所发，督脉与足太阳的交会穴，督脉及足太阳膀胱经均入络于脑，因此本穴主治神志病证。本神，足少阳胆经脉气所发，足少阳与阳维脉交会之处，位于前发际神庭穴旁，内为脑神之所居，主治情感、智力、神志、精神障碍等疾病，公孙、内关为八脉交会穴，公孙为脾之络穴，通冲脉；内关为心包经之络穴，通阴维脉。两穴交会于心、胸，主治神明、情志、心胸疾病，合智三针诸穴，共奏健脾养心、舒肝解郁、安神定志之功。抑郁焦虑症辨证多为肝郁心脾两虚，患者发作性失眠、情绪低落等症状休作有时，口苦咽干，舌质淡、苔白，脉弦细，合小柴胡汤脉证，予小柴胡汤疏利三焦、和畅气机，辅以百合、远志、茯神、丹参、郁金、酸枣仁以疏肝解郁、安神定志。

刘某，男，55岁。2003年10月15日初诊。主诉：突发左侧肢体瘫痪1个月。患者于2003年9月15日早上睡醒后发现左侧肢体瘫痪，口角向右喎斜，神志欠清，大小便失禁。即送某院急诊，经治30d，未见明显好转而转入本科住院治疗。入院时症见：神清，左侧肢体瘫痪，口角向右歪斜，时有头晕头痛，睡眠差，情绪低落，情感淡漠，少语叹气，胃纳呆，舌暗淡、苔微腻。有高血压史多年。查：血压140/80mmHg，神清，言语尚清，口角向右歪斜，左侧鼻唇沟变浅，伸舌向左侧歪斜，左侧肢体上、下肢肌力3级，肌张力增高，肌腱反射（+++）。按汉密尔顿（Hamilton）抑郁量表HAMD评定总分18分。中医诊断：①中风（气虚痰瘀阻络）；②郁证（肝郁脾虚）。西医诊断：①脑梗死；②抑郁症。治疗：针刺智三针（本神双、神庭）、内关双、公孙双，按治疗组方法操作；小柴胡汤加减，水煎服，每日1剂，连服30剂。治疗4周后，按汉密尔顿抑郁量表评定总分5分，随访1年患者病情稳定，临床治愈。

十一、八脉交会穴为主 调理脑神

潘永清应用针刺八脉交会穴治疗中风后抑郁，取得了较好的疗效。

取穴：人中、印堂、百会、四神聪、列缺（双）、后溪（双）、

申脉（双）、照海（双）、太冲（双）。

操作：患者取仰卧位，严格消毒皮肤用 1.5 寸毫针，人中向鼻中隔方向斜刺 0.3~0.5 寸，用雀啄泻法以患者能耐受为度；印堂针尖向下平刺 0.3~0.5 寸，用捻转泻法 1~2min；百会针尖向前平刺 0.5~0.8 寸，用平补平泻手法 1~2min；四神聪向百会方向斜刺 0.5~0.8 寸，用捻转补法 1min；后溪向掌心直刺 1 寸，列缺、申脉、照海均平刺，均用捻转补法 1min；太冲直刺 0.5~1 寸，用捻转泻法 1min。每次留针 30min，期间行针 1 次；每天针刺 1 次。

选取督脉穴及八脉交会穴，重在调理脑神，平衡阴阳，使五脏六腑阴平阳秘，精神乃治。督脉循行“起于下极之输，并于脊里，上至风府，入络于脑”，说明督脉直接与脑联系，且督脉为阳脉之海，各阳经与足太阴、足厥阴、冲任二脉及心肾等脏在经络上有广泛的络属，因此调理督脉对调节脑神的活动具有重要作用。人中为督脉与手足阳明经交会穴，具有醒神调神之功，并能解除情感淡漠和某些精神症状；百会为督脉与手足三阳经交会穴，位于巅顶，主“心烦闷，神恍惚……”，能清利头目，宁神醒脑。印堂为经外奇穴，但位于督脉循行线上，具有调理脑神的作用，且人中、印堂为醒脑的常用穴。四神聪是健脑益智的经验效穴。后溪和申脉、列缺和照海为八脉交会穴之配，后溪通于督脉，列缺通于任脉，督脉总督六阳经，调节全身阳经经气，为“阳脉之海”，任脉总任六阴经，调节全身阴经经气，为“阴脉之海”，针此四穴即以任督二脉为主，协调周身之阴阳，使五脏六腑阴阳平衡，气血旺盛，循经上荣于脑，促进脑部经络气血运行，发挥“元神之府”之功能，以达到“神自宁，郁自解”。太冲为肝经原穴，足厥阴肝经“上出额，与督脉会于巅”，用之可疏肝理气。

十二、针刺天谷八阵 调神解郁

蒋振亚选用著名老中医李仲愚医师的杵针穴位之一——天谷八阵治疗中风后抑郁症，疗效显著。

取穴：天谷八阵（天谷即百会，天谷八阵是以百会为中心，从百会到左右旁开 1 寸、2 寸、3 寸处为半径画圆圈所形成的八阵穴，每圈共 8 个穴位，穴位与穴位之间距离相等，从内向外依次为内、

中、外3组八阵)。

操作：每天轮流选用2组八阵穴。取28号1寸毫针刺入穴位，用泻法。得气后留针30min，每10min行针1次，每日治疗1次，6次为1个疗程。休息1天后再进行第二疗程。

中风后抑郁症的病机为清窍蒙浊，以致元神之府功能失调，神无所主，心神昏瞢，气血逆乱，气机升降失调而致抑郁。治疗重点在于醒脑开窍解郁，恢复大脑主神的功能。天谷八阵位于头部，是元神之府大脑所在之处。十二正经中十条经脉都与头部有直接联系，奇经八脉中督脉、任脉、阳跷、阴跷、阳维、阴维以及经别、经筋也与头部相连。头部是脏腑、经络气血汇聚的部位，百会穴是“三阳五会”，其周围的内、中、外八阵则贯穿多经多穴。在此处施术，一方面醒脑开窍；另一方面调神解郁，平衡脑内阴阳气血之逆乱，抑郁症状随之改善或消失。

参 考 文 献

- [1] 孔尧其. 头皮针治疗郁证的经验. 中医杂志, 1996, (8): 472
- [2] 任建宁. 针刺治疗抑郁症50例临床观察. 黑龙江中医药, 2005, (2): 35~36
- [3] 谢潇侠. 针刺治疗郁症308例临床观察. 甘肃中医学院学报, 2004, 21 (4): 44~45
- [4] 姜秀国, 陈香英. 针药并用治疗心脾两虚型郁证200例分析. 实用中医内科杂志, 2005, 19 (6): 584
- [5] 孟向文, 陈爽白. 互动式针刺法治疗抑郁症. 上海针灸杂志, 2003, 12 (11): 32
- [6] 李世君, 刘涛. 解郁调神法针刺治疗郁证临床观察. 中国中西医结合杂志, 2007, 27 (2): 155
- [7] 熊学琼, 毕旭伟. 针刺夹脊穴为主加耳穴压丸治疗抑郁症48例. 针灸临床杂志, 2004, 20 (9): 29~30
- [8] 王振萍. 针刺治疗抑郁症50例疗效观察. 山西中医, 2004, 20 (6): 34
- [9] 魏晓萍, 齐盛. 醒神开四关治疗更年期抑郁症38例. 四川中医, 2003, 21 (9): 84~85
- [10] 庄子齐. 针药合治中风后肝郁脾虚型抑郁症30例. 江苏中医药, 2005,

26 (8): 30 ~ 31

- [11] 潘永清. 针刺八脉交会穴治疗中风后抑郁 56 例. 陕西中医, 2007, 28 (2): 199 ~ 200
- [12] 蒋振亚, 何玲娜, 彭力群. 针刺天谷八阵治疗中风后抑郁症. 中国针灸, 2002, 22 (1): 30

【眩 晕】

眩晕，又称头眩、掉眩、冒眩、风眩等。“眩”是指眼花，“晕”是指头晕，是以头晕目眩、视物旋转为主要表现的一种自觉症状。常见于西医学的梅尼埃病、椎-基底动脉系统血管病以及贫血、高血压病、脑血管病等疾病。

中医学认为，本病病位在脑，与忧郁恼怒、恣食厚味、劳伤过度和气血虚弱有关。有因情志不舒、气郁化火、风阳升动、肝阳上亢而发者；有因恣食肥厚、脾失健运、痰湿中阻、清阳不升而发者；有因劳伤过度、肾精亏损、不能上充于脑而发者；病后体虚、气血虚弱、脑失所养亦能发生眩晕。

本篇所收针治经验中，有的取头部穴位为主、有的采用辨证取穴、有的取经验穴“定眩”、“舒肝”，重用手法、有的采用项部穴位针刺，都在眩晕证的治疗中获得良好成绩。

一、头穴为主 矩阵针刺

眩晕症是多种疾病的共有症状或由某些药物毒性及不良反应引起的一类证候群。除头晕目眩的主要症状外，往往伴随头昏、头胀、头痛、耳鸣、眼花、恶心欲呕、心悸烦躁、记忆减退、失眠乏力等，金钰钧采用矩阵针灸治疗效果满意。

取穴：四中（在百会的前后左右各2~3寸处）、双风池、头颞（在太阳穴后1寸，与耳尖平行，咬牙时颞部突起处）。配穴：高血压病配内关、三阴交；低血压病配外关、足三里，灸关元；神经官能症配印堂、神门、太溪；其他病配合谷、太冲。

操作：选用临床常用的30号2寸毫针。针刺四中穴，针尖对准百会穴平刺1.0~1.5寸；风池穴针尖对准喉头斜刺1.0~1.5寸；头颞穴针尖对准耳垂斜刺1.0~1.5寸，针刺得气为度，四肢部配穴按实则泻之，虚则补之的原则进行，留针30min。每日1次，15次为1个疗程，疗程间隔3天，治愈为止。

眩晕症是多种疾病的共有症状，诸如高血压、低血压、神经官能症、颈椎病、脑震荡等病均能出现此症，以及某些药物发生毒性及不良反应者亦多出现此症。矩阵针灸治疗眩晕症，是在头的上下和左右及前后对称选穴，用八穴方形成阵式以包围头脑部位进行针刺，这有助于神经高级中枢部位的功能障碍得到直接调整，同时改善了植物神经功能失调，降低交感神经兴奋性，提高迷走神经兴奋性，缓解小动脉痉挛，从而有助于血压的改善，并缓解神经官能症及某些药物的毒性及不良反应，而消除眩晕症状。

江某，女，53岁，高级工程师。患头晕、耳鸣10多年，6年前诊断为高血压病后，长期服用降压药，但头晕、头胀痛、烦躁、心悸、耳鸣、失眠一直未减轻。在针灸科就诊时，血压为180/120mmHg，经矩阵针灸治疗（每日1次）25次后，头晕消失，并能睡眠6~7h，血压降至130/80mmHg。评定为近期治愈，随访半年，情况良好。

二、主穴两个 调督益肾

齐建文运用调督益肾法针刺治疗眩晕症，获得了满意的疗效。

取穴：主穴：肾俞（双）、陶道。配穴：伴恶心呕吐者加内关、丰隆、中脘；眩晕较重欲闭目者加印堂、上星；兼颈项强痛者加风池（双）、大椎；伴头重脚轻、耳鸣、听力下降、少寐多梦、口干心慌者加百会、复溜（双）、足三里（双）。

操作：所选穴位常规消毒后，选1.5寸毫针，肾俞直刺1~1.5寸，用捻转及呼吸补法；陶道针尖向下，用捻转提插泻法，使针感

向下传导。所用配穴除肾经俞穴及足三里穴用补法外，其余均用泻法。每日针1次，每次留针30min，其间行针3~5次，10次为1个疗程。

眩晕一证，临床颇为多见，究其病因病机自古有多种说法。如《素问·至真要大论篇》有“诸风掉眩，皆属于肝。”《灵枢·口问》篇“上气不足。”《灵枢·海论》篇“髓海不足。”《丹溪心法·头眩》有“无痰则不作眩。”综合各家之谈，可归结为“风、痰、火、虚”四个方面。但齐建文认为“无虚则不能作眩”是其关键。这里的虚，应以肾虚为主，因为肾主骨生髓，脑为髓海，肾精亏则髓海不足；因肝肾同源，肾阴不足不能滋养肝木，则生火动风；肾主水，肾气充，则水液化，即可避免聚湿生痰。故齐建文治疗眩晕着重调督益肾，因督脉总督一身之阳，即为阳脉之海，功擅熄风清热为治标，通过益肾则为求本之意。其中补肾俞旨在补肾，泻陶道意在调督而达熄风清热之用。经临床反复验证，疗效甚佳。

三、平肝潜阳 息风开窍

眩晕是以头晕目眩为主要临床表现的一种常见疾病，轻者闭目即止，重者如乘舟车，旋转不定，不能站立，或伴有恶心、呕吐、汗出，甚则昏倒等症状。在临床中以肝阳上亢型的病例较为多见。唐亦蓉采用针刺完骨后上穴、百会、内关为主，配合太冲、三阴交治疗肝阳上亢型眩晕病，取得了满意的效果。

取穴：完骨后上穴（经验穴，该穴位于完骨穴后上方，紧靠乳突边缘）、百会、内关；配太冲、三阴交。

操作：按针刺常规操作，捻转进针完骨后上穴，针尖向同侧眼睛方向直刺1.5~2寸，用平补平泻手法捻转，以整个前额部及颜面部有较强胀感为度；平刺百会，针尖向前顶透刺，以头顶部有胀重感为度；太冲穴向涌泉方向斜刺，以足背部有胀麻感为度；用平补平泻手法直刺内关、三阴交得气为度。留针20min，每隔5min行针1次，每日治疗1次，10次为1个疗程。

《素问·至真要大论篇》说：“诸风掉眩，皆属于肝。”肝为风木之脏，体阴而用阳，其性刚劲，主动、主升。若素体阴亏阳盛；或忧郁恼怒，肝阴暗耗；或肾阴虚亏，肝失所养而肝阴不足等，都

会引起肝阳上亢而致眩晕。故治宜平肝潜阳，疏肝解郁，滋阴清热，熄风开窍。完骨后上穴是唐亦蓉在临床中长期治疗眩晕病探索出来的经验穴，位邻足少阳胆经，肝胆相为表里，针刺此穴具有平肝气、潜肝阳、清热开窍、明目醒神、息风除眩之功，故临床中针刺此穴，病人即感头脑清楚、眩晕减轻。百会穴位于督脉，居巅顶正中，为百脉之会，三阳五会之所，具有调平肝气、息风开窍、宁心安神、升清益髓的作用；内关穴位于心包经，有补心宁神、疏理肝气、潜阳开窍等功效；三阴交位于足太阴脾经，有调和气血、培补三阴等功效；太冲穴位于足厥阴肝经，具有平肝潜阳、滋养肝肾、疏肝理气之功。诸穴并用，可平肝潜阳，消除肝阳上亢所引起的眩晕症。

张某，女，43岁。1997年5月8日就诊。自诉于1995年3月与人争吵后，即出现头晕目眩，头胀痛，此后常因恼怒反复发作，眩晕加重，眠差梦多，口苦，大便秘结。经中西医结合治疗二年，疗效甚差。诊见神清，舌红，苔薄黄，脉弦略细，面红目赤等。证属肝阳上亢所致的眩晕证。按上法取穴针刺，一次后诸症明显减轻，10次后痊愈。随访至今未见复发。

四、调补髓海 重镇止晕

刘志顺针刺为主，辨证取穴治疗眩晕，疗效显著。

取穴：主穴：百会、风府、风池、上印堂。配穴：气血不足者加中脘、足三里、太冲；痰浊中阻者加中脘、丰隆、太冲；风阳上扰者加太冲、太溪；肝肾阴虚者加太溪、三阴交。

操作：百会用2寸毫针向后斜刺1.5寸，得到酸胀沉重感为度；风府用2寸针直刺1.5寸，使酸胀感窜向头顶为佳，不留针；风池用1.5寸毫针针尖向对侧眼球刺入1~1.2寸，提插捻转，使酸胀感窜向颞部，不留针；上印堂在印堂上1寸，用28号毫针向下斜刺入骨膜下，务必得到沉重紧涩针感。梅尼埃综合征及高血压所致眩晕，针刺每日1次，其他均每周针刺3次，留针30min。

《灵枢·海论》“髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩暈，目无所见，懈怠安卧”。眩晕，从病因病机上看，虽有痰浊中阻、气血不足、风阳上扰、肝肾阴虚之分，但其根本在于髓海不足，为本虚标实之证。治当调补髓海，宗《灵枢·海论》之法，针补其髓——百

会、风府。风池为手足少阳、阳维之会穴，使针感上于头，可熄风止晕。上印堂为经外奇穴，毫针刺入骨膜下可得到重压紧涩之针感，重能止晕，临床用之，即时疗效很好。

陈某，女，62岁。初诊时间：1992年6月25日。主诉：眩晕欲仆伴耳鸣、恶心呕吐1天。兼症：咽干，目涩，腰膝酸软，舌嫩红少苔，脉弦细。既往曾有两类类似发作史。诊为眩晕（风阳上扰），梅尼埃综合征。治则：调补髓海、潜阳熄风。取穴：百会、风府、上印堂、风池、太冲、太溪。针刺1次，眩晕、恶心呕吐即止，耳鸣等症减轻。第2天续针上穴，诸症均告消失，临床治愈。

五、传统针刺，标本兼治

眩晕是临床上常见的一组证候群，可由多种疾患引起。王光义在辨证论治的基础上，单纯针刺治疗脑供血不足导致眩晕的患者，取得满意疗效。

取穴：主穴为百会、风池（双）、眩晕点（华佗夹脊平颈椎第三椎旁）、三阴交（双）、太冲（双）。

操作：百会平刺，务求酸麻重胀之针感；风池向对侧眼球直刺；眩晕点稍向对侧鼻孔直刺；三阴交直刺；太冲斜刺向涌泉。留针30min，以上其间每隔5min轻捻转行针1次。每天治疗1次，5次为1个疗程。

临床上所见眩晕，一般病程较长，又多本虚标实，故常见虚实夹杂或虚实间相互转化。百会既为强壮穴，又对阳亢气陷有双向调节作用，故取之；太冲配三阴交以育阴潜阳，内庭滋水以制阳光，三穴相配临床多用于降压且效佳；足三里补益正气，眩晕点为经验穴。辨证得当，取穴有的，故效若桴鼓。

患者，女性，71岁。因头昏目眩半月，加重5天于2003年3月2日入院。自述：半月来常头晕目眩，动则加剧，盗汗，手足心发热，烦躁，口干而不欲饮，视物似转动不停，时时恶心欲吐，听力下降。查：神疲懒言，气短声低，面色少华；血压160/100mmHg，舌暗红，苔薄白，脉细弦。头颅多普勒示：椎-基底动脉血流速减慢。诊断：眩晕（肝肾阴虚，肝阳上亢型）。即取百会、眩晕点、风池（此穴及以下穴均取双侧）、三阴交、太冲、内庭、足三里，手法

如上述。每天治疗2次。治疗3天后眩晕明显好转，治疗15天后痊愈出院。随访半年无复发。

六、定眩舒肝 重在手法

赵义祥针刺定眩、舒肝穴治疗眩晕症，获得满意疗效。

取穴：定晕（双侧耳尖上方1cm处）和舒肝（剑突右侧肋缘下1.5寸处）。

操作：定晕采用2.5~3.0寸28号不锈钢毫针快速进针，刺入0.5cm，持续捻转每分钟150~200次，亦可提针向上、下、左、右斜刺入1.5cm，同速捻转约3~4min左右，间歇3~6min，再行捻转，速度及持续时间同前，共操作3次，约25min即可起针。舒肝穴亦用毫针，选定位置快速进针，再徐缓稍轻捻进皮下，猛刺一下不作捻转而迅速起针，此时病人会感到剧痛，乃为针刺“舒肝”穴得气之征。针刺深浅度视病人体质胖瘦而决定，一般针刺进入2寸左右为宜。针刺“舒肝”穴时，停服一切药物，第一次针刺可不受时间要求，待急性主要症状（眩晕、头痛、恶心、呕吐）得到控制或明显缓解后出针，宜上午施针，每日1次。以上二穴施针均以15天为1个疗程，停2~3天再施行第二疗程。

眩晕症可分为肝阳上亢、肾精不足、气血亏虚、痰浊中阻和瘀血阻络等型。定晕穴针刺治疗眩晕症能够通经活络、调和阴阳、醒脑开窍、运通气血、熄风豁痰。舒肝穴能解郁舒肝、健脾实土、条畅气机、承上启下，从而达平肝熄风、降逆止呕、镇静安神以定眩晕之功效。

苗某，女，37岁，教师。因反复眩晕7年余，加重两天，于1991年10月14日来诊。突发眩晕，视物旋转，自觉周围景物在动，需人搀扶，唯恐跌倒，闭目静卧，伴有恶心呕吐，耳鸣如蝉鸣，听力减退，既往一年发作一次或一年数次不等，开始服中药和西药镇静剂效果较好，停药一段时间又复发，曾在其他医院诊断为梅尼埃综合征。查体：患者发育正常，营养中等，神疲懒言，心悸欠寐，面色少华，舌质淡红，苔薄白，脉象沉细无力，纳呆，二便调畅。双目水平震颤，外耳道无分泌物，左耳听力略减退，颈软，心肺肝脾无异常，腹平坦柔软，无病理反射。检验：心电、脑血流图、血

脂、血常规皆正常，颈椎及乳突片正常。中医诊断为眩晕症（气血亏虚型）。以补益气血，养心安神健脾补肾法。针刺双侧“定晕”及“舒肝”，配百会、脾俞、肾俞、关元、足三里等穴采用补法和艾灸。针刺30min后病人恶心呕吐停止，双目可开亦可交谈。次日复诊，耳鸣尚存，头晕稍减，余证大减，1个疗程后精神欣悦，连续治疗3个疗程病获痊愈，随访年余病未复发，二年后路遇告之早已正常上班。

七、实眩十法 虚眩五法

彭静山根据眩晕患者临床表现，将其分为虚实两种。虚证面色苍白，气短，舌微苔，甚者舌边有齿痕，六脉沉细，血压多低。实证面色赤，舌无苔或黄苔，体胖，声音响亮，口干便燥，血压多偏高。

此证发于肝虚或肝郁，前者为虚证，后者为实证，系临床常见的多发病。血压异常的，当先调整血压。

实证眩晕：

（1）人迎洞刺：又名窦刺，其穴在颈外动脉窦。

操作：让患者仰卧，头部低位。先用手掐病人脖子，如患者感到头晕时则不宜用此法。针刺时，左手摸到人迎处的动脉，用手指固定，右手持1.5寸针，刺在动脉壁上，不可过深，易导致起小包。针后见针柄颤动为恰好。不施手法，10s起针，留针最长时间不超过2min。

（2）膈俞皮内针

操作：取膈俞穴找准穴位，埋藏1号皮内针1只，双侧埋针。可留至7天。适应于：胖人及对针畏惧者用之。

（3）耳穴耳背沟

操作：在耳背沟上1/3处有静脉可见，以三棱针点刺，出血如豆许，眩晕立止。

（4）太渊脉刺

操作：找准穴位，用2寸针刺在桡动脉寸口部位当太渊穴。不用手法，见针柄颤动为度，不动可微提调整。刺在桡动脉上，不可过深。留针5~10min。

(5) 眼穴疗法

操作：以5分30号针，刺眼4区即肝胆区，没皮横刺，眩晕不能睁眼者，针入即效。

(6) 针刺印堂、素髻

操作：二穴均用5分针由下向上以15°角斜刺之。

(7) 太冲

操作：针刺得气后，可用提插泻法。适用于肝阳上亢，眩晕较重者。

(8) 合谷透后溪

操作：针刺得气，手臂酸麻为度。适于口苦、便秘、尿赤、舌干、有黄苔，脉数者。

(9) 三里治晕

操作：凡胃脘不适，时常胀闷而发头晕者，针刺足三里，常规操作，以得气为度。

(10) 石门止晕

操作：妇人眩晕，月经不调，小腹不适者，可针石门。但未婚或已婚未孕者，不宜刺石门，可改太溪。

此十法治眩晕实证。血压高者，亦可降压。

虚证眩晕：

(1) 补足三里，常规操作，针刺得气再加蠡沟。

(2) 针刺大椎、陶道、肝俞。

(3) 针刺身柱，达到得气，留针20min，每天1次。

(4) 穴取侠溪、上廉，为上病取下法，可治虚人眩晕，用补法。

(5) 眩晕兼头痛者，太冲透涌泉加育俞有效。

赵某，女，40岁。忽然眩晕，不敢睁眼，卧床不敢翻身。往诊见面赤，脉弦，左关尤甚。诊断为肝郁热致眩。取眼穴刺双肝区，针入病除。

李某，男，53岁。平素体弱，每食后即眩晕。诊见神疲体倦，面黄肌瘦，脉来无力，右关尤明显。按压其三里穴，穴下虚软，是为胃病虚证的病穴，乃刺其足三里，使用补法。1次能增进饮食，2次精神健旺，3次痊愈。

八、滋阴潜阳 化痰降冲

高血压眩晕的临床表现为阴虚阳亢或兼痰湿作祟，以致造成人体正常气血逆乱。《内经》指出，气血并走于上而发为薄厥；张锡纯则责之冲脉之气上逆所致。据以上诸论，高章营治此类疾病的法则当是：滋阴潜阳以平肝，化痰降冲和气血。

主穴：公孙透太冲透涌泉，四神聪，太渊，补复溜泻行间。加减：痰湿盛加丰隆，项强加后溪、风池。

方义与操作：公孙是足太阴脾经的络穴，又是八脉交会穴，通冲脉。能降冲醒神，祛湿化痰。太冲是足厥阴肝经的原穴，能调血气而平肝。涌泉为足少阴肾经的井穴，与足太阳膀胱经交汇，经气通贯，善疗头疾。以上一针可刺三穴，共奏滋肾平肝，降冲醒脑化痰之效。针刺公孙透太冲，得气后，先行逆经补泻手法，以病人能耐受为度。继而深刺至涌泉，得气后，顺经行轻缓徐施插补手法，以病人感到头部轻松为快时即止。补泻施行有度，始能共奏良效。

四神聪为百会穴前后左右手各1寸之经外奇穴，专治头部疾患。进针方向尤其重要，计有四种刺法：①垂直点刺；②巅顶昏闷时，上神聪透下神聪，左（右）神聪透右（左）神聪，均穿越百会；③四神聪相连刺成菱形；④眩晕兼偏头痛或血管搏动者，针尖进入四神聪后，均同刺向患部的对侧。

太渊为手太阴肺经的原穴。当肝木失其条达，郁而化火之时，必反侮肺金；肝经经气循行，周而复始，必下传于肺经。刺太渊能通经接气。宣导经气后，起到解郁泻肝的妙用而防止冲脉之气上犯头目。

补复溜泻行间乃是补母泻子之法的变通。复溜是肾经五输穴中的金穴，金能生水，故复溜为肾经之母穴。于此穴施补法，可滋育肾阴之水以涵养肝木。行间系肝（木）经五输穴中的火穴，亦即肝经的子穴（木生火）。泻行间即能泻肝木之郁火。直折火势而能平其气血之冲逆。补复溜还可燃灸法徐缓自然灸疗；泻行间之灸泻法，却是以口急吹艾之火，让其充分热烈地急速燃烧，此可使肝经郁火借势发越于外。

阙某，男，76岁，退休工人。血压升高达210/100mmHg，头

昏、眼花，终日难以自恃。更兼咳唾清痰涎，难以平卧，呻吟不绝于耳。脉弦细数，舌淡暗苔白厚腻。性情急躁。诊断为眩晕，咳嗽。拟疏肝益肾、化痰宁嗽之法。取穴：公孙透太冲透涌泉，四神聪刺向四周，丰隆，太渊。连续治疗3次，得气后留针均不施行手法，这是由于其年事已高，且体弱的缘故。头昏眩明显减轻，血压稍下降，但咳甚仍喘。大便呈球状，3日未行，守原方法，如刺双天枢，次日得便，咳嗽明显减轻。苔由白厚腻转变为薄白，脉呈弦细而和缓。血压下降160/100mmHg。此后坚持治疗2周，血压稳定，眩晕消失。咳嗽虽减，仍未能根治，随访4月无恙。

九、项丛刺配穴注 标本兼治

眩晕是一种临床常见症状，眩指眼花，晕指头晕，两者并见称为眩晕。陈兴奎采用项丛刺法，配合穴位注射天麻素治疗眩晕，疗效较佳。

取穴：下脑户、风府、哑门、风池（双）为主穴。肝阳上亢配太冲、阳陵泉；痰湿中阻配丰隆、阴陵泉；瘀阻脑络配百会、血海；气血亏虚配三阴交、足三里；肾阴不足配太溪、三阴交；肾阳不足配关元、肾俞。

操作：常规针刺，针刺方向以毫针与穴位皮肤呈垂直，刺入1寸左右，轻度提插，以得气为度。每次留针30min，每日1次，10次为1个疗程，疗程间休息2天。

穴位注射：取足三里、三阴交，足三里穴皮肤常规消毒，用维生素B₁₂1ml和维生素B₁1ml混合，垂直快速进针，当针下有酸、麻、胀感时，回抽无血，则慢慢注入药物，再选用天麻素注射液2ml在三阴交穴位注射。每日1次，10次为1个疗程。

项丛刺法所取部位，主要为督脉经、足太阳膀胱经以及足少阳胆经所行。《灵枢·经脉》曰：“膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额交巅……其直者，从巅入络脑，还出别下项。”《难经》曰：“督脉者，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑。”而后项部深层为脑桥（生命中枢）、交感神经节、网状组织等重要组织，是掌握整体生命功能的重要环节。而天麻素注射液则能增加心血管的血流灌注量，增加脑血流量，减少脑血管阻力，增加椎基底动脉血供，

使小脑前下动脉、小脑后下动脉、迷路动脉、内耳的供血得以改善，两者共同作用，构成治标。临床上本证以本虚标实为常见，维生素 B₁、维生素 B₁₂ 穴位注射足三里、三阴交等穴，有健运脾胃，增补后天之本的功效。因此，此法有标本兼治功效，两者相辅相成，取得较好临床效果。

参 考 文 献

- [1] 金钰钧, 金钰红, 王菊香, 等. 矩阵针灸治疗眩晕症 71 例. 针灸临床杂志, 1994, 10 (3): 42~43
- [2] 齐建文. 调督益肾法针刺治疗眩晕症 38 例. 现代养生, 2002, (6): 19
- [3] 唐赤蓉, 童明鸥, 王娟, 等. 针创治疗肝阳上亢型眩晕 50 例. 四川中医, 1999, 17 (3): 47
- [4] 刘志顺, 张红, 刘军, 等. 针刺治疗眩晕 30 例临床观察. 中国针灸, 1997, (1): 35~36
- [5] 王光义, 梅国胜. 针刺治疗眩晕临床观察. 贵阳医学院学报, 2004, 29 (5): 450~451
- [6] 赵义祥, 赵亚杰, 赵保民. 针刺治疗眩晕证 58 例临床观察. 针灸临床杂志, 1997, 13 (2): 7~8
- [7] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 244
- [8] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 254
- [9] 陈兴奎. 项丛刺配合穴位注射治疗眩晕 48 例. 上海针灸杂志, 2002, 21 (6): 19

【附：颈性眩晕】

一、辨证取穴 疏通经络

颈性眩晕是由颈部原因导致颈椎椎动脉供血不足，使大脑产生一过性缺血缺氧致眩晕的一种临床表现，其主要临床特征是眩晕发生的时间短暂，且具有与体位相关的特点，故临床也叫体位性眩晕。傅云其进行中医辨证及针灸辨证取穴治疗颈性眩晕，疗效显著。

取穴：主穴：双曲池、印堂、百会、足三里。配穴：配穴以中医辨证分型取穴，痰浊中阻型配双丰隆、双间使，气血亏虚型配双三阴交、双内关；肝阳上亢型取双太冲、双太溪；心脾两虚型配以双神门、双血海。

操作：取主穴双风池、双足三里接 G6805 继续波电针刺激，配穴一组以电针刺激，刺激强度以病人适宜为度，每次 30min，每天 1 次，7 天为 1 个疗程。

锻炼：嘱患者避免伏案工作太久，切勿头部突然左右转动，避免卧床看电视书报。平时佐以工间操锻炼：即人体直立，双上肢同时上伸上举并且颈项部做前屈前伸后仰动作，上下午各锻炼 1 次，每次上下活动 36 次。

风池穴乃为足少阳胆经之腧穴，具有清利

头目，疏风定痛定晕之效验，实则为治头部颜面疾患之要穴，印堂穴是经外奇穴，具有镇静安神之功效。百会乃三阳五会，灸之或以电针刺刺激取之以升举清阳之气，引气血上营头目，使奇恒之腑血有所供，神有所归。综上三穴乃为局部取穴，亦是头部疾患之奇功要穴，相互配合，以求疏风定晕、镇静安神、升举清阳之效验，达到脑有所荣，神有所附之目的。再配以多气多血足阳明之合穴足三里，调补足三里以涵养脾肾，滋养气血，得以后天之本生化气血，供应清阳之腑，源源不断。

痰浊中阻型配以丰隆、间使两穴。丰隆穴乃为足阳明胃经之络穴与足太阴脾经相属，取之以健中州、振脾阳、化痰浊、降浊阴。间使乃为手厥阴心包经之经穴，化痰湿，宽胸膈，配主穴除胸闷恶心之兼证。

心脾两虚型配以神门、血海。神门穴乃为手少阴心经之原输穴，针之以安神养心，并主治本脏本腑之疾病；配以足太阴经血海穴以开泄气血生化之源，两穴相配以气有所养，血有所运，共奏健脾养心，安神定志之效验。

肝阳上亢型配以太冲、太溪。太冲穴乃为足厥阴肝经之荥穴，泻太冲以泻其上亢之肝阳，除其头重脚轻，达到敛肝阴，潜肝阳，滋水涵木之功效。

气血亏虚型配以三阴交、内关穴。三阴交为足三阴经之交会穴，针刺三阴交能滋养肝脾肾三阴之经气，肝有所养，脾有所运，肾有所归，配以主穴足三里使其气血生化之源充足，强壮中州升举清阳之功；内关穴乃心包经之原穴，宽胸开膈以治兼证，心有所养，气血得以正常运营。

另外配合颈部后仰后伸功能锻炼以纠正颈项部的生理弧度，增加局部血运，使得血有所供，脑有所养，神有所归，清明安康。

杨某，女，35岁，头晕头痛，恶心泛酸，颈项部酸痛半月。曾经口服中西药未效，遂来针灸科治疗，诊时已拍摄颈椎X线片示：颈椎生理曲度变直，C₄，C₅，C₆椎体骨质增生性改变，钩椎关节增生。TCD检查：双侧椎-基底动脉供血不足。刻诊：患者头晕目眩，脸色微苍，头痛耳鸣，恶心泛酸，纳差眠欠安，颈项酸痛，偶见手指麻木，月事不规，且色淡而稀，舌质淡苔薄白，脉细弱。此为气

血亏虚之证。治疗取主穴双风池，双足三里接 G6805 断续波电针刺激，并针刺印堂，百会。配穴内关、三阴交以电针刺激，刺激强度以病人适宜为度，每次 30min，每天 1 次，7 天为 1 个疗程。治疗后症状明显改善。后嘱咐颈椎功能锻炼。

二、温针颈夹脊 温阳补气

椎动脉型颈椎病主要表现为眩晕。颜少敏采用温针灸颈夹脊穴治疗颈椎增生性眩晕，取得了较好的疗效。

取穴：颈夹脊穴，每次取 2 对穴位。

操作：患者取俯坐位，局部穴位经严格消毒后，取 31 号 1 寸毫针刺入，行平补平泻手法，针刺得气后，在针尾套上 1 寸长艾炷，艾炷燃尽后取针，并于针刺处拔火罐 5min，15 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 天，再进行下 1 个疗程的治疗。

颈性眩晕属中医学痹证范围，与气虚、血瘀有关，构成“本虚标实”、“虚中挟实”的病理特征，正如《医林改错》中所述“元气既虚，必不能达于血管，血管元气，必停留而瘀”。治疗应以温阳补气，活血化瘀为主，穴取颈夹脊，行平补平泻手法，针刺得气后，针尾上加艾炷灸，针刺与艾灸效应同时作用于穴位，共奏温阳补气，活血化瘀之功效。

郑某，女，48 岁。1993 年 7 月 18 日初诊。头晕目眩，食入则吐 20 余日，自诉前阶段因操劳过度引起头晕目眩，食入则吐，7 月 2 日至 15 日以转动头部或侧弯头部而加重，曾到当地医院住院治疗，诊断为颈椎骨质增生，经治疗效果不明显，现转来要求用针灸治疗。刻诊：眩晕，面色淡白，神倦乏力，心悸少寐，舌暗边有瘀点，脉涩，四诊合参此为气血亏虚，瘀血内停型眩晕，治拟补益气血、活血化瘀，采用温针灸夹脊穴治疗 3 个疗程，痊愈。

三、针刺配刺络拔罐 行气活血

程小平采用针刺配合刺络拔罐治疗颈性眩晕，取得较好效果。

取穴：风池、百会、颈夹脊穴为主。

操作：常规消毒后，取风池穴向对侧眼球方向刺入 1.5 寸；百会平刺，颈夹脊向脊柱方向斜刺 1 寸；均用平补平泻手法，得气后，

百会、风池不留针，颈夹脊留针 30min 并接 G6805 电针仪。每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

刺络拔罐：取大椎穴，常规消毒，以三棱针点刺出血，并予局部拔罐，留罐 20min，隔日 1 次。

针刺风池有迅速缓解头晕、恶心、头项强痛的作用；针刺颈夹脊可直接疏通患部气血；百会醒脑利窍；大椎为诸阳之会，颈项部为督脉与足太阳经所过之处，故大椎刺络拔罐具有舒筋活络、祛瘀散寒、行气活血的作用。本法所取诸穴和施用的方法，可以改善脑部的血液循环，增加血流量，故能收到较为满意的结果。

张某，女，45 岁，2001 年 4 月 2 日初诊。诉 2 月前出现头晕目眩，头部转动时加重，伴有恶心、颈部强痛。曾做理疗及牵引治疗，无明显改善。检查：椎动脉扭曲试验阳性，TCD 检查椎-基底动脉供血不足。诊断：颈性眩晕。用本法治疗 2 次后，患者诉症状明显减轻，但椎动脉扭曲试验阳性，3 个疗程后，患者症状消失，椎动脉扭曲试验阴性。随访半年未复发。

四、针推并用 宣通气血

颈性眩晕指颈椎及其相关软组织发生改变，使椎动脉受刺激（或受压），导致脑供血不足而出现的证候群。周建新采用针刺、推拿治疗颈性眩晕，疗效满意。

取穴：百会、双风池、相应颈部夹脊穴、双悬钟、双太溪。

操作：嘱患者取俯卧位，胸部垫枕，双手重叠垫于额部，暴露出后颈部。皮肤常规消毒，取 28 号 1~2 寸毫针，其中风池用 1 寸毫针，针尖向鼻尖方向，进针 8 分，产生针感后，用平补平泻手法行针 1min 后留针；取颈部病变部位双侧夹脊穴，用 1 寸毫针，针尖向椎体方向斜刺 8 分，持续行针 1min，使针感向头顶部放射；百会穴用 2 寸毫针，针尖沿头正中中线由后向前平刺，持续行针 1min；其余各穴皆直刺，用平补平泻手法行针约 30s 即可。得气后于颈部穴位的毫针上接电针仪，用断续波留针 30min。每天治疗 1 次，10 次为 1 个疗程。

推拿：患者取坐位，医者用拇指、中指指腹同时按揉双侧风池穴 1min；从风池穴到颈根部，用拇指指腹与食、中指对称用力拿捏

颈脊柱旁开 1.5 寸处的软组织，由上而下操作 5min；用拇指指腹按揉风池穴 30s；在两侧肩胛分别施用滚法，每侧 2min；一手托住下颌，一手扶住枕部，做颈左、右旋转活动，每侧转动 10 次（要缓缓而行）；一手扶住前额，一手扶住颈项部，做颈后伸 10 次；一手扶住枕部，一手扶住颈项部，做颈前屈 10 次；一手扶住肩部，一手放在头侧，做颈左、右侧弯，每侧 10min；一手托住下颌部，一手托住颈后枕部，用力持续牵拉，方向与颈椎纵向一致，以微微能拉动患者躯体为度，一般持续 1~2min 即可，禁用暴力，应均匀、有力。再用滚法施于两肩胛 3min，最后按揉太阳、百会、内关、攒竹、耳门、听宫、听会等穴，每穴 1min。每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

中医学认为，颈性眩晕多因肝阳上亢，痰浊内蕴，肾精不足，气血亏虚，瘀血阻络，上扰清窍或清阳不升，髓海失养所致。华佗夹脊穴附近有相应的脊神经后支通过，针刺其可减轻病变部位对交感神经的刺激，缓解椎动脉痉挛，改善脑部血液循环；风池为足少阳胆经腧穴，又是手少阳三焦、足少阳胆、阳维、阳跷脉之交会穴，居于脑后，有通经活络、调和气血、醒脑开窍、明目益聪之功，取双侧风池穴可直接促进局部血液循环；头为诸阳之会，而百会居于头府之巅，又是手三阳经与督脉之交会穴，可清热开窍、平肝熄风、健脑宁神。推拿手法可平衡阴阳，宣通气血，温通经络，滑利关节。针刺、推拿联合应用，疗效满意，值得推广应用。

患者，男，42 岁，2005 年 9 月初诊。主诉：阵发性眩晕 1 年余，复发加重 10 天，伴恶心欲呕，视物旋转，行走不稳，影响工作和生活。曾长期服用中成药治疗，效果不明显。查体： $C_4 \sim C_6$ 椎体压痛，头颈部后伸时眩晕加重，舌淡，苔白腻，脉滑。颈椎 X 线片示：颈椎生理曲度变直， $C_4 \sim C_6$ 椎体唇样改变，椎间孔变窄。诊断：颈性眩晕。治疗：取 $C_4 \sim C_6$ 夹脊穴、双风池、天柱、悬钟，配以丰隆、中脘，毫针针刺，同时配合颈项部推拿手法。2 个疗程后，症状消失。半年后随访无复发。

五、小醒脑针法 祛痛止晕

颈性眩晕是由于颈椎病而引起的一种继发性眩晕，属椎动脉型。李智采用“小醒脑”针法配合推拿手法治疗颈性眩晕。

取穴：采用“小醒脑”针法：风池、完骨、天柱、四神聪、印堂、上星、百会。

操作：风池、完骨、天柱以 28 号毫针，针向喉结，进针 1~1.5 寸，双手同时行针，施用小幅度高频率捻转补法，每对穴行针 1min；四神聪，针向百会，进针 0.5~0.8 寸；印堂，向鼻根部斜刺 0.3~0.5 寸，施用雀啄泻法 30s；上星、百会沿皮平刺，进针 0.5~1 寸，施用捻转泻法 30s，留针 20min。

推拿：取穴同上，循督脉、足少阳胆经经脉依次用点、拿、揉、擦、拔伸等手法，各种手法每穴 1min，反复进行 3 次。

脑为元神之府，藏神，脑聪则神明，神明则五脏百骸气血充盈，活动正常，阴阳平衡，百病不生。“百病之始，皆本于神”，故治病亦宜先醒其脑，护其神，进而达到扶正祛邪，提高治疗效果。

“小醒脑”针法是天津中医学院第一附属医院石学敏教授创立的针对部分神志病变及头面部疾患的治疗方法。临床观察，通过针刺风池、完骨、天柱，可以显著改善椎-基底动脉的供血状态，使脑血流量增加，缓解血管平滑肌的痉挛，调动局部乃至全身的代偿因素，改善脑血管的自身调节系统，提高脑灌注压，从而保持脑血流量的相对稳定，进而改善机体内环境，增加抗病能力。上星、印堂、百会、四神聪具有开窍醒神、祛痛止晕之功。配合推拿手法以活血通络、养脑安神。总之，“小醒脑”针法配合推拿手法共奏益脑填髓、醒脑养神、开窍缓急、祛痛止晕之效，最终达到治愈疾病、恢复机体的目的。

六、傍刺天柱 疏调营卫气血

朱国祥在临床中运用傍刺天柱穴为主治疗颈性眩晕，临床获得肯定疗效。

取穴：双侧天柱、双侧 C₅~C₇ 夹脊、百会、后溪、束骨。

操作：穴区常规消毒后，用华佗牌 32 号 1.5 寸不锈钢毫针快速垂直刺入一侧天柱穴，深度 0.8 寸，行快速提插捻转手法 1min，或以患者穴位局部出现明显的酸、胀、麻等感觉为度；然后在天柱穴下 0.3 寸处向上 45°角再刺一同样毫针，快速刺入皮肤，进针深度 1 寸，行快速捻转手法 1min，或以患者出现酸、胀、麻、烘热感向枕

部传导为度。用同样的方法再刺另一侧天柱穴。其他穴位均施常规针刺快速捻转手法，以局部出现针感为度，静留针 30min。上述治疗每天 1 次，每周持续治疗 5 次，休息 2 天，治疗 2 周为 1 个疗程。

天柱穴属膀胱经，位于枕后，解剖位置与枕动脉分支、枕大神经干密切相关。《铜人腧穴针灸图经》论述道：“天柱，今附治颈项筋急，不得回顾，头旋脑痛”，说明天柱穴早已被认为治疗眩晕兼项强痛的要穴。颈性眩晕的临床特征中包括眩晕和颈项强痛的症状，根据《灵枢·官针》“傍刺者，直刺傍刺各一，以治留痹久居者也”。傍针刺被认为有疏调营卫气血的作用，选取天柱为主穴傍针刺治疗，能祛邪通瘀，加大刺激量，增强通督脉、膀胱经之气，健脑活络，祛瘀通痹。

七、经络辨证 局部取穴

颈性眩晕是颈部骨质或软组织发生病变，引起椎 - 基底动脉供血不足所致。督脉、足太阳膀胱经和足少阳胆经为分布于颈项部的重要经脉。常青据“经脉所过，主治所及”的原理进行经络辨证治疗颈性眩晕，取得良好疗效。

取穴：百会、玉枕、风池、颈百劳、头针晕听区。

操作：患者坐位，趴在椅背上。选 30 号毫针，常规消毒后进针，选用 G6805 型电针机，取同侧风池、颈百劳连 1 对电极，玉枕、头针晕听区连 1 对电极，选疏密波，以患者能耐受的最大、舒适刺激量为度。留针 30min，每日 1 次，连续 10 天为 1 个疗程。

颈性眩晕是由于颈椎退行性变而引起的一种继发性眩晕，临床主要表现为椎动脉供血不足，属中医学“眩晕”范畴。该病大多由于患者骨质退变，或颈部劳损，或感受风寒湿邪，以至颈部经脉不畅，络脉瘀阻，脑髓因气血津液不能上承而致眩晕。《难经·二十八难》“督脉者，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑。”《灵枢·经脉》膀胱足太阳之脉“其直者：从巅入络脑，还出别下项，循肩内，夹脊抵腰中，入循膂，络肾，属膀胱。”由此可见督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经均循行颈项部，入脑。督脉循行于头顶、项后，足太阳膀胱经循行于头顶第一侧线、项后，足少阳胆

经循行于头颞、项侧。取督脉与三阳经交会穴百会，调理、振奋全身阳气，阳气充足，经脉通畅则气血上行，滋养脑络。足太阳膀胱经为多气多血之经，取其玉枕穴及位于膀胱经上的经外奇穴颈百劳共奏疏通经络，调和气血，濡养筋骨之效。使颈项部经脉通畅，气血上荣于脑。足少阳胆经属木，其气外发，取位于足少阳胆经上头针晕听区、风池穴，可升发阳经之气血，使之上充于脑，髓海得养。诸穴合用使颈项部受阻之经脉气血通畅、上行，脑髓充益而晕止。

八、独取大椎 重在手法

徐福采用针刺大椎穴治疗颈性眩晕患者，疗效满意。

取穴：大椎。

操作：患者坐位，略低头取大椎穴，常规消毒，取1.5寸毫针1枚，用指切进针法进针，进针深约1~1.2寸（视患者胖瘦而定），捻转，幅度要小而频率快。待患者有酸胀感时，再略进针少许，常有触电感，以放射至枕部为佳，即退针少许。如此刺激3~4次后留针40min，此时嘱患者慢慢活动颈部（以左右转动为主），并用周林频谱仪照射颈部。每日1次，10次为1个疗程，共治疗2个疗程，疗程间休息5天。

颈性眩晕属中医眩晕范畴。气血运行不畅，脑窍失养为其基本病机，而以清气不升、气滞血瘀者占多数。督脉总督一身之阳，大椎穴为阳脉所聚，针刺可升一身之阳气。气行则血行，气血通畅，脑窍得以滋养，故眩晕可愈。

针刺大椎穴时，进针不可过深，也不必强求有放射感，但务必有酸胀感。另外，从治疗前后X线片的改变看，颈椎生理曲度变直者，经治疗后往往可恢复至正常弧度，而对骨质增生及韧带增厚、变性者，则几无改变。因此推测针刺大椎穴后，可引起颈部软组织的良性改变。

九、针刺配穴注 随证施证

颈性眩晕属中医“眩晕”范畴，本病多由于劳损、外感风寒湿邪以及脑动脉硬化等所致颈部曲线改变。而颈椎骨质增生是以椎间盘、关节韧带退行性改变，促使颈椎发生代偿增生引起颈椎的内外

失衡,增生物直接或因对其周围软组织的过度刺激而发生局部损伤性炎症,直接刺激、压迫颈神经、血管、脊髓而产生的一系列症状。郭准采用针药结合治疗颈性眩晕,疗效较理想。

颈项夹脊穴、风池、百会、后溪、悬钟,留针 30min,间断行针 2 次,其中针刺夹脊穴时,针感向上肢放射为最佳,30min 后取针。合并高血压患者,配以大椎穴三棱针点刺放血,加拔罐 5min,每日或隔日 1 次。合并心悸、出汗、恶心呕吐者,针刺内关、膻中、合谷等穴,在针刺治疗基础上,均采用丹参注射液 20ml 加 5% 葡萄糖注射液 250ml 内静脉点滴,每天 1 次,或将丹参注射液 10ml 注入颈部痛点:嘱患者轻微活动颈部,抬双臂,术者按压痛点,每穴注入 1~2ml,隔日 1 次,并于临睡前口服西比灵片 10mg/次,每天 1 次,每 20 天为 1 个疗程。

针刺颈项夹脊穴及相应疼痛反射区穴位,可有效降低神经应激功能,从而缓解颈部组织的紧张程度,促使局部循环通畅,改善动脉供血不足。丹参注射液有活血化瘀的功能,针药的双重作用使椎-基底动脉血流速度明显改善,血管弹性和有效血流量增加,从而达到临床治疗目的。

吴某,男,56 岁,教师。近日因工作繁忙感头颈僵硬,双上肢酸痛。2 天前突感头痛、头晕伴恶心呕吐、出汗,曾有猝倒发作,遂来本院就诊。刻诊:痛苦面容,精神差,呕吐不止,不能睁眼,颈项活动受限,双上肢感发麻,舌质淡红,苔薄白,脉弦。摄 X 线片示有明显 C₄₋₆ 钩椎关节增生,椎间隙狭窄、变形、脑血流检查有椎-基底动脉供血不足,西医诊断为:椎动脉型颈椎病。中医诊断为:眩晕。证属:痰瘀内阻、清阳不展。治拟:1 寸毫针针刺颈项夹脊穴,针感向双上肢放射,配以双内关、悬钟,留针 30min,并按压痛点,注入丹参注射液 1ml,每次注射 2 个痛点,隔日 1 次,经上述处理 4 天后症状缓解,又继续治疗 6 次后症状完全消失,随访 1 年半未见复发。

十、综合治疗 功效卓著

颈型眩晕属中医学的“眩晕”范畴。陈述列通过综合治疗,疗效显著。

取穴：百会、双侧风池、 $C_4 \sim C_7$ 夹脊，适当配头维、曲池、合谷、内关、丰隆等。

操作：患者取俯卧或背靠式坐位，保持颈部舒适及松弛，穴位常规消毒后，用 30 号 1.5 寸毫针，百会向后顶方向沿皮平刺 1.2 寸，双侧曲池， $C_4 \sim C_7$ 夹脊直刺 1 寸，捻转得气后，用上海华仪 G6805-2A 型电针治疗仪，连续波，强度以病人能耐受为度，留针 20min，每天 1 次。

药物：头晕严重者予 5% 葡萄糖 250ml 加复方丹参注射液 20ml 静脉点，5% 葡萄糖 250 ml 加刺五加注射液 20ml 静脉点滴。中药治疗以清热化痰、活血祛风通络、滋养肝肾为法。予温胆汤加减：陈皮 6g，姜半夏 10g，姜竹茹 12g，茯苓 15g，泽泻 12g，枳实 15g，川芎 6g，天麻 10g（先煎），石决明 30g（先煎），白芷 12g，羌活 10g，全蝎 6g，枸杞子 15g，钩藤 12g（后下），白蒺藜 12g。痰浊盛，加胆南星、石菖蒲；风寒偏盛，去竹茹，加防风、细辛；肝肾偏虚者，加熟地、山萸肉、鹿角霜。

针灸百会、颈部夹脊穴能畅通督脉、太阳经气而调和阴阳。现代研究表明：针灸颈夹脊穴可以纠正颈椎病所致的椎动脉血液动力学的紊乱，改善血流速度，提高脑血流量。陈述列应用温胆汤加天麻、枸杞、钩藤、石决明等取得良效，正是从中医风、火、痰、湿、虚的病机确立处方用药的。患者功能锻炼，亦可放松颈肌、改变颈椎间盘位置，促使颈部血液循环、炎症的吸收，恢复颈椎稳定的动力学平衡。

女，75 岁，渔民，于 2001 年 5 月初诊。患者由家人搀扶就诊，不能坐位，语气低微乏力。由家人代诉：反复头晕 20 年，加重 2 个月。近 2 个月患者头晕、视物旋转、呕吐胸闷、四肢乏力，在当地诊所吊针吃药，未见好转，反复更医数次，症状未减反而逐日加重，伴失眠，胃纳差，大小便正常。体查：心率 80 次/min，心音较弱，血压 98/60mmHg，颈肌紧张， C_5 、 C_6 椎棘突右偏，棘突旁压痛，颈部旋转时头晕加剧。心电图：未见异常。颈椎 X 线片示：颈椎生理曲度向后反弯， C_5 、 C_6 椎体唇样变， C_{4-5} 、 C_{5-6} 、 C_{6-7} 椎间隙狭窄，钩状关节突变尖，颈椎椎体骨质疏松。先给予复方丹参注射液、刺五加注射液静脉点滴，再针灸。患者治疗后头晕好转，头脑转清，

嘱其回家卧床休息，并开上述中药带回家煎服，第二天患者能由家人陪伴自己徒步就诊，并诉头晕好转过半，能入睡，胃纳佳，再用上述方法（去静脉点滴），并指导颈部活动，治疗2周而痊愈，嘱其坚持颈部功能锻炼。随访患者至今未复发。

十一、独取大杼 温针灸

张挺运用大杼穴温针灸治疗颈性眩晕，取得理想疗效。

取穴：双侧大杼穴。

操作：常规消毒，然后用指切进针法，将28号2寸毫针刺入，手法用三进三退先泻后补法，进针深度是根据病人体态胖瘦，从0.5~1寸不等。使针感向头顶传导，或向肩臂放散为佳。再取艾炷1寸长点燃，插于针尾，离皮肤0.8~1寸，灸2壮，约30min，以皮肤潮红为度。每天1次，5次为1个疗程，隔2天行第二疗程。

颈性眩晕大都由颈椎曲度变直，下颈段钩椎关节增生，相应椎间孔狭窄，引起椎动脉嵌压，脑供血不足所致。发病以中老年为多见。中医辨证多属肾水亏损，骨髓空虚，脑海失养，以致眩晕。大杼穴是骨之会穴，手足太阳经交会穴。其内上方是椎动脉盘曲经过之处。温针灸大杼，既能温通头部诸阳之经脉，使紧张强直的颈项部肌肉放松，又可扩张血管，增加脑血流量。温针灸大杼还有壮骨生髓健脑的作用，治疗眩晕要比单用针刺效果好。针刺进针时应注意针尖的方向要靠脊柱，并向于头侧，以三步缓慢进针，多用捻转补法，使经络产生热传导向头部放散。温针灸以皮肤透热潮红而不烫伤为原则。

参考文献

- [1] 傅云其. 颈性眩晕的针灸治疗. 针灸临床杂志, 2005, 21 (7): 28
- [2] 颜少敏, 颜亚红. 温针灸颈夹脊穴治疗颈椎增生性眩晕 193 例. 陕西中医, 1996, 17 (9): 418
- [3] 程小平, 马志芳, 李翠萍. 针刺配合刺络拔罐治疗颈性眩晕 58 例. 现代中医药, 2002, (3): 24
- [4] 周建新. 针推结合治疗颈性眩晕 64 例. 中国民间疗法, 2003, 15

(3): 23 ~24

- [5] 李智. “小醒脑”针法配合推拿治疗颈性眩晕临床观察. 河北中医, 2004, 26 (2): 124 ~125
- [6] 朱国祥, 岳红, 陈华德. 傍刺天柱穴为主治疗颈性眩晕疗效观察. 中国针灸, 2003, 23 (11): 665 ~667
- [7] 常青. 经络辨证针刺治疗颈性眩晕疗效观察. 广西中医药, 2005, 28 (3): 24
- [8] 徐福, 霍文璟. 针刺大椎穴治疗颈性眩晕疗效观察. 湖北中医杂志, 2003, 25 (3): 47
- [9] 郭准. 针药结合治疗颈性眩晕 42 例. 陕西中医, 2003, 23 (3): 266
- [10] 陈述列. 中药配合针刺治疗颈性眩晕. 时珍国医国药, 2005, 16 (1): 50 ~51
- [11] 张挺, 庞国军. 温针灸大杼治疗颈性眩晕 120 例. 浙江中医杂志, 2000, (7): 305

【胸 痹】

胸痹是指胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气，喘息不得卧为主症的一类疾病，轻者仅感胸闷如窒，呼吸欠畅，重者则有胸痛，严重者心痛彻背，背痛彻心。

本病的发生多与寒邪内侵，饮食不当，情志失调，年老体虚等因素有关。其病机有虚实两方面，实为寒凝、气滞、血瘀、痰阻，痹遏胸阳，阻滞心脉；虚为心脾肝肾亏虚，心脉失养。在本病的形成和发展过程中，大多先实而后致虚，亦有先虚而后致实者。但临床表现，多虚实夹杂，或以实证为主，或以虚证为主。

针灸治疗本病，以手少阴、厥阴经穴为主，佐以背俞穴，随证加减；或艾灸膻中穴；有人取华佗夹脊等，均能取到一定疗效。

一、证分三型 辨证取穴

王锐采用辨证取穴针刺治疗冠心病心绞痛，取得了满意效果。

取穴：肾元亏损型：①肾俞、心俞（左）、厥阴俞（左）；②关元、内关（左）、太溪。脾胃虚弱型：①脾俞、心俞（左）、厥阴俞（左）；②气海、内关（左）、阴陵泉（右）、三阴交（右）、足三里（左）。肝郁气滞型：①肝俞、心俞（左）、厥阴俞（左）；②期门（左）、

曲泉（左）、太冲（左）、内关（左）。

操作：各型患者均先俯卧位针①组穴，然后仰卧位针②组穴，每组穴均留针20min。其中肾俞、关元、脾俞、气海施烧山火或捻转补法，太溪、阴陵泉、足三里、三阴交施捻转补法，肝俞、期门、曲泉、太冲施捻转泻法，其余穴位皆施平补平泻法。每日针刺1次，每周5次，12次为1个疗程，观察1~3个疗程。观察期间要求患者逐渐停减其他抗心绞痛药物，心绞痛发作时可舌下含化硝酸甘油。

冠心病病位在心，但肾为先天之本，脾为后天之本，肝主疏泄、调畅气机；故该病之根本虽在肾与脾，但同时与肝密切相关。本病初起或偏于阴，或偏于阳，日久多阴损及阳，阳损及阴，终致阴阳同病，因此阴阳并调应是针刺治疗冠心病的一个重要原则，其体现为腹背侧腧穴同取，阴阳经腧穴并用等。脏腑或经脉病证的取穴方式是单取，还是双取，单取时取左侧，还是右侧，则是由脏腑经脉的气机运行特点决定的。《素问·刺禁论》曰：“肝生于左，肺藏于右”，《素问·咳论》曰：“脾咳之状，咳则右胁下痛，阴阳引肩背”。另外从脉象分候五脏的规律中也可以得到启示，寸关尺三部脉象分候五脏，《素问·脉要精微论》提出左手分候心、肝、肾，右手分候肺、脾、肾，因此心、心包的背俞及手少阴心经、手厥阴心包经和足厥阴肝经的腧穴多取左侧，而手太阴肺经、足太阴脾经的腧穴多取右侧，足少阴肾经的腧穴多双侧同取。相表里的手足三阳经腧穴则与之相反，即手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经的腧穴多取左侧，足太阳膀胱经的腧穴多双侧同取。此种取穴方式也体现了针灸用穴宜少而精，力专效宏的特点。

二、辨证分型 据证选穴

冠心病，对中老年人危害很大，发病率也逐年增多。王希湘根据中医理论，按针刺治疗冠心病的特点分为：阴虚、阳虚、气虚、痰阻、血瘀五个基本类型。如各型症状相兼者，谓之兼型，如气虚痰阻型。采用针灸治疗，效果满意。

取穴：主穴分两组，交替使用。第1组：心俞（或夹脊穴）、巨阙、心平（少海穴下3寸）。第2组：厥阴俞、膻中、内关。配穴：阴虚型配三阴交或太溪；阳虚型配关元或大椎；气虚型配气海或足

三里；痰阻型配丰隆或肺俞；血瘀型配膈俞或血海。

操作：背部穴针尖斜向脊椎，深度 0.5 ~ 1 寸，得气后刮针 2min；四肢穴直刺，要求有酸、麻、胀等得气感觉后，留针 20min。每日或隔日针 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 ~ 5 天。

中医学认为经络是运行气血的通道，如气血运行不通则产生疼痛。心绞痛是心经、心包经气血运行迟滞的表现，王希湘采用心经、心包经的俞募配穴及心经、心包经上的穴位，进行针刺治疗起到通经、活络、疏导两经气血的作用。由于经络气血运行畅通，因而心绞痛得以缓解，改善冠心病病人的心脏功能。

李某某，男，59 岁，干部。初诊日期：1988 年 7 月 9 日。主诉：心慌、胸闷、心前区阵发性绞痛 5 年余。多在劳累时出现，并放射至左侧肩背部，每次发作持续 5 ~ 10min。有高血压病史。血脂检查：胆固醇 200mg%，甘油三酯 210mg%，心电图示：ST 段，V₅ 水平下移 0.05mV，T、V₃、V₅ 倒置，aVL 低平，诊断为冠心病，高血压病，遂开始针刺治疗，三个疗程后症状改善，心电图显著好转，ST 段下移恢复，T 波由负变正。1 年后随访，仍巩固在针后水平，坚持工作。

三、艾灸膻中 择时施治

刘柄权临床采用艾灸膻中穴治疗胸痹，常收显效。

取穴：膻中。

操作：用艾条悬灸，每次 30min，每日 1 ~ 2 次，5 天为 1 个疗程。停灸 1 天后可以进行第二个疗程。艾炷灸，每次灸 10 壮，每日 1 ~ 2 次，5 天为 1 个疗程，停灸 1 天后可进行第二个疗程。每壮如花生米大，用火点燃艾炷尖端，直到患者有灼热感。如患者不能忍耐时，即用镊子除去艾炷。灸治完毕可涂油剂以保护皮肤。患者前来灸治最好选择午时（11 ~ 13 点）阳气最旺时，可以提高疗效。

膻中是足太阴脾经、足少阴肾经、手少阳三焦经、手太阳小肠经及任脉之会穴，又是八会中之气会穴。为人体宗气之所聚。这就说明膻中能治疗多经引起的胸痹疾患，尤善调理气机不畅，灸治能通阳散寒，温通经脉，消痞止痛。故无论何因引起，取该穴治疗均有疗效。

陈某，女，28岁，工人。自述胸中痹痛四个月，且日益加重，多方治疗无效，不能坚持工作而求诊。见形寒，肢冷，面色苍白，气短，脉缓，舌淡胖大，苔薄白，诊为阳虚寒阻而痛。治以艾条悬灸膻中穴，每日1次，午时（11~13点）灸治。二诊症状稍有改善。灸治3次痹痛明显减轻。五诊痹痛痊愈，形寒、肢冷亦大为减轻。一年后随访再未复发。

苏某，女，42岁。自述胸中不适，有压迫感，痛有八个月，因与邻居吵架心情不舒所致，曾到医院检查心肺无异常，经治无效。不能参加劳动。患者呈慢性病容，精神忧郁，面色苍白，脉弦滑，舌淡、苔薄白。诊为气机不畅，寒阻而痛。治用艾炷灸膻中穴，每日1次，每次10壮。灸治3次，胸痛明显减轻，压迫感渐消。四诊时基本无痛，压迫感已除，同法灸治，五诊症状消失痊愈。

四、针灸并用 立时见效

盛伟采用针灸方法治疗心悸、心绞痛患者，疗效显著。

取穴：心阳不振型：针内关、心俞、膻中、郄门，灸极泉。水气凌心型：针心俞、巨阙、膻中、内关，灸丰隆。瘀血阻络型：百会、神门、内关、郄门、三阴交、膈俞。心肾阳虚型：心俞、肾俞、关元、气海、足三里，灸涌泉、极泉。

操作：在急性发作时令患者平卧位放松针刺，针后5min行针1次，一般行针2次。平时治疗取坐位，一般双侧取穴，以左为主，穴位常规消毒后针刺，大部分患者行针刺后3~5min缓解，一般留针20~30min。艾灸10min后，患者自觉胸中有热感，20min后心中豁达，疼痛减轻或消失。

心悸、心绞痛是因夹寒、夹瘀、夹气滞、夹热等因素造成心脉瘀阻，心失所养。故出现心慌、心悸、心绞痛。针灸有运行阴阳、调解气血、行气化瘀之功。方中，取心之俞募穴巨阙以通阳调气，膈俞理气行血化瘀、宽胸利膈以通心脉之瘀阻，内关为手厥阴心包经络穴，八会穴之一。郄门是厥阴肝经郄穴，是心包经经气深聚的地方，可调畅心经之气机、宽胸理气止痛，极泉系少阴心经之首穴，针加灸可以温阳通络、化气行水、除湿，温养心脾肾之阳气，心悸疼痛自然解除。

张某，女，57岁。心悸已3年多，但不影响工作及正常生活，近因劳累心悸加重，并伴有心前区疼痛，几秒钟后缓解，但心前区疼痛仍频频发作，开始10min发作1次，继而3~5min发作1次，患者自觉心跳过速，动则尤甚，不敢移动，心电图ST波改变，电轴左倾，心肌供血不足，心动过速，心率113次/min。来诊时主诉：心慌、心悸，伴有胸闷气短，心前区疼痛，面色无华而微青，唇微紫，舌质黯紫，舌有瘀斑，脉沉涩而疾，一息6~8次。诊断：心悸、心绞痛。治宜补气养血，化瘀通络。处方：主穴：内关、郄门、膻俞、关元、三阴交。配穴：极泉、足三里。手法：平补平泻，5min后运针1次，极泉进针时避开腋动脉，进针1~1.5寸，用补法（烧山火），后用艾条灸针刺穴位，以左侧为主，患者自觉左胸有温热感，心胸豁达，疼痛减轻，心悸缓解，心率80次/min，灸10min后，基本恢复正常。连针10天，症状如常人，但活动过多或劳累时偶发1~2次心悸，每次3~5s，连针20次痊愈，5年后随访未复发。

五、针内关膻中 加然谷放血

贺普仁认为胸痹发生以心阳不振，瘀血内阻为主要矛盾，又与肝、脾、肾三脏有密切关系。治疗则应以调补阴阳、理气活血为原则。常取内关、膻中、然谷（放血），有时可以立即止血，缓解症状。

然谷，是足少阴肾经之“荣穴”，心经与肾经为同名经，胸部又为肾脉所过，刺然谷放血可祛胸中之瘀血，调畅胸中之气机，振奋阳气而止痛。内关，是心包经“络穴”，别走少阳之经，又为阴维脉之八脉交会穴。《难经》曰：“阴维为病苦心痛”。后人对四总穴歌补充云“胸胁内关谋”。内关能宽胸理气，治胸部的一切疾患。临床实践中，很多患者针内关后，首先感到胸中宽畅。膻中为任脉穴，“气会膻中”，故具有很强的调畅气机作用，气行则瘀血自通，胸痛可消。

贺某，男，54岁。1985年冬谈话间突然左心前区疼痛憋闷，胸有紧迫感，四肢凉，心乱不安，随即倒卧于床上，脉结代不整。证系心阳不振，气滞血瘀，脉道不通。治以强心通脉，活血化瘀。取

内关、膻中，然谷放血。下针后疼痛马上减轻，胸闷消失，然谷放血后心律不齐有所改善，但仍有三五不调。起针后半小时诸症消失，骑车回家。一周后家访，诉类似症状未再发作。

六、穴位旋转走罐 通经活络

曲祖贻用穴位旋转走罐法治疗胸痹取得较好疗效。

取穴：左胸心前区膻窗、乳根。

操作：准备2号玻璃火罐2个（1个备用），先将洗脸盆倒进热水半盆，再将火罐放进热水烫热，右手先将火罐放在左胸膻窗穴，再放乳根（左）穴的皮肤上，分别各向右方轻轻旋转100次，共计旋转200次，然后用间接法，在衬衫外面左胸膻窗和乳根部位上各旋转200次，前后共计旋转600次。操作时应注意，旋转速度要不快不慢，最好以1秒钟3下为合适。只在皮肤和衬衫外面轻轻旋转，不能重按。

穴位旋转火罐，是一种外治的急救法。有通经活络、活血化瘀、加强心脏功能的作用。将温热火罐在心前区穴位连续旋转活动达600次之多，使瘀者开，痹者通，缺血者补充，因而对胸痹心痛，在短时间内通过温阳通痹作用而获得满意的疗效。

于某，男，55岁，教师。因校务繁忙，授课劳累，突发心绞痛而住院，一日发作多达6次，发作时胸闷憋气，心悸气短，面色苍白，说话无力，时而虚汗，脉搏细弱。乃采用穴位旋转走罐法进行治疗，依法连作3次，汗出、胸闷憋气均好转，心痛亦逐渐缓解。治疗4次，诸证消退，心痛再未发作。

七、补泻兼施 标本兼治

朱海霞采用针刺内关等穴治疗冠心病心绞痛，疗效满意。

取穴：内关、郄门、膻中、厥阴俞、心俞、膈俞。

操作：常规皮肤消毒，穴取内关、郄门，直刺1寸，捻转补法1min，令针感向肘部放散；膻中，迎经向下斜刺1min，捻转泻法1min，令针感向两胁放散；厥阴俞、心俞、膈俞，向椎体方向针刺1.5寸，施捻转泻法1min，令针感沿肋间向前胸放散，每日针刺1次，留针30min，10天为1个疗程。针刺期间原则上不使用任何扩

冠药物，允许临时舌下含服硝酸甘油或异山梨酯。

朱海霞经过多年临床研究，认为该病病机以虚为本，以实为标，心气不足、胸阳不振、推动不利、血行不畅是该病病机的关键，治疗则应扶正祛邪，标本兼治，以益心气、通心阳、养心血、通心脉为治疗大法。故选用心包经之络穴内关、郄穴郄门以益心气、通心阳、养心血、安心神。气会膻中，泻之可行气通痹、振奋胸阳；心俞、厥阴俞，为心经、心包经之背俞穴，补之，可调养脏腑精气；膈俞为血之会穴，补之，可养血活血、通脉养心。诸穴合用可调理心之气血阴阳，使之趋于平衡，临床收效显著。

八、丘墟为主 辨证配穴

冠心病心绞痛属于中医学胸痹、真心痛范畴，刘来丽以针刺丘墟穴为主治疗冠心病心绞痛。

取穴：主穴为丘墟。配穴：血瘀型加膈俞；痰浊型加丰隆或肺俞；气滞型加阳陵泉；阴虚型加太溪、三阴交；阳虚型加大椎、关元；气虚型加气海、足三里。

操作：主穴选用 30 号 2.0 寸毫针，常规消毒后，直刺丘墟穴 1.0 ~ 1.5 寸，并施捻转泻法 2min，每隔 10min 行针 1 次，留针 40min，以针感循经上传为佳。配穴选用 30 号 1.0 ~ 1.5 寸毫针，常规消毒后，平刺或直刺 0.5 ~ 1.2 寸，提插捻转得到针感后，留针 20min。背俞穴得气后，刮针柄 1min 不留针。

历代医家认为，心脾肾等脏腑虚损，功能低下或失调是发生心绞痛的本虚之因，血瘀、气滞、痰凝是引起心绞痛的标实之因。刘来丽结合长期临床实践及现代医学知识，根据“经脉所过，主治所及”的道理，因足少阳胆经脉“……以下胸中贯膈，络肝，属胆……”，“其直者……循胸，过季胁……”，而丘墟又为足少阳胆经原穴，取之治疗本腑之病，又和“上病下治”之意。针用泻法，可收通阳泄浊、化瘀通脉之功效。按辨证取穴法选取配穴，通过针刺治疗，使心脉之阴虚、阳虚、气虚得补，血瘀、痰浊、气滞得以消除，起到标本同治作用，从而缓解心绞痛的发生。

九、益心气 通心阳

稳定性心绞痛是冠心病中常见的一种类型，常佩芬观察稳定性心绞痛病人，发现针刺治疗可明显改善患者症状，减少硝酸甘油用量，且没有不良反应。

取穴：①心俞、厥阴俞；②巨阙、膻中，两组均加双侧内关、郄门、神门、膈俞。针刺治疗期间如有心绞痛发作，可以含服硝酸甘油。

操作：选用30号毫针，除内关直刺进针1.5寸外，其他均直刺进针0.5~1.0寸，用捻转补法1min，留针30min，每天1次，两组交替进行。

冠心病心绞痛属中医胸痹范畴，其病机为本虚标实。本虚多为气虚、阳虚，标实有血瘀、气滞、寒凝、痰阻。而稳定性心绞痛的病机多属心气不足、胸阳不振、血运不畅，因此治疗上可采用益心气、通心阳、养心血、畅心脉的治疗原则。常佩芬选取的内关为心包经的络穴，郄门为心包经的郄穴，均具有益气通络、宽胸理气、宁心安神之效；心俞、厥阴俞分别为心经、心包经的背俞穴，可益心气、调心血、助心阳、散寒邪，与心之募穴巨阙穴俞募相配，调心气化瘀血；膻中为八会穴之一，气会膻中，故可行气通络、振奋心阳；膈俞亦为八会穴之一，血会膈俞，故可养血活血、养心通脉。

李某某，男，64岁，2004年4月20日就诊。主诉：间断性前胸憋闷7年。明确诊断为冠心病，稳定性心绞痛。平日服用倍他乐克12.5mg，每天2次，每周发作胸闷约3~5次，每次均需口服硝酸甘油，每周约2~4片。心电图： $V_3 \sim V_6$ 导联ST段压低2~3mV，T波倒置。经针刺治疗2周后，胸闷发作明显减少为每周0~1次，发作时无需再口服硝酸甘油。心电图： $V_3 \sim V_6$ 导联ST段压低1~2mV，T波低平。

参考文献

- [1] 王锐. 辨证针刺治疗冠心病心绞痛42例. 中国针灸, 2003, 23 (5): 280
- [2] 王希湘. 针刺治疗冠心病362例. 中国针灸, 1994, 增刊: 13~14

- [3] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 201
- [4] 盛伟, 石玉环. 针灸治疗心悸心绞痛 256 例疗效观察. 实用中医内科杂志, 2003, 17 (2): 141
- [5] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 201
- [6] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 202
- [7] 朱海霞. 针刺“内关”等穴治疗心绞痛 60 例临床观察. 针灸临床杂志, 2004, 20 (10): 38 ~ 39
- [8] 刘来丽, 赵红鹰, 刘丹华. 针刺丘墟穴治疗冠心病心绞痛 50 例分析. 中医药学刊, 2004, 22 (4): 721 ~ 722
- [9] 常佩芬. 针刺治疗稳定性心绞痛 30 例体会. 针刺研究, 2005, 30 (1): 50 ~ 52

【心悸】

心悸是由心失所养或邪扰心神，致心跳异常、自觉心慌悸动不安的病证。本病多呈阵发性，也有呈持续性者。可伴胸闷胸痛，气短喘息，或头晕失眠等症。

心悸的形成，常与心虚胆怯、心血不足、心阳虚衰、水饮内停、瘀血阻络等因素有关。平素心气怯弱或久病心血不足之人，骤遇惊恐，则“心无所依，神无所归”，心神不宁而为心悸；如思虑过度，劳伤心脾，既耗伤心血，又影响脾胃生化之源，致气血两亏而成心悸；若饮食伤脾，痰湿内生，或肾阳虚衰，不能蒸化水液，聚而为饮，则痰饮上犯，水湿凌心，心阳被抑而心悸；若心阳不振，血液运行不畅，或久患痹证，邪气内侵于心，而使心脉痹阻，气滞血瘀，而成怔忡。

针灸治疗该病大多以安神镇静，养血宁心为治则。从治疗方法上，有的单用针刺法，有的针灸并用，有的耳穴刺激，眼针心区等。针灸治疗心悸不仅能控制症状，而且对疾病的本身也有调整和治疗作用。但在器质性心脏病出现心衰倾向时，则应及时采用综合治疗措施。

一、穴取心包经 气至病所

阵发性室上性心动过速为临床常见的心律

失常之一。李澎近年采用针刺疗法治疗该病，收到较好效果。

取穴：内关、大陵、足三里、人迎。

操作：双内关穴直刺0.5~1寸，施捻转补法，令针感逆经上传向大臂及心胸方向；双侧大陵穴向手掌方向斜刺3~5分，令针感向掌部放散；足三里穴直刺0.8~1.2寸，施提插捻转补法0.5min；人迎穴（左侧）直刺1~1.5寸，令针感直达前胸，甚或心前区。每日针刺1次，每次留针20min，10次为1个疗程。

针刺采用的穴位以厥阴心包经穴为主。内关穴为心包经的络穴，是八脉交会穴之一，常用于治疗心胸疾患，针之有益气养心、宽胸通阳之功；大陵为心包经俞穴，有调和气血、清心宁神之效，该穴尚有双向调节作用。此两穴均属心包经，心包为心之外围，有代心受邪、代心行令作用；足三里调胃理气，使精微得化，心脉得濡；针刺人迎穴具有增加心输出量、降低心肌耗氧量、扩张冠状动脉的效果，即所谓“气至病所”。诸穴合用，可益气养血，镇静安神，以奏奇效。

患者刘某，女性，67岁，因左半身不遂7天于2001年8月12日入院。既往有冠心病史10余年，常感胸闷、心悸，间断服用速效救心丸、活心丹等，入院作心电图检查示侧壁、下壁心肌缺血。入院诊断：中风，心悸。患者病后情绪欠佳，肝气不舒，入院第十天因恼怒诱发胸闷、心悸、头晕，无汗出、肢冷，心电图示阵发性室上性心动过速，心电监护示心率200次/min，立即吸氧后针双侧内关、大陵、足三里，施捻转提插补法，并针左侧人迎，针后即感胸闷、心悸减轻，5min后心电显示窦性心律，心率83次/min，提示针刺复律成功。

二、三阴交 - 内关 先后针刺

马向明采用针刺治疗阵发性室上性心动过速，取得较理想疗效。

取穴：内关和三阴交。

操作：患者仰卧位，先针三阴交，后针内关。三阴交向对侧直刺0.5~1寸，进针后留针不动；内关向对侧刺0.5~0.8寸，施捻转手法，左右两侧同时捻转，持续行针至心率减慢后，留针15~30min。

阵发性室上性心动过速属中医惊悸、怔忡范畴，其致病原因多由于忧思过度，气血亏损。气不足则心不能自安，血不足则心失所养。内关为心包经络穴，主治心胸及血液循环系统的病证，有强心、镇静和安神的作用。《针灸甲乙经》云：“心澹澹而善惊恐，内关主之”。三阴交亦为足三阴经之会穴，肝藏血，脾统血，肾经与心经又有密切关系，若心肾不交，则惊惕不安，心跳加快。故针三阴交能活血养血，滋阴降火，减慢心率。内关与三阴交相伍确为治疗本病的良方。

三、缓慢进针 控制针感

高镇五认为本病的发生主要和患者心气虚弱，感受风寒湿邪，恣食肥腻烟酒，痰浊瘀血阻遏心阳有关，也有因忧思恼怒惊恐而引起。常在劳倦、外感、情志失和、饮食失节等情况下诱发。心电图检测常为心律失常或冠心病可疑等。

取穴：内关、神门、心俞、厥阴俞（或夹脊 $T_4 \sim T_5$ ）为主。每次选1~2穴为一处方，交替选用。伴阴虚者加三阴交、安眠。痰瘀阻遏心阳者加膻中、足三里。心阳虚衰者加素髻、关元。

操作：毫针刺用疾徐补法，或补法为主结合短促泻法。选直径0.23~0.28mm，长1.5寸毫针，迅速刺入皮下后，缓缓进针，“得气”宜缓，针感舒适，一般留针5~30min。初诊，二诊时留针时间宜短，以后逐渐延长。发作时留针时间宜长，平时为预防发作或巩固疗效留针时间可短。脉象迟缓者，留针5~15min，脉数、频发结代者，须留针20~30min。本虚标实者，留针过程间歇给予短促的中等或较强刺激2~3次。注意不宜突然或持续给予强刺激。素髻穴毫针刺皮刮针柄1~2min，1次/s。胸痛明显、畏寒、肢末发冷，踝部浮肿者，艾条温和灸15~30min。背俞穴可拔火罐10~15min。每日或隔日治疗1次，8~10次为1个疗程。如未愈，隔5天左右继续下1个疗程。患者在治疗期间和初愈不久，切勿疲劳，睡眠必须充足，避免受凉，预防感冒，节制肥腻烟酒，饮食不可过饥过饱，注意情志修养，避免精神刺激，这有利于巩固疗效，预防复发。

顾某，女，48岁。心悸怔忡，不能自控，胸闷，气短，乏力，间有失眠、头晕，病起已年余，舌尖红、苔薄白，脉沉细，频频结

代。心电图检查为频发室性期前收缩，呈二联律。辨证为心悸怔忡，气阴两虚。取内关、神门、安眠。针用疾徐补法，徐缓得气，针感弱而舒适，间歇动留针20min后出针。患者当时即诉心悸已无，胸闷消失，即时心电图复查已明显好转。每日针灸治疗1次，自觉症状稳定好转。治疗6次后，自觉舒服，心电图复查正常。为巩固疗效，续治4次，结果。4个月后随访，在正常上班。

四、经验选穴 眼针心区

怔忡是临床常见的疾病。坐卧不安，气短，心跳，稍一运动即心跳加速，甚则脉见结代，睡眠不安，日渐虚弱，心区特别难受。彭静山采用眼针心区治疗，疗效较佳。

针灸治疗方法：

- (1) 循经取穴，选用心经的原穴、合穴。
- (2) 大椎、陶道加神堂。
- (3) 心俞脊穴。
- (4) 眼针心区。

刺法：眼针心区穴在眼眶边缘外2分许，以30号5分长不锈钢针，左手把眼皮扒紧压住，右手持针，由经区交界沿皮横刺至皮下，不宜再深。虚证宜顺时针方向，实证则宜逆时针方向刺之。进针稍快，留针5min，起针宜缓缓拔出，急用消毒干棉球按压1min。

宁某，男，48岁，技术员。心跳间歇，自觉怔忡不安，周身疲倦，不能工作。病已很久，经治不效。1980年5月20日来诊。主诉：心区常觉难受，出现间歇脉时，自己有感觉。诊得脉来无力，左寸尤甚，时有结代，每分钟停10余次，停时病人感到非常难受。看查眼心区络脉弯曲，颜色鲜红。治疗：在眼的双心区刺入5分针两支，再诊脉则已由针前50次/min，变为60次，每分钟间歇3次。自觉症状显著减轻。以后每隔4~5天来诊1天，治法相同。1个月后，看眼心区络脉变细色淡，脉无结代现象。半个月后因运动过度，发生反复。脉又出现结代，每分钟间歇2次。又按前法治愈。嘱其劳逸适度，睡眠更宜充足。今已数年，电话随访，一切正常。

孙某，男，58岁。由于工作劳累，经常心跳盗汗，身体渐形虚弱。诊见形态较胖，面色微赤，舌无苔而近似阴虚舌，六脉沉细，

左寸尤为显著。诊为心阴虚型怔忡。取穴：大椎、陶道、阴郄。用28号2.5寸毫针，对穴直刺，深入两椎之间，刺至针尖有抵抗，病人脊背觉放射状酸麻感。经治疗数次痊愈。应当注意如针下有空虚感，是有伤脑膜之虞，宜急提出，调整方向，使针体垂直，深入抵脊为度。每次以大椎、陶道为主，多汗者加阴郄；睡眠不佳，则加神堂，效果良好。病情较重者，可刺心俞，以针尖向督脉偏斜靠脊椎横突之间刺入，以针下有抵抗感为度，其效颇佳。

五、独取内关 调整心率

阵发性室上性心动过速简称室上速，是内科常见病，部分病人通过刺激迷走神经即可终止，但仍有相当部分病人采用上述方法无效，胡广银应用针刺内关穴治疗，疗效满意。

取穴：内关。

操作：患者取仰卧位，常规消毒后，用28号1.5寸毫针，直刺双内关穴0.5~1寸，得气后施平补平泻手法，同时注意心率变化，当降至正常即停止行针，留针20min。

室上速在中医学属心悸、怔忡、心痛等范畴，针刺治疗具有简便、快捷、灵验的特点。内关为手厥阴心包经腧穴、络穴、八脉交会穴之一，通阴维脉，具有改善冠脉循环、改善心肌缺血、调整心率的作用。《甲乙经》卷七载：“……实则暴心痛，虚则烦心，心惕惕不能动，失智，内关主之。”针刺对心律的调整作用基本是一种由穴位针刺所引起，通过植物神经系统而进行的体表—内脏性反射活动。很可能穴位针刺既可以通过脊髓侧角交感神经链到达内脏器官引起心脏的节律失常，又可以在脊髓等处抑制内脏器官包括心脏的病理性传入冲动，从而纠正某些心律失常。

徐某，女，46岁，教师，有高血压、冠心病史，1998年6月23日就诊，诉心悸、胸闷、头晕，自服异搏定片80mg，并行颈动脉窦按摩、诱发呕吐等，症状未改善，3h后就诊，心电图示室上速，心率214次/min，依上法针刺，10s后顿感轻松，测心率82次/min，留针20min，随访2月未发。

六、安神镇惊 养血宁心

王宗学治疗惊悸，以安神镇惊，养血宁心为原则，若兼有痰者，佐以健脾和胃、涤痰之法，阴虚火旺者，佐以滋阴之法。

取穴：主穴：①内关、神门、中脘、气海、足三里。②心俞、肝俞、胆俞、脾俞。兼见痰积配丰隆，用泻法；胸闷不舒配腋中。头晕、失眠配百会、风池。阴虚火旺配太溪，用补法。耳穴：心、神门、皮质下、交感、脑干。

操作：根据“急则治其标”的原则，惊悸发作时，先针内关、神门、心俞、肝俞，用捻转补泻之泻法，配合耳穴贴王不留行籽。先探准穴位，然后将王不留行籽用胶布贴于穴位，嘱患者每日按压3次，3日更换1次，惊悸稍稳定后按上方常规治疗。主穴两组交替使用，每日1组。中脘、足三里、气海、胆俞、脾俞用补法。

张某，男，56岁。因撞车而致左上肢运动障碍，四肢及腰部麻木，头晕，失眠，惊悸，食欲减退。后惊悸逐渐加重，常常惊恐不安，心惊肉跳，每听到响声如关门、人喊、音乐等声音即心慌气喘，大汗淋漓，甚至不能平卧，因而导致彻夜不眠，烦躁不安，饮食日减，经检查心、肺、肝、胃均无异常发现。临证所见，患者消瘦，面黄无华，证如前述，脉象弦细无力，舌苔薄白。依上法治之，先探测耳穴，心、神门、皮质下、脑干、交感，贴压王不留行籽，然后针刺内关、神门，用泻法；中脘、气海、足三里用补法。当晚惊恐减轻，可以入睡。次日针心俞、肝俞，用泻法；胆俞、脾俞用补法。如此交替针刺10次，惊悸消除，食欲增加，肢体麻木均显著好转，继续治疗5次并配耳穴贴压巩固疗效。经随访未再发作。

七、辨证施治 标本兼顾

心悸即自觉心慌悸动不安，多见于神经官能症以及心律失常。朱慧勤多年来对心悸患者运用针刺疗法，辨证施治。

取穴：分为两组：①内关、神门、足三里、三阴交；②心俞、厥阴俞、脾俞、肾俞。心胆气虚型：加肝俞、胆俞；心脾两虚型：加公孙；心肾不交型：加太溪；心血瘀阻型：加曲池、血海；水饮

凌心型：加阴陵泉、膻中；心阳亏虚型：加气海、关元、百会。两组交替。

操作：各穴常规针刺，均施捻转手法，平补平泻，留针 20min，缓缓退出。隔日 1 次，10 次为 1 个疗程，休息 7 天行第二个疗程。

中医学认为本病大多由于忧思过度，气血亏损所致。气不足则心不能自安，血不足则心失其所养。本病主要与心经和心包经有关，故取穴以内关为主，内关为心包经之络穴，主治心胸及血液循环系统的病证，有强心镇惊和安神的作用。三阴交为足三阴经之合穴，肝藏血，脾统血，肾与心两经又有密切关系，若心肾不交，则惊惕不安，心跳加快，故针三阴交能活血化瘀，滋阴降火。足三里是足阳明胃经之合穴，为多气多血之穴，刺之能达气血双补之功效，且本穴对循环系统有良好影响，刺之可出现血管先收缩而后舒张的双相反应，可引起心率减慢，对心脏功能有调整作用。又神门为手少阴心经之原穴，《百症赋》：“发狂奔走，上腕同起于神门。”故内关、三阴交、足三里、神门 4 穴相配，为治疗本病之良方。取相应的背俞穴，因其位置与相应脏腑相近，作用与相应脏腑相通，能有效调节脏腑功能。十二经脉“本”在四肢，“标”主要在背俞，故同取四肢经穴与背俞穴，两者结合，以达到标本兼治的目的，取得其良好的疗效。

参 考 文 献

- [1] 李澎. 针刺治疗阵发性室上性心动过速 51 例. 中国中医急症, 2004, 13 (12): 800
- [2] 马向明. 针刺治疗阵发性室上性心动过速 68 例. 中国民间疗法, 1996, (4): 21
- [3] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 194
- [4] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 195
- [5] 胡广银. 针刺内关穴治疗阵发性室上性心动过速 8 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (5): 44
- [6] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 198
- [7] 朱慧勤. 针刺治疗心悸的临床疗效观察. 上海针灸杂志, 2002, 21 (3): 9~10

【头 痛】

头痛是由于肝阳上亢、痰瘀互结而致清阳不升，或浊邪上犯、清窍失养造成的以头部疼痛为主要表现的病证。疼痛部位多在头部额、颞、巅顶，或左或右辗转发作，或呈全头痛。疼痛的性质多为跳痛、刺痛、胀痛、昏痛、隐痛，或头痛如裂等。本病常为隐袭起病，逐渐加重或反复发作。每次发作可持续数分钟、数小时或数日，也有持续数周者。

本病之病因，不外乎外感和内伤两大类。外感六淫，风邪为长，上犯巅顶，阻遏清阳，而致头痛。五志过急，郁而化火，肝阳上亢；或肾阴素亏，水不涵木，风阳旋扰；或饮食受伤，痰湿内生，上蒙清空，阻遏清阳，均可致头痛。气血不足，肾精久亏，脑髓空虚也可致头痛。至于跌仆外伤，久病入络，脉络瘀阻，则不通则痛，发为瘀血头痛。

对本病的治疗，大多采取循经取穴与辨证取穴相结合，有刺血拔罐者、有梅花针叩刺者、有埋针者、有针药并用者。针灸治疗该病疗效显著，对某些功能性头痛能够达到治愈的目的。对器质性病变引起的头痛，针灸也能改善症状，但应同时注意原发病的治疗，以免贻误病情。

一、大椎为主 刺血拔罐

头痛，病因很多，霍则军根据“不通则痛”的理论，采用刺血拔罐治疗，获较理想疗效。

刺血拔罐：取穴大椎，先拔1个火罐，10min后取下，在拔罐处留下的印迹中，用医用采血片快速均匀点刺6~12下，再在原位拔1个火罐，留罐10min，出血约2~8ml。

辨证选穴针刺：前额疼痛加印堂、中脘；巅顶部疼痛加百会、太冲；后头部疼痛加至阴、透刺双侧风池；颞侧部疼痛加丝竹空透率谷、足临泣；全头空痛加太溪、足三里。以上治疗每天1次，5次为1个疗程。

头痛病因虽多，但归根到底，不外乎在各种致病因素作用下，局部气血运行障碍所致，即“不通则痛”。治疗上，应以通经活络，畅通气血为根本大法。霍则军多年体会，对于头痛，可选用放血法治疗其局部经络不通之“果”，若是实证，可多针深刺，出血量较多，可直接去瘀血、泻热毒、清肝火。若是虚证，宜少针浅刺，可激发局部经气，引经脉之气加速运行至此，改善局部气血运行之状况。选大椎穴，因大椎乃督脉要穴，诸阳之会，是全身之气血灌注头部必经之处，调节该穴，对人体头部与身体的气血通行有重要的影响，且该穴操作简便，先拔罐再刺血可减轻局部痛感。在治疗局部气血不通之“因”时，配合体针以去除其“因”，如肝阳上亢，可针太冲等平肝降逆；痰浊阻络，可针中院以泻中焦之浊。“因”“果”俱除，不但能迅速止痛，且能长时期不再复发。

王某某，男，45岁，1997年7月4日来诊。主诉：左侧头痛3天。患者3天前突发左侧头部剧痛，呈搏动性，以侧后部为重（风池穴外上处），伴恶心、呕吐、烦躁，曾于单位卫生室行针灸治疗两次，取穴合谷、太阳、风池，疼痛仅缓解半小时，又呈持续性疼痛。患者面色苍白，舌黯舌尖红，苔薄黄，脉弦有力。诊为瘀血头痛。取大椎穴放血拔罐，出血约8ml，左侧丝竹空透率谷，左风池透右风池，留针30min，行强刺激泻法。起针后，疼痛大减。2日后复诊，诉回家后疼痛减轻，疼痛由持续性变为间断性，可有数小时间歇，但低头吃饭或看报时会诱发疼痛加剧。依前法针3次痛止，又

针2次以巩固疗效，随访1年未复发。

二、刺血为主 辨证施治

付爱民采取灵活的治疗原则，以刺血为主，同时综合运用其他疗法，如：毫针疗法、艾灸疗法、拔罐疗法、七星针疗法以及按摩、理疗、药疗等治疗各类头痛，而不拘泥于一法一术的单独使用，以快速取效，彻底治愈为目的，均获得了满意效果。

前额头痛：上星刺血，揉按睛明（双），毫针刺印堂、合谷（双），二穴热泻寒补，解溪（双）平补平泻。

偏头痛：太阳刺血（双），毫针头维透曲鬓，远端取穴刺列缺（对侧）、侠溪（双）。

后头痛：以大椎为中心，用七星针叩刺半径约5~10cm的圆面，以出血为度，并加拔火罐。毫针刺列缺、后溪（二穴用互刺法，即头项强痛严重一侧的对侧取穴）、昆仑（双），并做颈项按摩治疗，纠正颈椎强直等。

巅顶头痛：首先重灸百会，然后针刺艾灸大椎，并使针感上达巅顶，针后拔罐。以出少许血液为好。远端取穴行间、太冲、至阴。

外感头痛：少商、商阳刺血，毫针刺风池（双）、合谷（双）、曲池（双）、足三里（双）。同时，将短波或超短波电疗机两电极板分别置于患者腰部和太阳区（背部大椎至至阳与两肩胛骨之间），以汗出黎黎为度（大约需40min）。往往1次而愈。

颅内占位性病变引起的头痛：泻涌泉，补列缺，手法宜重，针感要强烈，并向头部放散为好。百会、头维刺血，并长时间温灸百会穴，毫针取丰隆、曲池、风池（双侧）。并积极配合活血化瘀、软坚散结的中药治疗。

注意事项：①刺血时，一般多采用三棱针或梅花针叩刺，毫针刺后再拔火罐出血为宜。并严格无菌操作。②虚寒证多灸。热证刺血约1ml以上，实寒证刺血3~5滴。③头部刺血后，必须仰卧休息5~10min（头低于肩背或不枕枕头）。④不论何种头痛，刺血后，最好再用毫针针刺列缺穴（仰卧体位，对侧或双侧取穴），效果更好。⑤刺血后，如需再取其他穴位，最好在平卧体位进行，以防血晕或晕针，也有利于气血运行的改善。⑥每隔2天刺血1次，其间可每

天1次毫针治疗。每10天刺血3次为1个疗程，休息5天，再进行下1个疗程。

头为诸阳之会，髓海所在，根据《素问·针解》篇中所说：“菀陈则除之者，出恶血也。”又《灵枢·官针》云：“络刺者，刺小络之血脉也。”说明在人体的特定部位之青紫脉络中，刺出少量血液或淋巴液，就能治疗经脉壅滞、血瘀不通的疼痛或麻木性疾病。达到活血消肿泄闭、通经活络之目的。从而消除郁滞血脉中的邪气恶血。这也是“扬汤止沸”之意，是遵“疾在上者，越而出之”之旨。

列缺穴为手太阴经“络穴”别支入阳明经。又为八脉交会穴，通于任督，功能宣肺疏风、通经活络、醒脑开窍。头为精明之府，中医藏象学把脑的生理和病理统归于心而分属五脏，故大脑有心之精神意识和思维的统领功能。手阳明经、任督二脉又上通于头项及面部，列缺穴为这些经脉的“络穴”和“会穴”。所以列缺穴有通调颈项之气血的作用，可解除颈项等处的肌群紧张状态，扩张脑内的血管，从而改善供血功能。刺血后，让病人仰卧，刺列缺穴，也能更好地调节颅内血管供血，弥补由刺血或紧张等因素引发的颅内供血不足。

远端取穴，是治疗头痛的重要环节之一，以对侧或上病下取为取穴原则。可引血下行，并能升清降浊。达到平衡体内气血、阴阳的目的。

张某某，男，34岁，东阿县百货公司会计，于1995年4月21日来诊。主诉：头痛，以左侧太阳穴区，前额及眼眶疼痛为主。头胀如裂，视物变形成双或为蓝色，眩晕不得坐卧，不能饮食，食入即吐。自述自学生时期即开始头痛，频繁发作，服西药无效，只有针灸可暂时缓解，严重影响生活工作。近两天因感冒头痛加重，至针灸科求治。查体：神志清楚，面色苍白，晦暗无华，身体清瘦单薄，前额及太阳穴压痛，瞳孔略小，稍有畏寒怕冷之状。颈软、颞部动脉跳动不显，口角及面颊无喎斜，血压113/68mmHg，体温37.6℃。舌质瘦薄紫暗，苔白滑略腻，脉沉细而涩。印象：寒凝血瘀之少阳头痛。治以：取左侧太阳穴区之青紫脉络，用三棱针点刺出血约1cm，刺血完毕，病人即感头痛减轻。再让病人仰卧，并在

太阳区及腰部做短波电疗机治疗，同时取右侧列缺穴。约40min后，患者背部及头额汗出浆浆，自感头清眼亮，精神爽快，如去重负，头痛大减。以后每天1次毫针治疗，取穴合谷（双）、足三里（双）、丰隆（双）、解溪（双）等。共治3次（3天）而愈。1年后随访，自诉未再发生严重头痛，感冒时也只有头晕感，且身体较前丰润，面色光华有彩，工作生活大为顺利。

三、辨证合辨病 针刺加埋针

殷之放以辨证结合辨病，运用针刺加埋针治疗血管性头痛，有良好的近、远期疗效。

取穴：患侧风池、阿是穴（头部疼痛最明显处）和三阴交。

操作：风池穴向对侧眼眶直刺约1.3寸，阿是穴向同侧太阳穴透刺约1.0~1.5寸，捻转进针，得气后再捻转1min，三阴交穴直刺约1.3~1.5寸，留针3min，每隔10min行针1次。隔日治疗1次，10次为1个疗程，可连续治疗2个疗程。

埋针：取患侧太阳穴和悬钟穴，可选一穴，亦可交叉使用。取麦粒型皮内针，局部常规消毒后，以镊子夹持皮内针柄，对准腧穴，使针体与经脉走向垂直，沿皮下横刺约0.5~1.0cm，针柄留于皮外，用胶纸固定，留针2~4天。可连续治疗2个疗程。

血管性头痛属中医学头风范畴，多因肝气郁结，化风或化火，致肝胆经气不畅，久则成瘀而发。风池穴属足少阳胆经，有清热疏风，活血安神之功，三阴交穴为足三阴之会，能益肝理气、健脾化血、补肾填精，阿是穴透太阳穴为治疗头痛经验穴，能疏通经气、镇痛宁神。为巩固和提高临床疗效，殷之放尝试配合皮内埋针，取患侧太阳穴祛风止痛和健侧悬钟穴疏肝通络，运用平衡针法，“左之右，右之左”，由经络直达病所，发挥和维持效应，改善血管功能，调节气血运行，起到标本兼治的作用。针刺加埋针疗法治疗血管性头痛有良好的近、远期疗效，是一种较为理想的治疗方法。

患者，女，38岁，工人。2001年3月初诊。左侧头痛8年余，头痛时有发作，与经期、情绪和劳累有关，甚则恶心呕吐，面色苍白，畏光流泪，长期服用西比灵等药，发作时服“去痛片”等以求缓解。近1月来头痛发作频繁，痛如针刺，呕吐畏光，冷汗淋漓，

在外院诊断为“血管性头痛”，服药未能减轻。来诊时头痛剧烈，面色苍白，汗出如注，舌质红，苔薄黄，脉弦略数。脑血流图示左侧脑供血不足。即按上法取风池、阿是穴和三阴交穴针刺，并取患侧太阳和健侧悬钟穴，交叉埋针。治后头痛大减，诸症皆轻，3次后头痛缓解，7次后头痛等症悉除。续治3次巩固疗效后复查脑血流图正常，随访1年半未见复发。

四、四关为主 辨证配穴

朱赤采用四关穴为主治疗血管性头痛，疗效满意。

取穴：合谷、太冲。肝阳上亢者加行间，侠溪；痰浊内阻者加中脘、丰隆、内关；气血亏虚者加足三里、三阴交、气海、关元；肾精不足者加肾俞、太溪；气滞血瘀者加血海、行间；偏头痛甚者加太阳针刺放血。

操作：患者平卧，取合谷、太冲，局部常规消毒，用28号1.5寸毫针快速刺入约1寸，得气后强刺激，留针60min，出针时开大针孔，使之出血更好。配穴依据病证虚实，施以补法、泻法或平补平泻法，隔天针刺1次，10次为1个疗程。

血管性头痛属中医学头风范畴，是由经气不畅、血瘀所致。四关穴均为原穴，是脏腑经络中原气驻留的部位。合谷属阳，主气；太冲属阴，主血，气血相合，阴阳调和。针之可起行气活血化瘀之功效。本法治疗血管性头痛，方法简单，取穴少，容易掌握，用之得当，效如桴鼓。

吴某，男，46岁，工人。1993年10月初诊。患者自诉右侧头痛5年余。曾用中西药物治疗效果不佳。近来因情绪不佳疼痛又作，痛如针刺，甚则痛及巅顶或弥漫整个头部。头颅CT报告正常。脑血流图提示：右侧脑血管扩张。诊断为血管性头痛。取四关穴，给予较强刺激，留针60min，捻针4~5次，治疗1次后头痛大减，共针10次，症状完全消失，恢复正常工作，随访半年未复发。

五、远近配穴 重针刺方向

郑洁容采用局部取穴与循经远道取穴相配合的方法治疗头痛，疗效显著。

取穴：主穴取百会、风池。配穴：偏头痛取侠溪、外关、太阳；前额痛取内庭、合谷、印堂、攒竹；后枕痛取昆仑、后溪、玉枕；全头痛取涌泉、太冲。

操作：常规消毒后，以上诸穴除太阳、印堂用直径 0.45mm 粗毫针浅刺放血 1~2 滴外，其余皆用直径 0.30mm 长 1.5 寸毫针。百会针尖向病变方向横刺 1 寸左右，酸胀感传向病变部位。如全头痛，就以百会为中点，针尖向前刺入 1 寸左右，产生针感后退出，留针尖 0.1 寸许于皮下，然后改变针刺方向，即向左、右、后依次刺入；涌泉针尖稍向足跟方向，刺入 0.7 寸左右，酸痛向整个足底放射；风池穴针尖对准鼻尖方向刺入 0.8~1.2 寸，酸胀感向枕上方放射，偏头痛患者取患侧风池，其余头痛都取双侧。头痛剧烈者，可在出针后用醋泡过的吴茱萸碎末外敷涌泉穴 3~4h，疗效更佳。余穴都按常规取穴进针。得气后，配用 G6805 - III 型治疗仪，断续波通电 30min，强度以病人自觉舒适为度。每日 1 次，个别头痛剧烈者，可每日 2 次，并酌情延长留针时间。5 天为 1 个疗程。1 个疗程后，休息 2~3 天，继续第二疗程。治疗期间，嘱病人停用有关中西药物。

头痛是一种常见症状，中医学认为，诸病皆因气血壅滞所致。由于经脉循行受阻，气血运行不畅导致“不通则痛”。百会又名“三阳五会处”，是三阳经和督脉、厥阴肝经交会处，风池位于少阳经，针感散布于偏头部，故取此二穴为主穴。根据经脉所过，主治所及的原则，配用相应的经脉线上的五输穴，达到疏通经脉，调节气血的作用，通则不痛。

陈某，男，65 岁，1993 年 10 月 5 日来诊。主诉：头痛月余，近日加重。脑电图、脑血流图、CT 检查无明显器质性病变。西医诊断为紧张性头痛。数日来连服中、西药物难以奏效，前来针灸科就诊。即针刺百会、风池、涌泉、太冲，得气后，留针 15min 后，疼痛大减，渐渐入睡，家人怕出针惊醒他，要求延长留针时间。故留针 2h 后出针。此后至今一直未发。

六、风池百会 通络止痛

头痛是临床常见的一种自觉症状，可发生于多种急慢性疾病。张忆平运用针灸疗法，风池、百会为主，辨证治疗本病，疗效满意。

取穴：主穴为风池、百会，再根据临床辨证分型，分别配以不同穴位。临床上以外感型、肝阳型及瘀血型多见。①外感型：头痛遇风而发，痛势较剧。配以风府、列缺、外关、合谷诸穴。②肝阳型：头角掣痛，多偏于一侧，或连及巅顶，配以四神聪、太冲、水泉诸穴。③瘀血型：痛如锥刺，经久不愈，配以三阴交、阿是穴。

操作：局部常规消毒，用29号1~1.5寸毫针按辨证分型取穴，快速刺入穴位，针用泻法，外感风寒型及瘀血型加用艾灸头部穴位。风池穴要求使酸胀感放射至头顶部及耳后，百会穴沉胀感向穴位四周放射，每日针灸1次，留针30min，10次为1个疗程，疗程间休息2天。

中医学认为头为诸阳之会，风邪外袭，首当其冲；而足厥阴肝经上会于巅顶，因而肝阳上亢，或肝火上冲均可致头痛。若邪留不去，久必入络，络阻血瘀，致头痛日久不愈，反复发作。百会穴属督脉，居巅顶正中，为三阳五会之所，能清头散风，醒脑开窍，升清降浊，而使络通痛止。风池穴属足少阳胆经，善治一切风邪为患，既能祛风解表，清头明目，又能清肝降逆熄风镇痛。故取以上二穴为主穴。再根据不同证型分别配以风府、列缺、外关、合谷祛风止痛；太冲、水泉滋肾平肝；阿是、三阴交活血行气，共奏通经络、止头痛之功效，使头痛得除。

张某，女，46岁。初诊日期1998年3月15日。主诉：阵发性头部刺痛12年，加重1月。自述于12年前因感受风寒及工作紧张而致头痛，此后反复发作，痛苦难当。曾在某院诊断为“神经性头痛”，经多方治疗效果不显。1月前因遇大风致头痛加剧，以左侧为甚，痛如锥刺，夜间尤甚。舌质暗红，有紫斑，苔薄白，脉弦紧。诊断：神经性头痛。辨证为风寒侵袭，络阻血瘀，治以祛风散寒、活血通络。选取风池、百会、列缺、外关、太阳、阿是穴、三阴交，得气后施用泻法，风池穴针感直达前额及耳后，刺百会穴后患者感觉整个头顶沉胀麻木。针刺后加用艾条温和灸百会、风池、阿是穴。留针30min，起针后顿觉头痛大减，头清目明，当夜安卧。连针3次，其痛苦失。为巩固疗效，又续针7次而愈。随访至今未复发。

七、辨经与辨证并重 随证取穴

头痛可见于多种急、慢性疾病中。头痛的部位分为：前额头痛、侧头痛、后头痛及额顶头痛。按经络理论分别属于阳明、少阳、太阳和厥阴。孙六合在循经取穴的基础上进一步把头痛分成不同证型进行辨证取穴，把辨经治疗同辨证治疗有机地结合起来，指导临床实践，收到了非常好的临床效果。

（一）阳明头痛

（1）血瘀证 症见前额刺痛，痛在晚上或不定时，舌质黯紫，脉涩。治取合谷、首面、膈俞、血海、委中，重者加内迎香。合谷与首面为辨经取穴，其他为辨证取穴。膈俞、血海、委中均有活血祛瘀之功。内迎香是治疗阳明经血瘀头痛的重要穴位，尤其重证患者。用26~28号针刺内迎香至鼻根部，点刺出血3~5ml，均为暗黑色血液。

患者，女，12岁，头痛1年余，表现为前额部剧烈疼痛，夜间尤重。原来鼻涕多，病后突然消失，经多方治疗不效，以至辍学。五官科检查：下鼻甲黏膜暗红并肿胀。遂取内迎香，点刺出血约10ml左右，为暗色血液，头痛明显减轻，经用上穴调治2周，恢复学业。

（2）实热证 症见前额部跳痛，口臭，便干，舌红苔薄黄，脉洪大。治疗：内庭、合谷。证属阳明实热，取足阳明经荣穴内庭，一则上病下取，导热下行；二则荣主身热，可以泻阳明邪热。合谷为手阳明经原穴，用泻法可祛热止痛。上下相配，相得益彰。

患者，男，37岁。前额部跳痛，早饭后发作，逐渐加重，午后减轻，并逐渐消失，每日如此，历时数月。平素大便干燥，苔薄黄，脉洪大。病在前额，又发病于卯时，正应阳明大肠经主时，故用上穴治疗1周而愈。

（二）少阳头痛

（1）血瘀证 患者侧头部针刺样疼痛，舌有瘀斑，脉弦或涩。治疗：取足临泣、风池、血海、膈俞。足临泣为胆经的腧穴，属木中之木，可清热利胆止痛。风池可活血通经。血海、膈俞可活血祛瘀治疗头痛要注意手法：进针后待自觉沉胀感以后，以拇指向前捻

转，此时针感即传向侧头部。

男性，26岁，外伤后侧头痛1月，在当地针刺半月，疗效不明显，取穴为风池及侧头部多处穴位、外关等。临诊后取风池，如用手法使针感传向侧头部，加足临泣、血海、膈俞，10天愈。

(2) 痰湿瘀滞证 头痛如裹、头晕，或恶心呕吐。头维透角孙进针3寸左右，行针使针感放射到整个侧头部。选此二穴相透既对经又对证。头维属足阳明胃经，主湿、主痰，角孙属于少阳三焦经，中脘与内关相配可理气化痰、除湿通络。

(三) 厥阴头痛（肝肾阴虚证）

症见头顶空痛，头部活动时加重。治疗：取涌泉，配太溪、百会。证属肝肾阴虚，又痛在巅顶之上，故取涌泉，一则滋养肾水，补肝经之母；二则又合“越远越远，越近越近”之取穴原则，正如《肘后歌》：“顶心头痛眼不开，涌泉下针定安泰。”配肾经原穴太溪，加强滋补肝肾之阴的作用。百会引经气上至病所。

女，42岁，头顶空痛，头部活动时加重，伴失眠两年半，经多方针刺治疗效不佳，接诊以后，经询问唯未用过涌泉，遂取上穴治疗，对证对经，穴少而精，效如桴鼓，患者病愈而归。1年后，患者旧病复发，针刺不效，又求治于孙老师，仍用上穴，同样收效。

(四) 太阳头痛

太阳头痛多为外感，有风寒和风热之不同。风寒者可用灸法或刮痧走罐；风热者泻大椎，对于顽固性后头痛，可针至阴，《肘后歌》云：“头面之疾针至阴”。在临床上屡用颇验，不再一一列举。

八、梅花针叩刺 痛减症除

头为“清阳之会”、“诸阳之会”，五脏六腑的气血都上会于头部，五脏六腑发生病变，直接间接都可影响于头而发生头痛。辨证时要注意头痛部位、时间和性质。钟梅泉采用梅花针治疗本病，每每收到痛减症除的较好疗效。

(一) 辨证选穴

(1) 外感型 可见风寒束表证象，在 $C_1 \sim C_4$ 和 $T_3 \sim T_5$ 两侧可摸到条索和压痛。拟疏风解表镇痛为治。选穴以胸部和颈部为主：

大椎、风池、太阳、头部、大小鱼际、肘窝、阳性物处是穴。随症加减：合并鼻炎者加刺鼻部、迎香、印堂；咳嗽有痰者加刺气管两侧、太渊、颌下。

(2) 肝阳上亢型 除见肝阳上亢症状外，在 $C_1 \sim C_2$ 和 $T_5 \sim T_{10}$ 两侧、腰部可摸到条索、泡状软性物和压痛。拟育阴潜阳镇痛为治。选穴以颈部、腰、骶部为主；风池、三阴交、曲池、内关、期门、阿是穴，轻刺头部。随症加减：若头痛偏于一侧，病情常与劳累、情绪有关者，重点叩打颈部，风池、外关、太阳、患侧头部；若见头痛且晕，阴天痛甚，胃脘胀满，纳呆，身重懒言夹痰湿者，重点叩打 $T_5 \sim T_{12}$ 两侧、中脘、大椎、合谷、足三里；若见头昏发胀，或剧烈刺痛，反复发作，经久不愈，脉涩，舌苔薄、舌质紫，血瘀头痛重点叩打 $T_5 \sim T_{10}$ 两侧，风池、百会、中脘、合谷、三阴交；若见大便秘结者重点叩打骶部、下腹部。

(3) 肾虚型 可见肾气亏虚症状，在腰、骶部可摸到泡状软性物、条索和压痛。拟滋阴补肾，健脑镇痛为治。选穴以腰、骶部，颈部和头部为主：三阴交、百会、关元、风池、内关、阿是穴。随症加减：若见阳萎早泄重点叩打腰部、腹股沟、带脉区、百会。

(4) 气血两虚型 除气血两虚症状外，在 $T_5 \sim T_{12}$ 两侧、腰部可摸到条索、泡状软性物，风池穴有压痛。拟补养气血镇痛为治。选穴以脊柱两侧和头部为主：百会、风池、太阳、内关、头部、中脘。随症加减：若见失眠，多梦，心悸者，重点叩打颈、骶部，神门、百会；若见头痛位于前额，胃脘不适，纳谷差，嗳气，大便稀溏者，重点叩打 $T_5 \sim T_{12}$ 两侧、中脘、内关、足三里。

(二) 操作方法

(1) 对穴位和部位叩打法 在穴位表皮 0.5~1.5cm 直径范围内均可叩打 20~50 下。脊柱两侧自上而下叩打 3 行，第一行距脊椎 1cm，第二行距脊椎 2cm，第三行距脊椎 3~4cm。头部呈网状形叩打若干行。鼻部沿鼻背部两侧各叩打 2~3 行，于鼻骨与鼻软骨交界点刺 4~5 针。颞部以太阳穴为中心，呈扇状向上、向后叩打 5~6 行。肘窝皮区横刺 2~3 行。大、小鱼际各叩打 3 行。颌下部沿下颌骨下缘，由下颌角至颈部下平行叩打 2~3 行。下腹部由肚脐水平线

向下至耻骨联合上缘皮区，自上而下叩打8~9行，横叩打4~5行。腹股沟在该皮区从外向内下方叩打2~3行。带脉区在其体表循行区叩打3圈。

(2) 手法和疗程 外感头痛一日治疗2次。内伤头痛一日或隔日治疗1次，15次为1个疗程。休息半月，根据病情继续下1个疗程治疗。对肝阳上亢头痛者，头部叩打宜轻刺一般采用中等度刺激手法。对顽固反复发作性头痛，可在第1颈椎两侧及项窝阳性物处，采用梅花针重叩，用手指挤拧该处，使血渗出，然后用棉球擦去。反复3~4次，根据病情可隔日放血1次，连续5次。

王某，男，31岁，工人。头痛反复发作三年。半年来症状加重，发作频繁。常发整个头部疼痛，以后头部为甚。时有头晕，心烦性急，夜寐不安，梦多，口干苦，纳谷欠佳，溲黄便干。曾在几个医院诊断为神经性头痛，服中药、西药等收效不明显。血压16/80mmHg，眼底正常，鼻部检查未见异常。在 $C_1 \sim C_2$ 两侧、 $T_5 \sim T_{10}$ 两侧可摸到条索和压痛，脉细稍弦，舌苔薄。证属肝阳上亢夹痰湿。拟育阴潜阳，化痰镇痛为治。采用梅花针叩打颈部、 $T_5 \sim T_{10}$ 两侧，腰、骶部，风池、太阳、内关、三阴交、头部、阿是穴。经治2次后，疼痛明显减轻，治疗10次，头痛很少发作，经22次治疗后，头痛未再发作，症状消除，精神好转。再治1个疗程巩固调理，共治疗37次，无不适感而停诊，随访观察一年半，疗效巩固。

九、育俞-合谷-风池 顺序进针

欧阳伟选用以下穴位治疗头痛，每能收效。

(1) 育俞（在神阙旁外开0.5寸处）。有滋肾降逆之功。

(2) 合谷。清气分及头面之热。

(3) 风池。具有祛风解热、清脑开窍之功。无论外感、寒热、偏正头痛、外风内火、头面五官等病证皆可取。

操作：先取育俞穴。取1.5寸毫针，用捻转提插手法，使针感放射至上下腹部，停针。次取合谷穴。用1.5寸针，捻转提插进针，使针感放射至手及肘部以上，二穴留针20~30min后取针。最后刺风池穴，用1寸毫针，捻转提插进针，使针感放射至前额即起针。

(不留针)。

取此三穴，每次都必须按顺序进针。针刺均用双手进针，单刺手法亦可，6次为1个疗程。轻者隔日1次，重者每日1次。

陈某，男，42岁。自述于1982年元月底发头痛，在某医院治疗服药未见好转。2月25日拍片检查，见“松果体钙化斑”。脑电图检查正常，脑血流图示“血管紧张度两侧轻度增高”。意见：“脑脉管炎”。遂继续服中西药观察治疗二月余，病势有增无减。医生动员开颅检查松果体变化情况。因家属和病人拒绝动手术，于当年6月转入本院门诊部要求针灸治疗。当时患者由家属二人扶持就诊，病人双手紧紧抱着头，其痛难忍，如刺似裂，轻摸头发即觉头皮痛如针刺。神志清，不发烧，纳差，精神疲倦，面色苍白，脉沉弦，舌微红苔少，二便如常。遂让病人仰卧，按上述治疗顺序，先双手进针育俞穴，使针感放射至上下腹部，病人自觉似有气从头部下降，头痛稍觉舒适。次针合谷穴使针感上达肘部。两穴留针20~30min后起针。继刺风池穴，使针感放射至前额部即起针（不留针）。针后，病人自觉头痛大为减轻。第二天就诊时笑着说：“我解放了，再不要人扶，亦不抱头了”，第2次针后，嘱病人隔3日1次，观察病情。第三次治疗后病情明显好转，前后共针治8次痊愈。遂隔周针1次，巩固治疗6次。随访五年未发头痛。

十、风池 - 太冲 随因配穴

中医认为头痛的主要病因是由于风邪所致，并有“无风不头痛”之说。故刘敏勇以祛风为主体，参照西医诊断，着重针对病因进行选穴治疗。按此方法，获得满意疗效。

取穴：风池、太冲为主穴。然后按其头痛的部位，局部选用2~3个配穴，再按病因加取2~3个配穴。部位配穴：前额部头痛：配印堂、合谷、上星；两侧部头痛：配太阳、率谷；后枕部头痛：配风府、天柱；巅顶部头痛：配百会、四神聪。病因配穴：丛集性头痛：加阿是、印堂、三阴交、内关；精神源性头痛：加神门、哑门、三阴交；眼源性头痛：加承泣、睛明；鼻源性头痛：加迎香、鼻通；耳源性头痛：加听宫、中渚、瘰脉；颈椎病头痛：加大椎、崇骨、后溪透劳宫。

操作：患者取仰卧位或坐位。选用 1.5 寸毫针，常规消毒后进行针刺。针刺风池与太冲穴时，手法宜用泻法，针刺配穴时，以平补平泻手法。每日针刺 1 次，留针 20min。10 次为 1 个疗程，有效者连续针刺 1 个月，以便根治。

哈毕沙·马哈，女性，24 岁。初诊于 1992 年 6 月 18 日。主诉：左侧头痛发作一周。左眼眶及左颞部剧烈胀痛，已 4 天不能入寐。既往头痛反复发作 3 年。检查：呈痛苦面容，左眼球结膜充血，眼睑肿大且下垂，外眦有许多白色分泌物，左耳尖上方颞骨处压痛（++）。治疗选穴：风池（左）、太冲（左）、率谷透阿是穴（左）、印堂，以强刺激手法，并在太阳穴挑刺数针，微微放血少许。针刺 3min 后，疼痛减轻。第二天复诊时，头痛减轻大半，睡眠正常，左眼内分泌物消失，球结膜充血明显好转。针刺 5 次即已痊愈。半年后随访 2 次，均无复发。

十一、辨证分型 循经刺血

偏头痛是临床常见病，是一种发作性头痛症。临床表现以剧烈头痛为主，痛处相对固定左侧或右侧。在疲劳或情绪波动时易于发作。多因外风、肝胆郁热、脾胃虚弱而致，属少阳经头痛。

曾佑平采用循经刺血压痛点治疗偏头痛，疗效较为满意。

操作：外风型用 26 号粗毫针点刺阿是穴，太阳和少阳经上的压痛点出血；肝胆郁热型用 26 号粗毫针点刺阿是穴和少阳经上的压痛点出血；虚弱型用 26 号粗毫针点刺阿是穴出血，用 30 号毫针针刺中脘、足三里，手法用补法或平补平泻之法。

刺血也称放血，在中医学古籍中有明确记载。《灵枢·小针解》云：“宛陈则除之者，去血脉也”。说明放血能解除血脉中郁积久而致有脉络瘀滞现象，因此，放血有去瘀通滞的重要作用。曾佑平在治疗偏头痛时，采用循少阳经压痛点放血，能够疏泄肝胆炽火，促使经络通利，从而较快地恢复少阳经脉正常运行。所以，本法对肝胆郁热型偏头痛效果较佳。循太阳经压痛点放血，使少阳经风热循太阳经脉达表而出，对外风型效果较好。对虚弱型偏头痛需配合针刺中院、足三里，以补养气血，通调经气，达到止痛目的。

李某某，女，42 岁，护师，1992 年 9 月 22 日就诊。自诉左侧

头痛难忍2天，触摸头发亦感剧痛。伴口渴，失眠，烦躁易怒，胸胁胀痛，大便黄而稀。既往有偏头痛史11年。查：面赤，舌红苔黄腻，脉弦数有力。诊为肝胆郁热，肝木犯脾。治疗原则为疏泄肝胆炽火。选在患处点刺出血5~7针，循经点刺压痛点、丝竹空、太阳、率谷、头临泣、中渚、足临泣等穴出血。因见血后有恶心、心慌等晕针现象，平卧床上10余分钟，待晕针症状消失后述头痛也消失。第二日见其曰未痛。随访1年未复发。

十二、哑门深刺为主 随症加减

张继仲采用深刺哑门为主治疗头痛，疗效较为满意。

取穴：主穴：哑门、百会、印堂、太阳、风池、内关；配穴：前头痛加合谷，后头痛加昆仑，偏头痛加绝骨，头顶痛加三阴交。

操作：针具、穴位皮肤常规消毒。先令病人正坐，两前臂放在桌子上，两手掌重叠，前额抵在两手掌上；于后发际正中直上0.5寸凹陷处找准哑门穴，针尖指向上唇，夹持进针法直刺2寸左右（依病人胖瘦而定深度）；待病人出现酸、麻、重、胀感，沿后正中线上下载传导时即刻出针。随后针其他主穴和配穴（双侧穴左右交替），留针30min，留针期间，每5min行针1次，每天1次，10天为1个疗程，疗程间隔5天。

哑门在许多教科书上规定刺入0.5~1.0寸，不可深刺。历代不少医家也告诫此穴不可深刺。张继仲深刺哑门穴共306次，无一例发生意外和副作用。其操作的关键是：事先告诉患者要密切配合，出现针感不论如何强烈都不可前后、左右摇摆头部；医者取穴要准，方向要正确，得气速出针，即使得气不明显也不可反复提插。深刺哑门穴确有一定的危险性，但有一定危险性的穴位也往往是能取得极良疗效的穴位，《素问·刺要论》曰：“病有浮沉，刺有浅深。”病疾之邪多深伏，因此宜适当深刺，且留针时间要长。

中医学认为，头为诸阳之会，精明之府，五脏六腑之气血皆上会于此。故外感时邪、脏腑内伤，使头部清阳之气不得疏展，经络气血阻塞不通均能诱发头痛。针刺哑门、百会、印堂、风池、太阳，针位当脑之输，且有经脉入络于脑。依据“穴位所在，主治所在”之理，主穴皆在头部，针刺可调整脑府经气，疏通经络，

舒展阳气，通则不痛，故头痛可愈。配穴绝骨、合谷、昆仑、三阴交都在四肢，符合“经络所过，主治所及”之理，与主穴相配使头痛速却。

赵某，女，38岁，军人，1992年3月4日诊。发作性颜部跳痛伴流泪21年，劳累、精神紧张或月经前易发，每次发作持续2~3天方缓解。发作时面色苍白，两眼紧闭不欲睁，常需静卧安眠，无目屈光不正、高血压病史，脑电图及颈椎摄片未见异常。以往曾服用贾乃全、氟检利嗪可短时缓解，亦做过安定穴位封闭，但均未阻止复发。经上法针刺治疗，当日症减，连针3天，症状、体征全部消失，又巩固治疗7天，随访1年未见复发。

十三、针刺四关 配通天刺

朱振富运用针刺四关穴，配合头部通天刺法治疗血管性头痛，疗效满意。

取穴：选取四关（双侧合谷穴与太冲穴）；通天刺取穴为督脉上的神庭、上星、囟会、前顶、百会共5穴。

操作：患者采用坐位或仰卧位，消毒双侧的合谷与太冲，各进针0.5寸，轻度捻转。将通天刺法之5穴消毒干净后，采用两步针法：第一步，选用2寸长针，从神庭向囟会沿头皮平刺；第二步，选用3寸长针，从囟会向百会沿头皮平刺。两步进针后，均轻度捻转，以整个前额及头顶有酸胀感为宜。上述针刺均留针半小时。头痛剧烈者，中间行针1~2次。每日治疗1次，10次为1个疗程。

《医碥·头痛》说：“头为清阳之分，外而六淫之邪相侵，内而六腑经脉之邪气上逆，皆能乱其清气，相转击致痛。”《针灸大成》云：“四关四穴，即两合谷，两太冲穴是也。”合谷、太冲均为原穴，合谷主调气，太冲善调血，二穴相伍，犹如把关之将士，能扶正祛邪，通络止痛；通天刺5穴皆归属于督脉，督脉为“阳脉之海”，能总督诸阳，通天刺既治疗了局部的头痛，又起到了调节全身清阳之气的作用。四关穴与通天刺5穴，远近相配，标本兼治，相得益彰。

马某，女，36岁，1997年5月9日就诊。患者头部疼痛6年，近2年来频繁发作。4月22日出差途中因过度疲劳，复受风寒，致使头痛加重，始见巅顶疼痛，3天后疼痛转剧，似要裂开，自服止痛

药治疗，当时痛止，但数小时后，疼痛又发，并牵及前额部及眼球，同时流泪畏光，冷汗频出，泛泛欲吐。前往某综合医院治疗，服用麦角胺咖啡因、百服宁等药效不显。就诊时，双手抱头，痛苦万分，诉头要裂开。让其仰卧，给予针刺四关，轻度捻转，并用两步进针法行通天刺，捻转到酸麻胀感通达头部。针后患者头痛渐止，渐渐入睡。留针1h，中间行针1次，行针时病人诉有欣快感。起针后病人轻松自如。后巩固治疗10次，至今未见复发。

陈某，女，40岁，1998年10月20日就诊。患者头部阵发性疼痛8年，曾在外院检查，诊断为“血管性头痛”，并服用散利痛、西比灵等药效不显。今日中午12时许，左额及巅顶突然疼痛如劈，恶心欲吐，冷汗如珠，面红肢冷，身体稍动则头痛加剧。来本科时仍呻吟不已，痛苦不欲多语。让其仰卧，针其四关穴，并用两步针法行通天刺，均进行轻度捻转。针后15min，左额及巅顶疼痛逐步减轻，复行针1次，约40min后疼痛全部消失。起针后身体能转侧起坐。每日1次，共针15次，随访1年，头痛未见复发。

十四、针药并用 通络止痛

屈运东采用针药并用治疗顽固性头痛，效果满意。

取穴：太阳、百会、风池、头维、行间、中渚。

操作：太阳穴直刺1.0~1.5寸，百会穴平刺0.5~0.8寸，风池穴向同侧眼外眦方向刺0.8~1.0寸，针感扩散至同侧颞额部；头维穴横侧，向同侧曲鬓穴进针1.0~1.5寸；行间穴直刺0.5~1.0寸，使针感向上传导；中渚穴直刺0.5~0.8寸。以上诸穴除行间、中渚用强刺激外，余穴均用中等刺激。实证用泻法，虚证用补法，虚实夹杂者用平补平泻法。得气后留针，隔5min行针1次，留针30min。每日治疗1次，10次为1个疗程。

中药：川芎30g，荆芥10g，薄荷8g，羌活10g，细辛3g，白芷8g，防风8g，葛根12g，白芍20g，甘草8g，加水1000ml，煎至300~400ml，分早晚2次服用。加减：肝阳偏亢，加赭石15g、钩藤10g；瘀血阻络，加丹参6g、桃仁9g、水蛭3g；随月经周期发作者，加当归12g、熟地黄18g、赤芍10g、荆芥穗9g；精神紧张、过度疲劳发作者，加生黄芪12g、酸枣仁15g、仙鹤草15g；阴虚阳亢高血

压者，加生石决明 30g。

针药并用治疗顽固性头痛是通过经穴和中药的作用来调整气血，消除经脉瘀滞因素。针刺太阳穴为经外奇穴，其位置属于少阳经循行区域，能疏通局部经气而通络止痛，为治头痛之效穴；中渚属于少阳三焦经的腧穴，能清泄三焦之火而定痛；百会属督脉，为“三阳五会”，能够升提清阳之气；风池属足少阳胆经，是阳维脉的交会穴，也是祛风通络，通达脑目之重要腧穴，善治头痛；头维属于足阳明胃经，是足阳明经、足少阳经与阳维脉的交会穴；行间为足厥阴肝经的荥穴，有疏肝泻火、清热止痛之功。以上穴位远近相配，调和气血，通络止痛。再辅以中药，川芎、荆芥、防风、薄荷祛风清热；白芷、细辛、羌活引药上行直达清窍，祛风止痛；葛根辛凉解肌为头痛要药；白芍、甘草缓急止痛，又滋阴以防辛燥太过。诸药相配，奏效迅速，疗效可靠。

女，42岁，1998年6月10日就诊。患者已有17年头痛病史，头痛呈持续性胀痛，右侧为甚，疲劳、精神紧张或受振荡后加重，严重影响正常生活。检查：CT显示无器质性病变。脑血流图显示：右侧脑血管紧张性增高，右侧太阳穴处有索状物且压痛明显。按以上方法针刺并服用中药，治疗2个疗程后，疼痛基本消失，又施治1个疗程，头痛完全消失。脑血流图显示正常而告愈。随访6月，病未复发。

十五、辨证分型 锋勾针施治

曹伟民采用锋勾针治疗神经性头痛，收到显著效果。

取穴：风邪入络型主穴取天柱、合谷、太冲、痛点；瘀血阻滞型主穴取天柱、大椎、太阳、风池、痛点。配穴取百会、悬颅、悬厘、足临泣。

操作：选准穴位，局部常规消毒。右手拇、食、中指紧紧握持针身，留出所勾刺的长度；再以左手食、中指紧压穴位两旁，露出欲勾刺穴位，迅速将锋勾刺入皮下组织，稍待片刻，在穴位组织内的白色纤维牵拉之，再行上下勾割3~4次，待听到勾割吱吱声，即应按进针方向倒退出针，左手急速拿棉球按压针孔即可。每周1次，3次为1个疗程。

锋勾针治疗神经性头痛是通过经穴作用，来调整气血，消除经脉瘀滞及运行障碍等因素。锋勾针勾刺大椎、天柱清泄阳经之热，风池清阳平肝，兼利头目，太阳疏通患处气血，宣通脉络，使脉络通达，通则不痛，并以泻法出血，使热随血泄，达到祛除病源而取得较好的止痛效果。

李某某，男，33岁，干部。1989年8月16日初诊。主诉：右侧不定时头痛2年。近日因训练紧张，睡眠较差，自觉全身疲乏，右侧头痛欲裂，发作频繁，伴有恶心呕吐。舌体两边有瘀点，舌色紫暗，脉弦而数。做脑血流图检查，未见异常。诊断为神经性头痛。中医辨证为瘀血阻滞型。取大椎、天柱（双）、风池（双）、太阳（双）。以锋勾针勾刺泻法出血，当即针出痛止。8月22日患者来院复诊，自诉针后症状消失，后又巩固治疗1次。半年后随访，头痛未复发。

十六、头皮针为主 配导引吐纳

唐文中运用朱氏头皮针疗法治疗各种头痛，均取得较好疗效。

取穴：

（1）神庭区 定位以神庭为中心，前后各延长0.5寸，左右各旁开0.5寸的方形区，又以神庭为界，前后各分为神庭1区，神庭2区，属督脉、足太阳膀胱经，神庭1区功能：宁神醒脑，定惊镇眩。神庭2区功能：开窍利咽。

（2）百会区 定位以百会为中心，向前后左右各延长1.5寸的方形区，又以百会为界分前后二区，前为百会1区，后为百会2区，属督脉、足太阳膀胱经、足厥阴肝经。功能：百会1区，清利肠道，益气升阳；调经、通络止痛。百会二区，疏通经络，强筋止痛。

（3）本神区 定位以本神为中心，上下各延长0.5寸，左右旁开1.5寸的长方形区，又以本神为界分为内外二区，内侧为本神1区，外侧为本神2区。功能：本神1区，疏肝和胃，利胆清肠；本神2区，益肾利尿，调经固涩。

（4）率谷区 定位以率谷为中心，向上下左右旁开1寸的方形区，又以率谷为界，分为上下二区，下为率谷1区，上为率谷2区。

属足少阳胆经、足太阳膀胱经。功能：疏通少阳经气、定眩、利耳窍、潜阳平肝。

(5) 完骨区 定位以完骨为中心，向上下左右旁开 0.5 寸的方形区，又以完骨为界，分为内外二区，内到风池为 1 区，外至翳风为 2 区。功能：潜阳平肝，明目定眩，通少阳经气。多采用 1 区。

神庭区多采用 1 区，合并咽痛嘶者兼取 2 区，完骨区以取风池直刺为主，其他各区均以单刺、并刺、对刺为主。偏头痛较甚者取本神 1 区傍针刺。

操作：自上向下，取毫针 32 号 1 寸长，皮下透刺 0.5~0.8 寸，以并刺、排刺为主，行小幅度提插泻法，在行针时，嘱患者大口吸气，尽量憋气，然后行胸式呼吸，反复数次，行针 2min，间隔 10min，再行针两次，留针 30min 后出针，每天 1 次，7 次为 1 个疗程。

头皮针与导引吐纳相结合，进针及行针时嘱患者调整呼吸，有利于激发经气，疏通经络。使“气至病所”，导邪外出，配合深呼吸。除可调整一身气机外，还有助于调整大脑皮层——植物神经系统功能活动，扩大肺活量，加强气机及充分吸氧，促进新陈代谢。另外通过膈肌运动可反复地改善腹腔的压力，对内脏起按摩作用，促进血液循环，改善消化功能。

吴某某，女，45 岁，教师，于 1996 年 9 月 23 日初诊，主诉左侧颞部头痛 2 年余，加重 1 周。二年来常在生气劳累时发作，伴烦躁失眠，纳差乏力，常服麦角碱，镇脑宁胶囊等，疼痛得不到长期控制。查血压、体温、心率正常，脑血流图示左侧血管紧张度增高，颈椎 X 线摄片示生理弧度变直，余无明显异常，西医诊断为“血管性头痛”，治法取神庭 1 区单刺，百会 1、2 区并刺，左侧本神 1、2 区傍针刺，完骨 1 区风池直刺，率谷 1、2 区并刺，调整呼吸，进针后行小幅度提插泻法 2min，行针 2 次，留针 0.5h，取针后即感头痛消失，次日复诊时诉昨晚头痛复作，持续至入睡后减轻，睡眠改善，晨起感头晕，无明显头痛，仍按前法治疗，经治 4 次，诸症消失，遂巩固治疗 3 次，1 年后随访无复发。

十七、温针穴注 疏通经络

杨梅坤采用温针配合穴位注射的方法治疗头痛，取得了满意的疗效。

取穴：颈2夹脊穴、率谷（患侧）、四神聪、合谷（双侧）、外关（患侧）、足临泣（患侧）。

操作：患者俯卧位，穴位常规消毒后，用30号1.5寸毫针刺入皮下，行平补平泻手法，留针30min。留针期间颈2夹脊穴用艾条切成小块栓在针柄上温针灸。其余穴位只针不灸。每日治疗1次，10次为1个疗程。

穴位注射：取颈2夹脊穴、肺俞、心俞、肝俞、胆俞（均为双侧）。用10ml针管、配4号半针头，抽取复方丹参注射液6ml、维生素B₁₂1ml混合药液，刺入上述穴位，回抽无血后每穴注入0.5~0.6ml，隔日1次。10次为1个疗程。

中医认为头痛的病机是气血痹阻，不通则痛。常因久痛入络、肝阳上亢、气血亏虚等原因所致。风寒侵袭，上犯络脉，失于疏散，则气血不和，经络受阻。故取肺俞、颈2夹脊穴，配以温针灸，以疏通经络，疏散外来之风寒。肝木性喜条达，郁则气结化火而上扰清空；或因情绪激动，肝胆之风阳循经上扰，故取心俞、胆俞、肝俞泻肝胆之热，平熄亢逆之风阳；率谷、四神冲以疏通局部经络之气血，清利头目。外关、足临泣是八脉交会穴，两穴合于目锐眦、耳后、颊、颈、肩。《十二穴主治杂病歌》：“合谷在虎口，两指歧骨间。头痛并面肿。……针入五分深，令人即便安。”丹参具有活血化瘀、宁心安神的功效，维生素B₁₂有营养神经的作用。总之，温针加穴位注射治疗可起到疏通经络、活血化瘀、平衡阴阳、调整血管的舒缩功能、改善头部血液循环的作用，从而达到治疗头痛的目的。

张某，女，31岁。2005年3月3日来本科就诊。患者反复头痛4年，先为额颞部疼痛，逐渐蔓延至头顶。伴头晕、恶心、厌食，面色苍白，精神不振。得热则减，冬季头痛加重，夏季减轻。脑电图及CT检查未见异常。经上述方法治疗2次，头痛逐渐减轻。治疗1个疗程，头痛及伴随症状完全消失。为巩固疗效，继续治疗1个疗程。随访半年，未再复发。

十八、辨证取穴 针灸并用

王先香在详细辨证的前提下，采用针刺与艾灸结合治疗顽固性头痛，在临床上取得了较为满意的效果。

取穴：

风湿头痛：取穴以手足少阳，阳明经穴为主，配以艾灸治疗，取穴：风池、头维、通天，新头穴。前头痛加上星、阳白；头顶痛加百会、前顶；后头痛加天柱、后顶；侧头痛加率谷、太阳。

肝阳上亢头痛：取穴以足少阳、厥阴、少阴经为主。取穴：悬颅、颌厌、太冲、太溪、新头穴。目赤加关冲放血，面觉烘热加内庭。

痰浊头痛：取穴以任督、足阳明经穴为主。取穴：中脘、丰隆、百会、印堂、新头穴。呕吐加内关，便溏加天枢。

气血两虚头痛：取穴以督脉、足阳明，太阳经穴为主。取穴：上星、血海、足三里、三阴交、新头穴，艾灸肝俞、脾俞、肾俞、气海、足三里。

瘀血头痛：取阿是穴与手阳明，足太阴经穴为主，取穴：阿是穴、合谷、三阴交，眉棱骨痛加攒竹，侧头痛加瘰脉，头顶痛加四神聪。

操作：所取穴位先用75%酒精棉球行常规消毒，头部穴位均采用平刺手法，针刺得气后接6805电针治疗仪，频率调至250次/min，选用连续波，取针时注意按针孔以防出血。风池向对侧眼球方向斜刺0.5~0.8寸，新头穴以强刺激为主，其他穴位均采用直刺手法，远端穴位以针感向头部方向传导为佳，针刺得气后留针30min，留针期间断行针2~3次，每次行针约5min。风湿头痛，肝阳上亢头痛、痰浊头痛均用泻法，气血两虚头痛采用补法，瘀血头痛用攻补兼施法，即阿是穴泻，合谷补，三阴交泻。每日治疗1次，重病者每日治疗2次，10次为1个疗程，疗程间休息3~5天。

头者，精明之府，髓海之所在，手足三阳经脉及督脉和肝脉皆上会于头部，故又称为“清阳之府”，“诸阳之会”。凡五脏精华之血，六腑清阳之气，皆上注于头部。因此外感六淫，内伤七情，脏腑阴阳气血失调皆可引起头痛，而针灸具有调和阴阳，扶正祛邪，

疏通经络的作用，故针灸对头痛有较好的作用，尤以瘀血头痛效果最好，风湿效果虽好，但由于易再感风寒湿邪，故远期效果不够理想，有待进一步探索，痰浊头痛，肝阳上亢头痛及气血两虚头痛皆因内脏阴阳气血失调所致，故一般疗程较长，可能佐以中药疗效会更好一些。

张某，女，43岁，就诊时间：1995年4月3日，患者十年前始发头痛，后每遇感受风寒或因天气变化而反复诱发。此次因感受风寒而再度诱发，头痛欲裂，自感头顶灼热，前额胀痛，项背强，伴眩晕，恶心呕吐，不能动摇，遂送至本院内科住院治疗，经中西药治疗好转出院，1周后患者头痛再次发作，症状与前次发作时一样，被送到县医院住院治疗，好转出院，半月后又复发，再次被送到本院住院治疗。此次中西药治疗效果不显，遂来本科就诊，住院期间鉴于疼痛剧烈，反复发作，曾作CT检查，CT未显示颅内占位性病变，伴面色苍白，声低懒言，纳差，睡眠差，舌淡苔白，脉弦紧，诊断为风湿头痛，治以祛风散寒，化湿通络，取穴：风池（双）、百会、阳白（双）、通天（双）、角孙（双）、新头穴，按上治疗方法治疗，治疗1次后患者症状明显减轻，其他伴症均有明显好转，治疗5次后症状基本消失，后继续治疗10次以巩固疗效，随访1年未复发，1年后偶见复发，但症状轻微。

参考文献

- [1] 霍则军. 刺血拔罐治疗头痛 50 例. 四川中医, 1999, 17 (11): 55
- [2] 付爱民. 刺血为主治头痛. 针灸临床杂志, 2000, 16 (10): 16~18
- [3] 殷之放, 肖达. 针刺加埋针治疗血管性头痛临床观察. 上海针灸杂志, 2004, 23 (12): 8~9
- [4] 朱赤. 针刺四关穴治疗血管性头痛 30 例. 针灸临床杂志, 1998, 14 (7): 47~48
- [5] 郑洁容. 针刺治疗头痛 41 例疗效观察. 中国针灸, 1995, 增刊, 41~42
- [6] 张忆平. 针灸治疗头痛 120 例. 针灸临床杂志, 2002, 18 (10): 28
- [7] 席海霞. 孙六合教授治疗头痛经验. 河南中医, 2000, 20 (2): 55
- [8] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 332
- [9] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 343

- [10] 刘敏勇. 针刺风池太冲为主治疗头痛 100 例. 中国针灸, 1995, (1): 17~18
- [11] 曾佑平. 循经刺血压痛点治疗偏头痛 50 例. 中国针灸, 1994, 增刊: 196
- [12] 张继仲. 深刺哑门穴为主治疗顽固性头痛 31 例. 安徽中医学院学报, 1995, 14 (4): 52
- [13] 朱振富. 针刺四关穴配合通天刺治疗血管性头痛. 四川中医, 2001, 19 (10): 70
- [14] 屈运东, 解淑英. 针药并用治疗顽固性头痛 60 例. 山东中医药杂志, 2005, 24 (10): 615
- [15] 曹伟民. 锋勾针治疗神经性头痛 156 例. 中国针灸, 1995, (1): 23
- [16] 唐文中. 头皮针治疗头痛 50 例临床观察. 针灸临床杂志, 2001, 17 (7): 40~41
- [17] 杨梅坤, 刘明莉. 温针配合穴位注射治疗头痛 24 例. 四川中医, 2006, 24 (5): 98
- [18] 王先香, 余勤哲. 针灸治疗顽固性头痛 50 例临床观察. 针灸临床杂志, 1999, 15 (9): 19~20

【失眠】

失眠，是指患者经常入睡时间不够，或睡眠不熟。失眠的症状不一，有的难以入睡；有的睡中易醒，醒后难以再入睡；有的时寐时醒，睡眠不稳；甚者整夜不眠。中医称“不寐”、“不得眠”、“不得卧”、“目不眠”。本证可单独出现，也可与头痛、头晕、目眩、心悸、健忘、精神异常等症同时出现。常见于西医学的神经衰弱、神经官能症以及贫血等疾病中。

失眠的原因很多，中医学认为，本病的病位在心。凡思虑忧愁，操劳太过，损伤心脾，气血虚弱，心神失养；或房劳伤肾，肾阴亏耗，阴虚火旺，心肾不交；或脾胃不和，湿盛生痰，痰郁生热，痰热上扰心神；或抑郁恼怒，肝火上扰，心神不宁等。上述原因可使阳不入阴，阴不含阳，神不守舍而致失眠。

本篇收录的针治经验中，有的分型证治，有的独灸涌泉，有的采取梅花针叩刺，有的取耳穴压丸，有的芒针透刺等，都在失眠证的治疗中获得良好成绩。

一、背俞穴为主 重手法

失眠是临床常见的病证，其病位在心。由于足太阴经、足少阴经、足厥阴经与心相联系，足阳明、足太阳、足少阳经也分别上贯于心。

所以心的功能失常，或以上经脉所属之脏腑发生异常，都可影响到心，导致失眠的发生。所以失眠的发生与心、肝、脾、肾以及胃、胆等脏腑有关。而本证又多属虚证，据此，何树槐在临床上以背俞穴为主，进行治疗，取得了良好的效果。

取穴：心俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、肾俞、四神聪、三阴交。

操作：以上诸穴用毫针浅刺皮下1~2分，心脾两虚型全部用补法刺之。心肾不交者在心俞施以雀啄术，上下提插24次，以泄其热。肝肾阴虚型，在肝俞、胆俞施雀啄术，上下提插24次，以泄其虚热，余穴均用补法。

二、针药并用 平调阴阳

失眠的病因病机乃阴阳失衡，阳不入阴，昼夜阴阳运转失常。针灸治疗的关键，在于能调节阴阳的偏盛偏衰，疏通经络，促使机体归于“阴平阳秘”，恢复正常的生理功能。许红采用针刺加中药辨证论治治疗失眠症，疗效显著。

取穴：百会、印堂。心烦易怒，胸闷胁痛加行间、神门；胸闷脘痞，口苦痰多加丰隆、内庭、足三里；头晕耳鸣，心悸健忘加风池、太溪、三阴交。

中药：柴胡、龙骨、牡蛎、天麻、钩藤、赤白芍、丹参、夜交藤，同时酌情辨证加减。每日1剂，早晚煎服。

操作：患者安静仰卧，取百会常规消毒，逆督脉循行方向，平刺1寸。印堂正对鼻尖处平刺0.3~0.5寸。每隔10min行针1次，以捻转手法为主，留针30min。如患者当时能入睡，可适当延长留针时间，但不超过1h，隔日1次。

督脉统诸阳，为阳脉之海，百会为诸阳之会，逆督脉循行方向而刺以制阳，印堂虽为奇穴，在督脉循行线上，能调节阴阳，故针刺两穴可疏通督脉气血，调节脑功能，以达镇静安神，熄风潜阳之功。在针灸的同时配合平肝活血安神中药，较单纯药物治疗具有一定的优势。

三、艾灸涌泉 取效迅速

中医称为不寐，查少农多以灸法治疗，每获良效。

材料准备：自制长7寸，直径1.5寸的艾卷一根，或将市售的艾条3根捆在一起，备纱布（别的布亦可）一块。

取穴：涌泉（双穴）。

操作：让病人晚上临睡前以温热水泡脚10min，擦干后上床仰卧，盖好被褥露出双脚板。由施灸者点燃艾卷，用纱布遮掩双脚及床单，以防掉下火星灼烧。然后对准涌泉穴施行温和灸，使病人感觉温热舒适不烫为度，每穴各灸15~20min，至入睡为度。灸治7天为1个疗程，一般灸治当天即能安睡。

金某，56岁。因工作不顺心，气郁引起失眠5年余。伴头痛、头晕、心烦易怒、记忆力减退、纳食不香、口苦咽干、腰膝酸软，时有耳鸣。经多方治疗效果不显，每天服安眠药亦只能睡2~3h，醒后头晕胀痛，严重时彻夜不眠，心情极为苦恼。查：面色黯黄，舌质略红、苔薄黄，脉弦数。证属肾阴不足、心肝火旺。嘱其停服安眠药，施以艾灸涌泉之法。次日，患者十分欣喜来告：昨夜施灸后即安静入睡8h，这是近几年睡的第一个好觉。由于信心增强，又灸治6次，已能完全正常入睡。嘱其再灸1周巩固疗效。半年后随访，未再复发。

四、艾灸配捏脊 协调阴阳

失眠病因病机十分复杂，或因情志内伤，思虑太过，内伤心脾，气血生化无源；或气阴两虚，心肾不济；或因热病伤阴，肾精不足；或气郁化火，火灼真阴，阴虚阳越，心神失藏等。其主要病机为脏腑阴阳失调，阳不入阴，阴不涵阳，导致心神失养或心神不安。临床上王华兰采用艾灸涌泉、足三里，配合捏脊治疗失眠症，收效满意。

操作：治疗前，嘱患者用温热水泡脚10min，然后取双侧涌泉和足三里，点燃艾条，对准涌泉和足三里施行艾灸，以患者感觉温热舒适不烫为度，每次每穴各灸20min。施灸后，令患者俯卧，先用掌根在腰背部膀胱经及督脉循行部位来回按揉3min，使肌肉放松。然

后在长强穴处，用捏脊法操作。方法：用拇指桡侧缘顶住皮肤，食中指前按，三指同时用力提拿皮肤，双手交替捻转向前直至大椎穴。每次捏3~5遍，每日1次。治疗期间不服任何药物。

肾为先天之本，生命之根，益真阴而寓元阳，肾阴为一身之根蒂，肾阳为机体生命的动力。涌泉穴为足少阴肾经之井穴，又名地冲，灸之可补肾，通调一身之阴阳；又肾经“其支者，从肺出络心，注胸中”。故灸涌泉穴还可疏通心肾两经之经气，宁心安神，使心肾相交，水火既济，有引火归元之妙。足三里穴为足阳明胃经之合穴和下合穴，《素问·逆调论》记载“胃不和则卧不安”，因此艾灸足三里可健脾和胃，补益气血，使心神得养。在临床上用艾灸足三里治疗脾胃不和，痰湿、食滞内扰以及气血亏虚不得濡养心神，而致寐寢不安者有良效。脊柱属督脉经，督脉贯脊属脑络肾，督率阳气，统摄真元。因此艾灸涌泉、足三里，配合捏脊来协调阴阳，通调气血，镇静安眠，治疗失眠可收到理想的效果。

王某，女，55岁，退休工人。2000年6月8日来诊。间断失眠8年余，加重3个月。8年前因工作压力开始失眠，当时伴有健忘，心悸等症，虽经中西药物治疗但疗效不佳，后经自练气功，症状渐减至正常睡眠，因退休后无所事事而心烦郁闷，诱发失眠发作，每晚难寐易醒，时寐时醒，有时彻夜不眠，并伴有头晕头痛，记忆力减退，精神不振等症。虽经多家医院诊治，服药和练气功均无效，经人介绍前来治疗。艾灸足三里、涌泉穴并配合捏脊治疗1个疗程，患者自述每晚入睡顺利，持续睡眠5h左右。2个疗程治疗后，每晚睡眠6~7h，且伴随症状完全消失，精神状态明显好转。

五、主穴两个 大陵 - 失眠

林廷樾采用大陵、失眠治疗顽固性失眠，每获良效。

取穴：取双侧大陵、失眠（第二掌骨桡侧反应点，轻按即有酸麻胀或痛感处即是，如反应点不明显则取第二掌指关节后1寸，第二掌骨桡侧缘）。

操作：穴位常规消毒后，大陵取1寸毫针直刺0.5寸，得气后行平补平泻法，留针30min，失眠取2寸毫针先垂直向下进针至针尖平掌骨前缘后，针尖转为沿掌骨前缘向掌心方向平刺进针1.5~2寸，

患者有强烈麻胀感后，顺时针转针3圈，留针30min，每日治疗1次。

大陵是心包经原穴，具有清心除烦、安神定惊之功；失眠源于道医藏象针灸学，是经验用穴，具有清心除烦、安神定志的作用。其针法属于道医“过梁针”（即透穴针法），古代道医发现此穴并总结出上述用于治疗失眠症的方法，每获奇效。

陈某，女，46岁，干部。于2002年4月5日初诊。主诉：失眠1年，加重1个月。1年来睡眠欠佳，伴头晕、多梦，尤以出差更是彻夜不眠，每次必服安定片方能入睡2~3h，醒后不能再入睡，白天精神不振，头晕，健忘，甚则心悸，舌淡、苔薄白，脉细。按上法治疗1次即能睡12h，醒后精力充沛。又续针3次以巩固疗效，随访半年无复发，且出差都能正常睡眠。

六、辨证分型 巧用对穴

睡眠即寐，是人体顺应自然昼夜变化的一种生理性调节行为，只有气血调和、阴阳平衡，才能昼精夜寐。临床上，无论何种证型的不寐，其病机不外气血失调、阴阳失和，致使阳不入阴而不寐。程艳婷针灸用对穴结合辨证分型治疗失眠有利于发挥穴与穴之间的协同作用，使对穴之间气血共用、阴阳相配、上下相引，不但取穴少而精，而且兼顾周全，临床使用往往取得满意疗效。

（1）心脾两虚取神门、三阴交 心藏神，神门为手少阴心经之输、原穴，《针灸大成》载“主心性痴呆，健忘”，具有宁心安神、养心通络的作用。三阴交为脾肾经之要穴，具有补脾土、调气血作用；神门善走气分，三阴交善行血分，二者相配可调气血、和阴阳、养心安神。

王某，女，30岁，于1999年7月19日来诊。失眠1年，有时晚上仅能睡3~4h，患者伴多梦健忘、面色少华、肢倦乏力，舌淡苔薄，脉沉细无力，证属心脾两虚取神门、三阴交为主穴，配脾俞、心俞，针用补法，留针30min，每日1次，结果治疗1周后，每晚可睡7h左右，巩固治疗3次停针。

（2）心肾不交取通里、照海 通里为手少阴心经之络穴，别走手太阳小肠经，能清心火、定神志；照海为肾经腧穴，为八脉交会

穴之一，通于阳跷可滋肾益阴，引火归原。二者合用，一心一肾，一上一下，使心肾相交而安神定志。

邢某，男，54岁，1998年8月20日就诊。自诉失眠多年，近半年加重，伴多梦头晕，心悸乏力，腰酸耳鸣，舌红少苔，脉细数，证属心肾不交型。取通里、照海为主，配太溪、安眠。每日1次，治疗10次后自觉症状较前好转，夜间可睡5h左右，又加配耳穴神门、皮质下、心、肾，继续治疗半个月，临床症状消失，睡眠正常而停针。

(3) 肝郁气滞取内关、太冲 内关为手厥阴心包经之络穴，亦为八脉交会穴之一，而心包可代心受邪，阴维又维系一身之阴，故内关可宽中理气、宁心安神；太冲为足厥阴肝经之原穴，而肝藏血、主疏泻，太冲具有疏肝理气、调血安神的作用。二者上下取穴、气血兼顾，而且心、肝又与人的情志密切相关，所以临床用治疗肝郁气滞型失眠，疗效颇佳。

于某，男，37岁，干部，1998年7月21日初诊。自述1个月前意愿不遂、精神受刺激而彻夜不眠，在当地人民医院诊断为神经官能症，曾口服地西洋、氯氮平等药物，效欠佳。患者伴神绪不宁，时有心烦，记忆减退，舌薄黄中根腻，脉弦数，证属肝郁气滞。取内关、太冲为主，配神门，其中内关、太冲用泻法，留针30min。患者针刺过程中即入睡，继续治疗1周，精神转佳，睡眠正常停针。

(4) 阴阳失衡取申脉、照海 照海为肾经之要穴，交会于阴跷，有滋阴降火、引火归原之妙；而申脉交会于阳跷，可安神定志、通筋活络。二者相伍，通过调节阴阳跷脉而使人体阴阳平衡，而失眠之因在于阳不入阴，所以泻申脉、补照海使阴阳平衡而收安神之功。

刘某，女，45岁。自诉失眠多梦1年余，近日加重，夜间入睡困难。平日神疲健忘，月经紊乱，饮食尚可，舌淡红，苔薄，脉沉，证属阴阳失调。取申脉、照海为主，配神门，针刺泻申脉、补照海，每日1次，留针30min，针治10次后睡眠转佳而停针。

七、耳穴贴压 镇静安神

不寐属于现代医学神经衰弱的范围，是由于长期存在的各种精神因素引起大脑皮层兴奋与抑制相互制约、相互转化、相互平衡的

关系失常所致的疾病。中医学则认为本病病因病机主要是七情所伤，思虑劳倦太过或暴受惊恐，或因禀赋不足、房劳久病、年迈体虚阴阳失和，脏腑功能失调。胡素萍在临床上采用耳穴贴压治疗该病，疗效较佳。

取穴：主穴：神门、心、肾、皮质下；配穴：肝、脾、胰、胆、交感。

操作：主穴皆取，配穴随症选择2~3穴。常规消毒耳廓，用蚊式钳夹取耳压板上王不留行籽贴压于穴位上，嘱患者每天自行按压每个穴位3~4次，每次3~5min，睡前加强按捏。每次压一侧耳穴，3天后更换。

根据生物全息论的观点，人体任何细小部位在耳上都有其代表区，当人体某部位或某脏腑患病时，其相应耳穴就会产生一定的反应，如压痛、变形、变色等，这些反应就是用以防治疾病的刺激点——耳穴。耳与经络有着密切的联系，如：《灵枢·口问篇》说：“耳者，宗脉之所聚也”。在经脉循行线中，六阳经均循行分布到耳中、耳周围，六阴经经脉循行虽不直接入耳，但其经别循行合于阳经而上行。耳与脏腑也有密切的联系，如《灵枢·脉度篇》曰：“肾气通于耳，肾利则耳能闻五音矣”。耳穴神门镇静安神；皮质下调节大脑皮层兴奋和抑制的平衡；心主神明为火脏，肾藏精为水脏，两者水火相济则神志安宁；肝为木，木生火，补肝可补心；脾主运化；胰、胆可增强脾胃运化功能，两者结合可助气血化生而补心气；交感滋阴潜阳，可调节植物神经功能。诸穴结合，治疗不寐可取得较佳疗效。

张某，女，26岁，干部。头昏，眠差8年余，加重3月。患者8年前因参加高考，情绪紧张，用脑过度而致入睡困难，夜寐不宁，多梦易醒，长期服用安眠药维持睡眠，近3月因工作紧张致失眠加重，于1994年10月26日来本科就诊。症见：面色萎黄不华，神倦乏力，头昏痛，健忘，入睡困难，夜寐不宁，多梦易醒，每晚仅能入睡2~3h。纳少，腹胀，便溏，舌淡嫩、苔白，脉细弱。诊断：不寐。辨证为心脾两虚。治宜补益心脾。即按上法施治。取穴：心、脾、神门、肾、皮质下、肝、胰、胆、交感。治疗当日即睡眠改善，治疗1个疗程后睡眠恢复正常，伴有症状消失。为巩固疗效，继续

治疗3次，随访1年未见复发。

八、六交会穴为主 辨证加减

中医学称失眠为不寐，是由情志不调、劳神太过、气血亏虚而导致人体阴阳失调，脏腑功能紊乱，神气不宁。其病位在心，因心主藏神，神不安则寐不生，又因肾主藏精，上通于脑，肝主疏泄，而胆主决断，故心、肝、胆、肾的阳盛或阴虚均与不寐的发生有密切的关系，张大旭常采用针刺六交会穴治疗该病。

治疗方法：取内关、公孙、百会、关元、风池、三阴交为主穴。心脾两虚者加神门，阴虚火旺者加太溪，脾胃不和者加足三里、中脘、丰隆，肝火上扰者加行间、神门。针刺行间穴常用泻法，其他穴多用补法或平补平泻法，留针30~60min，针感强者可不行针，每日1次。

配方以经典的八脉交会穴中内关、公孙、百会、关元、风池、三阴交共6个穴位为主穴，因此可以叫做六交会穴针法，它能使六经、六脉互相贯通，从而达到疏通经络气血，调和阴阳，气血周流，营卫和谐。足太阳经与督脉交会于巅顶（百会），入络于脑，脑为元神之府，刺百会能安神定志，醒脑益智。又督脉总督诸阳，任脉总督诸阴，督任相连，用平补平泻手法针刺则百会穴能使脑阴与脑阳（抑制与兴奋）功能状态趋于平稳。风池穴是足少阳经与阳维脉、阳跷脉的交会穴，足少阳胆经别贯心，阳维脉维系诸阳，故刺之有宁心安神之效。三阴交为足三阴经之会，刺之可兼顾脾、肝、肾，加任脉关元穴，可起相得益彰之效。

九、芒针透刺 交通阴阳

陈章生在临床上采用芒针透刺治疗失眠，效果较好。

治疗方法：患者先取卧位，局部消毒后，用5~9寸芒针，取至阳透刺大椎、神道透腰阳关、腰奇透腰阳关。得气后行捻转泻法，留针20min起针，再令患者取仰卧位，用5寸芒针，取双侧内关透郄门，行捻转泻法，双侧三阴交透太溪，行捻转补法，留针20min后起针，每日下午针刺1次。

《难经·二十八难》云：“督脉者，起于极之俞，并于脊里上至

风府，入属于脑。”所以，运用芒针循经透刺督脉背部腧穴，施心肝泻法以制其亢奋之阳，达到安神定志之目的；配以内关透郄门以豁痰理气、宁心安神，三阴交透太溪健脾育阴、交通心肾。本法运用芒针，发挥其一针多穴、循经透刺、得气快、刺激强的特点来协调阴阳、通调气血、镇静安眠，故能收到理想的效果。

十、皮内针埋针 调整脏腑

失眠属于中医学不寐的范畴，多因七情内伤、饮食不节、房室过度等导致心肝脾胃胆肾等脏腑功能失调而致。心藏神，主神明；肝藏血，主疏泄神志；脾藏意，足太阴经注心中；肾藏精，足少阴经络心，足三阴经别均贯通于心。可见，脏腑功能失调，均能扰乱神明，致心神失养而不寐。王长来采用皮内针治疗，收效明显。

取穴：以背部阳性反应点为主，即在患者背部可触及到硬结或条索状物，其肌肤呈隆起、凹陷、松弛、紧张等状态，局部按之有压痛、酸胀或舒适喜按等感觉，与正常人的柔软肌肤不同。阳性反应点在心俞、神道、厥阴俞、膏肓、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、肾俞等腧穴上多见。若患者阳性反应点不明显者，取穴则以心俞为主穴；肝火、肝阳上扰者加肝俞；痰热扰心者加肝俞、胆俞、脾俞；瘀血阻络者加肝俞、膈俞；胃气不和者加脾俞、胃俞；心脾两虚者加脾俞；心肾不交者加肾俞。

埋针时间：气温高时为1~2天，气温低时为7天。

操作：以右手持止血钳夹住颗粒式皮内针针柄，左手食指和拇指把消毒后皮肤撑开，将针尖的方向以45°角对准腧穴迅速刺入皮肤，再将针身刺入皮内，皮内针与经脉相垂直。拇指和食指压针身两旁，将皮肤向针尖方向引回。此时，针柄如果抬起，说明针尖刺入皮下，未进入皮内，需退回一点再重新刺入皮内。取宽7mm、长21mm的长方型胶布顺着针身进入方向将针柄粘贴固定，操作时胶布用止血钳夹而不用手摸，以防胶布不粘，影响埋针效果。取单侧俞穴，两侧交替使用。

背部腧穴是脏腑精气输注汇集的部位。《难经本义》载：“阴阳经络，气相交贯。脏腑腹背，气相通应。”皮内埋针的方法是在针灸学理论上产生的一种皮内刺激疗法，它给皮部以弱而长久的刺

激，刺激信息通过穴位经络传入人体内，以“疏其血气，令其条达”，调整经络脏腑功能，达到治愈疾病的目的。

十一、温针灸 调阴阳

失眠以忧思劳倦之因常见，早在《素问·逆调论篇》中就有“胃不和则卧不安”的记载，以及《金匱要略·血痹虚劳病》“虚劳虚烦不得眠”的论述。不寐原因虽多，但总不外乎虚实两种，正如《景岳全书·不寐》所云：“不寐证虽病有不一，然惟知邪正二字则尽之矣，盖寐本乎阴，神其主也，神安则寐，神不安则不寐，其所以不安者，一由邪气之扰，一由营气之不足耳。”范氏认为其总的病因病机是阴阳失调，阳不入阴。治疗的关键是调和阴阳，补脑养心，镇静安神。范郁山采用温针灸法治疗失眠症，获得满意疗效。

治疗方法：病人取平卧或半卧位，全身放松，取百会、足三里（双）、内关（双）、三阴交（双），针刺上述各穴，行平补平泻手法，得气后分别加用温针灸器 30min，待温针灸器渐凉后取下，然后去针，每日 1 次。

百会是督脉与三阳经气的交会穴，“居一身之最高，百脉皆仰望而朝会也”，又称“三阳五会”，是治疗本病的重要穴位。针刺百会令阳气旺盛，引阳入阴，有升提收摄之功、提壶揭盖之意，能鼓动气血上荣髓海，改善脑部血液循环；内关，属心包经络穴，联络三焦经，直通阴维脉，和调内外，宣上导下，有镇静安神之效；足三里有健运脾阳，培土化元，补中益气，宣通气机，强身壮体之力；三阴交为肝经、肾经、脾经三条阴经之交会穴，有调和阴阳，和胃降浊的功效。对上述诸穴进行温针灸，共奏调和阴阳，补脑养心，镇静安神之功。

患者，男，56 岁，干部。于 1998 年 9 月来本院针灸科就诊。病人有失眠史 1 年余，长期依赖服用中成药剂枣仁安神丸、安定片等药物维持睡眠，睡后易醒，醒后则难以再入睡，伴有多梦、心烦、易怒、健忘，舌红苔薄黄，脉细数。采用温针灸法治疗，连续 7 次，失眠症状明显好转，睡后不易醒，梦少。再治疗 1 周，症状消失，自然入睡，每天睡眠时间达 8h，不再使用安眠药。

十二、补阴抑阳 平衡跷脉

失眠属中医不寐、目不瞑等范畴。中医学认为，人的睡眠和觉醒，与卫气在体内昼夜运行以及阴阳跷脉的平衡有密切关系。如《灵枢·口问》云“卫气昼日行于阳，夜半则行于阴，阴者属夜，夜则主卧，……阳气尽，阴气盛则目瞑，阴气尽而阳气盛则寤矣。”故人体正常睡眠的维持与阴阳跷脉有密切关系，其中阳跷脉主寤，为卫气行于阳的表现；阴跷脉主寐，为卫气行于阴的表现。只有二者功能正常，阴阳平衡，寤寐才能如常。不寐的发生则是由于卫气留于阳而不入于阴，使阳跷脉偏盛，阴跷脉偏虚，以至阴阳失衡所导致。张会珍于临床中采用补照海、泻申脉，通过补阴抑阳、平衡跷脉为主的方法治疗顽固性失眠，取得满意疗效。

取穴：照海、申脉、神门、心俞、三阴交、风池，均取双侧穴位。

操作：选用30号1~1.5寸毫针，针具、腧穴常规消毒，先取俯卧位，针心俞得气后，行平补平泻手法，不留针，起针后取仰卧位，先针照海行捻转补法，再针申脉行捻转泻法，其余穴均行平补平泻法，针感宜强，留针20~30min，间隔5~10min行针1次，每日午后治疗。

照海、申脉均为八脉交会穴，其中照海为足少阴肾经穴，通于阴跷脉针用补法；申脉乃足太阳膀胱经穴，通于阳跷脉，针用泻法。二者配用，补阴抑阳，可使阴阳调和，跷脉平衡，卫气由阳入于阴，则目可瞑，眠可安。三阴交乃足太阴脾经穴，又为足三阴经交会穴，脾经上注于心，肾经上络心中，故具有健脾补肾、调肝宁心的功效；此外由于“心主神明”，故取心俞配手少阴心经原穴神门养心安神；“脑为元神之府”，也主精神意识，风池位于脑后，为足少阳胆经与阳维脉交会穴，而阳维脉又合于督脉，督脉入络于脑，故风池具有镇静安神之功效。诸穴合用，则使阴阳调和，跷脉平衡，心神得宁，睡眠可安。

高某，女，37岁，保险公司职员，2000年4月20日就诊。患者自诉失眠3年，加重半年。3年前因工作压力较大出现失眠，常需服用“安定”或“舒乐安定”等药方可入眠，且药量逐渐加大，并

间断服用中药治疗，半年前病情加重，虽服中西药物仍难入寐，寐则多梦易醒，每夜入眠仅2~3h。平素精神萎靡，头晕健忘，心烦不安，痛苦异常。查舌红少苔，脉细数。经用上法治疗1个疗程后，睡眠明显好转，每晚睡眠已达5h左右，但仍多梦易醒；经治2疗程后，睡眠可达7h左右，且伴随症状明显减轻；又治1个疗程，睡眠正常，伴随症状消失，随访半年未复发。

十三、治疗失眠 重在调治内脏

中医学认为，不寐原因虽多，但总不外乎虚实两种。无论有邪之实证，或无邪之虚证，主要是因机体内在的气血、脏腑功能失调所致，故治疗失眠应着重在内脏的调治，使气血调和，阴阳平衡，脏腑功能归于正常。秦爱国曾用梅花针治疗单纯性不寐，获得满意的疗效。

取穴：双肩胛部和膀胱经在背腰部的第一侧线，重点叩击第一侧线上的敏感点、结节和条索状物，即阳性反应点或阳性反应物。

操作：根据病人疾病的虚实和体质的强弱分别采用轻、中、重3种不同叩击手法。一般轻手法用于虚证，重手法用于实证，阳性反应点和阳性反应物亦用重手法叩击。病人取俯卧位，然后沿肩胛冈由外向内叩击至膀胱经的第一侧（相当于肺俞穴）叩一条线，再沿膀胱经的第一侧线由上向下（相当于由肺俞至肾俞）叩击，每一叩击之间的距离为1~2cm，反复叩击5min，以皮肤潮红为度。对于实证亦可叩至皮肤微出血，每天1次。

根据经络理论，皮部是十二经在皮肤的分区，它具有局部性和整体性两种作用。疾病的发生起于皮部，通过经络内传于体表。因此，采用梅花针叩打体表一定部位、穴位或阳性反应区，便可以通过皮部—孙络—络脉和经脉，起到调整脏腑虚实、调和气血、通经活络、平衡阴阳之作用。

十四、头五针为主 辨证取穴

失眠的病因病机十分复杂，诸如情志内伤、思虑太过、饮食不节、惊恐伤肾而使阳不入阴、阴不含阳、神不守舍而致。其病理变化总属阳盛阴衰，阴阳失交。孙红选用头五针治疗失眠，疗效显著。

取穴：主穴：百会、四神聪；配穴：心脾两虚配心俞、脾俞、三阴交；心胆气虚型配心俞、胆俞、阳陵泉；心肾不交型配心俞、太溪；肝郁气滞型配肝俞、太冲。

操作：患者安静仰卧，取百会穴，常规消毒，医者立于患者头前，拇食指持32号毫针以15°夹角，逆督脉循行方向，沿头皮与颅骨骨膜间快速进针，平刺1寸左右。四神聪穴与百会穴进针方向及深度相同，即逆督脉循行方向，深度要求在1寸左右。留针30min。每隔10min行针1次，以捻转手法为主。配穴均速刺不留针。

《难经·二十八难》：“督脉者，起于下极之俞，并于脊里上至内府，入属于脑。”故百会有醒脑开窍、宁心安神之功。四神聪穴乃经外奇穴，其前后两穴均在督脉的循行路线上，左右两穴则紧靠膀胱经，膀胱经络肾，督脉贯脊属肾；络肾贯心，其气通于元神之府，故四神聪穴亦能醒脑开窍，安神定志。以上两穴应用时对各型失眠均有较好的疗效。但要注意针刺方向，并要求沿皮刺深度在1寸左右。

杜某，女，52岁，退休工人。就诊日期：1995年3月25日。主诉：患失眠10余年。伴头晕，心悸，纳差，健忘，形体消瘦。在本院各科已排除躯体和脑器质性病变。5年来每晚靠服3~4片舒乐安定维持睡眠。刻下：舌淡，苔薄白，脉细弱。证属心脾两虚型。针百会、四神聪，患者立刻觉得头脑清醒。20min后轻微鼾声起，约1h后患者醒，起针，又行心俞、脾俞、三阴交速刺不留针。嘱其回家后不饮茶，保持情绪稳定。隔日来诊时述：每晚只服1片舒乐安定即能入睡。且睡眠安稳，睡眠率在70%左右。头晕、心悸消失。3个疗程后痊愈。

十五、证分五型 取穴各异

失眠常妨碍人们正常生活、工作学习和健康，并能加重或诱发心悸、胸痹、眩晕、头痛、中风等病证，顽固性的失眠给病人带来长期的痛苦。本病病位在心，可涉及到脾、肾、胃、肝、胆。潘华在临床上运用针灸辨证施治治疗失眠，疗效显著。

分型：①阴虚火旺型：心烦不寐，入寐多梦，稍寐即醒，心悸不安，五心烦热，头晕耳鸣，口干少津，舌质红，少苔或薄白苔，

脉细数；或有梦遗、健忘、腰酸等症状。②肝郁化火型：不寐而兼见头痛、头晕目眩，目赤，口苦，急躁易怒，不思饮食，口渴喜饮，小便黄赤，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。③心脾两虚型：难寐易醒，头晕目眩，心悸健忘，神疲肢倦，饮食乏味，面色少华，舌淡苔薄，脉细弱。④痰热内扰型：卧寐不安，少寐头重，目眩，胸膈满闷，腹中不舒，吞酸恶心，恶食噎气，口苦，心烦，舌苔黄腻，脉滑数。⑤心胆气虚型：多梦，少寐或不寐，寐易惊醒，胆怯心悸，遇事善惊或怯弱多虑，气短倦怠，坐卧不安，舌淡，脉弦细。

取穴：阴虚火旺型：泻风池（双）、神门（双），补复溜（双）；心脾两虚型：泻风池（双），补神门（双）、三阴交（双）；肝郁化火型：泻风池（双）、神门（双）、太冲（双）；痰热内扰型：泻风池（双）、神门（双）、丰隆（双）、中脘；心胆气虚型：泻风池（双），补胆俞（双）、神门（双）、合谷（双）。

所用捻转补泻手法采用了明代陈会《神应经》中的捻转补泻方向，其补泻手法捻转时间的长短根据具体病情和病人耐受程度而定。泻法：刺入欲刺的深度，出现针感后进行捻泻，每隔5~10min捻泻1次，每次捻泻半分钟至3min，捻泻2~3次，留针15~30min拔针。补法：刺入欲刺的深度，出现针感后进行持续捻补3~5min甚至10min（严重虚亏或虚脱患者捻补的时间较长）即拔针。

张某，女，40岁，2002年5月9日初诊。主诉：患失眠2年。现病史：素体瘦弱，因工作繁忙、思虑操劳过度而得，2年中多梦少寐，入睡慢，易醒，伴有头晕、心悸、心慌之症，大便溏泄，每天行2~3次，稍食生冷食物则大便次数增加，小腹胀，下午及晚间加重，面色萎黄，舌质淡、边有齿痕，脉沉细无力。曾用中西药治疗效果不佳。中医诊断为“不寐”，辨证属思虑过度，耗伤心脾。治宜补益心脾，养血安神。针刺治疗泻风池（双），补神门（双）、三阴交（双）。每日1次，每日下午治疗，留针40min，10次为1个疗程。经治疗7次，夜晚睡眠可达4h，不易醒，头晕、心慌明显缓解，食欲增加。12次后，夜晚睡眠时间达7h，精神好，大便日行1~2次，成形。20次治愈。为防复发，巩固治疗5次，治疗结束10天后随访，告之失眠治愈。

十六、穴注与艾灸 两法合用

各种原因引起的失眠，其总的病机是阴阳失调，阴虚于内不能制阳，阳浮于外的阴虚阳亢之症，治疗宜滋阴潜阳。陈茹采用穴位注射和艾灸的方法治疗失眠，取得较好的效果。

治疗方法：①安眠穴注射：用5号针头，5ml注射器，取维生素B₁₂注射液2ml，维生素B₁注射液2ml，刺入安眠穴，垂直刺入1寸，左右捻转，轻度提插，出现针感后，注入药液2ml，对侧安眠穴亦如上法注射，隔日1次。②神门穴艾灸：每晚睡前，双侧神门穴隔姜灸各3炷，每日1次，嘱病人在家自行实施，以上两法同时开始使用。

安眠穴垂直刺入1寸许，位于颅底颈动脉管外口处，也是颈交感神经与动脉伴行入颅内的地方，针刺此处可引起复杂的生理效应，调节颅内外血管和神经功能，还能促使脑内源性内啡肽等介质的分泌和释放。神门穴为手少阴经“输”穴，心经“原”穴。艾灸此处，有温通心络，收敛浮越之阳的作用。这两法合用，相互补充，失眠可治。

高某，女，61岁，失眠30余年，加重1月余，患者于30年前因精神刺激导致失眠，睡眠间歇不宁，每晚累计睡眠时间不超过4h，且多梦，严重时彻夜不眠，常服安定片，现服用量已达每晚2片，但效果不明显，近日失眠加重，伴心慌、气短，时有窒息感。舌淡胖，苔薄白，脉沉弱。查心电图提示：心肌缺血。用上法治疗，期间停服安定等镇静药，10天后失眠明显改善，夜间累计睡眠时间可达6h，间歇清醒次数不超过2次，梦少，继续单用艾灸神门穴法治疗1月后，每晚能轻松入眠，睡眠无间断达7h之久，梦少。1月后随访，无失眠现象，且患者精神情绪很好，再未出现心慌、气短现象，临床痊愈。

参 考 文 献

- [1] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 243
- [2] 许红, 胡振霞. 针药结合治疗失眠症30例. 上海针灸杂志, 2001, 20

(6): 19

- [3] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, (233)
- [4] 王华兰, 尤艳利. 艾灸配合捏脊治疗失眠症 62 例. 陕西中医, 2005, 26 (5): 453 ~ 454
- [5] 林廷樾. 大陵、失眠穴治疗顽固性失眠 48 例疗效观察. 中国针灸, 25 (5): 331 ~ 332
- [6] 程艳婷. 对穴在失眠治疗中的临床应用举隅. 河南中医药学刊, 2002, 17 (6): 71 ~ 72
- [7] 胡素萍. 耳穴贴压不寐 166 例临床观察. 湖南中医杂志, 1997, 13 (3): 36
- [8] 张大旭, 张娅婕, 王秀玲, 等. 六交会穴针法治疗失眠 76 例疗效分析. 吉林中医药, 2004, 43
- [9] 陈章生. 芒针透刺治疗失眠 52 例对照观察. 中国针灸, 2002, 22 (3): 157 ~ 158
- [10] 王长来, 杜小庆. 皮内针治疗失眠 210 例. 成都中医药大学学报, 1998, 21 (1): 25 ~ 26
- [11] 范郁山, 姚春. 温针灸法治疗失眠 37 例. 陕西中医, 2004, 24 (2): 164
- [12] 张会珍, 贾春生, 余延芬. 照海、申脉为主治疗顽固性失眠临床观察. 四川中医, 2003, 21 (6): 75 ~ 76
- [13] 秦爱国. 梅花针叩刺治疗不寐 76 例. 中国针灸, 1996 (12): 46 ~ 47
- [14] 孙红. 头五针治疗失眠 150 例疗效观察. 中国针灸, 1997, (6): 377 ~ 378
- [15] 潘华, 李守然, 尚晓宇, 等. 针灸辨证取穴治疗失眠 192 例临床疗效观察. 四川中医, 2004, 22 (9): 93 ~ 94
- [16] 陈茹. 针灸治疗失眠 52 例临床观察. 甘肃中医, 2001, 14 (3): 67 ~ 68

【神经衰弱】

神经衰弱，中医学对本病的记载散见于“郁证”、“心悸”、“不寐”、“虚损”、“遗精”等证中，是一组以疲乏、头昏、失眠多梦、记忆减退、注意力不集中的衰弱证候群。多见于青壮年的脑力劳动者。

中医学认为本病的发病原因，与心、肝、脾、肾虚弱和失调有关。多由思虑劳倦，内伤心脾，营血暗耗，心失所养，脾失健运，生化之源不足，肝气郁结，或素体虚弱，肾气不充所引起。

现代医学认为，本病的病因与素质及环境因素有关。如长期过度紧张，学习任务过重，工作过分繁忙，缺乏足够的睡眠和休息，长期情绪紧张或心情郁闷等，均可促成神经衰弱的发生。

针灸治疗大多以养心健脑，交通心肾，平衡阴阳为主，临床取穴以头穴为主，配以远端取穴，这些不同的取穴方法对治疗本证都有一定的疗效。

一、矩阵针刺 镇静安神

金钹钩采用矩阵针刺治疗神经衰弱，效果满意。

取穴：四中4穴（于百会穴前后左右各2

寸处),安眠2穴(在风池与完骨穴之间有压痛处),头维2穴为主穴方。配穴:印堂、神门、太冲;有心血管系统症状者加内关、三阴交;有消化系统症状者加外关、足三里。

操作:选用30号1.5寸毫针12~15支。四中穴针尖对准百会穴刺入1.0~1.2寸,安眠穴针尖朝向对侧眼球方向刺入1.0寸;头维穴透向太阳穴。其他配穴按常规刺法(平补平泻)至针下酸胀重困感为度,留针30min,每隔5~10min行针1次。每日1次,6次休息1天;15次为1个疗程,治愈为止。

神经衰弱是一种高级神经中枢—大脑皮层的生理活动失调引起的功能性疾病,主要因大脑皮层的内抑制过程减弱而形成。在头部用矩形列阵的法则,用点角定位的方法,将穴位布置成三维空间的格局,进行合理的针刺使皮层的内抑制过程增强,达到兴奋与抑制的生理功能实现相对平衡,从而实现相互制约与相互转化的两大生理进程得到调整而治愈神经衰弱。矩阵针刺治疗时,除头部矩阵为主外,还在四肢配穴上考虑到肝、脾、肾三经的应用与调整。这也是取得满意疗效的一个方面。

另外,对神经衰弱患者的心理治疗也是一个重要方面;明确告诉患者,生活起居规律化,适当运动锻炼,加强营养,也是在治疗过程中不可忽视的重要方面。

宙某,女,54岁,患神经衰弱20年,因长期失眠、头晕、头痛、耳鸣、乏力、心悸、恐惧感等全身症状多,病情复杂,记忆力减退,而长期不能进行正常工作,曾在省级各医院就诊,均诊断为严重神经衰弱,并经住院和门诊未间断的治疗,但未见明显疗效。8年前因用安眠药物过量,引起严重的精神障碍,从此再未用药物治疗,而每晚饮酒催眠,因此酒量可达每次250g以上。1993年10月5日接受头部矩阵针刺治疗共45次后,全身症状消失,每日睡眠时间达6h以上,头脑清醒,记忆恢复。并于1994年1月10日重返工作岗位。连续走访3个月,情况良好。

二、少阳经枢转 揉抹点穴为主

少阳经枢转方法是一种民间独特方法。该法以揉抹点穴式少阳经理筋法为主,兼多种针刺方法和拔火罐法。在手触摸查清病灶的

基础上,根据病证、病情,运用枢转手法进行全身性调理及局部分筋理筋、点穴、转扳等手法治疗。韦英才对神经衰弱进行临床研究,发现很多神经衰弱患者在头部、颈部、胸部、背腰部都存在器质病变,即“痛性小结”,因而采用少阳经枢转方法调治神经衰弱,取得满意的效果。

施法顺序及方法:由眶膈部起始,依次眉间、额部、太阳、耳根、颞部、耳尖、头侧、枕外、风池、颈侧、肩部、肩胛、脊、腰、骶、下肢侧部、阳陵泉、悬钟、腓侧、足底反射。在施治中,按不同的部位使用不同的施治手法,采用揉抹法为主,结合运用切按、揉搓、捏治、点穴、掐等导引经脉,重点对痛性小结进行消灶。本法一般取坐位或俯位,医者以双手同时操作,用力适中,以患者局部出现酸、胀、麻感觉为宜,全程施治约需20~30min。一般隔天施治1次,7次为1个疗程。对病情严重者,可配合多种针刺法(含固灶行针,局部多针等)及投拔火罐等。在治疗的同时,指导病人自我穴位按摩、擦疗、练习静功等。治疗期间,停用一切针药。

在临床上,神经衰弱主要由于精神紧张所致,而精神紧张可导致肌肉紧张。肌肉紧张长期得不到松弛,就会引起伤筋。伤筋病灶形成后,又可压迫经脉造成经脉不通。不通则痛,经脉不通又可加重神经衰弱。因此,清除伤筋病灶,疏通经脉,克服“皮层-内脏”的病态恶性循环,达到消除肌肉紧张和精神紧张的目的,这是治疗神经衰弱的一个新途径。

少阳经包括少阳经脉和少阳经筋。对于躯体,以上下关系节段划分者,处于中焦部位;以前、中、后位作划分者,处于身躯的侧面,以阳经体系分布的位置划分者,处于太阳阳明之间。按照我国传统经脉的循环传递交接规律及病变的传递规律,由表向里传递者,始自太阳经、少阳经、阳明经,反之,由里向表传变者,则由阴经向阳经传递,至阳经阶段时,即呈阳明经、少阳经、太阳经反方向传递。因此,少阳经是经脉运转的功能枢纽,起着枢转机体功能动态平衡的重要作用。同时,按照三焦的划分法,本经脉应分为三个节段进行枢转调治,上焦的枢转,主要在头侧位,中焦的枢转,主要部位在胁部,下焦的枢转部位,主要部位在股髀。在临床发现上述三个部位都可以查到明显“伤筋病证”。这说明,少阳经枢转部位

的“伤筋病灶”可能是导致少阳经枢转失衡的主要原因之一。

中医认为，失眠是阳不入阴，神不守舍的病理表现。其中“阳不入阴”，少阳经枢转起关键作用。韦英才认为，要治疗神经衰弱，解决睡眠是关键问题。因为长期失眠可以导致神经衰弱，而神经衰弱又可导致严重失眠，这两者互为恶性循环。采用少阳经枢转方法调治，首次施治普遍反映都能提高睡眠质量，由于睡眠质量提高，才能有效地消除头晕头痛、精神疲乏，记忆力下降等症状，从而使病证获得治愈而稳定。

三、头部分区 循经取穴

神经衰弱是神经疾患的一种，属于中医的郁证或不寐范畴。本属多缠绵难愈、痛苦不堪，影响正常工作和学习，目前又无理想的疗法，李智依据有关中、西医理论，经过多年的临床实践，采用大脑皮层功能分区与传统的循经取穴相结合的选穴方法，针刺头部治疗顽固性神经衰弱，取得理想疗效。

取穴：顶中线（百会），顶旁线（通天），额中线（神庭），额旁线（本神），顶后线（率谷）。

操作：选用30号1.5寸毫针，快速进针，快速捻转出现酸胀或沉重感即止、留针30~60min，每日1次，10次1个疗程，配合心理疏导，首先详细询问病史及诱因，耐心地进行心理治疗，使病人对医生有信任感，树立战胜疾病的信心，避免精神刺激，身心放松。

中医学认为，脑主神明，人的精神意识思维活动发于脑，以认识世界、维持人体与自然、社会的相对稳定，和调情绪，促进形体与精神健康。脑又为身之元首，集一身之精华所在，可协调脏腑，稳定自身，拒邪于外，安神于内。脑为诸神所聚，七情活动是神的外在表现，如果七情所伤或脏腑功能失职必然会引起脑功能失调，从而出现失眠、心烦不安，抑郁不乐、头痛健忘、心悸等病变。

李智所选的穴位分别属督脉、膀胱经、胆经，其分布在头的额区、顶区和颞区，目的在于调整中枢神经功能活动，从而达到治愈本病的目的。因为督脉行于脊里入络脉，与脊髓大脑的功能关系密切，可主治精神、神志疾病，膀胱经行于背部及头部，且有背俞穴，对五脏之功能有调节作用，胆经行于一身之侧而具有调理人体气机

之功效，从而调合精神情志活动。另外从腧穴功能看，百会有镇静安神、醒神开窍之功效，是治疗神志病的要穴，古人就有用神庭、本神治疗精神系统疾病的记载，率谷、通天疏通膀胱经及胆经经气，对调整全身气机有较好作用，从而调节情志活动。

四、养心健脑 随症取穴

中医学中无神经衰弱之病名。临床常按患者的不同临床表现而归于失眠、心悸、便秘或腹泻、月经不调、遗精等病辨证论治。

董建勇总结杨廉德的临床经验，认为虽然神经衰弱临床表现多样，症状广泛，而被分属于中医不同病中，但其主要病变部位在心与脑。心主神、脑为元神之府。恼怒忧思则伤神，心血暗耗，心伤则神无所主。五脏六腑皆摇。故治疗神经衰弱以养心健脑为主。

取穴：百会、风池、颞颌点（自选刺激点，位于下关与颧骨连线中点，颧弓下缘，直刺1.5寸）。随证加减：失眠配申脉、照海调理跷脉；健忘配三阴交以益肾补髓；便秘、腹泻配天枢、足三里以调理胃肠；阳痿、遗精配三阴交、中极以补肾固精；月经不调配合谷、三阴交以调理气血。

颜某，女，21岁，学生，1998年7月11日就诊。患者平素胆怯、自卑、多疑、缺乏自信。近期经常失眠多梦，口干喜饮，心悸，健忘，注意力不集中，盗汗，手足心热，乏力，纳差，大便不爽，小便黄，舌尖红，苔薄白，脉弦。诊断：神经衰弱（失眠）。辨证：心肾不交。治则：交通心肾、养心健脑。处方：百会、风池、颞颌点、申脉、照海。上述穴位平补平泻，隔日1次。经10次治疗，睡眠正常，余症消失，嘱注意生活规律，加强锻炼。

五、治神十法 因症而施

洪建云运用周德安的针灸治神十法治疗神经衰弱，疗效显著。

主穴：百会、神庭、四神聪、本神、神门。配穴：根据临床症状配穴，共十种治法，故称治神十法。①失眠健忘：加三阴交；②眩晕：加太冲；③头痛：加行间；④心悸气短：加内关；⑤心烦易怒：加四关；⑥遗精阳痿或月经不调：加关元；⑦自汗盗汗：加太渊、太溪；⑧纳呆：加中脘、足三里；⑨哭笑无常：加人中、少商、

隐白；⑩精神萎靡不振：加灸关元。

操作：毫针刺常规针刺，平补平泻，留针 30min，10 次为 1 个疗程。

《景岳全书·卷三十八·不寐》曰：“盖寐本乎阴，神其主也，神安则寐，不安则不寐”。周老认为人的精神思维与意识受神的支配，在神的支配下产生七情变化，不同的情志变化本属人体对外界的正常反应，不会使人致病，但人的五志七情超越了一定范围就会导致人体阴阳失调，气血失和，经络阻塞，脏腑功能紊乱等一系列病理变化。

针灸治神十法具有调节阴阳、气血、脏腑等功能，百会穴位于巅顶，为诸阳之会，具有镇静安神之功，神庭为神所居也，与百会相互为用加强镇静安神之效，本神为胆经头部穴，具有健脑益智的作用，四神聪为经外奇穴，是后世医家用以镇静安神、健脑益智的经验效穴，以上 4 穴均在头部，“头为精明之府”、“头为天谷以藏神”，故取头部穴治疗神志病以达安神定志，健脑益智之功。

张某，女，37 岁，初诊日期：1995 年 1 月 4 日。主诉：反复夜间睡眠差 2 年，加重 2 个月。病史：患者于 2 年前因生气而导致夜间睡眠差，开始每夜能睡 4h，以后日渐加重，致难以入睡，曾在陆军总医院诊断为：“神经衰弱”，采用“音乐疗法”，疗效欠佳，近 2 月来症状加重，夜间不寐，心烦躁，在北京市中医医院服中药治疗，亦不效，故要求针灸治疗。症：夜间不寐，偶可入睡 1~2h，多梦，醒后不解乏，健忘，心悸心慌，头颈部胀痛，纳差，神疲乏力，心烦易怒，月经不调，量少，色黯，经期后愆，消瘦，面黄。舌脉：舌暗红，苔稍腻，脉弦细。中医诊断：不寐（肝郁脾虚，心神失养）。西医诊断：神经衰弱。立法：疏肝健脾，养心安神。取穴：百会、四神聪、神庭、本神、神门、三阴交、行间、内关、足三里。毫针刺，平补平泻，留针 30min。经针 6 次后，夜间可入睡 3~4h，针 16 次后，每夜可睡约 6h，其他症状亦明显减轻，继续完成三个疗程的巩固治疗，夜间睡眠已正常，其他症状亦消失，患者自我感觉良好，恢复正常生活工作与学习，随访半年病情无反复。

六、体耳针并用 安心神

谭中军采用体针耳针结合的针刺方法治疗神经衰弱，疗效较满意。

取穴：心俞、内关、太阳、三阴交、关元、神门、安眠、足三里、太溪、肾俞、命门等穴。耳针选穴：心、肾、脾、内分泌、神门、皮质下、交感等。以衰弱症状为主：如脑力易疲乏，感到没有精力和脑力迟钝，注意力不集中，记忆差的。谭中军选用百会、印堂、心俞、脾俞、肾俞、照海、足三里。耳针：皮质下、交感、心、脾、肾穴位。以兴奋症状为主：如容易精神兴奋，表现为回忆和联想增多控制不住。选用：间使、神门、心俞、肝俞、足三里。耳针选穴：皮质下、心、肾。以情绪症状为主：如易烦恼，易激惹，选用：内关、通里、太冲、太溪等。耳针选穴：心、皮质下、交感、神门。以睡眠障碍为主：如入睡困难，多梦，夜间不眠，白天没精打采，选用：神门、三阴交、心俞、厥阴俞、太冲、安眠。耳针选穴：皮质下、交感、心、脾、肾、内分泌、神门。以紧张性疼痛为主：如头痛，肢体酸痛。选用：百会、太阳、肝俞、足三里、三阴交。耳针选穴：枕、额、皮质下、神门。

操作：用平补平泻手法，每日1次治疗，10天为1个疗程，每次留针30min。1个疗程后休息3天后可进行第二疗程。

王某，男，18岁，某县重点中学学生。因失眠，多梦，记忆力下降，疲乏来本院就诊。自述其姐姐在1986年以优异成绩考入某重点大学，自己也暗下决心向姐姐那样要考入大学。1987年初中毕业后考入重点中学。入学后学习任务加重，每天学习非常用功，在期中考试属于中等生。自己感到怕考不上大学，压力特别大。近3个月来开始失眠，表现为入睡困难，上床后要2~3个小时才能入睡，睡后极易醒，伴有多梦，内容多是自己考试不及格，没有考上大学有关，白天感到头痛，头晕，周身疲劳，记忆力减退，学习成绩下降，有时老师讲课感到听得非常费力，当时听明白了，课后便忘记了。曾在当地医院内科就诊，做多项临床检查未发现任何躯体疾病，按“失眠症”治疗，服用安定，脑心舒等多种药物症状无改变。近来在平时考试时出现“三科”不及格，故来本院治疗。诊断：神经

衰弱。予以体针、耳针治疗。在针刺治疗同时配合心理治疗。选穴：百会、印堂、安眠、心俞、照海、足三里。耳针：皮质下、交感、神门。每日针刺1次，在针刺治疗4次后自诉临床症状减轻。共针刺10次临床症状消失。身体恢复正常。

七、补心宁神 平衡阴阳

王瑞霞采用补心宁神，平衡阴阳，交通心肾法，针刺治疗神经衰弱，疗效较佳。

取穴：百会、安眠、神门、足三里、三阴交、照海、申脉、太冲。

操作：病人平卧，常规消毒以上穴位。用毫针针刺，得气后留针40~60min。留针期间行针1~2次，平补平泻。每天治疗1次，7次为1个疗程，疗程间休息1~2天。一般治疗2~3个疗程。治疗过程中，停用其他治疗方法。

百会能清神醒脑，治疗头痛，增强记忆。神门为心经原穴，能清心安神，使心能“任物”，从而增强记忆力，使精力集中。三阴交为足三阴经交会之处；太冲为肝经原穴，疏肝解郁、平肝潜阳，可改善焦虑、抑郁、烦躁易怒情绪。照海为肾经穴位，通于阴跷脉，阴跷脉又统一身之阴，以上诸穴同用能培补人体阴精肝血，使阴精上荣于脑，则脑力恢复；脾精肝血滋养筋肉，则肌肉紧张疼痛消除，疲劳症状改善。神门、照海同用，能交通心肾，配安眠穴可治疗失眠，改善睡眠规律。足三里为胃经合穴，能益胃健脾，培补后天，增强体能。以上诸穴相合，能补心宁神，平衡阴阳，交通心肾，疏肝解郁，健脾和胃。切中病机，故治疗神经衰弱效果明显。

李某，女，32岁，教师。因“精力不集中、记忆力下降、失眠多梦3年，加重一周”于2002年5月6日就诊。病人于3年前因工作压力大，反复生气，而致精力不集中，自觉记忆力下降，失眠多梦，周身乏力，全身肌肉酸痛，头昏头痛，曾有一段时间不能胜任工作，到某精神病医院就诊。当时诊为神经衰弱，住院治疗1个月，好转后出院。近1周因精神刺激，而致以上诸症复发并加重，自觉注意力不集中，明显健忘，周身乏力，肌肉酸痛，失眠多梦，烦躁易怒。自服镇静药无效，来诊。查：情绪低落，烦躁不安，舌边尖

红，苔薄白，脉弦细。内科、神经科查体未见异常。中医辨证：肝郁血虚，心肾不交。西医诊断：神经衰弱。按以上方法治疗1个疗程后，症状明显减轻。治疗3个疗程，症状消失，恢复正常工作。随访2年未复发。

八、四神聪为主 针刺配心理治疗

神经衰弱属于神经官能症中的一种，其主要特征是精神易兴奋和脑力易疲乏，常伴有情绪烦躁易激惹以及睡眠障碍、头痛、多种躯体不适等症状。裴广祥采用针刺配合心理疗法治疗该病，获得较好的效果。

取穴：主穴：四神聪透百会。配穴：神门、足三里。

操作：穴位皮肤常规消毒，用30号1.5寸毫针先快速平刺百会前之神聪，进入皮下后向百会穴方向经帽状腱膜慢慢推进1寸，行针使病人产生酸胀的感觉后施捻转平补平泻手法。用同法依次针刺百会后、左、右之神聪，针尖均刺向百会，得气后均施捻转平补平泻手法，留针20min，中间用捻转平补平泻手法行针1次。神门、足三里分别直刺0.4寸、1.5寸，留针20min，亦施平补平泻手法。每日针刺1次，7次为1个疗程，疗程间歇3天，再进行下1个疗程。

心理治疗：无论初诊、复诊都必须以高度关心、同情病人的态度与其建立良好的医患关系，通过交谈的方式全面了解病史，根据病人的不同情况进行。①引导病人认识所患疾病的性质，告知病人该病不是器质性病变，是由于长期工作负担、长期精神负担所致，是可以治愈的。②消除患者对该病的疑虑及紧张情绪，指明这种继发性焦虑情绪可能导致疾病的加速或病程的迁延。③为了提高疗效，合理安排作息时间，坚持体育锻炼，适当参加文娱活动。

神经衰弱属中医“不寐”、“郁证”、“头痛”范畴，其致病原因或由于思虑劳倦过度，损伤心脾；或情绪紧张、肝气不疏，失于条达；或情志过极，心失所养，最终导致大脑阴阳平衡紊乱。阳主动、主寤、主兴奋，阴主静、主寐、主抑制，故调整阴阳是治疗该病的关键。大多数学者认为，心理社会因素是神经衰弱的重要原因，其致病机制可能是持续的精神过度紧张和疲劳以及负性情绪超强刺激

大脑，引起大脑过度应激反应，导致大脑皮质功能弱化，削弱对皮质下植物神经中枢的调节而出现的植物神经功能紊乱。因此病多发于胆怯、自卑、敏感、多疑、依赖性强、缺乏自信、任性急躁、自制力差者，故心理治疗也是治疗该病的重要一环。

四神聪是经外奇穴，于百会前后左右各开1寸取穴，是治疗神经衰弱的要穴，百会是督脉经穴，位于巅顶，督脉“入络于脑”，“脑为元神之府”，四神聪透刺百会能安神定志、醒脑益智。又督脉“总督诸阳”，任脉“总任诸阴”，督任相连，用平补平泻手法针刺百会穴能调节脑功能紊乱，使脑阴与脑阳（抑制与兴奋）功能状态趋之平稳。神门为手少阴心经原穴，“心主神志”，针刺神门穴能养心安神，使心有所主。足三里穴刺之能补心脾、益气血、消除疲乏，对中枢神经系统不平衡功能状态有调整作用。四穴合用，共收调整阴阳、安神益智、补益气血之功。心理治疗能帮助病人建立自信心，消除顾虑，松弛精神紧张，保持乐观态度，减少对大脑的超强刺激，避免大脑产生过强应激反应，使大脑功能保持在正常平衡状态，与针刺相配合，相得益彰。

九、取穴头腹足 辨证加减

姚益龙采用引阳入阴、平衡阴阳的观点配方组穴，取穴头腹足，以应天入地，经取任督、脾胃，交通阴阳，加取心经原穴，清心明志来治疗神经衰弱。

取穴及操作：主穴：神庭、前顶，循督脉向后斜刺；目窗（双）顺前顶至头维方向斜刺（合称头四针）；天枢（双）、气海，均直刺（简称腹三针）；三阴交（双）直刺；神门（双）、太冲（双），分别循经向胸腹方向斜刺；安眠透风池（双）。配穴：若肝气郁结、胸闷加内关；肝肾阴虚加太溪；胃脘胀满加中脘。手法均用平补平泻。留针30min，每日1次，10次为1个疗程。

中医学认为，神经衰弱属中医不寐证范畴。究其病因病机多由五志过极，而致气机逆乱，气血不和，阳盛阴衰，阳不入阴。《灵枢·寒热病》曰：“阳气盛则嗔目，阴气盛则瞑目”。针灸治疗的目的在于：调整机体阴阳、恢复脏腑气血功能。治法上采取“清泄过盛之阳气，补其阴气之不足”，使气血调和、心神得安。头为诸阳之

会，督脉与手足三阳经、足厥阴经、阳维脉、任脉相交，总督一身之阳气，其脉上连于脑，下连于肾。寒热虚实之邪易循经上犯，则多兼有头部症状。神庭穴为督脉与膀胱经、胃经之会，与前顶穴同属督脉，辅以胆经之目窗穴，可泄少阳郁热，配其相表里肝经原穴太冲，舒肝理气、调畅气机，兼图调整阴阳之效，共为君。奇穴安眠透风池，对证取穴，消减头痛头晕、耳鸣等不适症状，以达安神定志之功，为使。三阴交，是足三阴经之交会穴，能协调足三阴经的平衡。神门穴为心经之原穴，有补心作用。两穴相配，既交通心肾，又与头部阳经穴位相应，引阳入阴，以达阴阳平衡，为臣。足阳明胃经天枢穴，又为手阳明大肠经募穴，配伍任脉气海穴，取健脾去湿，补气调经，益肾固精之效，为佐。另据症状轻重缓急，辨证加减，共奏泄阳补阴、平衡阴阳、调和气血、安神定志之功。当然，心理疏导亦应贯穿治疗全过程，不可偏废。纵观全方，穴取头、腹、足，以应天、人、地，经取任督、肝胆、脾胃，交通阴阳，加取心经原穴，清心明志，以明“心为五脏六腑之大主”，“精神之所舍”之理论，也体现了中医学的整体观和辨证论治的基本特点。

宋某，女，36岁。4年前因家庭矛盾渐渐出现情绪不稳，烦躁易怒，处理事物偏激，进而心烦意乱，失眠，头部沉闷不爽。经前症状加重，多伴小腹腰骶酸痛，神疲肢倦，乳房时有胀痛。曾在多家医院诊治，服用多种中成药、中草药，症状时重时轻，易反复。近来症状趋向加重，不得已而服用安眠药，因出现药物依赖而寻求针灸治疗。舌尖红苔黄，脉弦沉细。发现乳腺增生4年余。诊为神经衰弱，辨证为肝郁化火，灼心伤肾，经脉不和，阴阳不调。治宜舒肝理气，育阴降火，交通心肾，平衡阴阳。穴取：主穴加配穴太溪，针刺5次后情绪平和，心烦消失。1个疗程后寐安，睡眠时间在7h以上。继针1个疗程，失眠心烦轻微反复，梦少，睡眠在6h左右，但自觉睡眠安稳，次日无神疲肢倦。再针1个疗程，睡眠安稳，心情舒畅，并能对之前的偏激情绪释然。又予1个疗程巩固疗效，随访半年未复发。

十、体穴百会风池 耳穴随症加减

徐耀智运用电针配合耳穴压籽治疗神经衰弱，效果满意。

(1) 电针

取穴：百会、风池。

操作：取俯卧位，穴位常规消毒，用 30 号 1.5 寸毫针，百会穴针尖向前斜刺至皮下，针刺深度约 1 寸。风池穴（双侧交替使用）针尖向下颌方向，针刺 1 寸左右，以得气为准。接上 G6805 电针治疗仪，用疏密波，电量以病人能耐受为度，留针 20 ~ 30min 起针。每日 1 次，15 次为 1 个疗程。1 个疗程后休息 2 ~ 3 天，再进行下 1 个疗程。

(2) 耳针

取穴：脑点、内分泌、皮质下、神门。配穴：根据临床表现加用适当的穴位，如伴心慌、多梦加心、脾；如伴纳差、腹胀、腹泄、精神不振，则加肝、脾、胃；如伴头晕、耳鸣、腰膝酸软，则加肝、肾。若无特殊不适，可用探针头按压耳廓，寻找压痛点、敏感点取之。每次取 1 ~ 2 个配穴。

操作：选好穴位后，耳廓常规消毒，把王不留行籽置于 0.5cm × 0.5cm 的胶布中央，贴在选定的穴位上，稍用力按压 3 ~ 5min，直至耳廓发热发红为止。嘱患者每天自己按压 3 ~ 5 次，3 天更换 1 次，5 次 1 个疗程。

百会穴是“三阳五会”，即百脉交会的地方，针刺它可以疏通经络，通调百脉，醒脑安神。风池穴为足少阳胆经穴位，胆主惊，心藏神，足少阳胆经经别贯心，故针刺风池穴能够疏肝泄胆，安神定惊。百会位于头顶，风池位于头项部，局部取穴，加上电针，可以改善头部血液循环，使大脑供血、供氧充足，诸证自然解除。

《灵枢·口问》：“耳者，宗脉之所聚也。”人体十二经脉汇聚于耳。耳穴脑点、皮质下、神门具有调节大脑皮质及植物神经功能；心、肝、脾、肾能够宁心安神、滋阴潜阳、健脾益肾，具有调节五脏六腑的功能，所以用耳穴治疗功能性疾病效果较好。

任某，男，30 岁，工人，1999 年 10 月 8 日初诊。主诉：失眠多梦，头晕耳鸣 1 年，加重月余。自服“安神补脑液、谷维素等”效果不佳。今来本科要求针灸治疗。自诉现在每晚只能睡 2 ~ 3h，且总处于似睡非睡状态，记忆力减退，心烦口苦，纳差，大便干，小便黄。患者 16 岁时曾患有“神经衰弱”，否认有“高血压、心脏病、肝

炎、肾炎等”病史。查：神清，性情急躁，面色潮红。心率86次/min，律齐，无杂音，血压120/79mmHg。经CT检查，头部未发现器质性病变。舌质红，苔薄黄，脉弦数。诊断：中医：失眠（肝阳上亢型）；西医：神经衰弱。治疗：用电针百会、风池加耳贴脑点、内分泌、皮质下、神门、肝、肾等，治疗1个疗程即愈。随访半年未见复发。

十一、梅花针浅刺 辅以心理开导

神经衰弱是临床常见疾病，常规治疗效果往往不佳。徐燕林采用梅花针浅刺加拔罐，并配合心理开导治疗本病，效果较满意。

针刺治疗：患者俯卧位，常规消毒患者背部皮肤后，在背正中线两侧各1.5寸处，从T₁水平起至S₁水平止，用梅花针叩刺皮肤至发红或微出血，再沿两侧叩刺部位拔罐（一般每侧4~5只），20min后取下火罐，用消毒棉球拭去局部的少量出血。每日治疗1次，7次为1个疗程。

心理开导：耐心听取患者的叙述，鼓励其充分述说自己的病情，并尊重病人，取得患者对医生的信任。引导患者正确认识本病的可治性，帮助其树立治疗信心。建议患者合理安排作息制度，鼓励患者适当参加文体活动和体力劳动。同时向患者家人讲述病人的性格特点，做到正确对待病人，以利于提高心理开导治疗的效果。治疗期间患者停服安眠药。

中医学中的“不寐”包括了因神经衰弱所致的失眠。其病因主要是思虑过度，伤及心脾，气血两虚而心神失养；或抑郁恼怒，肝火上扰而心神不宁。徐燕林治疗时所取经穴系足太阳膀胱经穴，自大杼至三焦俞止，包括了肺俞、厥阴俞、心俞、肝俞、脾俞、胃俞等重要背俞穴，以梅花针叩打刺激这些俞穴，可达疏通经气，振奋心脾，行气活血，疏肝解郁，安神定悸之功。鉴于情志致病的特点，在针刺、拔罐的同时，辅以针对性的心理治疗，解除病人思想负担，并对治疗做出积极反应，往往可产生良好的临床效果。

李某，男，15岁，初三学生。因父母离异精神受刺激，终日感头昏、头胀、失眠多梦，上课时注意力不能集中，学习成绩明显下降，因面临中考不得不休学。发病后曾在几家医院治疗，症状无改

善。1990年5月前来本院就诊。体检和脑电图均正常，予以针刺加拔罐治疗，并辅以心理开导。3个疗程后，患者睡眠恢复正常，头昏头胀等症状消失，于同年9月恢复上学。

张某，女，32岁，营业员。1年前因所在柜组商品短少，错被怀疑受到委屈而发病。患者性情急躁多疑，常无故生气，因严重失眠而痛苦万分。头昏头痛，心慌胸闷，无食欲，多汗，全身乏力。曾多处求医，中西药并服，均无改善。自认为无法治愈，情绪十分低落，已在家病休半年。1991年4月就诊。体检和其他各项检查均正常。予针刺加拔罐治疗4个疗程，并同时心理开导。经上述治疗后，患者睡眠明显改善，绝大部分症状消失。3个月后患者返回工作岗位。

十二、内关—三阴交 随症配穴

游阿香采用针刺治疗神经衰弱，效果满意。

取穴：主穴：内关、三阴交。配穴：肝肾阴虚配太溪，肝气郁结配太冲，心脾两虚配足三里。

操作：患者取卧位，选准穴位，用75%酒精棉球常规消毒，选用2寸毫针直刺内关穴进针1.5寸深，用3寸毫针直刺三阴交进针2.5寸深，用2寸毫针直刺太溪穴进针1.5寸深，用3寸毫针直刺足三里进针2.5寸深，用1.5寸毫针直刺太冲穴进针1寸深。使每个穴位均有强烈的酸、胀、麻及触电样的感觉。留针40min，每10min行针1次。每日1次，7次为1个疗程，休息3天再行第二疗程。

神经衰弱的主要症状为失眠，注意力不集中，头昏，健忘，急躁易怒。内关是心包经上的穴位，具有宁心安神功效，三阴交是足三阴经脉之会穴，具有养血安神功效，太溪是肾经上的原穴，具有滋补肝肾之阴虚而安神功效，足三里穴是胃经的下合穴，具有补益心脾而安神功效，太冲是肝经上的原穴，具有疏肝解郁而安神功效。使心神得宁，失眠得除，神衰得愈。

许某某，男，48岁。诉失眠、头昏、急躁易怒1年，近3个月加重伴记忆力减退、耳鸣。经当地医院诊为神经衰弱，服中西药无效，于1995年4月20日就诊于针灸科。查神经系统正常，舌红少

苔，脉弦细。按肝肾阴虚型治疗。针1次后当晚能睡4个小时，针1周后症状明显好转，夜睡5~6h，2周后症状完全消失。随访半年未复发。

十三、随证取穴 中药穴敷

翟秀玲近几年来采用中药穴位敷贴治疗神经衰弱，取得了较满意的效果。

取穴：内关、心俞、大椎、神阙、脾俞、肾俞、足三里、涌泉等，一般双侧取穴。痰热内盛加丰隆；心胆气虚加胆俞；肾阴虚加三阴交；心阴虚加神门；腹胀纳差加中脘、胃俞。根据辨证配穴、药物归经选方。

药物：①当归、赤芍、川芎、桃仁、红花、桂枝、丁香、乳香各等分；②白芷、砂仁、白术、木香等各等分；③吴茱萸等。以上各组药物研成极细末，过100目筛，用白醋适量，调成厚糊状备用。

操作：治疗时穴位常规消毒，然后将药糊敷于穴位上，并用胶布固定，24h后取掉，每隔1~2天治疗1次。穴位敷贴处起水疱者应调整穴位或间隔治疗次数，一般10次为1个疗程。

情志活动是以五脏精气为物质基础，情志所伤影响五脏，耗伤五脏精气，使脏腑功能失调，血不养心，神不守舍而致不寐，其中以心、脾、肾关系最为密切。因心主血脉，主神明，上荣于脑，故首选内关、心俞、大椎以养心活血通脑。气血津液、水谷精微皆赖以脾所化生，故选脾俞、足三里以健其生化之源，选心肾之俞穴相配伍，使肾精上承于心，心气下交于肾，则神志安宁；加涌泉之意在于引火下行，除烦安神；神阙乃任脉一重要穴位，通过经络沟通内外，网络全身，与人体十二经脉、五脏六腑、四肢百骸、皮毛骨肉密切相连。药物通过神阙穴可输布全身，疏通气血，调整脏腑功能，达到整体治疗作用。

患者男性，50岁。失眠10年，入睡难，多梦易惊，心烦头晕，腰膝酸软，影响工作学习，舌质红苔少，脉沉细。心电图未见异常，西医诊断为神经衰弱，中医诊断为不寐，证属阴虚火旺。取穴：大椎、内关、心俞、肾俞、神门、三阴交、神阙、涌泉。隔日敷贴上述第①组中药1次。治疗1次后患者夜间能入睡，2次后能睡6h，

心烦、头晕均减轻,5次后睡眠正常,诸症逐渐缓解,随访7个月未复发。

参 考 文 献

- [1] 金钰钩,解秀莲,金钰红. 矩阵针刺治疗神经衰弱疗效观察. 甘肃中医, 1994, 7 (4): 61~63
- [2] 韦英才. 少阳经枢转方法调治神经衰弱 56 例. 广西中医学院学报, 1996, 2 (1)
- [3] 李智. 头部分区循经取穴治疗顽固性神经衰弱 105 例观察. 中医函授通报, 1995, (6): 29
- [4] 董建勇. 杨廉德针刺治疗神经系统疾病的经验. 甘肃中医学院学报, 2000, 17 (2): 8~9
- [5] 洪建云. 应用周德安“针灸治神十法”的临床体会. 针灸临床杂志, 1998, 14 (5): 14~15
- [6] 谭中军, 尚光伟, 麻建伟. 针刺治疗神经衰弱 53 例临床观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (4): 45~46
- [7] 王瑞霞, 黄庆文. 针刺治疗神经衰弱 76 例. 中国民间疗法, 2005, 13 (5): 13~14
- [8] 裴广祥, 颜士鸿. 针刺配合心理疗法治疗神经衰弱 40 例疗效观察. 中国针灸, 2000, (2): 85~86
- [9] 姚益龙, 李竟成, 白晓英. 针刺治疗神经衰弱 89 例. 陕西中医, 2004, 25 (3): 261~262
- [10] 徐耀智. 电针配合耳穴压籽治疗神经衰弱 52 例. 针灸临床杂志, 2001, 17 (7): 37
- [11] 徐燕林. 梅花针配合心理开导治疗神经衰弱 32 例. 安徽中医学院学报, 1995, 14 (3): 38
- [12] 游阿香, 郑主钦. 针刺治疗神经衰弱 45 例. 福建中医杂志, 1996, 27 (4): 38~39
- [13] 翟秀玲, 张电光, 王晓霞. 中药穴位敷贴治疗神经衰弱 80 例. 中国民间疗法, 2000, 8 (8): 20

【三叉神经痛】

三叉神经痛是以三叉神经分布区出现放射性、烧灼样抽掣疼痛为主症的疾病，是临床上最典型的神经痛。多发于40岁以上的女性，有原发性和继发性之分。属于中医学面痛、面风痛、面颊痛范畴。

中医学认为，本病多与外感风邪、情志失调、外伤等因素有关。风寒之邪侵袭面部少阳经脉、太阳经脉，寒性收引，凝滞筋脉，气血痹阻；或因风热毒邪浸淫面部，经脉气血壅滞，运行不畅；外伤或情志失调，或久病入络，使气滞血瘀。面部经络气血痹阻，经脉不通，产生面痛。眼部痛主要属足太阳经病证；上颌、下颌部痛主要属手阳明、足阳明和手太阳经病证。

针灸治疗三叉神经痛以疏通经络、祛风止痛为其基本原则，按部取穴为主。从治疗方法来看，有采用穴位注射、梅花针叩刺、透刺法等，有的强调轻刺激，有的采用深刺激，龙虎交战，重刺激等，均取得了一定疗效。

一、叉三针为主 随症加减

谢建谋采用靳瑞教授的靳三针疗法，应用叉三针配合穴位注射治疗三叉神经痛，疗效满意。

取穴：叉三针为太阳、下关、阿是穴（面部疼痛敏感点）。配穴：取相应经穴，眼支痛取太阳、阳白、四白、承泣；上颌支痛取下关、颧髂；下颌支痛取颊车、迎香、地仓、承浆。远端穴取双侧合谷、内庭、阳陵泉。

操作：下关穴略向下斜刺1~1.5寸，手法用提插泻法，使周围酸胀或麻电感放射至下颌。太阳、阿是穴及配穴均采用常规直刺1寸许，采用大幅度快速捻转泻法，使局部酸胀或针感向周围扩散；每5min行针1次，每次行针1~2min，留针30min后取针；取针后即刻进行穴位注射，取穴以阿是穴为主，配穴取疼痛神经支分布区域4个穴位，5ml针管5号细针头吸取复方丹参注射液4ml，常规消毒后，每穴注入0.5~1ml药液；每日1次，10次为1个疗程，疗程间休息3天。

靳三针疗法之叉三针针刺加穴位注射，除有针刺作用外，加上复方丹参穴位注射，丹参可活血化瘀，疏通气血，扩血管、改善局部微循环，再则药物注入到穴位上，对穴位起到机械和化学的刺激作用，随着药液的吸收而延长了针感，从而达到止痛的目的。

张某某，女，58岁，2001年5月16日初诊，患者以左侧面颊疼痛反复发作1年，加剧1周就诊，虽经多方治疗，病情未见好转。查：左耳前下关穴处、鼻翼外侧，颧髂穴部疼痛剧烈，痛如刀割，纳差，夜寐不安，舌质红、苔薄白，脉弦细，诊断为左三叉神经痛；给予针刺叉三针加穴位注射复方丹参注射液4ml，起针后即感疼痛缓解，以后每日1次，1个疗程后病情基本痊愈，继续巩固1个疗程而愈，随访1年无复发。

二、按部取穴 通络止痛

李莉采用电针配合穴位注射疗法治疗三叉神经痛，疗效满意。

取穴：取患侧穴位，第Ⅰ支疼痛者取鱼腰、阳白、攒竹、丝竹空、太阳；第Ⅱ支疼痛取下关、四白、颧髂、迎香；第Ⅲ支疼痛取承浆、地仓、颊车、下关、翳风。配穴：合谷、外关、足三里、内庭。

操作：患者取卧位，取30号不锈钢毫针，根据不同的疼痛部位，进针在0.5~1.5寸之间，得气后，连接6805-Ⅲ型电针治疗

仪，选取连续波，电流强度以病人能耐受为度，通电 30min，再留针 30min 至 1h，针刺颜面部穴位，一定要“气至病所”，意在通络止痛，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

穴位注射：取针后选取 2~4 个穴位，皮肤严格消毒后，取 2.5ml 注射器，抽取维生素 B₁ 1ml、维生素 B₁₂ 0.5ml、利多卡因 1ml，得气后回抽无血再注入药物，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

三叉神经痛是一种常见且多发的顽固性疼痛疾病，中医学称之为面痛，可因风寒之邪袭于阳明经脉以致气滞血瘀、经脉痹阻，不通而发生疼痛；或是风热毒邪，浸淫面部，影响经脉气血运行而致。李莉根据中医辨证的原则，选用下关、迎香、四白、地仓、颊车，或循经取穴合谷、内庭，穴属手足阳明经脉，具有疏风散邪、通经活络的功效，对调节阳明经脉之功效甚强。结合电针刺激，可直接作用于病变神经根，刺激受累的神经纤维组织，促进局部血液循环，改善局部营养，缓解肌肉痉挛，达到通则不痛的目的。穴位注射兼有针刺与药物的双重作用，使药物直达病所，直接作用于病灶，消除炎性水肿，产生局部止痛的效果。电针配合穴位注射疗法，奏效迅速，疗效巩固。

李某，女，55 岁，2005 年 7 月 5 日初诊。病史：1 月前突感左耳前及唇周出现放射性电击样的剧痛，咀嚼、张口时则疼痛加剧。查体：患者左耳前相当于下关穴处压痛明显，面肌略有肿胀。诊断：原发性三叉神经第Ⅱ、第Ⅲ支疼痛。按上述方法，电针治疗承浆、地仓、颊车、下关等穴，配合穴位注射疗法，经 1 个疗程后疼痛明显减轻；连续治疗 2 个疗程后，疼痛完全消失，随访 1 年无复发。

三、病位取穴 龙虎交战

刘来明采用龙虎交战法加耳压疗法治疗三叉神经痛。

体针：主穴：第 1 支：阳白、头维；第 2 支：太阳、四白、颧髎、下关；第 3 支：下关、地仓、颊车、承浆。配穴：合谷、三阴交、太冲、足三里。采用 2 寸毫针，面部穴位得气后，第 1 支穴位头维，第 2 支穴位下关，第 3 支穴位颊车，先以左转为主，大拇指向前用力捻转九数，再以右转为主，大拇指向后用力捻转六数，如

此反复施行多次。面部余穴均采用平补平泻法，同时配以合谷、太冲、足三里、三阴交。留针 30 ~ 40min，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，休息 2 天，继续下 1 个疗程。

耳针：交感、神门、面颊区。左侧三叉神经痛者取左耳穴，右侧三叉神经痛者取右耳穴，王不留行籽压于交感、神门、面颊区。嘱患者反复多次按压，尤其疼痛发作时按压。

三叉神经痛属中医学面痛范畴，常由风寒、风湿及情志不遂而导致气郁不畅，阻于经络，气血运行受到影响，气滞血瘀而致面痛。三阳经脉均上延于头面部，且耳为“宗脉之所聚也”。为此，以手足三阳经穴为主，尤以三叉神经 3 个分支循行部位的局部取穴为主。配合耳压疗法，以疏通经络，调和气血。且头维、下关、颊车三穴在三叉神经分布区域内，采用龙虎交战法可增强止痛效果。

陈某，女，41 岁，教师。2002 年 7 月 8 日就诊。右面颊反复阵发性烧灼样疼痛 2 年，在某医院神经内科诊断为三叉神经痛，予卡马西平 2 片，每日 4 次口服，维生素 B₁₂ 片，每日 3 次口服，疗效甚微，前来本科就诊。症见：右侧下关穴周围烧灼样疼痛，持续约 40min，每日发作数次，心烦，睡眠不佳，口干不欲饮，舌质红，苔薄白，脉弦。采用龙虎交战法加耳压疗法治疗 7 次后，疼痛程度明显减轻，且发作次数减少。针治 2 个疗程后，症状完全消失。治疗期间，卡马西平逐渐减量至停药。停药卡马西平后，针刺配合耳压疗法巩固 1 个疗程。随访 1 年未复发。

四、透针法 强刺激重手法

三叉神经痛是一种原因未明的面部三叉神经分布区域内反复发作的、短暂的、阵发性剧痛，又称原发性三叉神经痛。属于中医学的头风、面痛、眉棱骨痛和阳明头痛的范畴。孙巧采用透针法治疗该病。

发病初期采用局部透刺方法治疗。第一支痛：攒竹透鱼腰，阳白透鱼腰；第二支痛：太阳透下关，四白透颧髻；第三支痛：太阳透颊车，夹承浆透颊车。针刺得气后，继续行针，使针感至整个疼痛分布区，采用中等刺激强度，留针 40min，间隔 5min 捻转行针 1 次，5 次为 1 个疗程，1 个疗程后可间歇 1 ~ 2 天后行针刺疗法。发

病后期用强刺激手法，除局部透刺外，加刺合谷、间使、太冲。

中医认为本病初起为风寒、风热之邪袭于阳明筋脉，侵注面部，凝滞筋脉，影响筋脉气血运行而致面痛。患者性情烦躁，因肝主情志，肝气郁结，郁而化火，横逆犯胃，胃火上炎，致肝胃实火。针刺局部穴位可使局部气血经络通畅，通则不痛，又加之远端取穴，旨在疏通面部筋脉，祛寒清热，清泻肝胃，使气血调和。本病病情顽固，病人非常痛苦，故用一般针刺手法收效甚微，采用透穴强刺激重手法，加强局部血液循环，解除局部肌肉紧张、痉挛、使气血得以畅通，通则不痛，故可收效。

杨某，女，54岁，退休工人。十年前因吃饭引起右侧面痛，疼痛为刀割样，每次疼痛10余秒，每日发作3~4次，近1个月来，发作次数增多，一日内发作20~30次，曾服维生素B₁及维生素B₆，服时疼痛减轻，停药后疼痛复发，如此反复发作。1993年9月8日初诊。症见：右侧面部如刀割样疼痛，每日吃饭或说话引起疼痛发作，每日疼痛发作20~30次，每次疼痛1min左右，兼口渴、目赤、大便干燥。中医诊断：右侧面痛（肝胃实火）。西医诊断：右三叉神经痛（第二、第三支疼痛）。治则：清利肝胃之火、镇痛养血为主。针刺取穴：太阳透颊车、太阳透下关。针感达二、三支疼痛分布区。配穴：合谷（双）、太冲（双）、内庭（双），留针40min，行泻法，强刺激手法，10次为1个疗程，间歇3天继续下1个疗程治疗。患者经过20次治疗，上述诸症消失。

五、独取阳明 通经络

徐大群采用阳明经取穴针刺治疗三叉神经痛。

取穴：患侧承泣、下关，对侧丰隆，双侧合谷、厉兑。

操作：穴位严格消毒，选30号1.0寸毫针垂直刺入，捻转进针，得气后行提插泻法，（承泣、厉兑2穴不行手法）。留针30min，每隔10min行针1次。治疗每周2~3次，3周为1个疗程。疗程间休息2~3天。临床治愈后每月针刺1~2次巩固疗效。1年后无复发者停止治疗。

中医学认为疼痛皆由不通而致，即“痛则不通、不通则痛”。凡风寒侵袭、风热壅滞、痰湿内盛、瘀血阻络均可导致经脉失通、气

血不畅而发生疼痛。故凡治痛均应以通为法。阳明为多气多血之经，为通经络、行气血之最要，且手足阳明经均上行头面，按“经脉所过、主治所及”之原则，应选此二经之腧穴治疗该病。本法采用“远近配穴”，选择足阳明胃经之承泣、下关与丰隆、厉兑相配合，以疏通该经气血，辅以手阳明大肠经之原穴合谷，取“面口合谷收”之意。诸穴配合，行以泻法，可达通调经络、行气活血之效。

莱斯蒂，女，55岁，德国人，牙医助手。1994年5月10日就诊。病史：右侧面部持续灼痛、阵发性加重28年余。每日疼痛发作数次至数十次。可因受寒、咀嚼、漱口、疲劳而加重。西医确诊为三叉神经痛。曾于1983年行三叉神经局部切除术治疗，疼痛缓解2年，后复发。来诊时疼痛日发作20次左右，每次持续10~30s。查体：右侧面部肌肉紧张，余无异常。按上述方法针刺治疗，每周3次。针8次后明显好转，疼痛大减，每日仅发作5次以下，每次持续5~10s。治疗7周后，诸症状基本消失，临床治愈。后每月针2~3次巩固疗效。18周后未见复发，停止治疗。随访1年未见复发。

六、辨证取穴 虚补实泻

陈萍采用针刺拔罐法治疗三叉神经痛，疗效满意。

取穴：主穴：合谷、翳风、阿是穴，背部反应点（在十二胸椎以上的膀胱经或督脉经上寻找红点或紫黑色斑点）。配穴：眼支痛配鱼腰，上颌支痛配四白，下颌支痛配下关（以上穴位均取患侧）。其中风寒袭络型加风池；风热侵袭阳明经者加内庭、大椎；风热侵袭少阳经者加太冲、大椎；痰湿阻滞型加足三里、三阴交。

操作：鱼腰、四白两穴进针后出现放射样传感，内庭、太冲用泻法，足三里、三阴交用补法，其余穴位平补平泻，施术完毕后接6805治疗机，选用断续波，刺激量以患者耐受为度，每日1次，每次40min，10次1个疗程，疗程间休息3天。阿是穴、大椎用三棱针点刺拔罐，出血量约2ml，隔日1次，若背部有反应点者，用锋钩针刺入约0.4cm然后用力挑断白色纤维组织数根即可，然后用创可贴外敷，5天1次，每次2~3个反应点。

本病属中医学“面痛”范畴，多因风寒、风热之邪侵袭阳明、少阳经脉，或痰湿闭络、气血瘀阻所致。在本病例的治疗中，分清

证型后，以循经取穴和局部取穴相结合的原则选穴组方。循经取穴以泻其经之有余，补其经之不足。痰湿阻滞型乃为虚实夹杂，脾虚湿困，湿邪阻于面部而致本病，故取脾胃经的两穴足三里、三阴交，用补法以健脾胃，除湿邪。而局部取穴，达到了激发经气，活血通络之目的。而风热侵袭阳明、少阳经者，分别取其经或相表里经之荥穴：内庭、太冲，“荥主身热”泻之能祛其经之邪热。中医认为“痛则不通”，面痛久病入络，瘀血停滞，按“宛陈则除之”的原则，阿是穴刺血拔罐可起到活血化瘀通络止痛之效。背部的红、紫、黑色斑点，是热邪或寒邪、瘀血等在背部的反映，挑刺可祛除邪热，疏解寒邪，通经活络。气血疏通，阴阳得调，则病可除。

李某，女，40岁，1994年8月15日初诊。主诉：右面部疼痛3年余，经中西药物治疗效差，近日加重。常因洗脸、进食等引起疼痛发作，右侧眼支、上颌支电击样阵发性疼痛，每次约2~3s，每日发作10余次，不敢触摸，疼痛停止后，面部有灼热感，口臭，鼻燥，咽干，舌质红，苔薄黄而干，大便3日未引。脉浮而数，诊为三叉神经痛（风热型），按风热侵袭阳明证型取穴治疗，当日疼痛即减，大便通，发作次数减少，9次面痛完全消失。随访半年未复发。

七、下关 - 合谷 随症配穴

三叉神经痛是临床上常见的一种疼痛性疾病，复发率高，药物不易控制。张玉红使用针刺与耳穴贴压相结合的方法治疗该病，取得显著效果。

取穴：主穴：下关、合谷。随症配穴：眼支分布区疼痛配太阳、阳白，上颌支分布区疼痛配四白、颧髁，下颌支分布区疼痛配颊车、听会，3支均疼痛时同时针上述诸穴。

操作：患者取端坐位，定准穴位常规消毒，用1~2寸毫针垂直刺入，捻转进针。得气后留针30min，每隔10min行针1次，每日1次，12次为1个疗程，疗程间间歇3天。以上均取患侧穴位，施捻转泻法，刺激量宜轻，手法应轻巧灵活。

耳穴贴压：面颊、额、上颌、下颌、神门。耳郭常规消毒，用0.5cm×0.5cm的橡皮膏将王不留行籽贴压于所选的耳穴上，嘱患者每日按压3~5次，每穴3min，两耳轮换，3天换贴1次，疗程间

歇3天（与体针同步）。

本病属中医面痛范畴，中医学认为疼痛皆由不通而致，即“痛则不通，不通则痛”。故在治疗上，以局部近取为主，下关为足阳明、少阳经之交会穴，合谷为手阳明大肠经原穴，阳明为多气多血之经，针之可疏通阳明经脉，调和面部气血，使之畅通而痛止，使用针刺与耳穴贴压相结合，提高对穴位的刺激强度，延长了针刺作用于穴位的时间，增加了止痛效果，从而使临床疗效大大提高。

患者，女，40岁，于1999年8月6日就诊。病史：右侧面部疼痛10余年，经神经科诊断为三叉神经痛，使用中西药物、针灸治疗，症状无明显好转，遂来本科就诊。疼痛时发时止，右侧面部皮肤及鼻翼部触之即痛，右眼睑亦痛，夜间疼痛影响睡眠，发作时疼痛如刀割，止时如常，来诊时疼痛日发作20次左右，每次持续10~30s。按上述方法治疗，1个疗程后疼痛明显好转，每日仅发作2~5次，每次持续6~10s。治疗3个疗程后，诸症状基本消失，临床治愈。以后每月治疗2~3次巩固疗效。20周后未见复发，停止治疗，随访1年未复发。

八、深刺强刺激 配穴注

孟昭记采用针刺配合穴位埋线治疗三叉神经痛，疗效比较满意。

取穴：主穴：第一支疼，取太阳透下关，阳白透鱼腰；第二支疼，迎香透巨髎，巨髎透下关；第三支或第二、三支疼，颊车透大迎，夹承浆。配穴：风池、翳风、三间、合谷、内关、足三里、太冲。

操作：选用2~2.5寸毫针，用直刺或斜刺透穴，直刺针尖一定要接触骨面，斜刺针体要紧贴骨面，每次取上述穴位4~5穴，交替使用，以捻转手法为主。进针出现针感后，接G6805型治疗仪，一根线接在颜面部主穴上，另一根线接在上肢配穴上，选用疏密波，其频率在100~200次/min，输出强度可见面部有较轻微动感为宜，也可根据病人的最大耐受量加以调整。连续通电30~40min，每日或隔日1次，10次为1个疗程。休息3~5天，开始第二疗程，直至疼痛消失。

穴位埋线：将皮肤消毒后，在穴位两侧1.5~3cm处局麻，用持

针器夹住带羊肠线的三角针，由一局麻点穿过穴位，由另一局麻点穿出，多次来回牵拉羊肠线，使穴位产生麻胀感，然后紧贴皮肤剪断羊肠线，敷盖纱布。羊肠线留在体内的部分力求长些，线头一定植入皮下，不得外露。取上述穴位，每次埋线3~5穴，每月1次，交替使用，一般1~2次痊愈。

孟昭记认为该病是由于“风邪侵入经络，气血凝滞而不行”所致。因此，根据《灵枢·始终篇》“刺诸痛者，其病皆实”，说明诸疼皆属实证。《灵枢·九针十二原篇》“虚则实之”“满者泻之”的原则，应用电针治疗，加强刺激强度，使面部经络气血疏通，达到阴阳平衡，因而取得了“通则不痛”的效果。

三叉神经痛必须循经取穴，沿手阳明大肠经和足阳明胃经，取上述穴位，深刺直达骨部，沿骨膜透穴位，针感才明显，所以镇痛效果甚佳。得气是取得疗效的前提，“气至病所”是针感集中病处的现象。在临床实验中，采取一定手法，可使针感集中于痛处，这就反映了行气至病所的现象。

羊肠线埋入人体有关的穴位，既有针刺的机械刺激，又具有持久柔和的“长效针感”效应。羊肠线作为一种特异性刺激，有增强肌体免疫功能的效应；同时，埋线刺激了穴位，起到了疏通经络、调和气血的作用，以达到病愈的目的。

朱某某，女，52岁，干部，1996年12月6日初诊。主诉：右侧面部呈阵发性锐疼犹如刀割，难以忍受。每日10~20次，每次数秒或数分钟，夜间疼痛影响睡眠。在当地医院按三叉神经痛治疗，先后用利多卡因、654-2封闭5次，用无水酒精封闭3次，口服卡马西平等药物，疼痛缓解1年，后又复发，且逐年加重，于是来本院治疗。检查：病人痛苦面容，右侧面部第二、第三支神经分布区域为阵发性疼痛，伴有肌肉抽动，尤其在右侧太阳穴处扳机点明显，每逢轻微触动即引起疼痛发作。脉弦滑，舌质暗淡，苔黄。西医诊断：三叉神经疼（右侧二、三支），中医诊断：面疼。按上述治疗2次后疼痛开始减轻，4次后疼痛明显减轻，仅洗脸、吃饭时偶尔轻微疼痛。7次后疼痛完全消失。愈后又连续治疗6次，以巩固疗效。年后随访疼痛未复发。

九、深刺太阳 随症配穴

朱进贵, 根据解剖学位置, 针对性选用分布在神经干及其周围的穴位, 针刺治疗原发性三叉神经痛, 取得较为满意的疗效。

取穴: 主穴太阳。如眼支分布区疼痛配眶上点、四白; 上颌支分布区疼痛配颧髁; 下颌支分布区疼痛配下关、颧髁; 3 支均疼痛时, 同时针上述诸穴。

操作: 选用 32 号 1.5 寸毫针和 2 寸毫针。

(1) 针刺太阳法 右手拇、食指持针, 左手食指指甲切太阳穴, 快速进针后, 针体向后向下呈 45° 角, 针尖刺向翼腭凹, 深度达 1.5 ~ 2 寸, 下颌有麻木感即为得气, 提插捻转 6 ~ 9 次, 每间隔 5min 提插捻转 1 次, 3 ~ 4 次即可起针。

(2) 四白针刺法 在瞳孔直下一寸处, 用左手食指指甲切住眶下孔凹陷, 右手拇、食指持针快速刺入皮下, 找到眶下孔, 直刺 1 寸时面部感觉麻木即为得气, 行针同太阳穴。

(3) 眶上点刺激法 在眶上缘内侧角处, 用左手食指指甲尖端切住眶上缘, 同时指腹向下压住眼球, 右手拇指、食指持针快速进入皮下, 针尖向上沿眶内上壁进针 1 寸, 轻轻提插捻转 6 ~ 9 次, 即可留针, 行针同太阳穴刺激法。

(4) 颧髁刺激法 该穴在下关穴前 1 寸, 颧弓中段下缘陷凹中。左食指切穴, 右拇指、食指持针快速刺入皮下, 向后上刺入下颌关节深部 2 寸, 出现下颌麻木为得气, 余同太阳穴。

提插捻转手法不能止痛时, 可在主配穴针柄上连接脉冲电流, 选用疏密波, 强度以患者能够耐受, 刺激 20min, 止痛效果更好。

每日治疗 1 次, 10 次为 1 个疗程, 疗程间可休息 5 ~ 7 天。

根据解剖部位, 选取疼痛分布区神经干上分布的穴位, 用毫针直接刺激神经干, 出现麻木、发热时, 疼痛即可缓解, 说明该法是治疗三叉神经痛的有效方法。针刺太阳穴的方向和深度应力求达到三叉神经第二、三支通过的部位, 才能取得满意疗效。针刺眶上点、四白穴时, 由于该部位组织疏松, 血管丰富, 进针时应避开血管, 起针后应按压 1 ~ 2min, 以免刺伤血管造成皮下血肿。

潘某, 女, 67 岁, 广东电白县人, 家庭主妇。病史: 左眼眶周

围及左前额发作性烧灼样疼痛伴流泪，每次发作历时数秒至1~2min左右，发病已42天。发病后曾在当地医院诊治，诊断为右侧三叉神经第一支疼痛，服用止痛药以及针灸治疗，晚上疼痛消失，但白天疼痛未见减轻，有时早上8~9点疼痛反复发作可持续1~2h。于1989年3月28日就诊，诊断为左侧三叉神经痛（眼支）。取穴左太阳穴配左侧眶上神经点，进针得气后提插捻转9次，每隔5min操作1次，共4次。左前额及左眼眶周围疼痛缓解，次日复诊时，发作性疼痛明显减轻，时间缩短。连续针刺治疗5次，疼痛未再发作，观察1周后回家。半年后随访，未再复发，疗效巩固。

十、针药并用 辨证施治

宋丽娟采用针刺结合电针和中药治疗三叉神经痛，取得了满意疗效。

（1）电针治疗

取穴：主穴：一支痛，取鱼腰、太阳、头维、阳白、攒竹；二支痛，取四白、迎香、大迎、颧髂；三支痛，取下关、地仓、颊车、夹承浆、翳风。配穴：合谷、内庭、太冲、风池。

操作：为了提高疗效，可用透穴针治：如迎香透巨髎，巨髎透下关，以控制一支扳机点；又如颊车透大迎、夹承浆透大迎，以控制二支扳机点。为延长刺激时间，一般宜留针20~30min。电针采用G6805治疗仪，一根导线接在面部主穴上，另一根导线接在配穴上，用疏密波，频率14~26次/min，一般诱导20min，以进行辅助治疗。

以上针治均须根据病人耐受程度为限，以达到治疗目的为度的治则进行。每日针治1次，每次取穴4~6个为1组，每组取主穴3~4个，配穴1~2个，每组交替取穴，10次为1个疗程，每个疗程后休息1~2天。

（2）中药治疗 主要分为风热偏盛型和肝阳偏盛型。

风热偏盛方药：丹参15g，川芎15g，全蝎3g，僵蚕12g，防风10g，杭菊10g。

肝阳偏盛方药：天麻12g，钩藤15g，丹参15g，川芎15g，全蝎3g，水蛭6g。

施术须仔细，进针宜谨慎，切忌粗暴针治。因为面部神经血管

分布稠密，注意不周，易出现血肿，如有血肿，应及时拔针，按压处理。暂停在血肿部位取穴，待两天左右血肿自然消失后，仍可继续取穴施术。

陈某某，男，56岁，1992年10月11日门诊。主诉：两个月前，右侧面部出现阵发性疼痛，肌肉抽搐，病情日渐加重。症见：在右侧面部二、三支三叉神经分布区，发作时出现电击、烧灼样短暂阵性剧痛，持续时间自几秒至十几秒，每天发作10~20余次。角膜反射消失，上唇与颊部之间有一扳机点，稍加触动，疼痛即可发作，洗脸、刷牙、咀嚼均可诱发疼痛。面潮红，苔薄黄，脉弦细。诊断：右侧三叉神经痛，属风热偏盛型。针治取穴：下关、颊车、翳风、夹承浆、颧髻、迎香、风池、合谷。每次针治交替取4~6穴，留针30min，电针诱导20min。每日治疗1次，针刺12次，服用中药风热偏盛型方5剂后，疼痛消失，面痛治愈。

十一、独取颧髻 针灸并用

原发性三叉神经痛是面部三叉神经分布发生的一种原因未明的阵发性烧灼样疼痛，国医学又称“面痛”、“头风”。孔尧其采用针刺颧髻穴治疗该病，效颇佳。

取穴：颧髻。

操作：坐位或仰卧位，常规消毒后，用28号3寸毫针垂直进针1.5~2寸左右，针行泻法，以病人有触电样针感并扩散至整个面部为得气，留针15~30min，留针期间，可在针柄套2cm长艾条点燃，施行温灸，每天1次，10次为1个疗程。

三叉神经痛虽发生原因未明，但一般认为与病毒感染、受寒等有关。面部为太阳、阳明和少阳经经行之处，颧髻穴归于手太阳小肠经，具有熄风通络之功，且为太阳、少阳之会穴，针行泻法，可疏导面部经气，消太阳风热、泻少阳风火，而有清热泻火、消肿止痛之效，达到“通则不痛”的目的。或因受寒而发，或久痛不愈，寒凝经络，则在针柄加艾温灸，以温通经气，寒去络通，痛也自消。故每每获效。

姚某，女，66岁，退休工人。1996年11月1日初诊。患者于4年前患左侧面痛，疼痛以上、下颌处较为明显，下关穴附近一触即

发,累及整个面部。疼痛呈烧灼、刀割样剧烈跳痛,痛时伴面红、面肌痉挛、流泪,疼痛持续数分钟后会自行缓解,而后又复发。近来因复发次数增多、疼痛时间延长而求诊,即予上法治疗,针进2寸左右,即有触电样感觉,疼痛随之减轻,留针30min。嘱每日来诊1次,但患者因疼痛缓解,常隔2~3天治疗1次,6次后疼痛完全消失,随访半年无复发。

十二、特定穴 清热降火

陈辉星以针刺特定穴为主治疗三叉神经痛,取得显著效果。

取穴:特定穴在疼痛一侧太阳后下0.5至1寸颧骨上缘处。配穴:翳风、合谷、下关。

操作:穴位皮肤常规消毒,选用28号3寸毫针,右手持针,在特定穴处快速刺入皮下,由颧窝与颧弓后缘间向内下斜刺,缓慢进针,当针刺入2~3寸时,针尖约至蝶腭神经节处,患者感觉半侧面部有酸麻胀感,即停止进针,用低频小幅度捻转手法,行针5min后,留针30~50min。也可直接接电针仪用低频连续波。配穴可适当选用,先刺主穴后刺配穴。治疗每天1次,10次为1个疗程。

三叉神经痛多为三阳经郁热,上泛于头面。所用特定穴为足阳明和手阳明经所循行的部位,可以清泻阳明郁热。下关为足阳明、少阳之会穴,合谷为手阳明大肠经原穴,翳风为手足少阳经之会穴。诸穴共用可清热降火,通经活络,达到泄热宣郁的治疗目的。

王某某,女,57岁,退休工人。1995年4月21日初诊。主诉:面痛2年。每日阵发左面颊处疼痛,持续数分钟。曾经西医药物治疗,效果不佳。患者平素心烦易怒,胃脘部不适,口干,大便秘结。舌苔淡黄有裂痕,脉细数。诊断:三叉神经痛。辨证为阳明热盛,上扰头面。治宜清泄阳明郁热。选穴:特定穴、下关、翳风、合谷。治疗2次,疼痛发作时间向后推迟3~4h。针5次后,疼痛明显减轻,但仍有不适感。后用电针治疗2次后疼痛消失。2年后随访无复发。

十三、针刺透穴 导气直达病所

吴光远运用针刺透穴疗法治疗三叉神经痛,疗效满意。

取穴：以病侧的神经分支取穴。第一支神经痛，取太阳、阳白、鱼腰、攒竹。第二支和第三支神经痛，取下关、承泣、四白、颊车、迎香。并按中医辨证配以辅助穴位，至阳、合谷、外关、足三里等穴位，加强疗效。

操作：除太阳直刺外，均采用透穴疗法，横刺透穴进针，阳白透鱼腰、鱼腰透攒竹、承泣透四白、下关透颊车、四白透迎香。采用强刺激，有酸、麻、胀等针感后留针 30min，其间每隔 5min 行针 1 次。每日 1 次。10 次为 1 个疗程。疗程间休息 2 天。

透穴疗法选穴应少而精，针刺深浅要适度，刺激应强，以患者能耐受为度。由一穴透往另一穴或双针交叉对刺，针感强，导气直达病所可迅速止痛。

吴某，女，58 岁，工人，自述 2 年前于进食时左侧面部发生剧痛如刀割样，痛至鼻弯及上唇部，每次疼痛持续 10 余分钟，反复发作，不堪忍受。曾用多种止痛药，疗效不理想。诊断为三叉神经痛，采用针刺透穴疗法治疗，取穴下关、颊车、承泣、四白、合谷。下关透颊车，使牙周出现酸胀感，承泣透四白，使上牙及上唇出现触电感，合谷穴刺健侧，进针 1 寸后调整针感，使其上传至肘部或肩部。经过 12 次治疗，疼痛消失，随访至今未复发。

十四、针刺配中药 通络止痛

张炉高采用针刺配合中药治疗三叉神经痛。

取穴：面额支痛取阳白透攒竹、丝竹空透曲鬓；上颌支痛取颧髻透巨髻、下关透耳门或下关直刺；下颌支痛取颊车透大迎、下关直刺。

操作：每次取 1~3 个穴位，平补平泻，切不可用强刺激或电针；留针 15~20min，每隔 5min 捻转 1 次，治疗 7 次为 1 个疗程。

中药：水牛角 30~50g（先煎），升麻 10g，防风 10g，川芎 15g，羌活 10g，白芷 10g，黄芩 12g，白附片 10g（先煎），炙甘草 5g。每日一剂，用 2 份水掺 1 份黄酒煎，每剂药早晚 2 次分服，7 天为 1 个疗程。

本病发作突然，疼痛短暂而呈闪电样，形如风袭，故面痛与风邪有关，又“风为百病之长”，风邪挟郁火痰浊上扰面部，阻滞少

阳、阳明经气，遂致本病。据此，张炉高采用针刺通络止痛之法以治标，运用中药祛风通络、解痉止痛以疗本。取下关、阳白、巨髎、颊车、曲鬓、丝竹空等阳明、少阳经穴为主，并采用透穴法以加强针感；中药水牛角、黄芩以清热泻火解毒，防风、白附子、升麻、羌活、白芷、川芎等药以祛风止痛解痉，针药相配，相辅相成，共奏祛风、清火、通络、止痛之功，而获良效。

陈某，女，52岁，农民，1993年8月22日初诊。主诉：上颌剧烈疼痛7个月，经外院诊断为三叉神经痛，几易医院，效果不显。常因进食、洗脸、刷牙不慎诱发疼痛，为电掣样灼刺痛。针刺阳白透攒竹、丝竹空透曲鬓，平补平泻，留针20min。中药上方加羚羊角。治疗3天疼痛明显缓解，治疗1个疗程痛止，改拟养血祛风之中药以善其后，1年后随访未复发。

十五、透刺强针感 配耳压

胡玉茹采用针刺配合耳穴治疗三叉神经痛，获得较好疗效。

取穴：面额支痛取攒竹透阳白，丝竹空透头维；上颌支痛取阳白透颧髎，下关，迎香直刺；下颌支痛取颊车透大迎，大迎透承浆，下关直刺。另各支疼痛均加刺合谷穴。

操作：采用平补平泻法，针刺得气后留针30min，其中合谷为常用远端穴，针刺得气后，提起针柄向上提插捻转，使针感上达面部。以上各穴每日1次，12次为1个疗程。

耳压：取额、神门、枕、上颌、下颌、面颊、肝、胃、肾、皮质下。以王不留行籽为压物，在上述穴位中选5~8个敏感点，以患侧耳穴为主，隔日1次，并嘱患者每日按压3~5次，每次5~10min，务使耳部出现胀热、酸痛的感觉，2天为1个疗程。

三叉神经痛多与风邪有关，而三叉神经分布区内为少阳、阳明经循行所过，风寒、风热之邪可单独侵袭少阳、阳明筋脉，使之气血凝滞不行，遂致面痛；亦可挟郁火痰浊上扰面部，阻滞少阳、阳明经气而致本病，因此，胡玉茹采用针刺通络止痛，刺攒竹、阳白、丝竹空、下关、大迎、颊车、承浆等阳明、少阳经穴，用透刺法加强针感，合谷穴为阳明经穴，多气多血，是治疗头面部要穴。耳穴疗法对各部位神经痛均具有不同程度镇痛作用，王不留行籽辛、甘、

平,具有活血通经作用,耳压肝、胃、皮质下、神门穴以疏利肝胆气机,安神定志;枕上颌、下颌、面颊为面部疼痛相应部位,按压该处以使局部气血通达,故两法相合而获良效。

刘某,男,63岁。1997年5月来诊,主诉:上颌剧烈疼痛3个月,经外院诊为三叉神经痛,曾口服卡马西平及中药,未效,常因进食,刷牙,洗脸发作,其痛如刀割,剧烈难忍,饮食、睡眠均受影响。即以针刺配全耳穴贴压治疗,选用攒竹透刺阳白,丝竹空透头维,合谷,均平补平泻留针30min,耳穴压额、枕、神门、肝、胃、皮质下。治疗第3天后,疼痛明显缓解,继续治疗1个疗程后痛止,一年后随访未复发,痊愈。

十六、针刺为主 配制络拔罐

张继红用针刺加刺络拔罐治疗三叉神经痛,收到较好效果。

取穴:面颌支取风池、耳门、太阳、阳白、丝竹空、攒竹;上颌支取风池、听宫、四白、颧髁、下关、迎香;下颌支取风池、听会、大迎、颊车、地仓、夹承浆。

操作:耳门、听宫、听会、下关均用30号2寸毫针直刺入1.8寸,使酸麻胀感向面部放射,其他面部穴浅刺。针刺之后在疼痛局部用三棱针点刺出血后拔罐,出血量可达5ml,留罐5min,至瘀血流尽起罐。针刺每天1次,刺络拔罐隔日1次,10天为1个疗程,疗程间休息2~3天,若患者正在服用卡马西平等止痛药。针刺后不宜骤然停服药物。应缓慢减量以至停药。

三叉神经痛属于中医面痛范畴,多由风寒、风热以及情志不遂,肝失条达导致气郁不畅,阻于阳明经络,影响筋脉气血运行,形成气滞血瘀而致面痛。在治疗时取风池穴能祛风通络,疏肝理气,降逆镇痛,耳门、听宫、听会均距三叉神经出颅部位最近,与其他面部穴位均属于局部选穴。由于气滞血瘀,经络不通而引起疼痛,根据“宛陈则除之”的治疗原则,刺络拔罐可疏通面部筋脉,使气血调和,通则不痛。因此此疗法有较好的止痛疗效。

王某,女,20岁,教师。2000年3月2日初诊。主诉:右面颊阵发闪电式疼痛3年,在省级医院疼痛科诊断为三叉神经痛并治疗,收效不显,故来本科治疗,当时每天服用卡马西平9粒,仍时有疼

痛。经针刺风池、听宫、听会、下关、四白、颧髻、迎香、口禾髎、大迎、颊车、地仓、夹承浆，起针后在疼痛局部用三棱针点刺出血后拔罐，每日针刺1次，刺络拔罐隔日1次，卡马西平逐渐减量至停药。共治疗4个疗程，痊愈，随访至今未复发。

十七、耳体穴并用 强刺激

顽固性三叉神经痛是针灸科的常见病，孙力在多年的治疗过程中发现耳穴刺激为主治疗本病，疗效较为满意。

耳穴刺激：取面颊、皮质下、神门。上颌支痛配上颌穴；下颌支痛配下颌穴；眼支痛配额穴。用0.5~1寸毫针针刺，强刺激，每隔5min捻转行针1次，留针45~60min。对特别顽固者，则给予穴位注射，用维生素B₁100mg及维生素B₁₂2.5mg的混合液，每次选2~3穴，每穴注射0.1~0.2ml。以上两种方法均每日1次，双耳交替使用。

体穴刺激：取双侧合谷穴，上颌支痛配承泣、下关；下颌支痛配下关、承浆；眼支痛配鱼腰。用1.5寸毫针针刺，强刺激，要求针感“气至病所”，如针刺承泣、鱼腰，使针感扩散至整个眼眶部；针刺下关要求针感扩散至上颌、下颌及牙部；针刺承浆则使针感传至下牙部。留针30~40min，每日1次。每次先用耳穴刺激法，后用体穴刺激法，若针刺耳穴后疼痛明显减轻，则不用针刺体穴。以上方法12次为1个疗程，休息5天，继续下1个疗程。

此病属中医“面痛”范畴，多由风寒或风热之邪侵袭阳明筋脉，邪阻经络，气血瘀滞，“不通则痛”，而发为面痛。在治疗中以耳穴刺激为主，耳与身体其他部位均有密切联系，《内经》中就有十二经脉，三百六十五络之气上达于耳的论述。《灵枢·口问》说：“耳者，宗脉之所聚也。”另外，从现代医学角度来分析，耳廓的神经分布极为丰富，其中就有来自三叉神经分支的耳颞神经，故刺激耳穴即可达到疏经通络，祛邪止痛的目的，再配合面部少而精的几个穴位，更加强了通络止痛之力。

参考文献

- [1] 谢建谋, 路月香. 叉三针加穴位注射治疗三叉神经痛 35 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (4): 37~38
- [2] 李莉. 电针配合穴位注射治疗三叉神经痛 40 例. 云南中医中药杂志, 2007, 28 (1): 25
- [3] 刘来明. 龙虎交战法配合耳压疗法治疗三叉神经痛 26 例. 河北中医, 2003, 25 (11): 844
- [4] 孙巧. 透针法治疗三叉神经痛 24 例. 针灸临床杂志, 1995, 11 (7): 42
- [5] 徐大群. 阳明经取穴针刺治疗三叉神经痛 17 例. 中国针灸, 1997 (12): 734
- [6] 陈萍, 王春霞. 针刺拔罐治疗三叉神经痛 45 例. 针灸临床杂志, 1998, 14 (6): 19
- [7] 张玉红, 张罡. 针刺加耳穴贴压治疗三叉神经痛 32 例. 中国针灸, 2005, 25 (11): 809
- [8] 孟昭记, 张士军, 胡大利. 针刺结合穴位埋线治疗三叉神经痛 60 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (8): 17~19
- [9] 朱进贵. 针刺治疗三叉神经痛 96 例. 中国针灸, 1997, (10): 621~622
- [10] 宋丽娟. 针药并治三叉神经痛 46 例. 江西中医药. 1995, 增刊: 45~46
- [11] 孔尧其. 针刺治疗原发性三叉神经痛临床观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (7): 11~12
- [12] 陈辉星. 针刺治疗三叉神经痛 40 例. 中国针灸, 1998, (3): 136
- [13] 吴光远, 戚克勤. 针刺透穴法治疗三叉神经痛 21 例. 针灸临床杂志, 1999, 15 (2): 15~16
- [14] 张炉高. 针刺配合中药治疗三叉神经痛 38 例. 中国针灸, 1998, (11): 672
- [15] 胡玉茹. 针刺配合耳穴贴压治疗三叉神经痛 36 例疗效观察. 甘肃中医, 2000, (4): 53~54
- [16] 张继红. 针刺加刺络拔罐治疗三叉神经痛. 河北中医药学报, 2003, 18 (4): 41
- [17] 孙力. 耳穴刺激为主治疗顽固性三叉神经痛 42 例疗效分析. 甘肃中医, 2004, 17 (5): 25~26

【偏头痛】

偏头痛包括在头痛证内，其辨证治疗也可参照头痛，但因临床上偏头痛较为多见，根治也较为困难，所以治疗方法较多，故单列为一篇。

偏头痛的主要症状是偏于头部一侧的疼痛，按经络循行属于少阳经，故此选穴多取少阳经穴位，本篇中有专家独取太冲，或深刺风池，或率谷穴三针齐刺，亦有取颈夹脊穴或头穴治疗者，方法多样，都有满意的效果。

一、率谷为主 三针齐刺

偏头痛是一种常见病，多发病，常表现为一侧或双侧搏动性的剧烈头痛。以青壮年特别是青年女性多见。周仲瑜采用齐刺法为主治疗本病，取得较为满意的疗效。

取穴：主穴：率谷（患侧）；配穴：风池、太阳、百会。阴虚阳亢者取太溪、太冲、肝俞、肾俞、三阴交；痰浊内阻者取脾俞、胃俞、中脘、丰隆；瘀阻脑络者取合谷、三阴交、膈俞。

操作：患者取坐位或侧卧位。主穴取患侧，配穴取双侧。穴位常规消毒，调整患者呼吸，以规格 1.5 寸毫针，采用提插进针法。率谷穴进针沿皮透向角孙，得气后用平补平泻法，然后在率谷穴左右各 1 寸各刺一针，针尖方向向

第一针针尖，深度约0.5~1.0寸，得气后留针，每10min行针1次，采用捻转手法，每次频率为80~100次/min，每次捻针1min。风池穴针尖向对侧眼眶，深度约1.0~1.5寸。其他配穴常规针刺，视虚实决定补泻，得气为度，留针30min，以患者全身放松舒适为佳，每日1次，6次为1个疗程。疗程间间隔1天。

偏头痛属中医学“偏头风”、“少阳经头痛”范畴。多因情志不舒、肝郁化火、日久伤阴或平素肝肾阴虚、肝阳上亢、上扰清窍、瘀血、痰浊、阴虚等多种病因阻滞经络气血，气血运行不畅，头面失于濡养而发生偏头痛。正如中医疼痛机制：“不通则痛”、“不荣则痛”。针灸最强有力的治疗作用为镇痛作用。齐刺法源于《灵枢·官针》。曰：“齐刺者，直入一，旁入二，以治寒气小深者；或曰三刺，三刺者，治痹气小深者。”齐刺法作为针刺方法之一，它具有增强疏通经络、行气止痛的功效。三针齐刺不仅加强了受刺穴位的刺激量，还扩大了受刺激穴位的作用面积，有利于针感的扩散，激发经气传导，使针感由浅入深，由近及远向四周扩散，迅速到达气至病所的针刺效应，从而大大增强了针刺镇痛效应，达到比单针刺法更为显著的效果。率谷属足少阳胆经之穴，齐刺率谷可以直接疏通局部少阳经气使经气疏通调和，配合太阳、风池、百会平肝祛风镇静，以达“通则不痛”的目的。同时辨证选穴针对病因治疗还能防散邪复聚。多法取穴治疗共奏疏肝理气、涤痰通络、清利头目之功。

吴某，女，36岁，教师。2000年5月16日初诊。主诉：左侧颞部反复发作性疼痛2年，加重5天，发作时左侧颞部剧痛伴头昏，恶心欲呕，心慌气促，持续1~2h，每因精神紧张或疲劳而诱发。休息或情绪缓和后而减轻至消失，头部CT、MRI检查均未见异常，舌淡，苔薄白，脉弦。西医诊断为血管神经性头痛又名偏头痛；中医诊断为偏头风（阴虚阳亢），采用上述方法治疗3个疗程，随访半年未复发。

二、深刺风池 立竿见影

张留远采用深刺风池穴的方法治疗血管性偏头痛，疗效满意。

取患侧风池穴，病人坐位头倾低向对侧，穴位严格消毒，用28号2寸5分毫针，左手以酒精棉球夹持针体，右手持针柄，针尖平

耳垂水平向对侧眼眶方向直刺，双手协同将针缓慢刺入穴位深处，当针尖刺至2寸（儿童1寸5分）深时，针下如刺橡皮样物（黄韧带），再将针轻轻刺进2~3分时感觉针下有落空感，患者突然一颤动，并同时出现触电样感觉传至前额一侧，头痛立即消失。同时退针。双侧头痛者也只针一侧风池穴即可，另一侧头痛也会同时消失。

深刺风池穴是针尖从上颈段侧面刺入，通过第一颈椎上方，刺进硬脊膜外（或触及脊髓），由于此点是脊髓的上段与延脑接近，因此针刺感异常强烈，这种强烈的针感，不仅抑制即时效应来得十分迅猛，而且所产生的抑制后效应也相应持久。任何非伤害性的感觉传入都可能有一定程度的镇痛作用，那么以针刺风池穴所引起的这种来自深部组织的针感，镇痛效应会更加显著。深刺风池穴治疗偏头痛，就是由于直接刺激了硬膜外的脊神经，所产生的强烈针感迅速传入大脑皮层，通过神经系统的整合作用，进一步激发有关的镇痛中枢而产生镇痛效应的结果。

李某，女，28岁。1993年10月20日初诊。病史2年，每逢劳累及生气时视觉障碍，右侧剧烈头痛，近半年来发作频繁，持续时间延长。发作前先有眼前冒金花、视物模糊、阵发性黑蒙、眼眶、前额及面颊部痛，旋即剧烈头痛，伴恶心呕吐。诊断为“血管性偏头痛”，久治不愈。刻诊，见患者痛苦貌、头扎布带、抱头呼痛、汗出淋漓、面色苍白、嘴唇青紫。系统检查（包括血压、心电图、头颅CT、生化）均无异常。视力检查不能合作，眼前段及眼底均无异常，眼压正常。诊断为“血管性偏头痛”。采用上述方法深刺风池穴，症状立即消失，随访2年无复发。

三、针刺耳压 平肝泻胆

偏头痛是一种周期性，反复发作的急慢性头痛，是临床常见的多发病，近年来胡学勤采用针刺加耳穴贴压的方法治疗本病，取得了较为满意的效果。

取穴：主穴：风池、率谷、阳白、太阳、百会。配穴：头维、印堂、丝竹空、天柱、丰隆、太冲、足临泣。

操作：每次选用主配穴5~6个或主配分成二组，交替使用。采用虚则补之，实则泻之，平补平泻的手法，局部常规消毒，进针得

气后加用电针施以连续波,强度以患者能耐受为度,留针 1h。每日 1 次,以 10 次为 1 个疗程。

耳压:神门、交感、肝、胆、内分泌。耳穴每次选用一侧 3 穴,让患者取坐位或侧卧位用 75% 酒精棉球常规消毒后,再以磁粒或王不留行籽埋藏,外用胶布固定,让患者用手指每日按压 3~4 次,每次 3~5min,使局部产生热、胀、痛等感觉,3 天更换另一侧,双侧耳穴交替使用。10 天为 1 个疗程,间隔休息 2 天,再行第二疗程。

偏头痛属中医头痛范畴,本证即是本虚标实,女性居多,其致病因素为风、火、痰、瘀,其病位在脑,属肝、胆两经,涉及肝、胆、脾、肾等脏腑,肝阳化风,痰瘀阻络,经脉不通为其主要病理机制,治疗以平肝泻胆,化痰解痉,活血镇痛为法,风池穴为足少阳、阳维、阳跷之会,百会系督脉阳经之会,率谷为足少阳、足太阳之会,三穴均位于头部,合用可起到疏通经脉,理气活血,醒脑安神镇痛的作用。

陈某,女,48 岁,退休工人,患者左侧偏头痛 2 年余,时轻时重,近 1 年来左侧头痛加重,发作频繁,甚则有时坐卧不安,晚上不能入睡,曾在某市某医院专家门诊,查头颅 CT 无异常发现,给予药物治疗,头痛未见减轻,于 2002 年 5 月 10 日前来本科就诊,查:神志清,Bp:160/90mmHg,取上穴加耳穴贴压治疗 2 次后头痛明显减轻,夜晚尚能入睡,5 次后头痛基本消失,再巩固治疗 3 次痊愈。

四、颈夹脊为主 随症配穴

徐红采用颈夹脊为主穴的针刺疗法治疗偏头痛,获得满意疗效。

取穴: C₂, C₅ 夹脊穴为主穴。根据头痛的不同部位(经络分布)取相应辅穴:少阳头痛加患侧风池、太阳、头维、率谷;阳明头痛加太阳、印堂、鱼际;太阳头痛加完骨、风池、强间、天柱;厥阴头痛加四神聪。

操作:患者伏首坐于床缘或桌边,额下垫枕头以支撑头部,并且调节枕头高度,使颈处于自然放松状态,局部常规消毒后,取 30 号 2 寸针,垂直刺入 C₂, C₅ 夹脊穴,进针 1.2~1.5 寸,行提插泻法;头皮诸穴取 28 号 2 寸针斜刺(30°),行小幅度快速捻转(120 次/min 以上的频率),使针感在局部扩散为度;风池、天柱向喉

结方向刺入1~1.2寸，不行针；鱼腰斜刺入眶上裂，行提插泻法；太阳斜刺向眼眶、行捻转泻法；印堂斜刺向鼻根，行捻转泻法。留针20min，每日治疗1次，10次为1个疗程。

偏头痛的病因是复杂的、多方面的，但其最终的根本病机不外乎脉络瘀阻、不通则痛。我们以颈夹脊为主穴，针刺颈夹脊穴具有疏通督脉经气的作用，而且较单纯取督脉穴更易得气，作用更强。督脉为诸阳之会，直通髓海，气为血之帅。督脉之气得通，则瘀阻之脉络得畅，疼痛立缓。另外，治疗时配合疼痛部位的局部穴位，行快速捻转法，疏通局部经气，进一步增强祛瘀通络之功效，使整体与局部有机结合。解剖学表明，椎间孔处有交感神经分支与椎动脉相伴行。针刺颈夹脊，直接作用于病所，正有调节交感神经张力，使之趋于平衡，进而缓解椎动脉痉挛，改善椎动脉供血不足的作用。

刘某，女，26岁，左侧偏头痛3月余，患者3月前在与他人争吵过程中首次发病。当时左颞部刺痛，伴有口唇、四肢麻木、语言不利等症，10min后缓解，以后反复出现左颞部搏动性胀痛、刺痛，但未再出现口唇、四肢麻木等伴随症状，曾自服去痛片，太极通天口服液等药，效果不佳。查TCD示：椎-基底动脉系统、大脑中动脉血流异常，舌质黯夹瘀、苔薄白、脉弦。诊断为少阳头痛（肝郁气滞、脉络瘀阻）。按上述方法治疗10次后，发作次数明显减少，发作时症状明显减轻。又治疗10次后，症状完全消除，随访半年未再发作。

五、曹氏额区调控点 沿皮针刺

曹欣根据临床经验摸索特定穴位，采用针刺治疗血管性偏头痛，取得了满意的效果。

方法一：患者取端坐位，取曹欣所创曹氏额区调控点（两眉之间，与发际中线点），局部常规消毒后，取1.5寸长28号毫针刺入皮下，留针45min以上，每日1次，10天为1个疗程。

方法二：患者取端坐位，局部常规消毒后，取3寸长30号毫针沿头皮头维线刺入头皮下，留针1h以上。左右两侧隔日交替应用，30次为1个疗程。

以上二法可选用其一治疗。

血管性头痛是由于脑动脉血管供血不足致使脑动脉血管收缩障碍，出现痉挛所致。曹欣运用额区针刺之所以能取得较明显的治疗效果，是因为该区属经络督脉之海，而其所创的曹氏调控区又在西医解剖上属额区边缘系统，能较好地调节血管神经，起到止痉作用。综合 20 年的临床经验，曹氏提炼出上述两种方法，简便易行，用针少；见效快，经临床验证，第一种方法适用于顽固性血管性偏头痛，尤适于病程长，经多种治疗见效甚微者。一般性血管性头痛可用第二种方法。在临床治疗中，也可根据实际情况两种方法配合应用。

六、针刺为主 辅以推拿

周厚强采用针刺配合推拿治疗偏头痛，疗效满意。

取穴：太阳、率谷、百会、风池、外关、足临泣。单侧头痛取患侧穴位，双侧头痛取双侧穴位。

操作：穴位皮肤常规消毒后针刺，太阳穴直刺进针 1 寸，风池穴向鼻尖方向刺入 1.2 寸，百会、率谷平刺 0.5 寸。所有穴位针刺得气后留针 30min，其间每隔 10min 行针 1 次，每天治疗 1 次，5 次为 1 个疗程，疗程间休息 2 天。

推拿：取针后即行头部推拿，术者用一指禅推法在患侧头部少阳胆经分布区域治疗约 2min，并用拇指按揉太阳、头维、率谷、头临泣、风池等穴，每穴约 1min，然后用拇指指腹由前到后推患侧少阳经，反复推 10 次，再用扫散法在患侧自前向后操作 10 次，最后用三指拿法沿膀胱经拿至大椎两侧，往返 4~5 次。

周厚强认为偏头痛的病理本质为气机瘀滞，阻遏经脉（足少阳胆经为主），不通则痛。治当调畅气机，通络止痛。头为诸阳之会，三阳经均循头面，厥阴经亦上达巅顶。所取之穴，多属足少阳经脉，刺之可调畅胆经气机，疏通经脉，从而达到止痛等效果，即所谓“腧穴所在，主治所及”。再配以推拿头部穴位及经络，可加强和巩固针刺疗效，促进气血运行，以达疏经通络、调和阴阳作用，共奏扶正祛邪止痛目的。

李某某，女，35 岁，左侧头痛反复发作 5 年，加重 3 月，5 年前开始头痛，每年发作 2~3 次，3 个月前开始频繁发作，每周 1 次，呈胀痛。伴恶心呕吐，怕光喜静，思睡懒言，一般经 1~2 天才能缓

解。服用去痛片、麦角胺咖啡因、丹参片等药，效果不佳。二便正常，舌质淡，苔薄脉细弦。诊见左侧太阳穴处血管怒张。头颅CT、脑电图检查均无异常。施以前述针刺、推拿疗法，治疗2次后头痛锐减，1周后疼痛及伴随症状消失，再巩固治疗1周，半年后随访未见复发。

七、独取太冲 重刺激

王科采用针刺太冲穴治疗偏头痛，疗效满意。

取穴：太冲（双）。

操作：患者取仰卧位，将针体、穴位常规消毒，用1.5寸不锈钢毫针向上斜刺0.5~1寸，采用重手法提插，使针感向上传至踝部以上，局部酸胀感较重为佳，留针60min。每15min行针1次。每日1次，10次为1个疗程。

偏头痛主要位于头的侧部，故责之于少阳经，而足厥阴肝经与足少阳胆经又相表里，太冲为足厥阴肝经输穴、原穴，“输主体重节痛”，输穴在治疗疼痛方面疗效较好。原穴是脏腑原气所留止之处，原气导源于肾间动气，是人体生命活动的原动力，通过三焦运行于脏腑，是十二经的根本。针刺原穴能使三焦原气通达，气机畅通，气行则血行，通则不痛，头痛得解。作为五脏之一的肝，主藏血，性喜条达而恶抑郁，针刺肝经经穴可起到调畅气机，使气血运行通畅的作用。故而针刺太冲治疗偏头痛疗效显著。

患者，女，56岁，2000年11月9日初诊。左侧偏头痛6年，每遇情志不畅、劳累发作，头痛，心烦，畏光，严重时伴有恶心呕吐等症状。近日因劳累，头痛发作，左侧额部呈跳动样胀痛，自服解热止痛片，静脉点滴扩血管药物，效果不佳；神经系统查体无阳性发现，心、肝、脾未见异常，血压115/80mmHg，舌质红，苔薄黄，脉弦。诊断：偏头痛（少阳经头痛）。治疗：按上述方法，针1次后胀痛明显减轻，次日精神好转，连针10次，疼痛完全消失，随访6个月，头痛未再发作。

八、疏风平肝 通络止痛

偏头痛，又称偏头风，其病发作，痛势甚剧，或左或右，或连

及眼、齿，痛止如常人，多系肝经风火所致，本病是临床常见病。肝阳化风、痰瘀阻络、经脉不通为其主要病理机制，周妍在临床采用针刺方法治疗，取得了满意的效果。

取穴：主穴：取双侧风池、百会，患侧取太阳、率谷。配穴：风痰上扰配太冲、丰隆；瘀血阻络配三阴交、阿是穴；外风袭表配合谷、大椎；气血不足配足三里。

操作：在所选穴位周围进行常规消毒，以26号1寸针直刺进针常规深度，除气血不足所配穴位用补法外，其余均用泻法。留针30min，间隔10min行针1次。每日针刺1次，7次为1个疗程，间隔2天再行下1个疗程。

偏头痛，属于“少阳头痛”范畴。周妍治以疏风平肝、通络止痛、化痰解痉为主。风池穴为足少阳、阳维、阳跷脉之会，既能祛风解表，又能疏风平肝；百会穴位于清阳之巅，属督脉能平肝熄风，太阳穴属经外奇穴，能祛风热、宁神志；率谷为足少阳、足太阳之会，能通络止痛。依兼证不同，加丰隆、太冲以化痰，三阴交、阿是穴以活血；合谷、大椎以祛风，诸穴合用，使经脉疏通，阴阳调和，通则不痛。此外，偏头痛患者还应注意预防，尽量避免情绪紧张，过度劳累，注意饮食，去除烟酒等不良习惯。

陈某，女性，51岁，干部。1999年4月17日初诊，主诉：右侧颞侧头痛13年余，反复发作，发作时常自服去痛片，但效果不明显。1周前，因与家人争吵，情绪波动很大，致头痛发作，伴面色苍白，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗：双侧风池、百会、印堂，患侧太阳、率谷，均用泻法。第一次治疗取针后，病人即感头痛减轻许多，全身轻快；第二、第三次治疗后，头痛程度和发作次数减少；第四次治疗患者述先前症状完全消失，生活如常，痊愈而归。后经半年随访未复发，疗效显著。

九、按部取穴 顺序针刺

偏头痛的临床表现为一侧或双侧头痛呈阵发性剧烈胀痛，宋双临采用针灸加穴位注射疗法治疗本病，效果满意。

取穴：偏头痛取合谷（双）、太冲（双）、百会、太阳（患侧）、头维（患侧）、天井（双）、中渚（双）、侠溪（双）；头顶痛取合谷

(双)、太冲(双)、百会、前顶、承灵(双)、后溪(双)、涌泉(双);前额头痛取合谷(双)、太冲(双)、百会、印堂、头维(双)、上星、丰隆(双);后头痛取合谷(双)、太冲(双)、百会、后顶、脑空(双)、风池(双)、天柱(双)、丰隆(双)、飞扬(双)、昆仑(双)。

操作:令患者取合适体位,常规消毒穴位皮肤,根据取穴选择1~1.5寸毫针,先刺合谷、太冲,再从头部百会穴开始由上而下依次进针,得气后行捻转手法,频率与强度以患者能耐受为度,留针20min。

穴位注射:针刺后用当归注射液2ml在风池(双)做穴位注射,每穴1ml。隔日针刺加穴位注射1次,10次为1个疗程。

宋双临认为本病多为脏腑经络气血阻滞互相影响所致,治疗当以行气活血、疏通经络、调理脏腑为主。选穴多取原穴、络穴、郄穴和交会穴。如:合谷为阳明原穴,是治头痛要穴;太冲为肝经之原穴,能降肝火,平熄亢逆之风阳;督脉为诸阳之会,其别络散于头部,故取印堂;足厥阴肝经与督脉会于巅顶,故取百会以平肝潜阳,风池为足少阳、阳维之会,又为止痛疏经之要穴,在此穴上采用活血养血作用的当归注射液,做穴位注射,与针刺双重作用,具有加强穴位效应,激发经气,疏通经络和行气活血化瘀,改善血管舒缩状态和血液循环,调理脏腑的功能。

十、审因辨证 随证取穴

陈淑琴将血管神经性头痛按部位、辨经与辨证相结合、制定出相应的治则,选出特效穴位,进行针刺治疗,取得了令人满意的效果。

取穴:主穴:风池、百会、太阳、神庭、列缺。配穴:后头痛者加至阴;风袭经络者加合谷、曲池;前额痛者加印堂、中脘;胃火炽盛者加头维、内庭、厉兑;偏头痛者加丝竹空、率谷、足临泣、颌厌透曲鬓;肝胆实热加行间;气血不足者加足三里;肝阳上亢加太冲、三阴交;痰湿阻络者加丰隆、阴陵泉;巅顶痛者加四神聪、太冲;肾精不足者加三阴交、关元;瘀血头痛可在局部取穴三棱针点刺放血。

操作：毫针刺用捻转补泻法；风袭经络、肝阳上亢及瘀血阻络者重用泻法；气血不足和肾精不足者重用补法，余用平补平泻法，每日1次，每次留针30min，7次为1个疗程，疗程间休息2天。

陈淑琴根据经络的循行、审因辨证论治，按部位辨经与辨证相结合，确立相应的法则，选用有效的穴位，进行针刺治疗，可取得很好的疗效。百会以通络；风池以祛风解热、清脑开窍，风池配百会意在通络止痛；神庭、太阳调和气血；列缺是手太阴肺经的“络”穴，八脉交会穴之一，可治疗头顶痛；合谷能疏风解表止痛；至阴为足太阳膀胱经之“井”穴，有调和气血，通达经络、止后头痛的作用；合谷配曲池可加强疏风解表止痛作用；中脘为胃之募穴，泻阳明胃热，清理气血，配印堂止前额痛；头维、内庭、厉兑能泻胃热；颌厌透曲鬓、丝竹空、率谷能疏通手足少阳经脉，调和气血止痛；足临泣能泄少阳经热，引热下行；行间能泻肝胆实热；足三里补养气血；太冲配三阴交能平肝潜阳；丰隆、阴陵泉祛湿化痰降浊；四神聪配太冲能潜阳降逆，通络止痛；三阴交配关元补肾填精；局部穴位三棱针点刺放血可祛瘀通络止痛。

张某某，男，32岁，出纳员。因左侧头痛半个月加重4天而到门诊治疗，来针灸治疗前已在市级医院神经内科确诊为血管神经性头痛。做脑电图未见异常，经颅多普勒检查提示左侧颈动脉痉挛。就诊时，左侧头痛，以左耳后、耳上部位为主，阵发性加重，痛如刀割，伴有面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑等症，中医诊断：头痛（足少阳偏头痛，肝胆实热型），按前法针刺治疗5次痊愈。

十一、远近配穴 呼吸补泻

杜雅俊采用针刺方法，治疗血管神经性头痛，收到满意效果。

取穴：风池（双侧）、百会、太冲（双侧）、太溪（双侧）、阿是穴、内关（双侧）。

操作：先针风池，嘱患者深吸气，迅速刺入该穴1寸（注意勿过深），令患者呼气，迅速将针退至皮下，而后待吸气时再进针，呼气时出，反复数次，有强烈针感后留针。依次针另一侧风池，方法同上。其余诸穴均用泻法，留针。阿是穴点刺，不留针。至患者疼痛减轻为止。每日治疗1次，12次为1个疗程。

中医认为头为诸阳之会，肝经上循巅顶，若肝失柔和疏泄，郁而化火，血热上壅，阻滞清窍则发头痛。肝体阴而用阳，肝阳所以潜藏，肝体所以柔和，全赖肝血肾阴滋养。若火盛伤阴，肝失濡养，或肾水亏耗，水不涵木则肝阳上亢，上扰清空而致头痛，亦可阴损及阳，肾阳衰竭，清阳不布则成头痛。故取风池，该穴为足少阳、足太阳之会，又为降压止痛之要穴。肝阳上亢常伴肝胆火旺，故针之可清少阳郁热，疏头风降压止痛，又兼调和气血，迅速缓解血管收缩。太冲穴为肝经之原穴，针之可降肝火，平熄亢逆之风阳，自古就有善治头痛的记载。太溪穴为肾之原穴，可补益肾阳，制约肝阳，舒张血管。足厥阴肝经上额与督脉会于巅顶，故取百会以平肝潜阳。内关为八脉交会穴，可宽胸解郁，理气活血。以上诸穴合用，配灸内关调和诸穴，加之阿是穴止疼痛之作用，故其效能彰。

李某，男，25岁，1986年12月1日就诊。病史：患者左侧头部分阵发性剧烈疼痛已3年，反复发作，痛不可忍，每逢疼痛即胸闷心烦。舌红苔黄腻，脉弦滑数。诊断为血管神经性头痛症，多方治疗无效，遂来针灸科诊治。以上述穴位针刺，一次即效，连续针刺7次后疼痛渐消，为巩固疗效，又针5次病愈。

十二、单针浅刺 配合叩打

曲祖贻在临床上采用叩刺法治疗偏头痛，常收效验。

操作：右手拇、食、中三指紧持32号1寸细毫针，微露针尖，向头部疼痛之处周围，以每秒6下速度，轻轻浅刺200下，同时右手侧掌用小指根部叩打头痛部位。稍停5min，依法再继续叩刺2次，每次仍为200下。

王某，女，40岁，护士长。曾因剧烈偏头痛住院，后经人介绍来针灸科诊治。检查：患者精神萎靡，面色苍白，行动迟缓，说话无力，头痛异常剧烈。脉搏弦细，舌干质紫，大便秘，小便少，不思食，经常失眠。脉证合参，辨证为虚中夹实的血瘀性偏头痛。《内经》中有五十九刺法，系大面积单针浅刺法，善能退热止痛，而按摩法中的叩打法，又善能排瘀止痛，于是将此二法合并应用。叩刺200下，果见奇效。患者连声称妙。稍停数分钟，依法又行2次。翌日再施叩刺2次，偏头痛基本消失。因久病津液涸者多烦躁，为了防止相火妄动，

再用32号细毫针，直刺患者后头乳突下方“天牖”穴，使酸胀得气，不提插，行刮针术，用右手食指在针柄上，以每秒钟3下速度，由下往上，连续刮动针柄缠丝处200下，以通经止痛，刮刺后起针，仍同前法，再轻轻叩刺200下，总计叩刺800下。

这种利用压力较大的侧掌叩打和大面积的单针浅刺，具有活血解瘀，通经止痛之效，连续治疗2天，每次叩次200次，使瘀者开，滞者通。

十三、华佗夹脊 补泻并用

血管性偏头痛是一种发作性疾病，多由于肝肾亏损，肝阳夹痰浊上扰所致。本病多起于青年时期，病程较长，往往迁延不愈。何树槐采用华佗夹脊穴进行治疗可取得良好效果。

取穴：华佗夹脊5、7、9、11、14，风池。

操作：针刺风池穴时，病人采取坐位，微低头，医者左手拇指固定穴位，右手持1.5寸长毫针，将针尖向着对侧眼角水平刺入1寸左右，得气后施以捻转泻法，使针感沿少阳经脉传至同侧前额或太阳穴处，随后起针。针刺华佗夹脊穴时，病人采取俯卧位，定好穴位，然后用1.5寸毫针沿棘突下两侧刺入，针尖对着脊柱斜刺，针身与皮肤呈75°角，刺入1寸左右（视病人胖瘦而定），使针感沿脊柱上下传导或沿肋间传导。华佗夹脊9用泻法，其余穴位用补法，留针30min。隔日治疗1次，10次为1个疗程，两个疗程之间休息10天。

马某，女，24岁，未婚。患偏头痛已十年，近二年加重。一般一周或10日发作1次，并与月经周期有关。头痛先始于前额部，后波及偏侧，以至整个头部。疼痛2h达高峰，持续24h后逐渐缓解。痛时伴有恶心、呕吐、大便秘结等症。服麦角胺类药物已不能控制。脉弦细，苔薄白。取穴：华佗夹脊穴5、7、9、11、14，风池。治疗7次后头痛开始好转，自述在此期间只发作1次，约1h即止。治疗11次后月经来潮，头痛也未作。为了巩固疗效，又针治10次，至月经再潮时头痛未作，回访1年，未再复发。

十四、刺血为主 辅以针刺

傅平华采用刺血为主治疗血管性头痛，收到满意效果。

刺血：取穴太阳、百会、印堂、足临泣，每次选用2~3个穴位。穴位常规消毒后，三棱针点刺出血，太阳点刺后拔火罐。每周1次，重症者每周2次。

针刺：取风池、合谷、太冲。常规针刺，得气后留针20min。每日1次。每周4~6次。

傅平华在临证中发现大多数患者发病时太阳穴处有明显的瘀络，有时瘀络显现在印堂或足临泣处。刺血治疗该病，可直捣病所，并有“治风先治血，血行风自灭”之意。足少阳经的足临泣刺血可引血下行，共奏熄风化瘀，通络止痛的作用。刺血对发作期头痛有较好的即刻止痛效果。多数病人于术毕即感到头痛明显减轻，或头痛若失。配以体针守方调治，常可获较好的远期效果。

李某，女，34岁。初诊日期：1993年8月24日。主诉：头痛4天。既往一侧头痛反复发作3年，每年发作约2~3次。大多为左侧头痛，有时右侧头痛。发作与情绪、劳累有关。本次由于搬房操心劳累引起复发。开始左侧头痛，一天后波及两侧太阳和耳后。头痛如刺，伴头部血管搏动感，眼球如欲脱。剧烈时伴呕吐，上身及头部冷汗淋漓，面色苍白、烦躁。服止痛片，注射安定等药物效果不佳。诊见患者神清，眼球结膜充血，双太阳穴处血管怒张。舌质红，苔薄黄，脉弦数。脑血流图报告：额-乳突导联波幅极低，枕-乳导联波形极不规则。证属气滞血瘀，经气不畅，治以行气化瘀，通经止痛。按上述方法太阳穴行双侧刺络拔罐，百会、足临泣点刺出血。出血约50ml。术后即感头痛消失。以后配合体针治疗，以巩固疗效。又坚持治疗3周，脑血流图复查，原低波幅增高恢复正常，告愈。随访2年未见复发。

十五、穴位注射 重在疏通

宋玉文用穴位注射药物的方法治疗血管性紧张性头痛，收到较好效果。

取穴：主穴为双侧太阳、风池、合谷；配穴为头维、率谷、神

门。有恶心呕吐加内关，前额部头痛明显者加印堂，头顶部痛者加百会穴。

操作：取5ml注射器吸取25%天麻注射液4ml、维生素B₁2ml。用5号半针头，将针刺入穴位内，待有酸、胀等针感后，抽无回血，即可将药物分别注入各穴位内，每穴位注射药物0.5ml。每日1次或隔日1次，3次为1个疗程。

用穴位注射药物的方法治疗头痛，是根据中医学有关经络气血“不通则痛”的理论，通过针刺有关穴位，疏通经络气血达到“通则不痛”的目的。天麻注射液具有镇痛、镇静、改善血液循环作用；维生素B₁有调节神经作用。宋玉文选用经穴加药物治疗取得了较好效果，而且治疗时间短，见效快，痛苦少。

十六、头穴为主 辨证加减

偏头痛是临床常见病，为发作性神经-血管功能障碍，以反复发作的偏侧或双侧头痛为特性。赵建玲采用针刺方法治疗本病取得了较为满意的效果。

取穴：主穴：双侧风池、百会、印堂，患侧太阳、率谷。配穴：风寒入络加合谷，肝阳上亢加太冲，气血不足加足三里，痰浊上蒙加丰隆，女性月经不调加三阴交。

操作：选30号1.5寸毫针，在所选穴位上用75%酒精常规消毒后进针，除气血不足所配穴位用补法外，其余均用泻法，留针20~30min，中间行针1~2次，隔日针刺1次，10次为1个疗程。

风池既能祛风解表，又能疏风平肝，能治一切以风为主的病变。重泻百会能平肝熄风，印堂、太阳两穴属经外奇穴，具有祛风热、宁神志的作用，能治一切头痛。太冲属足厥阴肝经原穴，功善泄肝火，清头目；率谷穴为头部临近取穴，属足少阳胆经，能疏通头部少阳经气，而达到通络止痛的目的。

王某，女，55岁，工人。2000年5月14日初诊。患者诉左侧头痛10年余，反复发作，发作时常自服去痛片等药。1周前，因与人争吵，心中一直不快，夜寐欠安，致头痛发作。来就诊时诉左侧头部持续性胀痛，伴面色苍白，精神萎软，舌质偏红，苔薄黄，脉弦数。取穴：百会、双侧风池、印堂，患侧太阳、率谷、天冲，均

用泻法。针1次后，患者头痛即缓解，由持续性胀痛转为间断性疼痛，针5次后，头痛消失。为巩固疗效，又针5次，1个疗程即告痊愈。

十七、风池为主 气至病所

窦国栋在临床过程中发现，偏头痛患者多在风池部有明显压痛和异常改变，并采用针刺风池为主治疗偏头痛取得较好疗效。

取穴：以风池为主穴，配取太阳、角孙、外关、合谷等。

操作：取风池或压痛明显处，直刺向对侧眼窝内下缘方向，略斜向下刺入1~1.5寸。局部胀并向头顶、颞部或前额扩散；如针感不强，也可在风池运用多针刺法，取其强烈针感为佳。太阳平刺透角孙，进针0.8~2寸，使胀感扩散至同侧颞部；外关、合谷以得气为度。留针30min，期间行针2~3次，每日或隔日1次，10次为1个疗程。

“头为诸阳之会”，“清阳之府”，手之三阳经皆循头面，偏头痛主要位于颞额部，故主要责之于少阳经与阳明经。窦国栋在针刺治疗偏头痛的临床实践中，根据腧穴近治作用原理，选风池、太阳、角孙以疏通局部经气，经气疏通故而通则不痛。从现代解剖学观点看，风池的深部为分布后枕部的枕大神经，针刺风池，可有效改善此神经的功能，并且可延及相邻神经。太阳和角孙深层结构中有颞神经和枕小神经双重分布，太阳深面有脑膜中动脉及其分支经过。针刺太阳透角孙有调整颅内外血管舒缩功能，及时地控制偏头痛发作，获得良好的镇痛效果。

张某，女，35岁，会计。1997年4月20日就诊。主诉：右侧偏头痛2年余，加重10天。多在劳累及睡眠欠佳时诱发，发作时感右侧太阳处跳痛，渐扩展至整个半侧头部，前额胀闷，每次发作历时数小时或数日不等，甚则恶心欲吐，夜不成眠。此次发作，经口服西比灵，中药10余剂而不解。刻诊：痛苦面容，心肺正常，颈部风池处压痛明显。舌淡红，苔薄白，脉弦数。诊断：偏头痛。采用上述方法治疗，1次后头部跳痛明显减轻，唯感颞额部胀闷，3次头痛胀闷基本消失，睡眠正常，针治5次痊愈。随访1年无复发。

十八、太阳 - 率谷为主 长针透刺

血管神经性头痛为临床常见病之一。安珂采用针刺方法对该病进行治疗, 疗效显著。

取穴: 头维、太阳、率谷、风池、合谷。

操作: 以 28 号 3 寸毫针, 自太阳刺入, 向率谷方向捻转进针 (太阳可先直刺 1.0 ~ 1.5 寸, 得气后退至皮下, 再行透刺), 约 1.5 ~ 2.5 寸, 采用捻转加小幅度提插法, 运针 1 ~ 2min, 留针。其余穴位以泻法为主。针刺得气后, 紧提慢插结合捻转反复运针, 增强针感。每日 1 次, 留针 30min, 每隔 10min 运针 1 次。5 次为 1 个疗程。

血管神经性头痛是常见的急性头痛之一, 病因尚不明了, 现代医学一般认为可能系头颅血管神经功能紊乱以及某些体液物质一时性改变所致。常有家族史, 且以女性多见。中医学认为头为诸阳之会, 五脏六腑的清阳之气皆上注于头。本病多由于外感风邪、情志刺激、劳倦及饮食内伤等因素所致, 使邪气上犯巅顶, 经络受阻, 瘀血阻滞, 气血不能上荣于头而发病。针刺治疗起到了活血化瘀、通络止痛的重要作用, 因此可以达到治疗目的。

参 考 文 献

- [1] 周仲瑜, 张瑛. 齐刺法治疗偏头痛 68 例分析. 中医药学刊, 2004, 22 (11): 2123
- [2] 张留远, 董自斌. 深刺风池穴治疗血管性偏头痛 120 例临床观察. 江苏中医药, 2003, 24 (11): 48 ~ 49
- [3] 胡学勤. 针刺加耳穴贴压治疗偏头痛 35 例. 黑龙江中医药, 2002, (5): 49
- [4] 徐红, 马磊. 针刺颈夹脊穴治疗偏头痛 200 例疗效观察. 云南中医中药杂志, 2005, 26 (1): 24
- [5] 曹欣. 针刺疗法治疗偏头痛 600 例. 中国民间疗法, 2000, 8 (3): 12
- [6] 周厚强. 针刺加推拿治疗偏头痛临床疗效观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (1): 56 ~ 57
- [7] 王科, 王红娥. 针刺太冲穴治疗偏头痛 20 例. 现代中西医结合杂志,

- 2005, 17 (14): 2288
- [8] 周妍, 王红. 针刺治疗偏头痛 40 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2004, 20 (7): 12
- [9] 宋双临, 黄刚. 针灸加穴位注射治疗偏头痛 36 例临床观察. 浙江中医学院学报, 1999, 23 (3): 55
- [10] 陈淑琴. 针刺治疗血管神经性头痛 132 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2003, 19 (2): 8~9
- [11] 杜雅俊, 张玉华. 针刺治疗血管神经性头痛 10 例. 中国针灸, 1996, (5): 5
- [12] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 349
- [13] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 351
- [14] 傅平华, 廖志宽. 刺血加针刺治疗血管性头痛 78 例. 中国针灸, 1998, (12): 727~728
- [15] 宋玉文, 叶振洪, 伏晓猛. 穴位注射治疗血管性紧张性头痛 100 例. 中国针灸, 318
- [16] 赵建玲. 针刺治疗偏头痛 60 例. 针灸临床杂志, 2002, 18 (10): 17
- [17] 窦国栋, 崔召东. 针刺治疗偏头痛 56 例临床观察. 针灸临床杂志, 1999, 15 (6): 12~13
- [18] 安珂. 针刺治疗血管神经性头痛 58 例. 甘肃中医学院学报, 2005, 22 (6): 43~44

【震颤麻痹】

震颤麻痹又称帕金森病，属于中医学颤证、震掉的范畴，是一种常见的中枢神经系统变性的锥体外系疾病，以静止性震颤、肌强直、运动徐缓为主要特征。

西医对本病未发现任何确切原因的称为原发性震颤麻痹，对有确切原因的则称继发性震颤麻痹或震颤麻痹综合征、帕金森综合征。原发性震颤麻痹好发于 50 ~ 60 岁，男性多于女性，少数有家族史。继发性震颤麻痹多见于脑炎、动脉硬化、颅脑损伤等。

中医学很早就对本病有所认识，明·王肯堂《外科证治准绳》中说：“颤，摇也；振，动也。筋脉约束不住而莫能任持，风之象也……壮年少见，中年始有之，老年尤多”。其基本病机多由肝肾亏虚，气血不足，脾湿痰浊阻滞脉络，经筋失养，虚风内动而致。病位在脑，病变脏腑主要在肝，涉及肾、脾，病性属本虚标实。

本篇选介了 11 位针灸医家的治验，他们的主要经验有：益精养血，柔筋止颤；合穴为主，头针腕针并用；梅花针轻叩等。针灸治疗本病对病程短者疗效较好，对僵直症状的改善比对震颤症状的改善明显。

一、以补为主 益精养血

震颤麻痹是多发于老年人的严重致残疾病，张乃钺采用体针加头针治疗震颤麻痹患者，收到了满意的疗效。

取穴：针取大椎、肝俞、脾俞、肾俞、合谷、曲池；头针取舞蹈震颤控制区。

操作：对所选穴位、控制区常规消毒，患者俯伏坐位，用4寸毫针向上斜刺入大椎，深度0.9~2.5寸，以患者出现触电感向四肢或全身放射为度。有此感觉迅速出针，不捻转提插，不留针；用26~28号1.5寸毫针，针与头皮呈30°左右夹角，用挟持进针法，刺入舞蹈震颤控制区，小幅度快速捻针，速度为200次/min左右，捻转2min，留针5min。如此捻针3次，即可出针；肝俞、脾俞、肾俞、曲池、合谷等穴采用补法，得气后留针15min。针刺每日1次，10次为1个疗程，每疗程间隔4天。

本病类似于中医学的“颤证”“内风”，与肝脾脑肾关系密切。肝脾肾虚，精血不足，上不能充养髓海，下不能滋濡筋骨肌肉，就会出现肢体震颤、肌肉强直、关节僵硬等症，导致震颤麻痹。因此对于本病的治疗应以补为主，重在滋补肝脾肾以益精养血，柔筋止颤。针刺肝俞、脾俞、肾俞以治肝脾肾诸脏本虚；大椎为督脉要穴，而督脉与脑相通，舞蹈震颤控制区亦在脑部，针刺大椎及舞蹈震颤控制区可直接恢复脑的调节筋骨肌肉功能，为治标之策，曲池、合谷祛风止颤，也是治标之计。

根据临床体会，体针加头针治疗震颤麻痹，大椎一穴至为重要，尤其是针刺大椎对震颤麻痹的控制，即时疗效颇佳。有些病人单独针刺大椎一穴，能在触电感后的一段时间（30min）内不再震颤。针刺大椎需注意的问题是：①病人必须有得气的感觉，尤以有触电感向四肢或全身散射为佳，而仅有酸麻胀痛等一般得气感觉，疗效稍差；②要想达到患者有触电感向四肢或全身散射，必须注意针刺深度（实际上最深也只触及脊髓），有触电感向四肢或全身散射后应快速出针，这样不会有任何危险。③大椎与头针和其他体针不可同时针刺，否则针刺大椎，患者有触电感时，肌肉收缩或不自主的肢体摆动，易致弯针、滞针、断针等意外情况发生。另外，从临床治疗

结果可以看出：体针加头针治疗震颤麻痹对初、中度疗效较好，可单独运用，而对重度患者，疗效不很理想，结合按摩等综合治疗，效果会更好。

刘某，男，65岁，工人。病史：患者自1984年9月以来，出现不明原因的右手指震颤，遂去某市级医院神经科就诊，诊断为原发性震颤麻痹。口服左旋多巴、安坦等药物治疗，开始时症状尚能控制，而后不见效果，反而加重。医生建议手术治疗，因患者有恐惧心理，遂寻求针灸治疗。现患者慌张步态，面具脸，双上肢震颤，每分钟4~6次，四肢肌肉强直，上肢无摆动，皮脂分泌旺盛，说话含糊不清，生活需子女照顾。头晕膝酸，舌淡苔少，脉弦细弱。诊断：原发性震颤麻痹（重度，20分）；中医诊断：颤证（肝肾两虚）。按上法治疗4个疗程后，患者生活能够自理，说话清晰有力，皮脂分泌减少，上肢能够摆动，步态平稳，上肢震颤偶尔出现，面部有表情反应。症状、体征评定总得分减少到6，（减少70%）达到显效标准。

二、辨证施治 针灸并用

陈兴华采用针刺加直接灸治疗方法治疗震颤麻痹，取得满意疗效。

取穴：百会、舞蹈震颤控制区、四关为主穴。依据临床辨证分型随证加用配穴。

操作：常规针刺，针刺得气后行平补平泻手法，每隔5min行针1次，留针30min。每日针刺1次，连续针刺10次为1个疗程，休息3天后进行第二个疗程治疗，连续2个疗程为1个治疗期。

直接灸：取穴肝俞（双），肾俞（双）、关元、气海。直接灸采用无瘢痕灸法，施灸时先在所灸腧穴部位涂以少量万花油，以使艾炷便于粘附，每次采用约如苍耳子大的艾炷，置于以上所选腧穴上点燃施灸，当艾炷燃剩2/5或1/4而患者感到微有灼痛时，即易炷再灸，每穴均5壮。

陈兴华认为本病的主要病机是肝肾亏虚，气血不足，虚风内生而起。正如高鼓峰在《医宗己任编》所云：“大抵气血俱虚，不能荣养筋骨，故为之振摇，而不能主持也。”以此为指导，陈兴华在临

床实践中,在常规针刺方法的基础上,加用直接灸气海、关元的方法,以达补肾培源、益气生血之作用;直接灸肝俞、肾俞,以收滋肾填精、益肝养血之功,同时前后并用,借以调理任督,使脑髓得于充填。诸法同用,共收补肾益肝、抗衰除颤之效。

患者王某某,男,65岁,退休工人。因四肢不自主震颤4年余于1995年8月就诊。自诉1991年始无明显诱因出现双上肢不自主震颤,逐渐发展至四肢震颤,伴有表情呆滞,动作僵硬,躯体前倾,慌张步态,书写困难等症。曾在外院服用安坦、美多巴等药治疗,症状时轻时重,近1月觉颤动又剧,伴有记忆力衰退,头晕,腰酸膝软,面具脸等症。舌质淡、苔薄白,脉弦细弱。诊为震颤麻痹(重度21分)。证属肝肾亏虚,气血不足型。给予针刺加直接灸方法治疗2个疗程后,患者四肢震颤明显减轻,仅上肢震颤偶见,步履平稳,肌张力降低,面部表情丰富。症状、体征评定总得分减至8分,进步率达到62%,疗效满意。

三、合穴为主 头针腕踝针并用

梁凤应采用针刺五腧穴中的合穴为主,结合头针、腕踝针,并配合药物治疗老年帕金森病,取得良好效果。

取穴:取五腧穴的合穴为主。第一组取阴陵泉、足三里、地机、三阴交、合谷、曲池、下关、地仓、廉泉。第二组取曲泉、阳陵泉、中封、太冲、支沟、手三里(外)、外金津玉液、颊车、承浆。第三组取阴谷、委中、太溪、飞扬、孔最、内关、天容、大迎、颧髎。头针取舞蹈震颤控制区,双侧交替使用。腕踝针:取上₅、下₄区。

操作:五腧穴、头针区1~1.5寸毫针进针,出现针感后,接G6805治疗仪,加电至患者能承受为限,刺激20min,每天1次,12天为1个疗程。一般治疗3~4个疗程。腕踝针用30号1.5寸毫针,与皮肤呈30°角快速进针。进入皮肤后,针体贴着皮肤表面,沿皮下平刺刺入1.4寸,以针下有松软感为宜。

中医治疗帕金森病常用滋补肝肾,益精养血,柔肝止颤等法,可辨证分为肝阴不足,虚风内动,肝气郁结,经络瘀阻,气血两虚,肝肾不足或脾虚湿重等型对证治疗。梁凤应采用中西医结合方法、配合五腧穴合穴结合头针、腕踝针治疗,取得较为理想效果。五腧

穴是手、足三阴三阳分布于肘膝关节以下的5个特定腧穴，临床应用范围较广，可用于治疗各种疾病。五腧穴的合穴主治肾病，取脾的合穴阴陵泉、胃的合穴足三里，肝的合穴曲泉，胆的合穴阳陵泉，肾的合穴阴谷，膀胱的合穴委中，可起缓解肌强直、少动及抑制震颤作用。头针治疗不仅对抑制震颤有效，对肌强直，运动减少，姿势不稳等症状也有着明显的改善作用，腕踝针通过十二皮部浅刺激机制，可以调整经脉之气，达到祛邪扶正、理气止颤效果。五腧穴结合头针、腕踝针综合治疗帕金森病，对帕金森病患者的震颤、肌强直、运动减少、姿势改变等症状可起到改善作用。

患者，男，69岁，1995年4月29日入院。四肢震颤、强直、少动已8年。曾多次住院治疗，诊断为帕金森病，颤证少动强直型。合并流涎，吞咽困难，尿潴留。针刺前已用美多巴加溴隐停、金刚烷胺、安坦治疗2年。中医诊断为“颤证”，证属肝阴不足，虚风内动。在原治疗用药不变情况下，加用针刺五腧穴中合穴，结合头针，腕踝针治疗，治疗第2天后，症状有所改善，行动较前灵活，身体有轻松感，震颤强直程度减轻，吞咽困难好转，能吃饭及服药。第一疗程结束后可以自己穿衣服，行走步距增大，转身灵活，前屈姿势逐渐改善。经治疗4个疗程，明显进步，进步率达82%。好转出院后，经1年随访，病情虽有反复，但较前明显减轻。目前生活能自理，无吞咽困难和尿潴留，震颤、强直症状也比以前减轻。

四、综合治疗 息风镇颤

帕金森病是以四肢震颤，肌强直，运动减少为主要特征的锥体外系疾病。本病多见于50~60岁的男性，一般起病缓慢，逐渐进展，严重影响患者的生活和工作。张静在临床工作中，采用头针、体针加药物穴位注射治疗帕金森病。

头针：取双侧舞蹈震颤区，两侧运动区下2/5处。穴位常规消毒后，进针后快速捻转使之得气，再用G6805电针治疗仪，选用连续波，电流强度以患者能耐受为度，通电30min。

体针：百会、风府、风池、印堂、合谷、太冲、太溪、三阴交、足三里。穴位常规消毒后，针刺穴位使之得气，每5min行针1次。

穴位注射：取双侧三阴交、足三里。穴位常规消毒后，用2ml

一次性注射器套上6号针头，吸入维生素B₁₂注射液0.5mg，分别针刺入双侧足三里，得气后各注入0.25mg的药液，次日依法将药物分别注射双侧三阴交，两穴交替注射。

帕金森病在中医学中属风颤范畴，主要是由于肝风窜犯四肢所致。多因年老体弱，或摄生不慎，或疾病所伤，致肝肾不足，水不涵木或平素多郁易怒，肝阳偏亢之人，均可使阴阳失调，肝风横窜四肢，扰乱脉络，气血运行不畅，经脉失养而发本病。治拟熄风宁颤，平补肝肾，调理气血。泻百会、风府、风池平肝以熄风镇静，印堂有镇静、宁颤之功。合谷配太冲为四关穴，既有开窍之用，又具镇逆之功。补太溪、三阴交平补肝肾，以制肝风，补足三里以调补气血，维生素B₁₂注射液具有营养神经，调补气血的作用，将其注射于穴位，可产生双重效应，从而达到调理气血，平补肝肾，息风镇颤的目的。

患者，男，48岁，工人，2001年5月10日初诊。四肢震颤3年。3年前无明显原因出现右侧上肢震颤，慢慢发展到右侧下肢和双侧上下肢体，并伴有肢体肌肉强直，活动不便，手部震颤为搓丸状，静止时尤为明显，入眠即止，醒则复发，烦躁易怒，常流口水，四肢感觉无障碍，肌肉无萎缩，服用安坦和多种中药后，症状稍有减轻，但停药后症状明显加重，因患病在家休养1年多。CT、脑电图检查未发现异常。诊断为帕金森病。遂按上法治疗，3个疗程后症状、体征基本消失，功能恢复正常，重返工作岗位，随访1年后未复发。

五、行气开郁为主 平肝风滋肝阴

毛红蓉以针刺为主治疗老年性帕金森病，取得较满意疗效。

取穴：头针：按焦氏头针取法，取双侧舞蹈震颤控制区、运动区上、中部；体针：取合谷、曲池、血海、足三里、太冲（均取双侧）、廉泉。

操作：在帕金森病常规口服药物治疗基础上加用针刺治疗，头针以30号1.5寸不锈钢针（毫针）刺到皮下或肌层均可，得气后以每分钟200转速度固定捻转2min后留针1h，每10min重复针1次。体针以30号1~2寸不锈钢毫针，进针得气后，行平补平泻手法后

留针 30min，并 10min 行针 1 次。头针、体针交替，每日 1 次，各 5 次，共 10 天为 1 个疗程，休息 3~5 天，继续下 1 个疗程。

本病属中医学“震颤”范畴。《素问》云：“诸风掉眩，皆属于肝”，“诸痉项强，皆属于湿”，又云：“掌受血而能摄，足受血而能步”。综观患者病程缓慢，多有气郁及痰象。因老年人肝肾日亏，精血不足，髓海失养，加之抑郁伤肝，劳神伤血，致筋失所养，故手足强直难用；郁而生痰，痰郁化热，热盛风动，故致震颤不已。治疗以行气开郁为主，辅以太平肝风，滋肝阴。取穴血海、足三里行气养血，气行则湿行，湿化则痰祛；曲池助气血运行；廉泉化痰开窍。头皮针疗法是直刺在大脑皮层的功能定位相应的头皮投射区，头部经络集中，经穴密布，与脑髓、脏腑气血皆有密切关系，针刺头皮定位区后，头脑部即有轻松和清醒感，这可能是对脑的黑质和黑质纹状体通路的变化有改善作用。临床中观察发现，发病年龄小，合并症少者，治疗 2~3 疗程后即可收效，而混合型年龄偏大，并伴有其他脑血管病者，疗程长，疗效差，即针刺疗效与病程长短、病情轻重密切相关。而防止针刺穴位的疲劳、积极治疗兼夹病症，是保证针刺疗效的关键。

六、肢体躯干肌群 梅花针轻叩

帕金森病是中老年较常见的神经系统变性疾病之一，主要表现为震颤、肌强直、运动减少和平衡障碍。张汉樑采用针刺治疗帕金森病运动障碍，疗效较好。

在美多巴等药物治疗的基础上，取梅花针叩击患者四肢和背部，然后再施以针刺。

叩击部位：上肢先从肩关节开始，分别叩击伸肌群和曲肌群。伸肌群从肩穴开始，沿着手少阳经向下轻叩，止于液门穴；屈肌群从手厥阴经的天泉穴开始，沿着手厥阴经向下轻叩，止于大陵穴。下肢取行于下肢前面的足阳明经，和行于下肢后面的足太阳经。背部则主要沿着两侧的足太阳经往下叩。轻轻地叩击，以皮色稍红为度。

针刺：按患者的步态和肢体震颤的不同程度，分别选取腕关节的阳池、阳溪、大陵和养老；肘关节的曲池、尺泽、曲泽和少海；

肩关节的肩髃、肩髃、肩贞和天泉；踝关节的中封、太溪和解溪；膝关节的阴陵泉、阳陵泉和委中；髋关节的环跳和承扶进行针刺。针具：依不同的穴位分别选取不同长度的、直径为0.30mm 不锈钢针灸针进行针刺。针法：整个针刺的过程，从入针、得气后的运针到出针，都要求用轻手法。得气后留针半小时，每5min 运针1次，运针时只轻摇或轻弹针尾，不提插捻转。疗程：每天治疗1次，15天为1个疗程，休息5~7天后再行下一个疗程。

针对帕金森病的肌强直可以发生在肢体和躯干肌群的特点，张汉樑使用了梅花针叩击手少阳经（伸肌群）、手厥阴经（屈肌群）、足阳明经（伸肌群）、足太阳经（屈肌群）以及背部两侧的足太阳经的方法，而且手法上强调轻叩，以达到松弛全身肌张力的目的。针对帕金森病的肌强直最先出现在腕关节，然后是肘关节和肩关节，因此在选穴上，取以功能上运动为主的、不同肢体的关节平面，近端取穴与远端取穴相结合来治疗帕金森病的肌强直。依据松弛训练可以降低肌强直的方法，张汉樑强调了在针灸施治的过程中一定要轻叩、轻刺。

郭某，女，62岁，退休干部，住院号：77839，于2002年1月就诊。主诉：肢体运动迟缓、肢体不自主颤动3年余。经头颅CT扫描，未见异常。长期口服美多巴0.25g，每日3次，症状没有明显缓解而收住院。入院时症见：肘、腕、掌指关节均有明显的静止性震颤，四肢肌张力呈齿轮样强直，腱反射亢进，写字时有明显的小字征，慌张样步态，玩具样脸。走10m所需的时间平均为56~58s，其中起动时间平均为4s，坐下时间平均为6s，转弯时间平均达14~18s，直线1m内平均步距为0.26~0.28m。按以上方法治疗3个疗程后，走10m所需的时间平均为48~50s，其中起动时间平均为3s，坐下时间平均为4s，转弯时间平均达10~13s，直线1m内平均步距为0.32~0.34m。同时，美多巴用量可以减少到0.125g，每日3次。随访1年，病情稳定，美多巴的用量没有增加。

七、补益肝肾 健脑安神

郑翎以头针、舌针、辨证取穴治疗震颤麻痹，疗效较佳。

取穴：头针：枕顶带、额顶带、运动区、舞蹈震颤区；舌针：

心、肝、脾、肾、上肢、下肢、聚泉。肝胃不足型加百会、风池、合谷、阳陵泉、三阳交、太冲、复溜、肾俞、肝俞；气血两虚型加百会、风池、内关、合谷、足三里、三阴交、气海、关元；气滞痰阻型加百会、风池、合谷、阳陵泉、丰隆、太冲、三阴交。

操作：用30号不锈钢毫针，进针得气后，行平补平泻手法，补泻配合手法。每日选取头针、舌针、辨证穴组各1组。针刺顺序为先针头针、次针辨证穴组，进针得气后，留针20min，拔针后行舌针点刺治疗。10次为1个疗程，每日针刺1次，头针、舌针、辨证穴组、每日选取1组，次日换取另1组。疗程间休息2天，再做下1个疗程。

震颤麻痹在中医学中属颤证范畴。本病的病变机制多系肝肾阴亏，气血不足，虚风内动，筋脉失养；或风火挟痰，气滞痰阻，络道滞涩，筋脉失养而成。肝肾不足、气血虚弱为本虚；气滞痰阻、虚风内动、风火挟痰为标实。辨证穴组与舌针穴的针刺起到了补益肝肾气血，健脑安神，行气蠲痰，平肝熄风的作用，从而激发了经气，气血得以正常运行，四肢百骸、五脏六腑、经脉经筋得到气血津液的濡养而缓解了症状。

赵某，男，55岁，工人。患者以肢体颤抖，运动迟缓两年余为主症，曾经CT检查：颅脑无异常。长期口服“安坦”，“左旋多巴”等药，症状缓解不明显，曾行“颅脑组织移植术”。术后症状无明显改善，于1993年5月10日以“帕金森综合征”收住入院。入院时症见：四肢不自主颤抖，运动迟缓，四肢麻木乏力，反应迟钝，说话缓慢，声音小，纳差，痰多，心情抑郁，小便正常，大便2天1次。查：行走呈前冲步态，面容呆滞，呈“面具脸”，油性皮肤，右头颅部有长约2cm的手术疤痕，心肺（-），脊柱生理弯曲存在，四肢肌张力增强，呈“铅管样变”，双手指精细动作差，四肢不自主颤抖，四肢随意运动差，协调作用差，双肱二、三头肌、膝跟腱反射亢进；舌质暗红夹青，苔薄白腻，脉细弦。既往有颅脑外伤史。入院诊断：颤证。（帕金森综合征）。按照 websten's 评分法评为19分系中度帕金森综合征。治以补益肝肾，益气养血，行气蠲痰，熄风止痉。取穴按上述治法取头针、辨证穴组、舌针。3种治法每日各选取1组穴位。具体治法如前所述。疗程间休息2天，经治疗7个

疗程，好转出院。

八、滋肾益肝 养血祛风

震颤性麻痹是一种锥体外系的慢性进行性变性疾病。目前，临床上对本病的治疗，只能改善其症状，治愈的可能性很小。蒋英在传统中医理论指导下，采用体针与头针相结合的方法治疗，收到较为满意的疗效。

体针取穴及补泻手法：太冲（补）、太溪（补）、血海（补）、合谷（泻）、曲池（泻）、风府（泻）、风市（泻）。每次用双侧穴位，留针 20min。

头针及电刺激波型选择：取舞蹈震颤控制区（先取运动区：上点在前后正中线上中点后 0.5cm 处，下点在眉枕线与鬓角前缘交界处，两点连线即是。运动区平行前移 1.5cm 为舞蹈震颤控制区），每次取一侧，两侧交替使用。用 28 号 1.5 寸针，至适当深度，得气后用 G6805 型电针仪通电，选用疏密波型，留针 20min。每次治疗，体针与头针并用，刺激强度适当，10 次为 1 个疗程，每疗程间休息 3 ~ 4 天。

中医学认为，本病的发生是由于肝肾阴亏，筋脉失养，虚风内动，或病久入络、气滞血瘀所致。故治疗大法当以滋肾益肝、养血祛风、活血通络为主。中医有“治风先治血，血行风自灭”之说，故首先选用养血活血、祛风通络的血海；太冲是肝经原穴，具有养肝祛风之功效；太溪是肾经原穴，有滋阴益肾的作用，肾水充足，则肝木得以涵养，虚风自息；合谷、曲池、风府、风市，共起祛风活血通络之功效。诸穴合用，标本兼治，再加上头针的配合治疗，相对于西医治疗，具有疗效好、安全、无毒性及不良反应、容易被患者接受的优点。

九、督脉为主 豁痰息风

李小军在采用西药治疗的同时，配合针刺督脉穴为主治疗帕金森病，疗效满意。

根据患者的病情，选用美多巴或配苯海索、金刚烷胺，剂量为常规剂量的一半，配合督脉穴针刺治疗。

取穴：上星、神庭、百会、四神聪、风府、身柱、灵台、脊中、悬枢、腰阳关、肝俞、阳陵泉。辨证配穴：阳亢者加风池、太冲；痰盛者加丰隆；虚证者加肾俞、足三里。

操作：上星向神庭平刺，百会向四神聪平刺，各穴针刺以得气为宜。百会、肝俞施捻转补法，余穴平补平泻。以上每天针1次，20次为1个疗程，中间休息1~2天。

《素问·骨空论》“督脉者……上额交巅上，入络脑……”，《难经·二十八难》“督脉者……上至风府，入属于脑”，故取督脉穴主治脑病。督脉循身之背，统摄一身之阳，其上巅入络脑，百会居于巅顶之上，与经外奇穴四神聪合用开窍通络止颤，又补下元虚损，疏泄肝风；风府为督脉、阳维之会，可清泄内风；上星、神庭镇静止颤；肝俞可息风止痉；阳陵泉为筋会，主治筋病。诸穴合用，共奏豁痰息风、开窍止颤的作用。

十、头针合四关 息风通络

俞竹青以头皮针合四关穴为主针治震颤麻痹取得较好疗效。

取穴：主穴：头针取额中线、顶中线、顶颞前斜线，太冲，合谷。配穴：头晕痛取风池、大椎、曲池；气血虚亏取肝俞、肾俞、足三里、三阴交；胸闷取内关、心俞等。

操作：头针用抽气法或进气法，四关、大椎平补平泻，肝俞、肾俞、足三里等体针用小幅度高频率捻转之补法，得气后留针30~60min，并艾灸足三里2~3壮。每日1次，10次为1个疗程。

中医学认为本病与肝肾有关，尤与肝的关系密切，“诸风掉眩，皆属于肝”，肝肾不足，精血虚亏，而致筋脉失养，约束不能，故震颤不已。又血虚生风，风盛则动而致颤动，所以治疗用滋补肝肾、息风通络之法。

额中线、顶中线属于督脉，顶颞前斜线经过督脉，督脉为阳脉之都纲，它的脉气与手足三阳经相交，大椎是集中点，又因督脉循行于脊里，入经于脑，与脑有密切联系，故取头针达醒元神、利机关、疏通经络之作用，合谷、太冲，一阴一阳，一气一血，一上一下，各为四关，两者同时有调气血、和阴阳、平肝潜阳之功。风池是足少阳胆经与阴维脉交会穴，醒神止眩，疏经活络。肝俞、肾

俞为背俞穴，合强壮要穴足三里，共奏滋补肝肾、固培原气之效。

娄某，男，50岁，干部。患者两年前双手出现不自主颤抖，症状持续加重，持物及行走不稳，行动迟缓，经服金刚烷胺、安坦，颤动一时缓解，时轻时重。近期头晕加重，颈项板滞，头部也出现震颤。查体：神清，目光迟钝，双手有节律震颤，头部微颤，颈项肌肉紧张，转动不利，病理反射未引出。诊断：震颤麻痹。治疗取额中线、顶中线、合谷、太冲、足三里、大椎、风池、肝俞、肾俞。1个疗程后头晕基本消失，颈项活动自如。2个疗程后，自觉四肢较前有力，行动较前敏捷，颤动减轻。

十一、头体针并用 息风解痉

庄垂加采用针刺经穴配合头皮针的方法治疗震颤麻痹，疗效满意。

体针：取穴：百会、风池、合谷、太冲、三阴交。随症加减：腰背酸痛者加肝俞、肾俞；言语不利，加上廉泉、承浆。操作：选用毫针，百会进针0.5寸，施捻转补法；风池针向结喉，进针2寸，施小幅度高频捻转补法，行手法1min；合谷、太冲直刺1寸，施呼吸泻法；三阴交直刺1.5寸，施捻转补法；肝俞、肾俞均刺向横突，进针1.5寸，施捻转补法，上廉泉在舌骨体上取穴，针向咽部，直针2寸，以咽部酸胀为度。留针30min。每日1次，10天为1个疗程。

头皮针：取穴：双侧震颤麻痹区、运动区。操作：用1.5~2寸毫针快速刺入，进针1~1.5寸，以每分钟200次的速度捻转3min，休息10min后，再捻转3min，如此重复3次，每日1次，10次为1个疗程。

庄垂加根据震颤麻痹的临床表现分析，其病位在肝，病机属风，故治疗以补益肝肾，息风解痉为主。在治疗过程中发现不少病人都伴有明显的腰背痛，刺肝俞、肾俞，有较好的效果。本病的主要症状包括震颤、僵硬和运动减少，但临床上常有所侧重，有以震颤为主，也有以僵硬为主。临床观察到，针刺对前者疗效较差，尤其对病程较长者，效果不满意；而对后者因针刺对降低肌张力有一定疗效，故可延缓其病情的发展，并对早期症状不严重的病人有较好的

疗效。

参 考 文 献

- [1] 张乃钺, 韩旭华. 体针加头针治疗震颤麻痹 35 例临床观察. 中国针灸, 1996, (2): 5~6
- [2] 陈兴华. 针刺加直接灸治疗震颤麻痹 30 例临床观察. 中医杂志, 1999, 40 (6): 342~343
- [3] 梁凤应, 刘式祺. 针刺配合药物治疗老年帕金森综合征 55 例. 广西中医药, 1997, 20 (5): 34~35
- [4] 张静, 沈宏家. 针刺加穴位注射治疗帕金森综合征 68 例. 上海针灸杂志, 2005, 24 (11): 25
- [5] 毛红蓉. 针刺为主治疗老年性帕金森综合征 67 例. 湖南中医杂志, 2000, 16 (4): 19
- [6] 张汉樑, 祝维峰. 针刺治疗帕金森综合征运动障碍的临床观察. 中国针灸, 2003, 23 (12): 709~711
- [7] 郑翎, 金宇. 针刺治疗震颤麻痹 52 例临床观察. 针灸临床杂志, 1997, 13 (3): 13
- [8] 蒋英. 针刺治疗震颤性麻痹 19 例. 四川中医, 2000, 18 (9): 56
- [9] 李小军. 督脉穴为主治疗帕金森综合征临床分析. 中国针灸, 2003, 23 (8): 445~446
- [10] 俞竹青. 头皮针合四关穴为主治帕金森综合征. 浙江中医学院学报, 1994, 18 (6): 45
- [11] 庄垂加. 针刺治疗震颤麻痹 32 例临床观察. 山西中医, 1997, 13 (3): 31

【脑 瘫】

脑瘫是指脑损伤所致的非进行性中枢性运动功能障碍，属于中医学五迟、五软、五硬、痿证的范畴。主要由围产期和出生前各种原因引起颅内缺氧、出血等导致，如母孕期感染、胎儿窘迫、新生儿窒息、早产、脑血管疾病或全身出血性疾病等。

中医学认为本病多因先天不足、肝肾亏损或后天失养、气血虚弱所致。父母体质素虚，精血不足，或母体疾病缠绵而致胎元失养，使胎儿先天禀赋不足，以致小儿出生后肝肾亏损，气血虚衰而成脑瘫；或者因分娩难产，窒息缺氧，颅脑损伤或疾病缠绵，治疗不当均可损伤心脾，导致气血虚弱而发病。

针灸治疗本病，常以阳明经穴位为主，根据症状，随症加减。专家们除积累了丰富的选穴经验，有的以风府哑门为主。治疗方法上有的摸索出舌针、头针滞针法，有的采用针刺配合运动疗法等，均能取到理想疗效。

一、阳经为主 合靳氏理筋术

黄劲柏采取阳经取穴结合靳氏理筋术治疗痉挛型脑瘫取得较好的效果。

取穴：以手足阳明、少阳经穴为主，上肢取曲池、外关、合谷、中渚，下肢取风市、伏

兔、梁丘、足三里、悬中、申脉。语言障碍配舌三针（拇指一、二指骨间横纹平贴于下颌前缘，拇指尖处为第一针，其左右各旁开1寸为第二针、第三针），腰软无力配腰三针（肾俞、大肠俞、委中），流涎配地仓、颊车，智力低下配智三针（神庭，左右本神穴）。

操作：选用1寸不锈钢毫针，进针0.5~0.8寸，以得气为度，每隔5min行针1次，施以平补平泻手法，留针30min，主穴每次均用，配穴随症选用。每日针刺1次，12天为1个疗程，疗程之间休息2天。

靳氏理筋术：头颈部：先以五指指尖叩击头部诸穴，再以五指指腹自前发际至后发际推数遍，按揉百会、风池、风府、哑门。腰背部：先捏脊3~5遍，然后用双手拇指点压夹脊穴，食指与中指指腹自大椎下推至长强，最后弹拨足太阳膀胱经第一、二侧线。四肢：循经点压手足三阳经诸穴，并施以推、捏、拿、搓、摇、抖、摩、弹、拉伸等手法，在此基础上重点对肩、肘、腕、髌、膝、踝等关节做被动屈伸、外展、内收、旋前、旋外、环转等运动，每次操作30min。

根据中医理论，阳明为多气多血之经，刺之可疏通经脉气血，而少阳位于身体侧面，如门户之枢转动由之，刺之可使营卫之气出入正常，二经穴位分布在伸肌处，刺之可增强伸肌肌力。靳氏理筋术是导师靳瑞教授在长期的临床实践中探索形成的治疗脑瘫的运动功能障碍的有效按摩手法，可改善肝主筋，脾主肌肉，肾主骨生髓之功能，同时可改善局部的血液循环，活血化瘀，增加受损组织的营养供应，促进新陈代谢和组织细胞的修复，以减轻肌肉萎缩，另外适当的被动运动，可增加肌肉的伸展性，使被牵拉的肌肉放松，亦可使挛缩的肌肉得以舒展并恢复到正常的功能位置。在针刺的同时配合靳氏理筋术等手法刺激，可从整体和局部缓解肌肉紧张状态，达到增强肌力，减轻痉挛的作用。以手足阳明、少阳经穴为主配合按摩治疗痉挛型脑瘫，将中医传统的经脉理论与现代解剖学知识相结合，在临床中取得较好疗效。

陈某，6岁，广东韶关人，1999年7月18日初诊。患者为早产儿，羊水早破，现6岁，不会走路，扶持能站立几分钟。两上肢内收，后旋，双下肢伸直，膝关节屈曲，扶立时脚尖着地，扶走时交

叉步。双上下肢肌力Ⅳ级，肌张力不高，腱反射亢进，巴彬斯基征(+)。以手足阳明、少阳经穴为主，实施以平补平泻手法，同时以轻柔，舒缓的揉、按、捏等手法作用在双侧上下肢肌肉痉挛处，经上法治疗两个月，双下肢痉挛减轻，可靠墙独立站立，按上法治疗两个月，痉挛进一步减轻，上肢可协调完成一些精细动作，下肢可独立行走十余米，双侧上下肢肌力Ⅴ级，肌张力不高，病理征消失。

二、头体针并用 配运动疗法

凡具有脑瘫高危病史的患儿称为脑瘫高危儿，他们不一定成为脑瘫患儿，但患脑瘫的几率远远大于普通婴幼儿。钟小蓓早期应用针刺配合运动疗法治疗脑瘫高危儿，取得较理想疗效。

取穴：①头穴：以顶颞前线、顶中线、顶旁1线、顶旁2线、枕下旁线及头部腧穴如百会、四神聪、风池、智三针为主，严格消毒和避开囟门。②体穴：上肢取肩髃、臂臑、曲池、三阳络、外关、阳溪、合谷；下肢取髌关、梁丘、足三里、丰隆、解溪、风市、阳陵泉、悬钟、丘墟、曲泉、太冲、殷门、合阳、承山、昆仑、照海；颈腰背配天柱、大椎、身柱、至阳、脊中、命门、腰阳关、腰俞、脾俞、肾俞、夹脊穴；语言迟缓配头部语言区、通里、内关、舌三针；伴流涎配地仓透颊车、承浆。

操作：以上穴位，根据患儿病证每日交替选用，用1寸毫针，局部消毒后，快速进针，采用捻转法，平补平泻，留针15~20min，每日1次，每周5次，20次为1个疗程，疗程间休息1周。

运动疗法：被动、主动及牵张运动；采用Vojta法诱发反射性翻身及腹爬，应用Boboth法抓住关键部位训练以达到控制头脑，诱发翻身，正确坐、爬，促进平衡能力建立，达到独站及行走。每次40min，每日1次，每周5次，3个月为1个疗程。疗程间休息10天。

患儿病情轻重不同，早期干预的时间不同，治疗时间亦不同。病情轻，早期干预介入早，治疗6~10个月；病情重，早期干预介入晚，治疗12~16个月。

根据神经发育原理，大脑在出生后2~3年内发育最快。有证据

表明,若在此期给予良性刺激,可促进脑结构发育和功能代偿。因此,钟小蓓选用针刺,通过神经、经络系统,促进了脑电活动和神经递质的分泌,有可能激活了其他脑细胞的代偿功能,改善了脑干功能,使外周信息能顺利地到达大脑皮质,有效地调节了大脑皮质功能。

运动疗法是运用徒手或借助器械,利用物理学的力学原理来预防和治疗的方法。对脑瘫儿进行规定量的强化训练可以增加肌力,改善运动,减少残疾。其机制之一就是正确运动只有达到一定量才能阻抑外周异常,才能在中枢以正确模式代替错误模式。因此,早期针刺配合运动疗法治疗可以减少脑瘫高危儿往脑瘫发展的几率。

黄某,男,3月15天,2004年12月13日初诊。其母代诉:至今不能竖头。病史:33周剖腹娩出,出生体重2000g,Apgar评分不详,否认窒息抢救史。查体:环境适应差,喜哭闹,视听反应差,仰卧呈弛缓性蛙位姿势,俯卧位紧张性迷路反射(+),肘无支撑,全前倾坐,扶站无支撑;肌张力低下,股角 120° ,髋窝角 150° ,足背屈角 60° ;Vojta姿势反射7项异常。出生后10天CT示:脑实质低密度,皮髓质分界不清,CT值 $13\sim 15\text{Hu}$ 。诊断:中枢性协调障碍,中医属五软。按上述治疗方法坚持治疗,于18个月时检查达到正常月龄发育水平,DQ:93分。

三、针药并用 辨证施治

脑性瘫痪(脑瘫)是当今儿童致残的主要疾病之一,虽呈非进行性,但运动功能障碍却长期存在。何爽采用针刺结合中医辨证的方法对脑瘫患儿进行了综合治疗,均取得满意效果。

头针:取穴:从神庭穴沿皮直刺向百会,从百会刺向脑户,国际标准化头针的运动区(双侧),足运感区(双侧),平衡区(双侧),此8针为治疗小儿脑性瘫痪的重要选穴及区域。若有智力障碍配四神聪,若有语言障碍可配国际标准化头针的语言1区、语言2区、语言3区。刺法:每隔2~3天针1次,每次留针1h,体弱患儿可适当减少留针时间。在留针期间,快速捻转($200\text{r}/\text{min}$)3次。疗程:每针10次,休息10~15天,针刺30次为1个疗程。

体针:主要按瘫痪部位及伴有症状取穴,上肢瘫选穴臂臑、曲

池、极泉、外关、手三里、合谷等，下肢瘫选环跳、阳陵泉、足三里、三阴交、解溪等，颈腰软弱无力者，针刺督脉与华佗夹脊穴。针法：每隔2~3天针1次，平补平泻手法，3岁以下及体弱儿不留针。3岁以上患儿留针30min，疗程：每针10次，休息10~15天，针刺30次为1个疗程。

中药：参照相关文献标准：共分5个证型。肝肾不足型选用补肾地黄丸；血虚邪侵型选用当归散；肝强脾弱型选用加味六君子汤；脾肾虚弱型选用补中益气丸合六味地黄丸加减；阴虚风动型选用大定风珠加减。以上汤药在主方的基础上均实行随证加减的原则，每日煎服1剂。

小儿脑性瘫痪是发育成熟前多种原因引起的脑部疾病，以非进行性非中枢运动功能障碍和姿态异常为特征，严重影响患儿行走和日常生活。其发病原因与先天禀赋不足，肝肾亏损，脑髓失养；后天哺养失调，脾胃亏损，气血虚弱，以致筋骨肌肉失于濡养，经脉运行不畅而不仁不用有关。其病机虚实夹杂，阴阳气血失调，症状顽固，缠绵难愈，单一治法往往顾此失彼，难获全效。何爽在运用头针、体针刺的同时，结合中医辨证施治，起到标本兼治，增强疗效的作用。

脑瘫的治疗应注意培先天肝肾，补后天脾胃。经云：“肾主骨，藏精生髓，通于脑”、“脑为髓之海”，肝肾充足，则脑健智聪，筋骨强壮，有利于小儿生长发育及智力的提高。《保婴撮要·五软》篇说：“手足软者，脾主四肢，乃中洲之气不足，不能营养四肢；肉软者，乃肉少皮松，饮食不养肌肤也；口软者，口为脾之窍，上下龈属于手足阳明，阳明主胃，脾胃气虚，舌不能藏而示也”。故后天脾胃增强，则气血化源充足，患儿体质得以强壮。同时体质的改善也能更好地配合治疗。针刺与中医辨证合用对小儿脑瘫有很好的疗效，且经济简便，可长期施治，是治疗脑瘫较佳的方法之一。

脑瘫患儿的中医证候类型不同，取穴和配穴也不同，必须正确辨证，根据经络决定深浅，还要辨阴阳，阴则深刺，阳则浅刺；另外要熟悉解剖位置，找准穴位。深刺与浅刺及穴位的准确性对疗效起决定性作用。

患儿，4岁8个月，于2002年12月18日来本院门诊就诊。曾

在外院就诊，确诊为小儿脑瘫（弛缓型）。初诊时检查：表情痴呆，反应迟钝，听力减退，不会言语，仅能发单音，智力明显低于同龄儿童。肌肉松弛乏力，下肢不能站立、腰不能挺直，站立不稳不能行走，手软下垂、不能抬举；生活不能自理。舌淡，苔白，脉沉细无力。中医诊断：五迟，五软——脾肾虚弱型。治则：益气补脾，强肾壮骨。方选补中益气丸合六味地黄丸加减治之。针刺：采用本文所述头针和体针综合疗法。经1个疗程治疗后，患者精神大为好转，反应较前灵敏，双手能持物，基本能自行站立，并能自行行走，语言能进行简单交流，能分辨出亲人声音。智测检查明显好转，智力接近正常。

四、风府—哑门 随症加减

脑性瘫痪包含两类：一类是先天性大脑发育不全，相当于中医学的“五迟”，主要由于其母在妊娠期体弱多病、受有害因素刺激、分娩不当和某些遗传因素等造成；另一类是后天性脑性瘫痪，主要是外伤、脑病或中毒等引起。王焕美采用针刺疗法治疗小儿脑性瘫痪，疗效较佳。

取穴：主穴：风府或哑门，交替进行。配穴：根据患者病情，每次选8~10个，百会、风池、头维、印堂、大椎、陶道、命门、肩贞、曲池、尺泽、外关、内关、合谷、环跳、风市、委中、足三里、三阴交、丰隆或太冲等。

操作：风府或哑门，交替进行，每日针刺1次，直刺，针刺深度以得气为度，可按患者颈周围长11%~13%作参考。配穴左右侧交替进行，常规针刺。每天针刺1次，以15次为1个疗程。疗程之间休息3天，针治5个疗程后，改为隔日针刺1次，疗程之间休息5天。

小儿脑瘫是一种难治病，脑瘫患儿脉多细滑或细缓，舌体偏胖，舌质偏淡偏暗，面色无华，纯系大脑发育不全，禀赋不足，或后天大脑受损。王清任《医林改错·脑髓说》曰：“小儿无记性者，脑髓未满”。风府、哑门穴均为督脉腧穴，位于脑后空窍处，与脑直接相连，有醒脑填髓、活血通络的作用。临床实践证明，针刺两穴可提高脑能量代谢及利用率，增加氧供，提高脑细胞活性，改善脑微

循环，确有醒脑开窍和开音利语的重要作用。

刘某，女6岁，于1991年5月14日入院。患儿为第1胎，足月，难产，产后窒息，经抢救后幸存。当时囟门处有一血肿，3个月后方吸收，囟门关闭较同龄儿晚，至今不会走路，不能站立，颈软不能抬头，不能自己吃饭，咀嚼无力，偶有流涎，智力低下，忽哭忽笑，5岁以后始能叫“爸、妈”，不会说话。6年来曾多次到全国各地求医，疗效不佳，故来我院请求针灸试治。查体：神清，痴呆面容，智力低下，不能行走，被抱入病房，不能用言语交谈，颈项、四肢软弱无力，肌张力低，腱反射弱。

治疗经过：患儿入院后经采用上述疗法后，针6次后，可用手势比划回答自己的年龄，可模仿单词，颈项较前有力，头可直起，扶物可站立数分钟；针10次，头部可自行转动，能说生活方面常用单词，可模仿短句，情感反应正常，能自己用匙吃饭，针16次，可回答自己的名字与年龄，扶床边自己可缓慢行走，但步态摇晃；针20次后，可背诵短小儿歌，唱简单歌曲；针30次后，记忆力、理解力明显提高，对事物可作简单叙述，可从“1”数到“50”，可计算“10”内的加法；针60次后，反应较灵敏，能说短句，能背诵数首儿歌，唱简单的歌曲，准确认出1~100的数字做简单的加法，面容也变得令人喜爱，能独自行走10m以上，针72次，患儿基本治愈出院。

五、舌针为主 配头体针

小儿脑性瘫痪是指出生前到出生后一个月内发育期非进行性脑损伤所致的综合征。临床主要表现为中枢性运动功能障碍和姿势异常，可伴有智力低下、惊厥、行为异常、语言障碍等。属中医学五迟、五软、五硬范畴。管遵惠采用舌针为主，配合头针、体针，治疗小儿脑瘫，收到显著疗效。

舌针：心穴、脾穴、肝穴、肾穴、舌柱、金津、玉液。针刺方法：医者左手垫纱布敷料，固定舌体于口外，进行针刺；补法：选用30号1寸或1.5寸针灸毫针，在选定的穴位上，拇指向前小弧度捻转3或9次，稍停，为一度补法。一般行一度或三度手法，不留针，捻转时，进针0.5~1分许，勿太深，一般不会出血。泻法：选

用28号1寸或1.5寸针灸毫针，进针1~2分，拇指向后大弧度捻转6次，稍停，为一度泻法，一般行二度或四度手法，不留针。舌底穴位中矩、舌柱、金津、玉液进针要稍深，针刺泻法个别穴位可能会出血。

头针：益脑十六穴：①囟门前三针：前发际上1寸，水平旁开1.5寸，计3穴；向前平刺0.5~0.8寸。②枕骨后三针：后发际上2寸，脑户下0.5寸，水平旁开1.5寸，计3穴；向下平刺0.5~0.8寸。③头颞左三针：头颞左侧，角孙上2寸，水平旁开1.5寸，计3穴；向下平刺0.5~0.8寸。④头颞右三针：头颞右侧，角孙上2寸，水平旁开1.5寸，计3穴；向下平刺0.5~0.8寸。⑤巅顶四神针：百会前后左右各1.5寸，计4穴；向百会方向平刺0.5~0.8寸。以上16穴，可根据瘫痪部位选择取穴，亦可全部取穴。针刺方法：用29号或30号1寸毫针，针与头皮呈15°角沿皮刺入达帽状腱膜层，快速捻转6次或9次，留针20min。

体针：上肢瘫：肩髃、曲池、支沟、合谷、后溪、八邪、少海、支正、劳宫；下肢瘫：髀关、伏兔、风市、阴市、阳陵泉、绝骨、太冲、足三里、三阴交、解溪、跟腱；智能低下，语言障碍：哑门、风府、风池、翳明、天容、人中、承浆、廉泉。针刺手法：补法：选用30号1寸毫针刺入选定穴位，拇指向前捻转3次或9次，稍停，为一度补法，一般行三度或九度手法。在捻针时，进针深度0.5寸左右，不留针，疾速出针后按压针孔。泻法：选用28号或30号1寸或1.5寸毫针，在选定穴位上，进针1寸左右拇指向后大弧度捻转6次，稍停，为一度泻法，一般行六度或八度手法，不留针。出针后，用消毒棉球轻擦针眼。

隔日1次或每周针刺2次，30次为1个疗程；每个疗程后休息7天。

小儿脑瘫属中医学五迟、五软范畴。其病机主要为先天禀赋不足，后天失养或感受邪毒，髓海受损，致肝肾亏损，心脾不足，气血亏虚，精乏髓涸，心窍蒙蔽，筋脉失养。肾为先天之本，主骨，生髓，藏精，通于脑，脑为髓之海，为精明之府，赖心气、脾气、肝阴、肾精所充养。病理改变涉及到肾、肝、心、脾及脑、髓、骨、脉等多个脏腑器官，故中医临床常以调补肝肾、益精生髓、醒脑开

窍、养心益智、疏经通络、强筋壮骨为基本治疗法则。

舌为心之苗，又为脾之外候。《灵枢·脉度》篇云：“心气通于舌，心和则舌能知五味矣”。心为五脏六腑之大主，脾是“后天之本”。故《灵枢·邪气脏腑病形》篇说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍……其浊气出于胃，走唇舌而为味”。从生理上说，脏腑精气必荣于舌；以病理而言，脏腑气血病变亦反映于舌，基于舌与全身脏腑器官的整体联系，故舌针具有醒脑益智、通关开窍、补益心脾、调和气血之功。

脑为元神之府，头为诸阳之会。益脑十六穴，通调督脉，振奋诸阳经气，起到充实髓海、健脑益智之效。兼以经络辨证，循经取穴，疏经通络，濡养经筋，调补肝肾，强筋壮骨。诸法合用，相辅相成，相得益彰，故能获得较好的临床疗效。

杨某，女，5岁，香港人，1999年10月11日初诊。

患儿足月剖腹产，出生后第四天出现溶血性黄疸、发热、角弓反张、抽搐，诊断为“新生儿胆红素脑病”，采用二次换血疗法及对症处理，1个月黄疸消退。8个月后始偶发单音，双下肢痉挛性瘫痪。1996年经香港医院检查确诊为“小儿脑瘫”。先后在香港、英国、美国等多家医院医治无效；后赴广州、北京等地针灸治疗3月余，收效不显。检查：表情痴呆，反应迟钝，听力减退，不会言语，仅能发单音“啊”、“妈”。双手臂不自主运动，持物不稳，膝、踝反射亢进，双足轻度下垂内翻，在成人牵拉下呈剪刀型步态行走，多动不宁，智力明显低于同龄儿童。脉细滑，舌淡红，苔白腻。辨证：肝肾亏损，精乏髓涸，痰蒙心窍，筋骨失养。中医诊断：五迟，五软。西医诊断：小儿脑瘫（混合型）。治则：调补肝肾，填精益髓，醒脑开窍，强筋壮骨。采用舌针、头针、体针综合治疗，36次后，听力基本正常，会说“吃饭”、“再见”等简单语言，可单独行走，双手持物较灵活。治疗8个月后，会接电话，能分辨出亲人声音，可以准确辨认20以内数字。治疗160次后，患儿可以说简单言语，可读、写100多个字，能单独跑步和上下楼。生活能自理。智测检查明显好转，智力接近正常。

六、三穴为主 随症加减埋线

陈学农在大量临床实践的基础上,结合脑瘫的临床特点和针灸治疗的优势,采用穴位埋线法治疗小儿脑瘫,取得较好疗效。

取穴:主穴:肾俞、大椎、风池透翳风。配穴:主要根据患儿病情的不同情况对症取穴。肢体功能障碍取患肢肩髃、臂臑、曲池、外关、大陵、合谷、环跳、髀关、风市、四强(经验穴,位于髌骨上缘中点直上4.5寸)、足三里、悬钟等穴。其中痉挛型加脾俞、阳陵泉;肌张力低下型加脾俞、三阴交;共济失调型加少海、阴陵泉;混合型加肝俞、脾俞、阳陵泉。伴智力低下加心俞、神庭;伴语言功能障碍加哑门、廉泉;伴听觉功能障碍加听会、四神聪;伴视觉功能障碍加瞳子髎、光明;伴癫痫加鸠尾、腰奇。一般随症选取15~20个腧穴组成2组,轮流使用。

操作:根据所选用腧穴的不同部位和有无透穴等情况,分别装入3~6cm长的0/2号肠线,局部常规消毒后铺洞巾。押手固定腧穴,刺手进针,达到相应深度后,施以一定量的刺激,然后一边缓慢退取套管针,一边推压针芯,将肠线平直植入穴位内,出针。针眼用消毒敷料覆盖,嘱患儿家属治疗1周内,注意治疗腧穴局部的保护,防止感染,1~2天后取下敷料,不需做其他处理。25天左右治疗1次,3次1个疗程。

肾为先天之本,主生长发育,主骨生髓充脑;而肝为黑极之本,主筋;心主神志;脾主肌肉、四肢,运化水谷精微,为气血生化之源,后天之本。本病的发生正是由于先天不足,后天难养,五脏精气不能上荣元神之府所致。因此治疗取肾俞补肾生精充髓,取督脉穴大椎以益智充脑,风池透翳风是陈学农多年摸索治疗中枢神经系统疾病的有效经验穴;再配合相应症状取穴,诸穴合用可达到补肾荣脑、养心益智、调养肝脾、补养五脏精气之功。从而使经络气血运行畅旺,精气上荣脑府,五脏功能协调。

七、头针滞针 醒脑开窍

小儿脑性瘫痪是指出生前到出生后1个月内由于各种原因所致的非进行性脑损伤,是儿童主要的致残疾病之一。米曙光采用头针

滞针刺法治疗小儿脑性瘫痪，取得较满意的疗效。

取穴：头针选穴参照《中国头皮穴名国际化方案》中的14条治疗线，结合临床症状及CT病理显示取双侧头皮治疗线及病变部位在头皮的投影取穴。主要取顶中线、颞前斜线、顶旁1线、颞前线、顶旁2线、额中线、额旁1线及四神聪。体针选穴以手足阳明经及任督二脉为主。取阳溪、曲池、肩髃、扶突、足三里、解溪、髌关、关元、命门、水沟、大椎、风府、哑门、三阴交、涌泉、内关。

操作：头针滞针刺法。病人取坐位，由助手或家长固定好患儿头部，选用26~28号1~1.5寸毫针，常规消毒皮肤后，根据临床症状选取上述3~4条治疗线，使针体与皮肤呈25~30°夹角快速刺入头皮下。当针尖达到帽状腱膜下层时，使针与头皮平行继续缓慢捻转进针，深度达0.7~1.2寸，然后单向（或左或右）捻转针，似搓麻线样，使单向旋转3~6转，使针下沉紧感，难以捻转不能施行手法为度，造成人为滞针。出针时先反向将针捻转2~3转，再小幅度左右旋转，使滞针松解，然后缓慢出针，出针后注意压迫止血（注意：凶门未闭婴幼儿禁针顶中线、凶门区及四神聪）。

体针：每次取10~13个穴位，上下肢合理搭配，选用26号2~3寸毫针，常规消毒皮肤后快速进针入皮下，其中哑门、风府直刺0.5~1.5寸，不提插可捻转，其他体穴进针0.5~1.5寸，施以捻转平补平泻手法。水沟、内关针刺法：水沟向鼻中膈斜刺0.3~0.5寸，施以雀啄泻法。内关穴直刺0.5~1寸，施捻转提插泻法。

一般3岁以内施手法后不留针，3岁以上（或懂事配合的幼儿）可留针15~20min。每日1次，30次为1个疗程，连续针刺10天可休息2~3天，每疗程可间隔5~7天。

小儿脑性瘫痪系先天胎禀不足、肝肾亏损或气血虚弱、髓海空虚、窍闭神匿、神不导气所致，治疗当醒脑开窍、补益脑髓、通调督脉、疏通经络。督脉为阳脉之海与脑和各脏腑关系密切，取督脉穴对脑和各脏腑功能均有作用。任脉与督脉相通，一阴一阳，相互协调，以调全身五脏六腑之功能，疏通阻滞的经脉气血，取一经之穴达到调节多经之功。水沟、内关又是醒脑开窍要穴，根据经络理论，头部穴位又是诸阳之会，人体六条阳经直接经过头部，六条阴

经也通过十二经别间接上头，并通过任督二脉循环，头和脑又是脏腑经络气血汇聚之地，故头针可调五脏六腑及全身功能。另一方面，从神经解剖学原理，头针取穴又是大脑皮层功能在体表的投影，故诸穴合用，共同醒神开窍，健脑益智，改善四肢运动功能，以达治疗小儿脑性瘫痪之功。

滞针，一直被认为是针刺的一种意外情况而强调应予避免，然而近来有人有意应用于临床治疗某些顽症，疗效颇佳。行滞针时，可对所针刺穴位的组织造成轻微的破坏，导致穴位轻微的无菌性炎症反应。这种反应形成了对穴位的一种持续刺激，直至这种炎症消失为止。

因为针感的获得是针刺治疗取效与否的关键，患者针感的反应表现为针感局部或向远处传导的酸、胀、麻等感觉，行滞针法时其针感反应比常规针法更为强烈和持久。这种持续刺激传入大脑皮层，能引起多重神经冲动，从而提高疗效。常规的针刺法刺激量小，不持久，针感较差，对大脑皮层中枢刺激较轻，引起的神经冲动亦少。可见，滞针法能更有效地增强针感，从而更好地调和阴阳，补虚泻实，从而达到提高疗效的目的。

八、针推穴注 综合治疗

王军英依据中医学脏腑经络学说理论与现代医学中枢神经损伤后功能重组重建理论，对患儿进行针刺、穴位注射、按摩运动为主的中西医综合治疗。

(1) 针刺治疗

取穴：根据临床症状，运动、智能、听觉、视觉、语言、肌力、肌张力、异常姿势等障碍，选择相应的头部、四肢、背部、腰部穴位及全息胚反应点。智力低下取智三针（神庭穴1针，左右本神穴各1针）、四神针（百会穴前后左右各1针），语言障碍取通里、廉泉、哑门；颈项软取天柱、身柱、颈夹脊穴。上肢瘫取抬肩（肩峰前下1.5寸）、举肩、曲池、外关、合谷；下肢瘫取环跳、髀关、伏兔、康复（梁丘上1.5寸）、瘫康（伏兔下2寸）、四强（髌骨上缘直上4.5寸），腰软无力取相应背部膀胱经穴，平透腰夹脊；肘拘急取少海、手三里；手指握拳取合谷、后溪、八邪；腕下垂取外关、

养老、阳池、阳溪；足内翻取绝骨、申脉、跗内翻穴；足外翻取三阴交、照海、跗外翻穴（三阴交下0.5寸），尖足取解溪、足内翻、丘墟透申脉；足外旋中封透商丘至照海；剪刀步取解剪；下肢肌张力增高取阳陵泉，肌力低下取足三里、脾俞；膝反张取直立、委中；不跨步，无跳跃动作取迈步（髌关下2.5寸）、跳跃（髂嵴最高点下2寸），角弓反张取筋缩、神道；流涎加承浆、地仓透颊车，趾屈曲取八风、足跖趾背屈取大都。手拇指内收取鱼际，前臂内旋后伸取肩前、肩贞、肘尖。头针取穴：运动功能障碍取运动区、足运感区，精细运动失调取运用区，智力障碍取智力区，语言障碍取语言二区、语言三区，听力障碍取听区，视力障碍取视区，步态不稳、运动失调取平衡区，体针取8~10穴，头针取3~4穴区。

操作：患儿取抱坐位（头针时用）、仰卧或俯卧位（背针、四肢针时采用）充分暴露穴位，常规消毒，用30号0.5~1.5寸毫针，四肢腰背部以飞针法，根据证型不同，分别施以补泻手法，如精血不足、肝肾亏虚型以快速重捻转震颤多针刺手法为主；血虚风乘型、肝强脾弱型、阴虚风动型以快速轻捻转少针刺为主，不留针。头部以标准头穴线与焦氏头针参合应用，留针25~50min。每天1次，10次1个疗程，30次1个大疗程。

（2）穴位注射

药物选用脑复康、乙酰谷酰胺、维生素B₁、维生素B₁₂，智力障碍选脑复康，肢体功能障碍者选乙酰谷酰胺、营养不良纳呆者加用维生素B₁、维生素B₁₂，每次取4~6穴，以主穴为主，每穴0.3~1ml。每周一、三、五毫针，二、四、六穴位注射，10次为1个疗程，30次为1个总疗程。

（3）按摩

采用推、拿、揉、按、拍、叩、捏、抹，以随症施术为主。揉按肌肉、穴位、捏脊叩督约15~20min，接着运动训练30min。每天1次，30次为1个总疗程。

（4）督导家属施以床上按摩康复训练

以指腹梳头，掌面摩腹，搓手擦足，叩脊为主，每天坚持1次，30天为1个疗程。

针刺能调节脑电活动，改善颅内血液流变学和微循环，调节血

浆中神经递质含量,提高肌力,平衡肌张力,并且提高脑瘫患儿认知能力,推拿促进患儿脑干的脊髓中枢神经功能恢复,促进局部循环,改善肌细胞内环境。协调肌群间的运动,改善随意运动。针灸推拿缓解肌紧张,抑制痉挛,醒脑开窍,镇心安神,能有效地作用于康复训练中的不利因素。药物穴位注射在针刺及药物的双重作用下。增强穴位的效能、疏通经气,健脑安神,调和气血,恢复大脑及麻痹神经的功能,同时结合现代康复技术,进行全方位刺激,诱导动作发育,抑制异常姿势,提高认知功能,促进全面康复。

九、风府哑门为主 针刺配刮痧

王焕英采用针刺配合刮痧治疗小儿脑瘫,疗效肯定。

针刺:主穴:选风府或哑门,每日针刺1次,交替进行,直刺,针刺深度以得气为度,可按患者颈周围长11%~13%作参考。配穴:根据患者病情,每次选8~10个,左右侧交替进行,常用穴位为百会、风池、头维、印堂、大椎、陶道、命门、肩贞、曲池、尺泽、外关、内关、合谷、环跳、风市、委中、足三里、三阴交、丰隆、太冲等。

刮痧:常规消毒后,在相应的部位上涂抹刮痧活血剂,先在印堂-百会-风府-哑门刮拭,重点以印堂、百会、风府、哑门、大椎为主,刮至局部发红,再在大椎穴以下至命门穴部位以上的足太阳膀胱经第一侧线上重点刮拭心俞、肝俞、脾俞、肾俞,以皮肤潮红、皮下有瘀点为度,之后在背部拔火罐。

每天针刺1次,以15次为1个疗程。疗程之间休息3天,针治5个疗程后,改为隔日针刺1次,疗程之间休息5天。刮痧3~5天1次,5次为1个疗程。

小儿脑瘫是一种难治病,属中医五迟之范畴。脑瘫患儿大脑发育不全,禀赋不足,或后天大脑受损。风府、哑门均为督脉腧穴,位于脑后空窍处,与脑直接相连,有醒脑填髓、活血通络的作用。临床实践证明,针刺两穴可提高脑能量代谢及利用率,增加氧供,提高脑细胞活性,改善脑微循环,确有醒脑开窍和开音利语等重要作用。

十、针刺夹脊 解痉挛

张小莉近年来采用针刺夹脊为主，配以头针、体针治疗小儿脑瘫，取得较满意效果。

取穴：夹脊穴、十七椎、长强。

操作：用28号1~2寸毫针，自第7颈椎旁开始，斜刺或平刺，针刺方向朝脑部，根据患儿身长针数不限；十七椎处直刺2~4针，深度1寸；长强穴朝脑部方向斜刺1针。每日1次，每次留针30min，患儿如无抽搐史，均加用电针刺激，每周6次，6~12周为1个疗程。

张小莉采用针刺夹脊、十七椎和长强，主要目的是解决患儿肢体痉挛，改善智力状况。针刺背部夹脊主要是华佗夹脊“夹背脊大骨完中去脊各一寸”，夹脊穴途径长，路经肌肉多，深浅层方向均有，每穴相伴发出脊神经支亦多，主治范围广泛，浅则调整皮表，深则调整脏腑，表则平衡阴阳，里则调理气血，肝、心、脾、肺、肾无不周全。肝肾两虚治以健脾补肾，气血虚弱治以益气养血，肝肾不足治以补肾养肝，气血不足治以补心养血、通窍。

长强穴位于督脉任脉交会处，谓之“长强者长于阳而强于阴，生气通于天，其质造形而通于地”，为纯阳初始，具有很好的宁神镇痉，解除瘰纵、脊强反折，除其癫疾之功效。

十七椎位于腰背筋膜、棘上与棘间韧带中，布有腰神经内支后侧支，有较强的镇痉止痛功效。

十一、夹脊穴为主 随症加减

刘金喜在参加第十一批援赞比亚医疗队期间对当地脑瘫患儿采用针灸疗法，疗效满意。

取穴：主穴：华佗夹脊穴、百会、肾俞。配穴：上肢重者，合谷、曲池、肩髃；下肢重者，取太冲、足三里、三阴交、环跳、风市。灸穴：肾俞。

操作：常规消毒后，快速进针，行提插捻转补法，3min出针，所有穴位均不留针。每天1次，或隔天1次，双侧肾俞穴施以艾条灸，每天1次，或隔天1次，每次10~20min，4周为1个疗程，疗

程间休息1周。

小儿脑性瘫痪属中医“五迟”、“五软”范畴，因天生胎禀不足，肝肾亏损。肝主筋，肾主骨，若肝肾不足，则骨弱筋痿，故见立迟、行迟、齿迟之症，心气不足则智力不发达，故语迟。百会乃督脉穴，位于头顶，督脉总督一身之阳气，刺之可激发人体阳气生成。肾经夹脊而行，故夹脊穴刺之可填补肝肾之精，配穴可局部通经活络，促进肢体功能恢复。艾灸肾俞，可温补肾阳，“善补阴者必于阳中求阴”，故阳得补阴则生，故诸穴针灸合用对小儿脑瘫有很好的疗效。

患儿，女，3岁8个月，曾在卢沙卡赞比亚大学儿童医院就诊，确诊为脑瘫。右侧上下肢偏瘫，站立不稳不能行走，生活不能自理，伴语言障碍。右侧上下肢内收痉挛，膝-踝反射亢进。取穴：华佗夹脊、百会、肩髃、合谷、曲池、环跳、太冲、足三里、三阴交，每天1次，用艾条灸肾俞穴，每天1次，每次20min，经3个疗程治疗，患者能自行站立，并能自行行走，语言能进行简单交流，内收性痉挛消失，生活基本自理。

参 考 文 献

- [1] 黄劲柏. 阳经取穴合靳氏理筋术治疗痉挛型脑性瘫痪37例临床观察. 针灸临床杂志, 2002, 18 (7): 28~29
- [2] 钟小蓓, 夏梓红, 孔艳英. 早期针刺配合运动疗法治疗脑瘫高危儿临床观察. 中国针灸, 2007, 27 (2): 106~108
- [3] 何爽, 骆钧梵, 陈竞芬. 针刺结合中医辨证治疗小儿脑性瘫痪31例疗效观察. 云南中医中药杂志, 2005, 26 (6): 25~26
- [4] 王焕美. 针刺治疗脑瘫24例临床观察. 中国自然医学杂志, 2002, 4 (3): 182~183
- [5] 管遵惠, 郭翠萍, 丁丽玲. 针刺治疗小儿脑瘫150例临床观察. 针灸临床杂志, 2002, 18 (1): 11~13
- [6] 陈学农, 周清毅, 叶燕, 等. 埋线治疗脑瘫300例临床研究. 中国针灸, 2002, 22 (1): 9~11
- [7] 米曙光. 头针滞针法治疗小儿脑瘫临床观察. 中国针灸, 2002, 22 (7): 461~463

- [8] 王军英, 张惠佳, 王益梅, 等. 针刺、穴位注射、按摩、运动综合治疗小儿脑瘫 200 例临床研究. 中医杂志, 2002, 43 (7): 504 ~ 505
- [9] 王焕英. 针刺刮痧治疗小儿脑瘫 24 例临床观察. 中国中医基础医学杂志, 2002, 8 (8): 58 ~ 59
- [10] 张小莉, 王祥荣, 张秀宝, 等. 针刺夹脊为主治疗小儿脑瘫 354 例疗效观察. 中国针灸, 2000, (5): 269 ~ 270
- [11] 刘金喜. 针灸治疗小儿脑瘫 35 例. 陕西中医, 2003, 24 (11): 1026 ~ 1027

【面 瘫】

面瘫是以口、眼向一侧歪斜为主要表现的病证，又称为“口眼喎斜”。本病可发生于任何年龄，多见于冬季和夏季。发病急速，以一侧面部发病为多。手、足阳经均上头面部，当病邪阻滞面部经络，尤其是手太阳和足阳明经筋功能失调，可导致面瘫的发生。本病相当于西医学的周围性面神经麻痹。

中医学认为，劳作过度，机体正气不足，脉络空虚，卫外不固，风寒或风热乘虚入中面部经络，致气血痹阻，经筋功能失调，筋肉失于约束，出现喎斜。周围性面瘫包括眼部和口颊部筋肉症状，由于足太阳经筋为“目上冈”，足阳明经筋为“目下冈”，故眼睑不能闭合为足太阳和足阳明经筋功能失调所致；口颊部主要为手太阳和手、足阳明经筋所致，因此，口喎主要系该三条经筋功能失调所致。

对本病的治疗，不少专家都有自己的独特经验。有沿皮透刺的；有刺络放血的；有针刺耳穴，配合艾灸的；有梅花针叩刺治疗的。总之经验各异，方法多样。

一、分期治疗 方法各异

朱荣英将周围性面瘫分为3期：发病1~7天为急性期，8~14天为静止期，15天以上为

恢复期。总结出一套采用不同方法分期治疗周围性面瘫的疗法。

操作：

(1) 急性期 选择健侧穴位进行常规针灸治疗，取穴太阳、下关、颊车、承浆、迎香、头维、地仓、阳白、攒竹，按常规手法针刺，均用平补平泻法，留针 30min；配以健侧合谷泻实手法，另加艾条温灸患侧，每次 30min。

(2) 静止期 选择患侧上述面部穴位进行浅刺，刺入皮下 5~7mm，不提插，不捻转，使针柄自然下垂，留针 30min；配以健侧合谷泻实手法，同时以艾条温灸患侧 30min。

(3) 恢复期 选择患侧上述穴位进行常规针刺治疗，进针深度 13~20mm，配以双侧足三里给予补法，同时加用 SP 治疗仪照射患部，每次 30min。

急性期针刺健侧穴位源于《素问·阴阳应象大论》：“善用针者，从阴引阳，从阳引阴，以右治左，以左治右”。面瘫的急性期正是气之盛衰、左右失衡的时期，根据元·王国瑞的“泻左即补右、泻右即补左”原则，急性期针刺健侧，加上艾灸温通患侧之血脉以利扶正祛邪。静止期采用浅刺法源于《灵枢·终始》：“脉实者，深刺之，以泄其气；脉虚者，浅刺之，使精气无得出，以养其脉，独出其邪气”。因面瘫起因是络脉空虚，外邪侵袭，病邪在表，病位较浅，故用浅刺法可疏通经络，散寒祛风，调和气血。因有“面口合谷收”之说，故急性期与静止期皆配以泻合谷以泻阳明之火的刺法。恢复期配以补气活络、调和营卫之足三里可对植物神经、局部血液循环、细胞免疫、体液免疫及特异性免疫、内分泌等功能进行调节，加上 SP 治疗仪的温热效应可使人体组织温度平均值升高，血液循环加快，达到通络牵正效果。

二、梅花针叩刺 辅以隔姜灸

中医学认为面瘫是由于脉络空虚，风寒之邪乘虚侵袭面部阳明、少阳经络，以致经气阻滞、气血流通不畅，经筋失于濡养，筋肉纵缓不收发病。雷鸣采用梅花针配合隔姜灸治疗该病。

操作：

(1) 梅花针叩刺 取患侧阳白、鱼腰、攒竹、丝竹空、下关、

四白、地仓、迎香、承浆、颊车，以上十穴分两组，交替选用，每天选用五穴后常规消毒，持梅花针轻叩穴位皮肤，以使局部皮肤潮红为度。

(2) 隔姜灸 将艾绒搓成直径约 0.8cm、高 1.0cm 的艾炷置于切成厚约 0.3cm 的新鲜姜片上，每次放在患侧阳白、下关、地仓、迎香、颊车等穴上施灸，当患者感到灼热时将姜片稍提起，使之离开皮肤，旋即放下，反复进行，直到艾炷燃尽，每穴施灸 3 壮，至局部皮肤潮红为度。

在治疗初期采用梅花针叩刺，每天 1 次，治疗 10 次后，采用梅花针叩刺与隔姜灸交替隔日进行。10 次为 1 个疗程，每 1 个疗程间隔 2 天。

雷鸣认为采用梅花针局部叩刺，一方面可以促进局部血液供应，起到疏风散寒、活血化瘀的作用；另一方面可以避免因长期针刺造成的面部肌肉的疲劳和伤害，另外配合隔姜灸可以给面部的经脉、经筋以温热刺激，促进局部的血液循环，使经脉、肌肉得到更多的营养，从而使瘫痪肌肉的功能得以恢复。

邹某某，男，23 岁，2002 年 3 月 10 日就诊。该患者 3 天前曾有轻微感冒，今日晨起后漱口时发现口角漏水，照镜后发现口角向左喎斜。遂来本院就诊。查：右侧额纹变浅，右眼闭合不全，露白约 0.2cm，右鼻唇沟变浅，口角向左侧喎斜。不能鼓腮、皱眉、蹙额、吹口哨。舌淡苔薄白，脉紧。诊断为右侧面瘫。治以祛风散寒通络。以梅花针和隔姜灸交替进行，取穴及方法如前述。并嘱出门时佩戴口罩，每日以温水洗脸，并以温热毛巾做面部热敷，2 周后痊愈。

三、水沟承浆 平衡阴阳

周围性面瘫是针灸临床中的常见病。为提高周围性面瘫后期病人的治疗效果，项琼瑶以平衡阴阳针刺法治疗周围性面瘫后期病人，疗效显著。

取穴：局部取穴：阳白、攒竹、四白、地仓、颊车、下关、翳风、风池、水沟、承浆。远道取穴：合谷、足三里。

操作：针刺皆选用 1.5 寸不锈钢毫针。局部穴位均针患侧，地仓和下关在治疗后期取双侧。阳白向下平刺透鱼腰；攒竹向睛明方

向斜刺；四白斜向上透睛明；地仓斜透同侧颊车；颊车向同侧耳部斜刺；下关、翳风直刺；水沟、承浆均向患侧斜刺。均为轻度捻转刺激。远道穴位均针双侧，直刺，合谷为轻度捻转刺激，足三里为捻转提插补法。加用 G6805 - C 低频电子脉冲治疗仪，一组电极选取下关、合谷，一组选取阳白、承浆或阳白、水沟，交替使用。频率 3Hz，轻、中度强度，连续波，留针 30min。隔日 1 次，每星期 3 次，10 次为 1 个疗程。

督脉二脉在调整阴阳平衡方面的作用是历代医家都非常重视的。督脉，被称为“阳脉之海”，在颜面部有着丰富的分支，并与手足三阳经、带脉、阳维脉交会。对全身阳经脉之气起到统率、督促的作用。

水沟，别名人中、鬼宫。当鼻唇沟的上三分之一交点处。陈修园曰：“人之鼻下口上，水沟穴一名人中，取身居乎天地中之义也，天气通于鼻，地气通于口，天食人以五气，鼻受之，地食人以五味口受之，穴居其中，故名之人中。”可见水沟穴是人体交通阴阳的一个非常重要的穴位。口眼喎斜主要是阳明经的病变，因手足阳明经都分布在面前部，所以针灸取穴时均以阳明为主。水沟穴为督脉、手阳明大肠、足阳明胃三脉之会穴，故为治疗口眼喎斜的重要穴位。对面瘫后期的患者采用督脉的面部穴位水沟既有局部牵正作用，又有整体的平衡阴阳、扶正作用。

任脉为“阴脉之海”，《素问·骨空论》：“任脉者，起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，至咽喉，上颐，循面入目。”《灵枢·五音五味》：“冲脉、任脉皆起于胞中，上循背里，为经络之海，其浮而外者，循腹（右）上行，会于咽喉，别而络唇口。”承浆，别名天池、鬼市、垂浆等，和督脉相接，又为足阳明胃经、任脉之会。任脉在此分支环唇，沿面部进入目下的地方。故此穴能治口角歪斜、面肿等头面疾病。同时任脉对全身阴经脉气有总揽、总任的作用。其脉气与手足各阴经、阴维脉、冲脉相交会。故取承浆又有交通阴阳的作用。

在上述两组的针刺治疗中，阳白、攒竹、四白、地仓、颊车、下关、翳风等皆为局部阳明、太阳经取穴。风池为足少阳、阳维之会，阳维主一身之表，故风池解表、祛风散寒，在面瘫后期作为辅

助穴位。合谷、足三里疏阳明经气，足三里还具扶正强健之功效。诸穴一起促进周身经气的循环，加速病情的好转。

四、穴注为主 配合体针

罗春燕用穴位注射配合针刺治疗面瘫后遗症患者，效果较好。

取穴：阳白、四白、上迎香、迎香、颧髻、颊车、地仓、太阳、丝竹空等穴。每次取3穴，交替注射。

操作：用一次性注射器，抽取无菌注射用水1ml，溶解扶济复（神经细胞生长因子，北京双鹭药业股份有限公司，4000U/支）。每穴注射药液0.3ml，每日1次或隔日1次，10次为1个疗程。注射完毕后，配合体针，除面部局部取穴外，加四关穴（双侧合谷、太冲）。面部可用TDP灯照射。

扶济复是冻干重组人碱性成纤维细胞生长因子，有促进神经、成纤维血管内皮再生的作用。穴位注射疗法虽然属于局部注射给药，但尚有针刺功效，对面部的经络腧穴之经气起到了调整作用；同时，药液在穴位内逐渐吸收的过程产生了对穴位相对持久的刺激作用，即针刺“守气”作用，从而从多方面提高针刺疗效。

赵某，女，45岁。主诉：面瘫4年。病史：4年前受凉后出现耳后疼痛，继而出现面部瘫痪，经西医诊断为面神经麻痹。服用激素、维生素B族、抗病毒药治疗，未见好转，后又经针灸治疗数月后未见明显好转，为求系统诊治于8月来诊。刻诊见：左侧额纹消失，抬眉不能，左眼睑闭合不全，左侧鼻唇沟消失，左侧口角下垂，皱眉、耸鼻、示齿、努嘴、鼓腮均不能。诊断为面瘫后遗症。治疗以穴位注射为主配以体针，取阳白、迎香、地仓、丝竹空、颧髻、颊车等穴，每次3穴，交替注射扶济复药液1ml。治疗1个疗程后，明显好转，左侧额纹有所恢复，但较健侧浅，患侧鼻唇沟有所恢复。治疗3个疗程后，左侧额纹恢复，上额运动中等，左眼睑可完全闭合，口角对称，面部运动基本恢复，临床告愈。

五、远近结合 深透刺

刘涛根据不同辨证结果，采用面部深透刺结合远取足三里、厉兑治疗周围性面瘫，取得较好效果。

取穴：面部取阳白、鱼腰、瞳子髎、太阳、颊车、地仓、迎香、上关、下关（以上穴位均取患侧）。风热型取患侧厉兑，风寒型取患侧足三里。

操作：风寒型和风热型病人均采用相同的面部穴位深透刺法，阳白透鱼腰，瞳子髎透太阳，颊车透地仓，地仓透迎香，上关透下关。使用1.5寸无菌毫针，与面部皮肤成30°角向所透刺的穴位深刺40mm，采用平补平泻手法，务使针感到达所透刺的穴位，得气后患侧面部有绷紧和被固定的感觉。留针30min，留针期间不行针。每日1次，10次为1个疗程。

风寒型病人取足三里，直刺25~40mm，采用提插补法，务使针感向上传导。每日1次，10次为1个疗程；风热型病人取厉兑穴，采用刺络放血法，用无菌三棱针点刺穴位局部后，用力挤压，令出血量如黄豆粒大。隔日1次，5次为1个疗程。

透刺法是治疗面瘫的常用针法，是一针双穴甚至一针多穴之法，透穴通络，能更好地使“气至病所”，发挥“通经络，调气血”的作用。而深透刺则更能增加刺激强度，加强针感，更好地达到驱散病邪的目的。刘涛的体会是，面部穴位的操作应采用强刺激，使病人有强烈针感，整个患侧面部有紧绷、固定的感觉；出针后，这种感觉仍然会持续一段时间。

针灸治疗疾病，取穴的重要原则之一是“远近结合”，而这种结合的根据则是经络循行的线路。足阳明胃经的循行从头至足，在面部有两条较大分支，几乎覆盖了整个面部，“经脉所过，主治所及”，故远取足阳明胃经腧穴。配合远取穴位，不仅可以提高治愈率，而且可以使多数痊愈病人的疗程明显缩短。

谢某，男，35岁，工人，2001年9月14日初诊。2周前曾感冒，伴发热头痛。7天前晨起刷牙时发现左侧口角漏水，以后几天内逐渐出现左侧口角下垂、咀嚼食物障碍、迎风流泪及听力异常等症状。查体：体温36.6℃，血压115/60mmHg，左侧额纹消失，不能皱眉，左侧眼睑不能闭合，左侧鼻唇沟消失，左侧嘴角下垂，肢体运动正常，无偏瘫。伴头痛，目赤，大便干燥，舌红、苔黄厚，脉滑数。脑CT检查未见异常。西医诊断：周围性面神经炎；中医诊断：周围性面瘫（风热型）。经面部深透刺配合足部厉兑穴点刺放

血，治疗6次后症状明显缓解；15天后，所有面肌功能完全恢复，临床症状均消失，与病前无异。

六、针刺合谷 气至病所

贺春山在临床实践中以针刺合谷穴使“气至病所”治疗周围性面瘫，疗效较其他疗法，疗程短、面部功能恢复快。

取穴：先取健侧合谷，其次取患侧阳白、地仓、颊车、下关、太阳、翳风等穴，每次取3~4个穴，交替使用。

操作：首先取健侧合谷穴进针，行均匀提插捻转催气到来，然后以针尖向上（顺着手阳明大肠经循行方向）进行小幅度的旋捻（1~3min，200~300次/min），使针感上行至患侧面部，同时左手拇指按压合谷穴下方，若患侧面部无感觉则把针尖提至皮下，再稍调整部位刺入并重复上面的手法操作，或施以弹法、刮针柄等手法而加强行气作用。患侧面部有酸胀感、发热感，蚁行感等为“气至病所”的针感。其次取患侧阳白、地仓、颊车、下关、太阳、翳风等穴，每次取3~4个穴，交替使用。选用28号或30号1~2.5寸毫针针刺。以浅刺为主，手法以捻转补法或平补平泻手法。5次为1个疗程，每日1次。

针灸治疗面瘫其作用为“通其气血，调其阴阳”。运用补泻手法以蠲邪扶正，推动经气，疏通经脉，调和气血，经脉一经通畅，营卫自然相随，不仁不用的肌肤即能渐次恢复正常。临床过程中首先取健侧合谷穴，使“气至病所”，行气至面部。如《灵枢·经脉篇》载：“大肠手阳明之脉，其支者，从缺盆……还出挟口，交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔。”阳明经为多气多血之脉，针合谷穴引气上行至面部，可调和气血，通畅经络。

关某某，男，32岁，干部。1986年6月10日初诊。患者叙述三日前午睡时开启窗户，醒后即感左面部麻木，左眼不能闭合，进食时如嚼花椒。翌日清晨漱口时左口角漏水，进食时左腮部塞食。检查：左侧面部表情肌和咬肌无力收缩，左眼不能闭合，左面部感觉减退，不能鼓腮及吹口哨，左鼻唇沟平坦，口角右喎斜，示齿时左侧见半个牙，进食及喝水时漏饭、水，舌前2/3味觉减退，舌苔薄黄，脉象浮滑略数。诊为：左侧面部周围性面瘫。治疗：先针刺

右侧合谷穴，采用“气至病所”手法催气至患侧面部，后针阳白、下关、迎香、颊车、地仓等。经治疗7次后症状完全消失，面肌功能恢复。

七、顽固难症 独用灸法

庄子齐采用直接灸（面部穴位隔姜灸）治疗顽固性面瘫，疗效满意。

取穴：①组取牵正、翳风、颊车、地仓、太阳、阳白、足三里、合谷；②组取关元、气海、中脘、脾俞、肝俞。

操作：面部穴位用小麦粒艾炷隔姜灸，5~7壮/次，其他穴位用小麦粒艾炷非疤痕灸，5~7壮/次，①、②两组穴位交替进行，每日1次，2周为1个疗程。

周围性面瘫多为面神经炎所致。早期及时用针刺治疗一般疗效较佳，若病延日久则疗效差。一般病延3个月以上成顽固性面瘫则针刺疗效差。此时中医辨证多为气虚痰瘀阻络。根据“针之不为，灸之所宜”之原则，故以小麦粒隔姜灸面部穴位，以祛风湿经、活血通络。直接灸足三里、合谷、中脘，以健脾祛痰，益气活血，温经通络。直接灸关元、气海、脾俞、肝俞，以健脾益气养血，扶正固本以驱邪，以治其本。

颜面五官一般不宜施用直接灸，故面部穴位予以隔姜灸，灸前先在面部穴位涂上少许万花油，再施以隔姜灸，灸时应以患者自觉热为度，灸完再涂少许万花油，以免烫伤，隔日1次。

平时可嘱患者自我悬灸患侧面部穴位及关元、气海、足三里等穴，以巩固疗效。

邓某，女，56岁，工人，住院号71236。以左口眼喎斜4月余入院。查左闭眼不全（眼裂1cm），左额纹消失，口角右喎斜，左鼻唇沟变浅，伸舌居中，舌淡暗、苔白腻，脉细弦。西医诊断：面神经炎。中医辨证：面瘫（气虚，痰瘀阻络）。按上法治疗2个疗程（4周）痊愈出院。

八、左右交替针刺 通调气血

面瘫，即面神经麻痹，临床上分周围性与中枢性两大类。张福

顺采用健侧穴位与患侧穴位交替针刺的方法，治疗周围性面神经麻痹，取得满意疗效。

取穴：风池、翳风、地仓、颊车、攒竹、丝竹空、太阳、阳白、四白、合谷、太冲。

操作：患者取仰卧位，头面部穴位每次选用以上4~6穴，穴位皮肤常规消毒后，用28号或30号1寸毫针快速平刺或斜刺，针刺得气后，行平补平泻法，再接G6805治疗仪，病程在15天以内者用密波，刺激强度以患者感到舒服为宜，病程在16天以上者用疏密波型或断续波型，刺激强度以患者能耐受为宜，每次20~30min；起针后，再用维生素B₁₂500mg+2%普鲁卡因0.5ml，在以上穴位注射，每次用2穴；每天针治1次，7天为1个疗程。每疗程的第一天和第五天头面部穴位取健侧穴，其余时间取患侧穴。合谷、太冲每天取单侧，左右交替针刺，平补平泻或泻法，留针20~30min，每10min行针1次，每天针1次，7天为1个疗程。1个疗程完后，休息3天，再针下1个疗程。

《素问·缪刺论》指出：“邪之客于形也，必先舍于皮毛，留而不去，入舍于络脉……，邪客于经，左盛则右病，右盛则左病……，如此者，必巨刺之……，左取右，右取左。”《内经》提出的这种发病机制，临床上的面瘫病人表现最为突出，口角喎向健侧，说明左右两侧面部络脉的经气不平衡，左侧经气充实则右侧发病，右侧经气充实则左侧发病。张福顺采用左右侧穴位交替针刺法治疗面瘫，是根据《素问·缪刺论》中的巨刺、缪刺针法演变而来。首行针刺健侧，乃是根据患侧络脉空虚而设，是通过针刺来调节健侧与患侧络脉的经气，使其在新的基础上重新达到平衡，以后针刺患侧穴位，以达到驱邪外出，加速患侧络脉经气的畅通和恢复，从而达到既能驱邪外出，又能调节左右两侧面部经气的平衡的治疗目的，切合面瘫病因病机，故能收到良好的疗效。

李某，男，42岁。从左侧耳后疼痛、左侧面瘫1天来诊。查：左眼闭合不全，口角喎向右侧，左侧鼻唇沟及额纹消失，鼓腮漏风，舌红，苔薄黄，脉浮略数。即刺健侧风池、翳风、地仓、颊车、攒竹、太阳，针刺得气后行泻法，再接G6805治疗仪，选用密波，强度以患者感到舒适为度，治疗30min。针刺右侧合谷、太冲，泻法，

留针30min, 每10min行针1次。第二、三、四天针患侧穴, 治疗3次后左耳疼痛消失, 治疗1个疗程, 左眼基本能闭合, 口角已正。休息3天后, 再针治3次而痊愈。

九、半刺法 调整阳经气血

面瘫是临床常见病, 耿文在《内经》半刺法的启发下, 治疗儿童面瘫, 取得较好疗效。

取穴: 攒竹、阳白、丝竹空、迎香、地仓、颊车、对侧合谷。

操作: 选用32号1寸针, 均平刺快速进针至皮下, 阳白、攒竹向鱼腰平刺0.5寸, 迎香向上平刺0.5寸, 丝竹空向太阳平刺0.5寸, 地仓与颊车相对平刺0.5寸, 合谷直刺0.5寸。5次为1个疗程, 疗程间隔2天。

临床上儿童面瘫多因年少络脉空虚, 风寒之邪侵犯面部阳明、少阳筋脉, 以至气血阻滞而发病。取穴中迎香、地仓、颊车、合谷均为阳明经穴, 阳白、丝竹空均为少阳经穴, 攒竹为太阳经穴。均能调整各阳经气血, 疏调经气。针对患儿惧怕扎针, 深刺时针感强, 患儿不容易接受的特点, 临床采用半刺轻刺激治疗。半刺是浅刺快出、不伤肌肉的刺法。这种刺法是浅刺于皮肤, 刺得浅、出针快, 好象拔去毫毛一样。因其刺入极浅, 不是全刺, 所以称半刺。主要作用是宣泄浅表部的邪气, 属于十二刺之一, 以阳明、少阳经穴针刺为主, 疏通阳明、少阳筋脉, 祛风散寒。在实际操作过程中, 应尽量沿皮下透刺, 以达不伤肉的目的, 以避免诱邪深入。此外, 急性期即患病1周内, 速刺时不提插不捻转。恢复期即患病1周后, 透刺到对侧穴下后, 用平补平泻法左右各捻360°, 对治疗效果也起到关键作用。

陈某, 女, 5岁。于2004年8月5日就诊, 家长代诉, 1天前出现左颜面麻木不适, 未治疗, 病情逐渐加重, 出现口角向右喎斜, 左眼睑闭合不全, 遂来就诊。病起时有乘车感受风寒病史。诊断为面瘫。用上述方法治疗10次痊愈。

十、面瘫三针方 顿退六部法

周围性面瘫经治疗6个月仍未愈, 留有口眼喎斜等后遗症者为

陈旧性面瘫，郭效汾使用顿退六部针刺手法治疗陈旧性面瘫。

取穴：面瘫三针，即颊车、翳风、阳白与丝竹空穴连线中点处（为经验穴）。

操作：用28号3.5寸不锈钢针，颊车向地仓透刺，阳白与丝竹空中点处向下关穴透刺，翳风穴直刺2寸左右。顿退六部手法在每穴内先刺到应刺深度后，分六部施术，先深后浅，每部先滞针行顿退插提术，间歇性向外紧提针柄，六部施术完毕后，针尖再从浅层插向深层（或由所针穴处插向所透穴处），每隔5min施术1次，20min后出针。每日针刺1次，7次为1个疗程，隔1天再开始下1个疗程。

顿退六部手法是结合传统的提插补泻法总结出来的，同时改六部退针，每部均滞针后重提不插，目的是要重泻邪气，因陈旧性面瘫病程较长，邪气深入，非重泻不足以祛邪。

“面瘫三针”，其穴位均位于面神经分布的重点区域，刺激该类穴区有利于支配神经的活跃。

十一、针刺效点 补虚泻实

郭效宗在40多年的临床工作中，对周围性面神经麻痹摸索出有效点的选穴规律，按有效点进行治疗能使症状消失，或明显减轻。

寻找有效点的分布规律：全身分为四段，即：头颈段、躯干段、上肢段、下肢段，各段又分四个区，即一区、二区、三区、四区。在各区的八个方面：①沿血管及血管分叉处周围。②神经丛、神经干周围。③上下对立分布，上病取下，下病取上。④对侧的相同处。⑤病位水平线。⑥病位垂直线。⑦经纬线。⑧循经分布等处。按照这些部位寻找出治疗周围性面神经麻痹的“有效点”，如按压四渎穴，能使头痛、耳区痛、耳鸣、面部发紧感消失或减轻，针刺后面部麻痹的肌肉较针前活动灵活或恢复活动能力。按压健侧下鱼腰穴，病侧的眼睑能闭合或完全闭合。

治疗本病时应根据患者的具体病情、病程、病位选有效点，同时还要遵照以下治疗原则：①急性期（炎症期）采用远端有效点，禁刺颜面穴位，特别是禁刺痛处的穴位。②恢复期（后遗症期）远端有效点和患部有效点相结合，以近端取穴为主，远端取穴为辅。

急性期针刺穴位：大椎、风池、四渎、合谷、上巨虚。恢复期，近端穴：太阳、下鱼腰、睛明、地仓、翳风。远端穴：四渎、上巨虚。以上述穴位为主。亦可随症加减。恢复期的病人亦可以用透刺法，如地仓透颊车，地仓透四白，地仓透颧髎，地仓透承浆、地仓透禾髎，地仓透迎香等，每穴针刺时要得气。急性期用清泻法，恢复期用温补法，健侧轻刺。急性期每日针1次，恢复期隔日针1次，不留针。常用1~1.5寸毫针，一般用平、清、温补、泻五种手法。治疗时按患者体质辨证施治，不实不虚者用平刺法，体虚者以补法为主，偏实者以泻法为主，受外邪而实者用清法，受外邪而寒者用温法。取穴要准确，每针刺一个穴位或有效点都要有特定感传，才能收到满意疗效。如针风池穴针感要达到额头部，针上巨虚针感至足尖等。

李某，男，52岁，干部。1985年2月13日来诊。主诉：左侧面部发紧，嘴喎、漏水五天。五天前无明显诱因，晨起漱口时觉左口角漏水，左面发紧，偶有跳动感，嘴角向右侧，眼不能闭合、流泪，即去某医院就医，诊断为周围性面神经麻痹。经予泼尼松口服及维生素B₁、维生素B₁₂肌内注射，不见好转，来本所求治。检查：左额纹消失，抬眉不能，眼裂增宽，露睛约2mm，左鼻唇沟变浅，皱眉不能，口角下垂，示齿口角向右侧喎斜，鼓腮漏气。按上述方法，针10次后，额纹出现，闭眼全。鼻唇沟变深，但示齿仍差。继续针刺大椎、风池、四渎、合谷、上巨虚8次，左面部活动基本正常，抬头纹两侧对称，鼓腮不漏气，示齿好。为巩固疗效继续针3次，痊愈后停诊。

十二、三步疗法 分期施治

周围性面瘫为临床常见病，多发病。若治疗得当预后佳。林宾采用3步疗法治疗周围性面瘫，可大大提高临床疗效，预后佳。

第一步 发展期（1周内）：采用浅刺、加灸或TDP照射为主。

①针刺：取穴：风池（双）、太阳、下关、攒竹、阳白、四白、颊车、承浆、合谷（双）。操作：选用30号0.5~1寸毫针，均浅刺，手法宜轻，留针20min，每日1次。②灸法：将艾条点燃后灸患处10min。③TDP照射10min。

第二步 稳定期 (7~20 天): 采用透刺闪罐或加电针治疗。①透刺: 取穴: 地仓透颊车、颊车透下关、下关透太阳、阳白透鱼腰、四白透睛明、攒竹透睛明、承浆透地仓。操作: 选用 30 号 1.5~2 寸毫针, 面部诸穴透刺, 进针与面部呈 15° , 留针 30min。②闪罐法: 针刺后于患侧面部循经闪罐, 即拔即起, 并可沿经牵拉走罐, 每日或隔日 1 次。③电针疗法: 病重或恢复缓慢者可加用此法。取穴: 患侧阳白、攒竹、太阳、地仓、人中、承浆、迎香、双侧合谷。方法: 患部选 2 组穴位加电针治疗仪, 采用连续波, 以面部肌肉轻微抽动为宜。每隔 10min 换 2 组穴位, 留针 40min, 每日或隔日 1 次。

第三步 恢复期 (20 天以后): 针刺穴位要少, 浅刺为主。并嘱患者进行自主面肌功能锻炼, 如皱眉、蹙额、鼓腮、闭眼、噘嘴等动作, 或多用患侧吃饭及咀嚼口香糖。

周围性面瘫多因面部受风寒诸邪侵袭, 经络失调, 气血阻滞, 血不荣筋, 肌肉迟缓不收而发生。林兵宾根据该病分期不同, 采用“3 步”疗法来提高针灸治疗面瘫的临床疗效。第一步发展期的针灸治疗方法极其重要, 如果不当, 会延误病情, 影响面部功能恢复。1 周内属风寒袭络, 病在表浅, 据“病在表, 浅而疾之”治疗原则, 采用浅刺、轻刺、少取穴为主。若早期使用透刺、重刺或电针等, 会使神经损伤程度加重, 不利于面神经功能的恢复。另早期加用艾灸或 TDP 神灯照射可温通经络, 祛除风寒, 起到热疗作用, 可改善局部的血液循环, 消除水肿, 加速面神经功能的恢复。第二步稳定期, 邪已入内, 选用透刺、电针治疗, 目的在于加强针刺感应, 促使面神经功能的尽快恢复。第三步恢复期, 病邪已去, 故选穴宜少, 手法宜轻, 并嘱患者加强面肌功能的锻炼。因运动能促使血液循环加快, 则肌力加强, 有利于运动功能的恢复, 预防肌肉萎缩。故“3 步”针刺法治疗周围性面瘫可提高针灸临床疗效。

马某某, 男, 62 岁, 工人, 1998 年 6 月 20 日就诊, 3 天前睡觉时开窗, 早晨起床后自觉左侧面部不适, 耳后疼痛, 刷牙时漏水。今日前来本门诊就诊。患者左侧额纹消失, 眼睑闭合不全, 口角向右侧喎斜, 鼓腮漏气, 人中沟喎斜, 左眼流泪, 舌淡苔白, 脉浮紧。测血压正常, 既往体健。诊断: 周围性面瘫, 采用以上“3 步”疗法, 15 天痊愈。

十三、从经筋论治 标本兼顾

王霭平有感于周围性面神经麻痹因失治误治而导致症状缠绵难愈，潜心研究针灸经络学，以经筋理论为指导进行治疗。

取穴：①局部取穴：承浆透大迎、地仓透颊车、鼻通透睛明、耳门透听会、攒竹透鱼腰、球后透睛明。②远端取穴：百会、头维、天容、天窗、曲鬓、风池（双）、风府、足三里（双）。③拔罐取穴：患侧面部和颈部，以及足太阳经在背腰部的第一循行侧线。

操作：分3步进行。第一步依次在患侧的面部及其同侧的周边取上述穴位针刺，面部刺法为平刺透穴，只捻转，不提插，得气后以右手拇、食、中三指持针柄单向捻转滞针，慎守经气勿失；风府穴针刺得气后取针；其余各穴均用平补平泻法，留针20min。第二步在患侧面部和颈部作闪罐治疗，以局部出现潮红充血为度。第三步在足太阳经的背腰部第一侧线上给予拔罐10min。

经筋较经络而言浅显。筋，肉之力也，即指肌肉。因而治疗面瘫取面部经筋时针刺应以平刺透穴为主，然而经筋须受气血的濡养以及经络的调节，因此通过针刺患部的周边穴和远端穴可以达到“依脉引筋气”的目的，从而使受损的面部经筋得到较好的恢复。

《灵枢·经脉》篇载，足太阳主“筋”所生病。《素问·生气通天论》说：“阳气者，精则养神，柔则养筋”；《素问·热论》又说，足太阳能“为诸阳主气”，足以说明足太阳经在治疗经筋病变上的重要作用。采取患部经筋针刺及闪罐，同时又在“依脉引筋气”及足太阳经主“筋”所生病的理论指导下，加取周边穴及远端穴的针刺与拔罐而共同起到了标本兼顾的作用，从而取得较理想疗效。

十四、分期辨证 加减配穴

孙申田在临床治疗上基本将面瘫分为Ⅲ期，每期的治疗方法也各有不同。

（1）初期 亦称为急性期，发病在1~15天。初期的治疗以辨证为主，应用八纲辨证分为风寒外袭型和风热外袭型。

取穴：翳风、阳白透丝竹空或阳白透攒竹、四白透地仓、地仓透颊车或透大迎、下关。风寒型加风池、合谷；风热型加大椎、

外关。

操作：翳风以2.0~2.5寸毫针深刺，深度达2寸左右，然后快速捻转提插（提插幅度不宜过大）1~2min，使患者针下有强烈的酸麻胀的感觉，再配合以弧度刮针和青龙摆尾法，同时让病人反复做面部表情活动，以观察即刻效应。如果有改善则恢复迅速，不留后遗症。其他局部穴位针刺，进针多以透刺为主，下关与翳风、地仓与颊车通电，风寒型可同时配合艾灸，以加强温经散寒的作用。

（2）中期 亦称恢复期，发病15天~3个月。

取穴：四白、阳白透丝竹空或阳白透攒竹、地仓透颊车或透大迎、下关。

操作：采用四白穴滞针提拉法，取2.5寸毫针于四白穴向下透刺地仓，进针2寸左右，然后单向逆时针捻转，使针体与肌纤维缠绕，捏紧针柄向上外提拉，使面肌随着针的提拉被动向上牵引，然后松手使面肌恢复原状，如此反复提拉30余次，最后在向上外提拉的状态下用另一根针穿过该针尾部的小孔，并且将另一根针刺入瞳子髎并透刺太阳穴以固定提拉针，这时瘫痪的面肌由于牵拉而被基本矫正。其余穴位采用透刺，同初期。

（3）末期 亦称后遗症期，病程在3个月以上。

取穴：百会、健侧头针顶颞前斜线下2/5、翳风、阳白透丝竹空或阳白透攒竹、四白透地仓、地仓透颊车或透大迎、下关。

操作：百会配合健侧头针顶颞前斜线下2/5，并且通电，其他局部选穴方法同中期。末期的治疗多结合初期的翳风深刺方法和中期的四白穴滞针提拉法，针刺手法宜轻，如果患侧面部出现痉挛则局部不宜用电针。

初期的治疗以翳风、下关为主穴。翳风相当于下颌支与乳突之间，深刺可达面神经干附近及茎乳突前缘，故能直接改善局部循环，从而迅速减缓面神经水肿，解除神经压迫，达到治疗目的。另外，翳风为手足少阳之会，可疏风通络，配合风池、合谷祛风散寒，配合大椎、外关祛风清热，从而增强疗效。下关为足阳明、足少阳经交会穴以疏通经络，其深处是茎乳突前部、面神经干的分支处，故亦深刺，选为主穴。中期气血阻滞，肌肉纵缓不收，治以调和气血，疏通经络，以滞针提拉法达到起废复用的作用，使瘫痪的肌肉迅速

恢复肌力。末期邪气久留，经络失养，正气不足，治以提补正气，舒筋活络为主，故主取百会。配合健侧头针顶颞前斜线下2/5，是考虑其对应的颅脑部位是中央前回，主管对侧头面运动，又上运动神经原对下运动神经原具有抑制作用，通过针刺作用到脑干面神经核，从而对损害的面神经起着调整作用，达到治疗面瘫的目的。

沙某某，男，30岁，教师。1999年11月3日就诊，患左侧面瘫2天。刻诊：左侧额纹完全消失，不能蹙额、皱眉，眼睑闭合不全，流泪，鼻唇沟平坦，口角向右侧喎斜，说话漏风，不能做漏齿、鼓腮、吹口哨等动作，耳内、耳后完骨处疼痛，无疱疹出现。舌红苔白，脉浮数，证属风热外感型。治疗首先揉按翳风穴3min左右，之后让其做闭眼、抬眉、示齿等动作，然后用2.5寸毫针深刺翳风穴2.0寸左右，行捻转提插手法1min后，在配合以弧度刮针和青龙摆尾法的同时让病人反复做面部表情活动，结果额纹出现皱褶，嘴角稍动。其他局部穴选：阳白透攒竹、四白透地仓、地仓透颊车、下关深刺，配合大椎、外关以祛风清热、疏通经络。第2天复诊时，患者闭眼、嘴角收缩均好转，结果该患共针灸9次而告痊愈。

十五、辨证治面瘫 以补为主

面瘫多由脉络空虚，风寒之邪乘虚客于面部经络，使经气阻滞，经筋失养，肌肉纵缓不收而致，管遵惠临床辨证为：风中脉络。

(1) 分期特点 管遵惠认为，掌握面瘫发病及转归的规律，针对不同病程阶段，采取相应的治疗措施，对提高临床疗效至关重要。

①发病期：开始发病至10天内，病情尚未稳定，临床症状可能会逐渐加重。

②稳定期：病情相对稳定，时间大约在发病10~15天左右。

③恢复期：约在发病后15~25天左右。

④后遗症期：患者1个月后尚未恢复，即有可能转为后遗症期。

(2) 辨证取穴 采用针刺、艾灸，配合穴位注射综合治疗。

①针刺取穴：主穴：合谷、地仓、颊车、太阳、丝竹空、四白。配穴：不能皱额蹙眉取阳白透鱼腰、攒竹透丝竹空；人中沟喎斜取人中透迎香；颊唇沟喎斜取承浆透地仓；乳突部疼痛取翳风、风池透完骨；眼睑不能闭合取上睛明（位于目内眦上方约0.3寸，左右

各1穴)、下睛明(位于目内眦下方约0.3寸,左右各1穴);不能鼓腮吹哨取下关透颧髻、地仓透颧髻、颊内(位于口腔黏膜上,相当第一白齿平齐处,左右各1穴)、地关(位于地仓、下关连线下1/3,向下关透刺,左右各1穴)。

②艾条灸:风池、地仓、颊车灸15min。共奏祛风散寒,通络牵正之功。

③穴位注射:维生素B₁₂500μg加当归注射液2ml混合后注射;风池、完骨、风门、牵正,每次1~2穴,每穴0.5~1ml。

(3)手法特点 在面瘫发病期宜双侧取穴,用双手进针法,患侧取穴宜少,以浅刺为主,手法宜轻补,留针15~20min,患侧面颊经穴可酌情配合艾条雀啄灸10min,不宜重灸;稳定期宜双侧取穴,采用双手进针法,患侧补法,健侧平补平泻法,患侧艾条雀啄灸15min;恢复期宜双侧取穴,用双手进针法,可根据病变部位适当增加配穴,患侧补法,健侧平补平泻法,患侧施灸20min;后遗症期采用双侧取穴,双手进针法,双侧平补平泻法,患侧勿施灸。对于额纹较浅,难于恢复者,采用阳白齐刺法;口角喎斜甚者采用经验穴地关,用1.5寸毫针向下关方向刺约1寸左右;或用经验穴颊内点刺不留针;对于眼睑闭合不全者,采用经验穴上、下睛明,留针,不提插捻转。

陈某,男,49岁,2000年8月3日初诊。右侧口眼喎斜4天。患者于4天前晨起漱口时口角漏水,出现口角喎向左侧,经服中西药物无效,病情继续加重。现症见:口角喎向左侧,右眼闭合不全,露睛流泪,右侧鼻唇沟变平,右侧面部已不能做蹙额、皱眉、鼓颊等动作,进餐时食物滞留于右侧齿颊之间,舌淡苔薄,脉浮。辨证:风中脉络。诊断:右Bell's面瘫。治疗经过:取双侧合谷、地仓、颊车、太阳、右丝竹空、四白、人中透迎香、承浆透地仓,右侧以浅刺为主,手法宜轻补,留针15~20min,右侧面部配合艾条雀啄灸15min,经治6次后基本痊愈,又巩固治疗2次后痊愈。

十六、腹针为主 通调气血

周围性面瘫是临床上较常见的疾病,但在针刺时机选择上尚有一定争议,为了探索最佳治疗方案,周贤华采用腹针疗法为主治疗

本病，取得较满意的疗效。

腹针：取穴：中脘（梅花刺）、下脘、气海、关元、滑肉门、外陵。操作：患者平卧，暴露腹部，皮肤常规消毒，选用直径为1寸毫针刺，按以上穴位所列顺序依次直刺，采用三部法：①候气：进针后只捻转不提插或少提插，停留3~5min；②行气：候气后再捻转使局部产生针感；③再隔5min行针1次，使针感向四周或远处扩散，留针30min后起针。

体针：取穴：攒竹、阳白、太阳、四白、地仓、颊车、迎香、翳风、合谷、太冲，按常规手法针刺，均用平补平泻法，留针30min。

急性期采用腹针为主治疗，7天以后加体针治疗，每天1次，5天为1个疗程，疗程间休息2天。

腹针疗法是一套以神阙为核心的微针系统，始于胚胎期，是人体最早的调控系统和经络母系统，具有向全身输布气血的功能和对机体宏观调控的作用。方中中脘、下脘均属胃脘，合用有理中焦，调升降的功能，气海为气之海，关元培肾固本，四穴合用有“以后天养先天”之意，故名为引气归元，滑肉门、外陵左右四穴为腹四关，具有通调气血，疏理经气的作用，是引脏腑之气向全身布散的妙穴，中脘在腹针中对应人体的口部，梅花刺意在引经气直达患部。因此，腹针疗法具有多层次的调节作用，与中医的“整体观念”和“扶正祛邪”的原则十分吻合，同时又避免面瘫急性期因针刺面部穴位，增加局部组织水肿，而使面神经受到进一步损害的可能。

王某某，女，46岁，干部，2006年4月10日初诊。主诉：右口眼喎斜2天。现病史：2天前开窗睡觉，不慎受凉，次日晨起刷牙觉右口角漏水，右眼流泪，同侧额纹消失，眼睑闭合不能，右侧鼻唇沟变浅，鼓腮漏气，口角喎向左侧，右耳后部胀痛，舌质淡，苔薄白，脉浮紧。诊断：周围性面瘫。治疗：就诊后1~6天，采用上方腹针治疗，每天1次，右口眼喎斜明显好转，之后结合体针治疗3次，共治疗10次后痊愈。

参考文献

- [1] 朱荣英, 穆黎春, 张燕. 不同方法分期治疗周围性面瘫疗效观察. 中国针灸, 2005, 25 (6): 393 ~ 394
- [2] 雷鸣, 杨玲. 梅花针配合隔姜灸治疗周围性面瘫 38 例疗效观察. 针灸临床杂志, 2005, 21 (3): 17
- [3] 项琼瑶, 傅莉萍. 平衡阴阳针刺法治疗周围性面瘫后期的临床观察. 上海针灸杂志, 2005, 24 (8): 32 ~ 34
- [4] 罗春燕, 马英. 穴位注射为主治疗面瘫后遗症 50 例. 中国针灸, 2005, 25 (7): 498
- [5] 刘涛, 季守贤. 远取足三里、厉兑结合面部深透刺治疗周围性面瘫临床观察. 中国针灸, 2004, 24 (12): 821 ~ 822
- [6] 贺春山. 针刺合谷穴“气至病所”治疗面瘫 416 例疗效观察. 北京中医, 2004, 23 (3): 169 ~ 170
- [7] 庄子齐. 直接灸治疗面瘫 36 例临床观察. 新中医, 1994, (10) 32 ~ 33
- [8] 张福顺. 左右交替针刺治疗周围性面瘫 168 例疗效观察. 北京针灸骨伤学院学报, 2000, 7 (1): 31 ~ 33
- [9] 耿文, 刘智慧, 吕娜. 半刺法治疗儿童面瘫 60 例. 陕西中医, 2007, 28 (1): 92 ~ 93
- [10] 郭效汾, 邢文堂, 杨硕平. 顿退六部针刺手法治疗陈旧性面瘫 260 例. 针刺研究, 1994, 19 (2): 8 ~ 10
- [11] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 47
- [12] 林兵宾, 徐莺. 针刺 3 步疗法治疗周围性面瘫 86 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (7): 29
- [13] 王霁平. 周围性面神经麻痹从“经筋”论治. 上海针灸杂志, 2004, 23 (1): 15 ~ 16
- [14] 金泽, 金亨镐, 金载润. 孙申田教授针灸治疗面瘫的临床经验. 中医药学报, 2002, 30 (6): 27 ~ 28
- [15] 丁丽玲, 王雪松. 管遵惠老师辨证论治面瘫与面痉经验初探. 云南中医药杂志, 2005, 26 (4): 1 ~ 2
- [16] 周贤华, 徐美爱, 卢俊. 腹针为主治疗周围性面瘫的临床观察. 针灸临床杂志, 2007, 23 (1): 18 ~ 19

【面肌痉挛】

面肌痉挛是以阵发性、不规则的一侧面部肌肉不自主抽搐为特点的疾病，多发生于中老年人，尤以女性多见，开始于眼轮匝肌，以后缓慢地扩散至半侧面肌，呈阵发性不规则的痉挛，入睡后消失。属于中医学的“面风”、“筋惕肉瞤”等范畴。本病以神经炎症、神经血管压迫等神经损伤为主要原因，但确切的机制尚不清楚。诱发本病的因素有膝状神经节受到病理性刺激、精神紧张、疲劳、面部随意运动、用眼过度等。

中医学认为，本病属于面部经筋出现筋急的病变。外邪阻滞经脉，或邪郁化热、壅遏经脉，可使气血运行不畅，筋脉拘急而抽搐，阴虚血少、筋脉失养，导致虚风内动而抽搐。

针灸治疗该病取穴除了注意局部取穴与远道取穴结合外，有以面部穴位为主，采取重泻透刺手法的；有主张针刺时取穴宜少，手法宜轻，留针时间宜长的；有采用多针浅刺的；有的采用齐刺、浮刺、直刺。这些不同的针刺疗法，对治疗本证都有一定的疗效。

一、主穴三个 吊针配刺络拔罐

面肌痉挛病情比较顽固，周冰采用吊针配合刺络拔罐法治疗，疗效满意。

取穴：主穴：翳风、风池、足临泣。风寒外袭型加列缺、大椎；气血瘀阻型加合谷、血海；气血不足型加足三里、气海；肝阳上亢型加太冲、三阴交。配穴：眼眶部取丝竹空、瞳子髎、四白；口鼻部取迎香、禾髎、地仓；面颊部取颧髎、下关。上述主穴取双侧，配穴均取单侧。

操作：常规消毒后，用30号2.0寸毫针，迅速刺入皮下，让针身、针柄垂吊，造成牵拉之势，手法轻巧。对于顽固性面肌痉挛，于禾髎、下关、四白、太阳、阳白穴处分别行刺络拔罐，每次放血2~3ml。针后用指腹轻揉患处，用拿法分拿两侧头部，并嘱其回家双手心对接至发热后干浴面，不计其数，以面部发热、舒适为度。每日针1次，10天为1个疗程。

面肌痉挛多发生于口角、下眼睑、面颊部，均为手足少阳、阳明经所过之处，局部气血瘀阻、气血不足或寒邪外袭均可导致经脉失养而致本病。临床采用驱风散寒、活血通络、益气养血、平肝潜阳治法。周冰在治疗时有如下体会：①病室要保持安静，医者应全神贯注，施捻转手法，引导经气至病所，患者宜平心静气，闭目养神，有助于降低神经兴奋性。②采用吊针，手法要轻巧，造成牵拉之势，令收缩的面肌得以舒张，有利于抑制抽搐的发生。③采用刺络拔罐、推拿、干浴面等措施，可起到活血化瘀、祛瘀生新之功效，促进患部血液循环，通调少阳、阳明之经气。④根据辨证取穴原理，上下配合，更能协调脏腑，调和气血，扶助正气。诸法有机配合，治疗本病效果较好。

宫某，男，65岁，干部，1993年9月18日初诊。患左侧面肌痉挛6年。左侧口角、眼睑呈间断性、不规则性、不自主抽掣，每次抽动时间在几分钟至数小时，情绪波动或受外界因素刺激时加重，曾多方治疗效果不明显。近日，症状加重，引起左眼球受牵拉而疼痛，遂来本科治疗。脑电图检查未见异常，舌质红、苔薄黄，脉弦。诊为面肌痉挛，证属肝阳上亢型。取双侧翳风、风池、足临泣、太冲、三阴交，施捻转补泻手法；患部取丝竹空、四白、迎香、地仓、颧髎，采用吊针治疗。出针后用指腹轻揉患处，推拿两侧头部少阳、阳明经。于禾髎、下关、太阳、阳白处行刺络拔罐，出血2~3ml，每日1穴，隔3日1行。嘱患者回家干浴面，每日2次，以增强疗

效。经上述治疗5次后，抽搐次数减少，幅度减轻，2个疗程后，症状全部消失。随访1年，未再发作。

二、依经筋论治 多针浅刺

面肌痉挛是一种不明原因引起的一侧面神经运动功能紊乱，临床上以一侧面部肌肉阵发性不自主抽搐为特点。一般神经系统检查无阳性体征，抽搐时面部无痛感，病情进展缓慢，病程多迁延日久以致长期不愈或反复发作，是一种难治之症。唐燕萍采用多针浅刺与行气法结合，以经筋辨证治疗本病，疗效较佳。

取穴：颧髎、瞳子髎、率谷、丝竹空、攒竹、合谷、外关为主，其中合谷与外关交替使用，伴有全身症状的配以辅穴，如流泪、视物不清者加承泣、四白；食欲不振、月经量少者加足三里、三阴交、中脘；烦躁易怒、失眠者加太冲、申脉、百会；体虚畏寒、久病不愈者加背俞穴。

操作：患者仰卧或坐位，在患侧面面部穴位采用多针浅刺针法，即在同一穴上，同时刺入三根直径0.35mm毫针，针刺1~2分深，使针尖处皮肤呈突起小丘，不做手法，留针10min；在患处远端穴位，采用行气法治疗，即运用手法激发，使经气由刺激点开始，沿经到达病所。对病程长、寒痹重者，在患侧面面部加用艾条悬灸10min，并用梅花针叩刺背部心俞至肾俞区域，以局部皮肤潮红为度。每日1次，10天为1个疗程。

唐燕萍认为面肌痉挛多因气血亏虚，血不养筋而致，以肌肉痉挛、抽搐为特征，故属经筋病变的“筋急”，应以经筋论治，治疗重在调理经筋的阴阳缓急。因足三阳经筋皆上行于眦（即面部鼻旁颧骨部位）和眼周围，面部是足三阳经筋结聚之处，《素问·调经论》曰：“病在筋，调之筋”，故结合经筋病变部位，辨明与该病经筋相连属的相应经脉，是取穴的关键。即“以痛为腧”，采用近端腧穴颧髎、攒竹、瞳子髎、颊车、地仓、率谷、丝竹空为主，不仅有局部的治疗作用，调节足三阳经筋，且对经筋网络循行的邻近部位也有调节作用，以疏通患处周围局部经气；因本病病程多迁延日久，而“筋急”者属寒，故以虚寒证为多，针法宜选用温补法。此病虽属难治之症，但邪在络不在经，针刺局部穴位宜采用多针浅刺法。三针

齐下，浅刺入，故可散在络之邪。结合用行气法针刺远端穴位中脘、足三里、三阴交调理脾胃功能，健脾补虚；筋会阳陵泉，配合百会调神解痉；又跷脉司眼睑开合，阳跷主动，申脉通阳跷，刺之可止眼睑颤动，合谷与外关交替针刺，以上诸穴合用，使气至病所，气至而有效。对病程久者应多激发几次，以增强针感。温灸可温经散寒，祛邪扶正，膈俞为血之会，配肝俞养血活血，血行风自灭；故叩刺心俞至肾俞区域。以上诸穴合用，诸法同施，才能调理脾胃，滋肾养肝，培补气血生化之源，使气血旺盛，解痉熄风，达到调整整体阴阳平衡，促进疾病恢复的目的。所以用多针浅刺法和行气法结合治疗此病，疗效较好。

三、挂针为主 配辨证取穴

面肌痉挛，中医学属于面风、面𦵏范畴。多为半侧面部肌肉阵发性的不自主抽搐。何晓宏采取以挂针刺为主，配以辨证取穴，取得了明显的治疗效果。

取穴：主穴：局部阿是穴（以面肌痉挛处为主）。配穴：风池、太冲、太溪、太阳、阳陵泉、合谷。

操作：面部严格消毒后，用30号1寸长针15~30根，浅刺阿是穴，采取密集排针或散刺，其间隔为0.5~1.0cm宽，针尖约刺入皮下2分，随即将手松开，使针柄自然下垂，针体悬吊而不下落，针尖所在处皮肤微突起，形成一个小丘。在远端交替配以风池、太阳、太冲、太溪等穴位，施以平补平泻手法，留针40min，每日1次，10次为1个疗程。本法针刺时，面部有微微发热感，或皮肤充血发生，属正常现象。

面肌痉挛，属中医学𦵏动证。多因气血虚弱，三阳脉失养，阴虚阳亢，血虚生风所致。挂针刺法是取十二刺中浅刺法中的毛刺、浮刺、扬刺三法之长，以散寒舒筋，调和气血，使经脉气血畅达，经脉得养，而痉挛自止。再加入风池、太阳、太冲、太溪以补肾潜阳，激发六阳经脉经气，通经活络，故而法合病机，治得其要。从现代医学的角度出发，阵发性面肌痉挛系面神经的异位兴奋或伪突触传导引起的面部肌肉的抽动，挂针刺法将多枚针快速浅刺后将针柄悬吊，针尖将穴位处皮肤挑起，手法轻巧，使疼痛刺激温和而持

久，有效抑制面神经的异位兴奋，加速患者康复。

张某，男，47岁。2001年9月1日初诊。主诉左侧面肌痉挛、反复发作2个月，加重1周。初始为左侧眼轮匝肌阵发性痉挛，经休息后可缓解。1周前，因生气后诱发，痉挛延及到面部肌肉。就诊时左侧面部肌肉强烈痉挛，讲话时以手按压面部肌肉方能进行，表情痛苦，情绪烦躁，随依上方治疗，针3次后，症状明显减轻，2个疗程后症状消失，随访半年未复发。

四、齐刺—浮刺—直刺 三法结合

刘佩云采用齐刺、浮刺、直针刺三法结合治疗面肌痉挛，取得满意疗效。

取穴：患侧鱼腰、攒竹、瞳子髎、承泣、四白、迎香、地仓、颊车、合谷。

操作：常规消毒后，取30号毫针1~1.5寸等长的三根针，先使针尖在术者押手的指腹上对齐，三根毫针并在一起同时迅速垂直刺入同一个穴位，针刺1分深，因其刺入皮肤内甚浅，针常呈下垂状。进针后不提插、不捻转，每次留针40min，每日1次，6次为1个疗程，疗程后休息1天。

取《灵枢·官针》十二刺中的齐刺、浮刺、直针刺三法之长，独创而成。“齐刺者，直入一，傍入二，以治寒气小深者。”齐刺，为三针齐用。直针刺：“直针刺者，引皮乃刺之，以治寒气之浅者也。”直针刺，是夹持起皮肤将针刺入皮下。浮刺：“浮刺者，傍入而浮之，以治肌急而寒者也。”浮刺，是斜向浅刺。本病因风寒稽留，经筋收引，时久则津液枯少。阴虚而筋脉失养，血不养筋，则时发抽动。本法以局部穴位为主，以散寒舒筋，调和气血，又根据足太阳经筋为目上纲，足阳明经筋为目下纲，面部是足三阳经筋结聚之处，故取足三阳经穴为主，经脉气血畅达，经筋得养，故痉挛自止。

吴某，女，43岁，1987年8月6日初诊。患者左侧眼睑及面部痉挛性跳动半年余，进行性加剧，面部不定时抽动，约5~10min抽动1次。经多家医院诊治，均诊为面肌痉挛。曾用中西药物治疗无效，故来就诊。取穴：攒竹、鱼腰、承泣、四白、瞳子髎。以上穴

位均采用多针浅刺。留针 40min，每日 1 次。每次治毕，效果明显，治疗 4 个疗程，面肌痉挛停止发作。随访至今未复发。

五、辨证取穴 头体针并用

李金桂采用体针疗法及头针疗法治疗面肌痉挛，收到较满意的效果。

取穴：①邪壅脉络：体针主穴：患侧：四白、翳风，对侧：合谷。随证取穴：头痛加风池；面肿加三阴交；痰湿加丰隆；热盛加曲池。头皮针：对侧：下 2/5 运动区，下 2/5 感觉区。②气血亏虚：体针主穴：患侧：四白、地仓、颊车、翳风。双侧：足三里、三阴交。随症取穴：头昏性急易怒加太冲；治疗后仅眼睑抽搐减地仓、颊车、加养老。头皮针：同邪壅脉络。

操作：卧位（以减少晕针），用 1~3 寸 28~30 号毫针。穴位用 75% 酒精棉球消毒后方可进针。体针刺常规深度，多用平补平泻、迎随补泻手法；头皮针需刺入帽状腱膜以下，同时用 G6805 治疗仪，波型：继续波，电流：以患者自我感觉舒服为度。留针均 20~30min，每日 1 次。10 天为 1 个疗程，取效后隔日 1 次，疗程间隔 2~3 天。头、面部易出血，起针时用消毒干棉球按压针孔；忌食辛辣、烟、酒刺激之品；局部保暖；心情要静，注意休息。

俞某，女，44 岁，芜湖二纺厂工人，97 年 4 月 20 日初诊，患者左侧面部抽搐壹年，曾服中药治疗，效不显。其面色少华，左侧目眶下及口角抽动不已，左侧面部有牵拉感，左眼裂变小，鼻唇沟加深，作露齿运动时，左侧面部肌肉不收缩，舌体胖，苔白腻，脉细。此属病久气血亏虚，且运行不利，筋脉失其濡养所致，治以益气血，止痉挛，体针：取左侧：四白、地仓、颊车、翳风、足三里，头针取右侧：下 2/5 运动区、下 2/5 感觉区，针刺 1 次后，自觉面部抽搐减；针刺 3 次后，平静状况下，目眶下、口角抽搐基本消失，唯面部牵拉感。2 个疗程后，症状消失，唯天凉时或劳累后，局部偶有抽动，每天约 2~3 次，每次均在 5s 之内，振幅较小。第三疗程改每周针刺 2 次以巩固疗效，经过 4 个疗程治疗，面部外观恢复正常，诸症悉除。经随访，至今未发作。

六、辨证取穴 补益气血

张旭东用针刺辨证施治治疗面肌痉挛，疗效肯定。

取穴：以厥阴和阳明经为主，气血亏虚，肝风内动者，取足三里、三阴交、太冲、内关、人中。肝肾阴虚，肝风内动者，取太冲、三阴交、足三里、内关、太溪。心胆气虚者，取内关、足三里、三阴交、太冲、上星、前顶。局部配以四白、地仓，瞳子髎透下关，眼周症状明显者配攒竹、丝竹空、印堂，口角症状明显者配人中、承浆、夹承浆、迎香。

操作：主穴每次均取，配穴随症加减，主穴中的太冲、足三里、三阴交、内关均选用 28 号毫针，行捻转补法或平补平泻法，以刺激量稍大为宜，使针感向穴位上下传达。人中、上星、前顶刺入后稍加捻转，使有得气感。配穴多位于颜面部，以 30 号 0.5 寸毫针平刺，针刺后留针 20min，嘱患者静心守神，勿活动。每日针 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3~5 天，病情临床控制后，再巩固 1 个疗程。

面肌痉挛中医属“内风”范畴，与心、肝、肾关系密切。患者多为中老年女性，故本质上属于虚证。是一种本虚标实，上盛下虚之证。张旭东据患者具体脉证将其分为“气血亏虚，肝肾阴虚，心胆气虚”三型。虽为三型，但均以气血不足为本，故选取气血旺盛之脑穴，施以补法，补一身之气血。“治风先治血，血行风自灭”气血充盛，经筋得以荣养，故内风不生。

李某，女，61 岁。主诉左侧面部不自主抽动一月余，以口周为甚。面部自主运动或精神紧张时易发作，舌质淡红，苔少，脉细弦，诊为肝肾阴虚型。针刺太冲、足三里、三阴交、内关、太溪，局部刺四白、地仓等穴，三个疗程症状控制。一年半后复发，且伴有左侧面部麻木，仍按上法治疗 3 个疗程而控制。

七、针刺配穴注 辨证施治

面肌痉挛，是一种以阵发性面肌抽搐或痉挛为主要表现的顽固性疾病，王家田采用针刺结合穴位注射维生素 B₁₂，治疗面肌痉挛效果比较满意。

取穴：睛明、四白、太阳、迎香、地仓、颊车。风寒稽留加风池、完骨；气血两亏加关元、足三里；肝肾阴虚加太溪、太冲；脾虚湿重加地机、章门；肾阳不振加命门、肾俞；痰火内盛加丰隆、外关。

操作：针刺局部穴位时，得气后行强刺激手法。针刺远端穴位时，可根据具体的症状选择补泻手法。手法完毕后在面部穴位上加用 G6805 电针仪，用密波，留针 30min，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 5 天。穴位注射用 5ml 注射器及 5 号针头，吸入维生素 B₁₂ 1000μg/2ml，每次选面部腧穴 2~3 个，分别注射，交替使用。操作时，刺入一定深度获针感后，稍抽吸针栓，无回血，再缓慢注入药液。隔日注射 1 次，5 次为 1 个疗程，与针灸同步进行。

经脉所过，主治所及，面部属阳明、少阳经脉，在取穴时多取阳明、少阳经的腧穴，或循经取穴，重用特定穴。针刺面部的穴位时，行强刺激手法，使整个面部有较强的温热针感，有利于镇痉止挛。针刺远端的穴位时，可根据具体情况，确立补泻针刺手法，一般采用烧山火及行气手法，激发经气，使经气循经感传，达到“气至病所”的良好效果。

加电针时必须用密波，密波能降低神经应激功能，先对感觉神经起抑制作用，接着对运动神经也产生抑制作用，能缓解肌肉的痉挛。

穴位注射维生素 B₁₂，能改善神经肌肉的营养，防止肌肉变性，促进肌痉挛的恢复。

赵某，女，54 岁。5 年前，睡眠醒来时，发现额纹消失，眼不能闭合、迎风流泪、面部板滞、口角喎斜。当地卫生院诊断为周围性面瘫，经针灸治疗后，面瘫好转但留下右脸抽动频繁，病侧面部怕冷、怕风、阴天及情绪激动时，抽动明显加重。查其舌苔白，舌质红，脉浮弦。辨证为风寒稽留、经筋收引。治则温散风寒、舒筋、解痉。取上述穴位，用上述方法治疗 2 个疗程，痉挛减轻一半，第三疗程后，偶而跳动一下，痉挛基本控制，又治疗 1 个疗程痊愈，停止治疗观察，随访 5 年，未复发。

八、四关为主 辨证分型取穴

严善余采用针刺四关穴为主，辨证分型治疗，收到较好的效果。

操作：

(1) 风寒阻络型 取风池、风门、合谷、列缺、太冲，浅刺泻法。

(2) 气血两亏型 取脾俞、膈俞、气海、足三里、三阴交、合谷、神门、太冲，用补法。

(3) 肝肾阴虚型 针刺肾俞、肝俞、合谷、神门、太溪、太冲，用补法。

(4) 阴虚阳亢型 针补肾俞、肝俞、太溪、合谷，泻风池、神门、太冲。

(5) 脾虚生风型：针补中脘、足三里、章门、合谷、阴陵泉，泻神门、三阴交、太冲。

(6) 痰热中阻型：针泻内关、合谷、神门、阴陵泉、丰隆、太冲。

(7) 心脾不足型：针补心俞、脾俞、神门、合谷、足三里、三阴交，泻太冲。

留针 30min，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。休息 5 天，再作第二疗程。

《针灸大成》曰：“四关、四穴。即两合谷、两太冲穴是也”。合谷是手阳明大肠经脉所过为原的原穴，脉经面颊、齿口，主治面颊、齿口部诸疾，《玉龙歌》：“头面纵有诸般证，一针合谷效通神”。泻之可疏风清热，补之可补气振羸。“太冲是足厥阴经所注的输穴，阴经以输代原，为足厥阴经原穴。《素问·咳论》：“治脏者，治其俞”，肝脉上升“目系，下颊里，环唇内”。太冲泻之可疏肝理气，平肝息风，补之可养肝血。四关穴作为一种固定的配穴，它具有镇静解痉作用。以四关穴为主，结合辨证分型取穴，或补或泻，对症治疗而获效。

患者，女，36 岁，塞内加尔人。1992 年 5 月 9 日初诊。主诉：右侧面部抽搐，眼眶下缘疼痛 5 年。病史：1988 年初自觉右侧上眼睑不自主轻微跳动，后向下面部扩展，口角牵引抽动，逐渐加重，

右侧面部肌肉抽动，频繁不断，抽时口角向右牵拉，右眼紧闭，致右眼缩小，眼眶下缘疼痛。每次抽动约 5~15min，每日 20~30 次。右侧面肌稍见萎缩，表情呆滞，神疲肢倦，气短自汗，头晕嗜睡，舌淡红、苔薄白，边有齿痕，脉弦细。辨证：气血虚亏。治法：补益气血。处方：针补脾俞、膈俞、气海、足三里、三阴交、合谷、神门；针厉兑、泻太冲。合谷穴针感务使上达病所。效果：针 5 次后，面肌抽动、眼眶疼痛日渐减轻，经过 2 个疗程的治疗而愈。一年后随访，未复发。

九、透刺为主 一针两穴

面肌痉挛又称面肌抽搐，是一种以阵发性面肌抽搐为主的顽固性疾病。回克义用针刺治疗此病，疗效满意。

取穴：阳白透丝竹空，颧髻透迎香，下关透颊车，四白透承泣、合谷，均取病侧穴。

操作：患者坐位或仰卧位，病侧面部穴位常规消毒后，先选用 28 号 2 寸毫针，从阳白穴进针后，沿皮下透刺至丝竹空穴；用 28 号 2 寸毫针，从颧髻穴进针后，沿皮下向迎香穴透刺；用 28 号 1 寸毫针，从下关穴进针后，沿皮下向颊车穴透刺；用 28 号 1.5 寸毫针，从四白穴进针后，沿皮下向上透刺至承泣穴。上述穴位均采用平补平泻手法。另用 28 号 2 寸毫针，针刺合谷穴，针尖向上斜刺，用提插捻转手法，使针感向上传导至面部。上述穴位均留针 40~60min，在留针期间，每隔 20min 行针 1 次。每日针刺 1 次，7 次为 1 个疗程。疗程间休息 3~4 天，再进行第一疗程治疗。

回克义依据中医“经脉所过，主治所及”的治疗原则，取颧髻、迎香、下关、颊车、承泣，可调节局部经气；手足少阳经上面而至目锐眦，故取阳白、丝竹空以疏风止痉；四白、合谷均属阳明经穴，为治疗面部、口、眼、鼻部诸疾的要穴，具有通经活络、祛风散邪、抑制抽搐的作用。经临床观察体验，在针刺治疗中取穴宜少、留针时间宜长，方能收到满意的效果。

面肌痉挛与精神因素有密切关系，情绪波动、精神紧张都会使病情加重，影响疗效。因此，在针刺治疗过程中，医者务必要做好患者的思想工作，使患者情绪放松，并注意调摄情志，以减少诱发

面肌痉挛的因素。

王某某，女，41岁，于1989年10月5日就诊。患者右侧面肌频发性抽搐2年余，情绪波动或劳累时抽搐明显加剧，每次抽搐时间约5~10min，每日抽搐约15~25次。曾在某医院诊断为面肌痉挛，用中西药物及面部穴位注射等治疗，均未取得明显疗效。诊见右侧面肌抽搐频繁，右眼睑痉挛，眼裂变小。伴右侧头痛，心烦失眠，小便如常，大便干结，舌质红，苔薄白，脉弦细。予针刺治疗如上法，1个疗程后，抽搐次数减少，发作时间减为1~2min。继予第二疗程治疗后，面肌抽搐及其他症状完全消失。随访1年未复发。

十、循经远取 长留针

梅国胜遵循经络学说，并参考现代神经解剖学，采用远端取穴为主，局部不针或少针的方法治疗面肌痉挛，获得了比较满意的效果。

原则：针刺之穴要选精而少，既刺之针留针时间要长，治疗过程中宜以见效为准，不必拘泥于短疗程。痉挛部位一般不用针，或对重顽之症取穴点刺，切忌留针。

取穴：主穴为百会、合谷（交替取一侧）、血海。辅穴为风池、翳风、足三里、阴陵泉、三阴交、太冲、内庭，根据辨证或轮流取1~3穴。对病程长或症状顽固者，每疗程末加印堂、水沟、承浆、地仓、颊车。

操作：头部皮肉浅处取1寸针，以左手于穴处捏起，右手持针于穴凸处顺经脉走向快速刺入，不求针感。翳风直刺；合谷穴针感较强，体强者取适度长针，自合谷透刺后溪，体弱者浅刺，加刺后溪，此穴进针有针感即留针，无须捻转；地仓透颊车（面肌痉挛起、止点）时，以2~3寸针沿皮下自地仓向颊车透刺，强捻转牵拉出针，不留针。其余诸穴以适度长针直刺或斜刺。除地仓透颊车外，诸穴均留针不少于60min，其间视情况轻捻转3~5次，或嘱病人自己轻动手指、足趾以助之。隔日治疗1次，每周治疗3次，5次为1个疗程。

中医学认为风邪属阳，其性主动。风邪有内外之分，而内风作祟莫不责之于阴虚血少，阴不制阳。临此证时以风为纲，详辨阴阳

经脉气血的孰多孰少；明穴性，谙功能，取与气分血分生理病理密切相关之穴配伍熄风止痉之穴。百会穴又称三阳五会，由于它的特殊部位和交会经脉的生理病理作用，临床上对阳亢气陷有双向调节作用，其针感差异可直接影响疗效，故为主穴之一。合谷为原穴之一，具疏风止痉之功，有“面口合谷收”之验，临证可补可泻，是又一主穴。血海属多血之脾经，与血分生理病理关系密切，在治疗风邪作祟的疾病中，取血海以调理血分生理，进而制止躁动之内风，确有独到疗效，用之以求“治风先治血，血行风自灭”之效。地仓透颊车的行针手法，取引气归位制止痉挛之意。操作中，若进针后病人即有触电或麻感，应稍向上提针，防伤及神经，引发它病。治疗中，不宜在面部取穴进针，切忌强求针感，因确有加重面神经兴奋性、加重症状之虞。地仓透颊车，仅是针对重顽之症偶一为之，不可作为常法。

罗某，女，63岁，农场退休职工。于1988年8月4日来针灸科就诊。刻述：7年来，除入睡外，左面部抽动频繁，少有停顿，尤以情绪激动或睡眠不足时甚之。左面部麻木、沉紧，左侧头部及额部酸胀痛且清晨麻木明显，眠少易醒，食欲不佳。查：左面部牵拉、抽动频繁不止，口角移动近2cm，左眼裂明显小于右侧。形体略瘦，肤色略黑。舌瘦少津而红，苔薄黄，脉弦数而浮。血压120/80mmHg，无面瘫史。诊断为原发性面肌痉挛。阴虚血少，内风妄动而上扰是其病机。穴取百会、合谷、血海、足三里、太冲、内庭；酌加印堂、水沟、承浆、地仓透颊车。1个疗程而症大减，头痛止，仅余地仓处间歇性抽动但已轻微，间隔时间延长。休息1周后续治7次而愈，随访1年无反复。

十一、取阳明为主 浅刺久留针

面肌痉挛是针灸科常见病，亦是多发病。张福会在临床上采用针灸与中药结合治疗该病，取得了较好的疗效。

取穴：主穴：腕踝针上1，2区，风池、风府、三阴交、足三里，阿是穴。配穴：病变区在阳明经者配对侧内庭，合谷；肝肾阴虚者或肝气郁结者配中渚、太冲、太溪。

操作：面部穴及中渚、内庭和合谷，针入3~5分，得酸胀样针

感后留针 40min，留针期间不行针；风府、风池用平补平泻法，太冲用泻法，三阴交、太溪用补法。每 10min 行针 1 次，留针 40min。两日针刺 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间休息 3 天。部分病人痉挛顽固者，用细火针局部点刺，每次 3~5 点，每周 2 次。

中药：以养血息风止痉为治疗大法，以四物汤加味。药用当归、白芍、川芍、熟地、僵蚕、葛根、钩藤、全虫（研末冲服）。随症加减：失眠者加柏子仁、枣仁、朱砂、远志；病灶区有紧张感者加白芷、细辛；肝气郁结者加柴胡、郁金；肝肾阴虚者加山萸肉、知母。每日 1 剂水煎服，日服 2 次，每次 150ml，10 剂后休息 4 天。

张福会治疗依（灵枢·九针十二原）“刺热者，如以手探汤，刺寒者如人不欲行”。在针刺病灶区局部穴和其他部分穴位得气后采用久留针的方式。以应“刺寒者如人不欲行”，亦有“以静制动”之意。（难经·七十六难）亦有“当补之时从卫取气”。取面部穴和循行于面部的多气多血的阳明经穴内庭、合谷，用浅刺久留针法从卫取气，留针期间不行针，以补其经气不足，多数患者针刺后，面部局部和阳明经穴周围皮肤充血，温度升高，故此法可散其寒邪，通其经脉，温养筋肉。正如《灵枢·终始》云“一方虚，浅刺之，以养其脉，疾按其痛，无使邪气得入”。寒邪重而经脉闭塞者宜用细火针点刺局部、温经散寒，散结通络。以上针法结合其他三阴交、足三里、风池、风府的益气养血，熄风止痉功能，可使经脉气血充足，润养肌肉，使痉挛肌肉痉挛自止。该病一般与情绪变化和劳累程度有明显关系，辨证中多有血虚气郁表现，所以在应用中药治疗时，主要以养血理气，熄风止痉为主。遵“治风先治血，血行风自灭”之训。

李某某，女，农民，48 岁。2002 年 3 月 27 日初诊。患者右眼外侧及眼眶下、口角右侧时有阵发性肌肉抽搐 1 年余，加重 1 个月。1 年前，因家事不和生气后，出现右眼外侧及眼眶下抽搐，近 1 个月来发作频繁，且口角右侧亦时有抽搐，每当劳累或情绪不佳时加重，伴有头昏、失眠，胸闷。查体：面色萎黄，右眼外侧及眼眶下、口角右侧时有不自主的阵发性的抽搐。舌质淡、苔薄白，左脉细弦，右脉沉细。诊断：面肌痉挛。证属：肝气郁结，血虚生风。治则：养血熄风，佐以理气活血、安神。针灸方法与中药应用如上所述。

治疗2个疗程后症状、体征消失。随访半年未见复发，临床治愈。

十二、耳穴治疗 调十二经气

面肌痉挛为阵发性不规则的半侧面部肌肉不自主抽搐，亦称面肌抽搐。张宝荣采用耳穴注射药物及耳穴针刺对其进行治疗。

取穴：穴位注射取耳穴面颊、神门；耳针取肝、肾、心、脾、交感、口、皮质下、内分泌。

操作：耳穴穴位注射时患者取半侧卧位，患侧耳廓常规消毒后，在耳廓面颊敏感区穴缓慢注入2%普鲁卡因0.02ml，不拔针头再将安定注射器套入针头缓慢注入药液0.01ml。然后再取神门穴注射，操作方法同上。耳针在预先选好的所有耳穴上分别用28号毫针垂直法刺入，每10min捻转1次，使之产生热胀感，每次留针30min。穴位注射隔日1次，耳针每日1次，7次为1个疗程。

该病起因大致与七情所伤，肝阴暗耗，肝肾阴虚以致肝风内动及感受风寒，寒邪稽留，经筋收引所致和劳累过度，耗伤气血，血不荣筋，以致肝风内动。但临床上多不是一种因素所引起，而是多种因素共同作用的结果，尤以气血亏虚为多见。

治疗上张宝荣认为病之初应“审因论治”易收效，对于病程长者则不应拘泥于“求因”，而应根据具体病情施治，辨证取穴。

根据经络学说中“经脉所过，主治所及”的理论，人体十二经脉是与耳直接相互联系的。故取耳穴面颊、神门、心、脾，既能调和营血，驱风活络，宁心安神，解痉活血，又有健脾补气，营养肌肉的作用，通过调整心的功能可使心气旺盛，血脉充盈；皮质下是大脑皮层的代表区，具有补髓健脑，宁心安神，镇痉止痛，调理冲任作用，并且调节大脑皮层的兴奋或抑制；交感穴有舒筋活络，宁心安神及对肌肉有较强的镇痛解痉作用；口、内分泌可助舒肝理气，驱风通络，活血补益下元，清热利湿，祛风解毒，调节内分泌功能紊乱。所以，针刺耳廓经穴循行线上的“对应点”，既能调节十二经的经气，又能达到疏通经络，调和气血，祛除疾病的目的。

十三、健脾疏肝 标本兼顾

面肌痉挛属中医学瘛纵、筋惕肉瞤范围，病机多为脾虚乘肝，

筋失所养，虚风内动所致。何胜彪认为治疗原则为健脾疏肝、舒筋活络。

取穴：风池、四白、瞳子髎、丝竹空、阳白透攒竹、迎香透睛明、地仓透颊车、合谷、中脘、气海、足三里。

操作：针刺面部穴位均用捻转泻法，轻巧刺入，合谷、中脘、气海、足三里用捻转补法，均需严格掌握刺入深度，得气后留针30min。每日1次，10次为1个疗程。

取合谷、中脘、气海、足三里健脾和胃，加强消谷运化之功能以固其本；风池疏泄浮阳，使熄其虚风以治其标；四白、瞳子髎、丝竹空、阳白透攒竹、迎香透睛明、地仓透颊车疏调局部之经气，其中三组穴位用透刺之法，加强疏调局部经气的作用。诸穴合用，从而达到健脾疏肝，舒筋活络的目的。故在临床运用中，取得了较满意的疗效。本病面部取穴较多，因针刺局部穴位能选择性地作用于面部运动神经末梢与肌肉交接部位，阻断神经冲动下传肌肉，使肌肉松弛，痉挛消失。

王某，女，56岁，农民。1996年2月13日门诊。主诉：右侧面部肌肉抽搐9年，近半年来病情加重，面肌抽搐发作频繁，并已由眼部开始逐渐延伸至整个右侧面部，一直未经治疗。查体：右面部肌肉频繁抽搐，右眼裂紧缩，口角抽紧向右侧歪斜，颅神经（-），系统检查无阳性发现。诊断：面肌痉挛。治疗：取穴：风池、四白、瞳子髎、丝竹空、阳白透攒竹、迎香透睛明、地仓透颊车、合谷、中脘、气海、足三里。其面部诸穴均用捻转泻法，轻巧刺入，合谷、中脘、气海、足三里则用捻转补法，所有穴位均严格掌握刺入深度，得气后留针30min。治疗2个疗程后面肌抽搐显著减少，2个疗程后完全消失，随访1年未复发，疗效显著。

十四、病分四型 辨证取穴

原发性面肌痉挛，常见者有以下几证。

（1）气血亏虚，经筋失养证 面部肌肉跳动或抽动，伴有气短乏力，头晕心悸，纳呆，便溏，小便频，失眠多梦，劳累失眠后加重，舌体胖大。舌质淡，苔薄白，脉虚弱。偏于气虚，则见面部拘紧，晨起加重，日重夜轻。偏于血虚，则见面色不华，面、舌、耳、

肢体麻木，夜间重，睡眠仍抽动，晨起减轻，久视加重，治以补益气血，熄风解痉。针中脘、气海、足三里、三阴交，以补气养血。针百会、风府或风池，以熄风。合谷、列缺交替取用（行气法）。面部拘紧，火针点刺四白、颧髻、大迎等穴。劳累后加重者加通里、大钟（补法），治疗后仅眼睑跳动者，合谷易养老（行气法）。

（2）肝肾阴虚，经筋失濡证 面部肌肉跳动或抽动，伴有头晕耳鸣、失眠多梦，性情急躁，视力模糊，郁怒则抽动加重，女子多见经期提前，量少色红，舌红中裂，脉弦细数。治宜补益肝肾，熄风解痉。针太冲、太溪、关元（补法）、百会、风池、合谷（行气法）。郁怒加重者加丘墟、蠡沟。

（3）阴虚阳亢，化火生风证 面部肌肉跳动、抽动，伴有头痛头晕，性急易怒，尿黄，便干，口干，气郁或失眠后加重，舌质红，苔黄干，脉弦数。治以补阴泻火，熄风解痉。针太冲（补）、合谷（行气法）、百会、风池，大便干者加天枢，口苦者加阳陵泉。

（4）外风引动内风证 面部肌肉跳动或抽动，伴有遇热则舒，遇冷加重，变天加重，冬季复发，夏天缓解，面部紧皱、僵硬、或面部穴位出现压痛，有感受外寒史，但无口眼喎斜。舌质淡红或暗红，苔薄白、脉弦或紧。治宜温散风寒，熄风解痉。

上述四证在证候上，外风证常与气血亏虚或肝肾阴虚证并见，在治疗上，除辨证取穴外，辨经取穴亦常收效。本病以阳明经穴为主。如四白、地仓、大迎、颊车、头维压痛或按之抽动缓解者，取厉兑、头维；如扶突、禾髻反应者，取风池、头维。若面肌抽动与耳鸣有密切关系者，或完骨、风池、丘墟压痛者，取头窍阴、听会；若耳门压痛者，取中渚、丝竹空。若膈俞、天宗压痛者，取至阴、睛明或养老、攒竹。另外，凡精神因素或心理因素加重者取哑门。

曾治周某，女，44岁。右面肌痉挛8年。患者于8年前因恼怒而致前额剧烈疼痛，头晕恶心，当时自用毛巾冷敷，服止痛药头痛好转。一个月后出现面肌抽动，始则日抽1~2次，以后病情逐渐发展为终日抽动，毫无间歇，甚则呈长时间紧缩（强直性），不能睁眼，看书、讲话、经期抽动明显，冬天重于夏天。曾先后去五个医院，接受中药、西药、电针和维生素B₁₂穴位注射等治疗。在这些治疗过程中，最短坚持2~3个月，长则8~9个月，但均未能收效。

睡眠、饮食、二便均正常，月经周期26~28天，行经日期5天，经血量多。舌质淡，舌体胖边有齿痕，中有裂纹，舌苔白滑，脉沉细而弦。证属气血亏虚，肝风内动。治以补益气血，熄风解痉。

针阳陵泉、足三里、百会、合谷（行气法），治疗24次后，痉挛明显减轻，夜间醒后已不抽，痉挛次数、力量、范围均减，持续时间缩短。前穴加哑门，经42次的治疗，症状基本消失，出现48h未抽，平素仅口角偶尔抽动一下。前穴续针，哑门与风府交替取用，治疗48次后，体质增强，能往返骑车2h来针灸科就诊。前穴仍用，合谷与列缺交替取用，经58次治疗，痉挛缓解，经期、阴雨天仅感面部发紧，共治疗71次，历时1年。3个月后随访，仅情绪特别激动时，偶有右面发紧的感觉，有时抽动一下即止，已十年未见复发。

十五、四关血海 辨证施治

叶国传遵循经络学说，采用开“四关”加血海穴为主，配合辨证施治取穴的方法，治疗面肌痉挛。

取穴：主穴取合谷、太冲、血海。风寒入络加列缺、内庭、后溪；气血亏虚加足三里、气海、关元；肝肾阴虚加太溪、三阴交、内关；肝气郁结加行间、阳陵泉、三阴交；风痰阻络加丰隆、太白、内关、中脘。

操作：用1~1.5寸毫针针刺。主穴针刺得气后，行针刺手法，使针感向上放射至面部，配穴针刺得气后，用平补平泻手法。留针20~40min，隔日1次，10次为1个疗程。

叶国传在临床上治疗以平肝熄风、祛风通络、补气养血、滋肾柔肝、健脾化痰为主。遵循经络学说，采用开“四关”加血海穴为主，合谷为手阳明大肠经之原穴，具有疏风解表，调理脏腑气血，活血镇痛，《四总穴歌》云：“面口合谷收”，《玉龙歌》云：“头面纵有诸样疾，一针合谷效同神”，太冲为足厥阴肝经原穴，《针灸甲乙经》：“痉，互引善惊，太冲主之”，具有平肝熄风，清理头目，理气通络，有镇痛止痉等作用，合谷配太冲，两个原穴，左右同时选用，一阳一阴，一腑一脏，一上一下，有镇痛止痉等作用，相得益彰，谓之“开四关”。血海穴属于多血之脾经，能够调理血分，进而制止躁动之内风，用之以求“治风先治血，血行风自灭”，气血充

盈，经得以荣养，故内不生风。因此以上各穴相配，则血有所养，经络得通，增加平肝熄风，理气活血，通络止痉等作用。再结合辨证施治的加减配穴，能取得良好的效果。特别施针刺手法时一定要行气，使气至病所，气至面部才有效。

患者，女，48岁，2002年10月18日就诊。左侧面肌抽搐3年余。患者3年前，不明原因突然出现左侧眼睛跳动，逐渐发展到左侧面部肌肉抽动，经中、西药治疗，病情有所缓解。近半年来，因工作繁忙、精神紧张而病情加重，每日左侧面部肌肉抽搐频繁，尤其在劳累、情绪激动、天气变化等情况下，其面部抽搐不止，再用中、西药物多方治疗，无法控制，患者非常痛苦。经人介绍前来针灸科求诊。见左侧面部抽动频繁不止，面肌抽搐时口角向右侧移动近2cm，左侧眼裂明显小于右侧，说话时一手按压左侧面部肌肉方能进行，情绪烦躁，胃纳尚可，睡眠欠佳，大、小便正常，舌质红，苔薄黄，脉弦数。血压120/80mmHg，无面瘫病史。诊断为面肌痉挛。针刺取内关、太冲、血海、三阴交、阳陵泉。隔日1次，经过2个疗程针灸治疗后，症状明显减轻，偶尔有面肌抽搐，再巩固治疗1个疗程，其病痊愈。随访半年余，面肌抽搐未发。

参考文献

- [1] 周冰，张恒虎，牛建华．吊针配合刺络拔罐法治疗面肌痉挛21例．山西中医，1996，12（5）：30~31
- [2] 唐燕萍．多针浅刺与行气法治疗面肌痉挛37例．上海针灸杂志，2005，24（11）：17~18
- [3] 何晓宏．挂针刺为主治疗面肌痉挛87例．辽宁中医杂志，2003，30（5）：399
- [4] 刘佩云．齐刺、浮刺、直针刺三法结合治疗面肌痉挛33例．新中医，1998，30（12）：19~20
- [5] 李金桂．浅谈面肌痉挛的针刺治疗．针灸临床杂志，1998，14（4）：17~18
- [6] 张旭东．针刺辨证施治治疗面肌痉挛43例疗效观察．针灸临床杂志，1995，11（7）：20~21
- [7] 王家田．针刺结合穴注治疗面肌痉挛78例．黑龙江中医药，1998，（1）：44

- [8] 严善余. 针刺四关穴为主治疗面肌痉挛 52 例. 中国针灸, 1996, (4): 26
- [9] 回克义, 赵敏. 针刺治疗面肌痉挛 56 例. 中国民间疗法, 1998, (4): 10~11
- [10] 梅国胜, 黄选玮. 针刺治疗面肌痉挛 176 例临床观察. 中国针灸, 2000, (11): 659~660
- [11] 张福会, 李彦成, 秦有学. 针药结合治疗面肌痉挛 78 例临床观察. 陕西中医学院学报, 2004, 27 (1): 62
- [12] 张宝荣. 耳穴治疗面肌痉挛 36 例. 上海针灸杂志, 1996, 15 (3): 138~139
- [13] 何胜彪. 针刺治疗面肌痉挛 60 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (7): 14~15
- [14] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 76
- [15] 叶国传. 针刺治疗面肌痉挛的临床体会. 上海针灸杂志, 2005, 24 (5): 23~24

【痴 呆】

痴呆是指意识清楚的病人由于各种躯体疾病而引起持续性高级神经功能的全面障碍，包括记忆力、解决日常生活问题的能力，已习得的技能，正确的社交技能和控制情绪反应能力的障碍，最终导致精神功能衰退的一组后天获得的综合征。

中医学认为，引起本病的基本原因是肝肾亏虚、气血不足、经脉失养、髓海不充。此外还有痰浊瘀血阻滞经络等继发因素。病变脏腑主要在肾，其次在心、脾。

针灸治疗该病具有多元化，干预措施有毫针、电针、拔罐、穴位注射等，其中电针和毫针是目前最为常用的方式。从穴位选取上，有体针、头针等；从治疗运用看，有单独用毫针，有针药合用，有针刺和氧疗合用等，针刺手法、取穴处方多样，内容丰富。

一、醒脑通络针法 健脑养神

姜文根据中医学理论认为呆病病位在脑，气虚血瘀，瘀血内阻，蒙蔽清窍，脑髓不充为其主要病机。

取穴：风池（双），风府，百会， $C_3 \sim C_7$ 夹脊穴。

操作：均用 1.5 寸毫针，穴位常规消毒，

快速进针后，行补法，留针 30min，中等刺激强度，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，休息 1 天，继续下 1 个疗程。注意：风府穴垂直进针 1.5 寸，针尖略向下，嘱患者头部不得前后俯仰。

《素问·骨空论》：“督脉者……上额交巅上，入络脑”。取督脉经穴风府、百会，可以补脑益智。颈夹脊穴，内夹脊里督脉，外邻膀胱经，督脉之别由督脉“别走太阳，”挟脊而行于督脉与膀胱经之间，其针刺效应是通过督脉和膀胱经得以发挥作用。诸穴合用起到醒脑开窍，健脑养神之功效。

杨某，男，65 岁。因反应迟钝，记忆力下降 1 年余入院。症见神情淡漠，记忆力明显下降，回答问题不准确，反应迟钝，善疑多虑，急躁易怒。有高血压病史 10 余年。CT 检查示：脑萎缩；彩超示：椎动脉供血不足。用上述醒脑通络针刺法治疗 1 个疗程后，症状明显改善，2 个疗程后病人基本痊愈。

二、穴位注射 调补先后天

董俊峰在临床上用穴位注射治疗老年性痴呆症，疗效较理想。

取穴：主穴取肾俞，配穴取足三里、三阴交，均取双侧。

操作：嘱患者取正坐位或卧位均可，穴位常规消毒后，用 5ml 注射器、6 号针头，抽取乙酰谷酰胺 2ml、复方当归注射液（含当归、川芎、红花）4ml，将两液混合。然后分别刺入上述穴位。针刺主穴用补法，即进针缓慢，得气后快速小副度提插 3 次，再快速注入药液，每穴 1.5ml，然后快速出针。配穴用泻法，即进针疾速，进针后即缓慢注入药液，每穴 1.5ml，再徐徐出针。隔天 1 次，10 天为 1 个疗程，休息 3 天后行第二疗程。

根据经络原理，肾俞穴补脾温肾养气血，以资生化之源；三阴交主治肝脾肾虚，能调气行血以调后天之本。而乙酰谷酰胺能促进脑和脊髓组织的活动，又能通过血脑屏障进入神经细胞，为中枢神经组织中的中间代谢物，有利于大脑功能恢复，促进脑组织的活动，并能维持良好的神经应激功能；复方当归注射液活血化瘀。穴位注射，既发挥穴位本身的作用，又增强药物的功能，先后天均得以补养，气血运行通畅，津液输布正常，则脑髓充盈，痴呆故而自愈。

王某，男，54岁，教师。1992年8月4日诊。患者半年前因善忘，写字迟钝，特别是说话时颠倒，举止失常而病退。然由此犹如受罚，整天沉闷，逐渐发展至无记忆力、理解力、思维力，表情呆板，语言重复，行动迟缓，如上街不识回家路，常丢失衣物等。诊断为老年性痴呆症，CT示双侧脑萎缩，曾服脑复康、桂利嗪等中西药罔效。今症见双眼无神，双侧瞳孔等大，对光反射灵敏，时而傻笑，舌胖大，边有齿印，尖有瘀点，苔薄白，脉细涩。用上法治疗3个疗程而愈，记忆力、理解力、思维均恢复正常。随访至今未复发。

三、头部围刺 直指病灶

伦新在临床上采用头颅CT定位电围针治疗多发梗死性痴呆，常能收到较好疗效。

取穴：主穴以头部CT所示病灶在同侧头皮的投射区周边为针刺部位；配穴为肝俞、肾俞、足三里、合谷。

操作：严格消毒穴位局部皮肤后，用1~1.5寸毫针4~8根（针数视病灶大小而定）施行围针疗法。针刺方向皆刺向投射区的中心，进针方法同常规头皮针，得气后以180~200次/min的频率捻转2min，其强度以患者能忍受为度，施行平补平泻手法，留针20min，中间间断行针2次。然后，接上海产G6805型电针仪，通以疏密波，频率约14~26次/min，强度以患者产生明显酸麻胀等针感且能耐受为度，每次30min，每天1次，2个月为1个疗程，休息10天继续下1个疗程。同时采用复元合剂（由广州中医药大学第一附属医院制剂中心提供，主要药物有鹿茸、人参、枸杞子、丹参、益智仁等）口服，每次50ml，每天3次。

本病的病位在于脑。中医学认为：“头为诸阳之会”，手足三阳经皆会于头，根据标本学说，头在上为标部，十二条经脉中有八条经脉的标部在头，且头部也为根结所在处（根是指经气相合而始生，结是经气相将而归结），《标幽赋》里的“四根三结”，其中头部为“三结之一”；《灵枢·根结》也记载了三条阳经的结在头部。由于“经脉所过，主治所及”，因此头部CT定位围针能广泛影响上述经络部位，达到疏通经络、调整脏腑、平衡阴阳、补益脑髓、启智开窍的目的。肝俞、肾俞、足三里、合谷等穴位有益气活血、补肾生

髓之效，为治本之必需。

四、药氧针刺 通补兼施

老年痴呆综合征是以老年人脑的意识功能障碍及患者社会功能低下为主要临床表现的综合征，侯安乐采用药氧针刺方法，即将吸氧、中药雾化吸入、针刺三者结合治疗老年痴呆，取得较好疗效。

取穴：风池、百会、四神聪、神门、足三里、内关；辨证配穴为太冲、太溪、三阴交、丰隆。

操作：常规针刺，进针得气后留针 30min，每日 1 次，30 天为 1 个疗程。药氧液以黄精、首乌、石菖蒲、麝香、冰片等为原料由本院制剂室按《中华人民共和国药典》（95 年版）附录合剂标准制备。取药氧液 15ml（相当于原生药 15g）加入等量蒸馏水后倒入雾化器（上海产 402 型）的雾化罐中，将医用纯氧接入雾化器的风门处，使氧气能够完全和药雾充分混和，让患者口含雾化器的含嘴，经口腔将药雾吸入肺内。氧流量调为 3l/min，常规雾化开始后，调节雾化量使之 30min 内将药氧完全雾化，并同时施以针刺治疗。

中医学从整体论治之，有明显优势，认为该病是由于肾精亏虚，痰瘀阻滞，脑窍蒙闭所致，故治之宜补肾扶正、活血逐瘀、醒脑开窍。药选黄精、首乌，针刺取肝俞、肾俞、足三里等穴，补肾扶正；以麝香、皂角、冰片、川芎等药，选四神聪、百会、神门、丰隆等穴，在于开窍醒脑、活血化瘀。针药并用，通补兼施，故取良效。

五、原络配穴 辨证施治

血管性痴呆的病位在脑，病机责之于心肝脾肾功能失调，气血痰瘀互阻，脑髓不通而致脑神失养。所以，在针刺治疗上，应从调理脏腑入手，行气活血，以达祛瘀通经的目的。治疗时应以标本同治，补虚化瘀兼顾，故赵惠在传统的“主客原络配穴法”的基础上，根据本病的特点，提出原络配穴治疗血管性痴呆。

取穴：神门、太溪、飞扬、太白、丰隆、太冲、百会、本神、风池、大椎、膻中、关元。

操作：患者取半卧位。在针刺得气后，留针 30min，其间每

10min 行针 1 次。按照“祛瘀通经、补虚泻实”的原则，对上述穴位施以不同补泻手法。偏于虚证用补法，并对关元、太溪、太白 3 穴施以雀啄灸法；偏于实证用泻法，并于每日出针后轮流选取大椎、丰隆 2 穴中的任一穴，三棱针刺络放血。每日治疗 1 次，每 6 天休息 1 天，60 天为 1 个疗程。

原穴是原气所经过和留止的部位，为本经的代表穴，具有本原和原气之意，是人体生命活动的原动力。原穴不但可治其脏腑疾病，也可治疗与脏腑有关及经脉所过部位的疾病，还是经络感传的激发部位。络穴是联络表里两经的穴位，故有刺一络治两经之说。因血管性痴呆的病机责之于脏腑功能失调，故选取神门（心经之原穴）、太冲（肝经之原穴）、太溪配飞扬（肾经之原穴配膀胱经之络穴）、太白配丰隆（脾经之原穴配胃经之络穴），配合一定的针刺补泻手法，以达到补虚泻实的目的，符合“心主神明、主血脉”、“肝主疏泄”、“肾主生髓，通于脑”以及“脾主运化，为后天之本”的传统中医理论。“督脉为阳经之海”、“总督诸阳经，通于脑”、“任脉为阴经之海”，而“头为诸阳之会”，故以任、督二脉及阳经穴为主，协调阴阳、交通十四经，选取百会、大椎、膻中、关元、风池、本神等穴。百会为头之巅，内络于脑，补之益气升阳，使髓海充盈，而行灵机记性之功。关元为任脉与三阴经之会，本穴内应胞宫精室，为元阴元阳之气所藏之处，针之可以强壮身体。膻中为气之海，与精神、神志有关。风池穴为足少阳与阳维脉之会穴，经气经此穴上行至头部，有清头目之功。本神与神志关系密切，针之有健脑益智之功。

六、综合治疗 阴阳平衡

血管性痴呆属中医学老年呆证范畴，究其病因病机可概括为痰瘀阻窍，肝肾不足、气血亏虚，临床多表现为本虚标实之证候。针对病位在脑，与心、肝、脾、肾、胆等脏腑密切相关的特点，石奕丽认为以补虚泻实为治疗总则，具体组穴当据病情体现化痰开窍、活血醒脑、滋补肝肾为治疗大法，临床上采用针刺、叩刺、走罐综合疗法治疗。

（1）毫针

取穴：合谷、太冲。

操作：患者取仰卧位，常规消毒后，各穴进针皆 0.5 寸，轻度捻转得气后留针 20min，留针期间行针 2~3 次。

(2) 梅花针叩刺

取穴：脑神聪区，即头部督脉后顶、百会、前顶、囟会、上星、神庭连线及左右膀胱经曲差、五处、承光、通天、络却连线。

操作：患者取坐位或卧位，常规消毒后，用七星针顺经叩刺，采用弱或中等刺激强度，每隔 1cm 左右叩刺 1 下，每条穴线叩刺 20~40 次左右，三条穴线交替叩刺（刺后用双手对捏叩刺部位，挤压出血即可），治疗时间每次 10~20 min。

(3) 走罐

取穴：背部膀胱经膈穴、夹脊穴及督脉。

操作：患者取俯卧位，选用中号玻璃罐，用闪火法在背部拔住，然后快速顺经推移玻璃罐，能推多远为多远，推不动时起罐再闪再推，直至所选部位皮肤全部红润或充血为度。叩刺脑神聪区及循经走罐隔日 1 次交替使用。以上治疗每天 1 次，每周 5 次，休息 2 天。

四关穴均为原穴，合谷主调气化痰，太冲善调血活血，此左右四穴犹如把关之将士，能扶正祛邪开窍醒脑。脑神聪区涉及头部督脉 6 穴，膀胱经左右 10 穴，两经循行中均从头顶入脑。督脉总督阳经，故为“阳脉之海”。背膈穴是五脏经气输注之处，位于背部膀胱经第一线，故膀胱经是脑和脏腑经络之桥梁，督脉、膀胱经位邻相近，经气相通，叩刺可起振奋清阳、调补五脏作用，有达阳助阴长之功。循经走罐，人体背部属阳，有诸多阳经循行，沿膀胱经膈穴、督脉、夹脊穴走罐可达平衡阴阳、调补五脏、补益后天之功。针刺、叩刺、走罐三法结合共奏阴阳平衡、五脏安和、脑健神明、激静抑躁之效，恢复兴奋与抑制的正常状态，使智能精神等症状得以改善，即所谓“阴平阳秘，精神乃治”，故病自当改善。

七、头部电针为主 辅以体针

赖新生以电针头部特定穴为主配合体针治疗老年性血管性痴呆，取得显著疗效。

取穴：四神针（百会左右前后各旁开 1.5 寸）、智三针（本神、

神庭)、水沟;配穴:神门、后溪、足三里、太溪。

操作:针刺穴位常规消毒,以28号或30号1.5寸不锈钢毫针,四神针、智三针用平刺法,进针0.8~1寸,捻转得气后连接G6805-1型电针治疗仪,连续波,45次/min,电流强度以病人能耐受为度。留针45min,每隔15min行针1次,施以提插捻转手法。每日1次,12次为1个疗程,休息3天,再行第二疗程。

杨某,女,65岁,广州市居民。病史:右侧肢体活动不灵伴神情呆滞4月余。1993年6月18日因参加老年组拔河比赛用力过度,当晚突发右侧肢体麻木不遂,伴说话不清,在当地医院抢救。CT示左大脑半球出血,诊为出血性脑梗死。住院治疗1个月后病情基本稳定,但数月来渐见语言颠倒或语不连贯,善忘易惊,神情呆滞,行为怪僻,服用脑复康、注射脑活素及服中药20多剂无效。查右上下肢肌力均Ⅱ级,双目呆滞,舌质暗红、脉细涩,辨证属气滞血瘀型中风呆证。按法治疗3个疗程,右上下肢肌力Ⅳ级,语言较前流利合理,复查CT示左侧外囊出血溶解吸收。

八、针药合用 醒脑益智

王宁宁临证中用针刺为主配合中药治疗中风痴呆病(脑血管栓塞性痴呆),收到较满意的疗效。

取穴:神庭、百会、神门。配穴:太溪、三阴交、丰隆、太冲、足三里。

操作:头部选28号1.5寸毫针,采用平刺,体针选30号1.5~2.5寸毫针直刺,得气后平补平泻1min,留针30min,每隔15min行针1次。每日1次,10天为1个疗程,连续针刺治疗3个疗程,每疗程之间,间隙休息2天。同时配合服用醒脑再造胶囊,每日2次,每次8粒(3g)。

痴呆病属本虚标实之证,所选穴位中,百会、神庭为督脉经腧穴,督脉为阳脉之海,总督全身阳气;神门为手少阴心经腧穴,其经脉循行通于脑,针刺具有温阳益气,醒脑益智的功效,故选以上三穴为治疗本病的主穴;太溪为足少阴肾经腧穴,针之能滋补肾阴,益髓健脑;三阴交为足三阴经交会穴,能培土补肾,疏通经脉;足三里、丰隆同为足阳明胃经腧穴,尤其足三里又是胃经合穴,为全

身强壮要穴，针之能调理脾胃，扶正培本；丰隆既可和胃，又能豁痰逐瘀；太冲为足厥阴肝经原穴，针之既可调理肝气，又可活血化瘀。诸穴相和，则标本兼治，共奏补肾健脾，豁痰化瘀，醒脑益智之效。醒脑再造胶囊由黄芪、红花、全蝎、三七、僵蚕、胆南星组成，具有益气通络，化痰醒脑的功效，为治疗脑梗死的有效中成药。针药合用，可取相得益彰之功。

侯某，男，68岁，退休干部。1999年3月10日初诊。患者以记忆力明显减退半年，伴计算误差，定向力偏差之主诉门诊就诊。半年前患者曾以“多发性脑梗死”在某省医院住院采用中西药治疗1月，头昏头晕，右侧肢体无力等症状减轻，病情基本稳定。但逐渐出现近记忆力明显减退，思维能力显著下降，简单算术多数出错，伴失眠多梦，沉默呆滞，多疑拒食，舌质略暗、苔白厚腻，脉沉细。头颅CT示：双侧丘脑内侧多发性梗死。西医诊断：多发脑梗死性痴呆，中医诊断：中风痴呆病，证属：脾肾双虚，痰浊瘀阻，治则：健脾益肾，豁痰开窍，化瘀通络。针刺选穴：神庭、百会、神门、太溪、三阴交、太冲、足三里、丰隆。头部穴采用平刺，肢体穴采用直刺，进针得气后行针1min，留针30min，15min行针1次，每天1次，10天为1个疗程。休息2天，继续行第二疗程，经治30次后，配合服用醒脑再造胶囊，每日2次，每次8粒（3g），服用1月。患者记忆力、思维能力、计算力明显提高，失眠多梦、沉默呆滞、多疑拒食均有明显改善。嘱其注意调节情绪，加强功能锻炼。半年后随访，临床症状基本消失。

九、智三针 - 四神聪 电针治疗

江钢辉采用电针智三针、四神聪的方法治疗血管性痴呆，取得了较好的疗效。

取穴：主穴：智三针（包括神庭、本神双）、四神聪。配穴：心肝火盛加太冲、行间、少府；气滞血瘀加合谷、血海；痰浊阻窍加足三里、丰隆、人中；髓海不足加太溪、绝骨、大椎；肝肾不足加肝俞、肾俞、命门；脾肾两虚加脾俞、肾俞、足三里。

操作：用华佗牌30号不锈钢毫针，平刺，得气后主穴接G6805电针仪，采用疏密波，刺激量以患者能耐受为度，每次30min，配穴

平补平泻。治疗每天1次，每周连续治疗5天，休息2天，继续第2周治疗。

智三针所取三穴，位于前额，四神聪穴位于头顶部，为与神有关的穴位。《淮南子·精神训》有“神者，智之渊也”的论述，可见智力本身就是神的重要组成部分，来源于神。头为精明之府，诸阳之神气皆上合于头，故有“脑为元神之府”之称，脑的主要功能是主宰神志、思维、记忆和情感等。神庭，为脑内元神所藏之处，主要治疗与神志有关的病证；本神为足少阳胆经脉气所发，是诸神之本，故名为“本神”。其次，本组三穴，位于大脑额叶表面的头皮层，而大脑额叶又是情感智力所在，因此，本组穴位配合四神聪可主治情感、智力障碍等疾病。电针智三针、四神聪治疗血管性痴呆可取得较好的临床疗效。

十、益元聪神 祛风火痰瘀

早老性痴呆是一种神经退变性疾病，以记忆损害、认知障碍进行性加重，且发病年龄较早为主要特征，目前尚不能根治。吴迪采用自拟“益元聪神法”针灸治疗早老性痴呆取得一定疗效。

取穴：关元、百会、风池、神门，辅穴为三阴交、足三里、丰隆。

操作：严格消毒穴位局部皮肤后，取1.5~2寸毫针针刺。患者坐位，先取风池，针向喉结方向斜刺1.2寸，双手同时操作，施赤凤迎源法3次；患者仰卧，取百会，斜刺1.0寸至帽状腱膜下，有松软感时施龙虎交战法1min；关元直刺1.5~2寸，施烧山火法，局部有温热感后结合青龙摆尾法使针感扩散，用2cm艾条插于针柄施灸；神门斜刺1寸，施抽添法至手指抽动；足三里直刺2~3寸，施阳中隐阴法；丰隆直刺3寸，施阴中阴阳法；三阴交斜刺1.5寸，施苍龟探穴法至腿足抽动。留针30min，中间不行针。诸穴除关元、百会外，均取双侧。治疗每天1次，每周治疗6天，间隔1天，3周为1个疗程。

关元为任脉与足三阴之会，三焦元气所出，联系命门真阳，乃阴中有阳之穴，针灸关元，既能补益气血精髓之亏，又可激发脏腑经络之能，是“益元”的关键。脑位于人之首，其功能活动有赖于

气血精髓的充养，又赖于阳气的升腾。督脉主一身阳气，上络于脑、下络于肾，肾藏精，精生髓，“脑为髓之海，其输上在于其盖”（《灵枢·海论》），故取百会补脑髓、升阳气。百会、关元分踞督任，属上下配穴，可使三焦通利、阴阳调和，精充、气足、神旺。风池疏风通络、醒脑宣窍；神门“独治痴呆病”（《玉龙歌》），可清心火、安神志，是以“聪神”。三阴交、丰隆、足三里调整脏腑气血各有所长，可滋元气生化之源，乃“益元”之佐；又能化瘀血、祛痰浊、清热和中，为“聪神”之使。

张某，男，62岁，本院职工家属。患者半年前出现记忆力明显减退，且对周围事物反应冷漠、迟钝，头晕乏力，嗜睡少语。2月前又出现语言不利，口角流涎，四末发冷，双下肢无力，小便频，偶有失禁，饮食及大便尚可。头MRI示：脑白质脱髓鞘改变，脑萎缩。血生化检查正常。体查：神清，表情淡漠，反应迟钝，语言含混不清，鼻唇沟对称。伸舌不偏，心肺腹检查未见异常。双下肢肌力V级，生理反射存在。病理反射未引出。舌淡苔白，脉沉细、两尺无力。HSD测试评分19分。予益元聪神法针灸治疗，随证酌情加减四神聪、人中、廉泉、地仓。治疗1个疗程后，患者头晕减轻，双下肢较前有力，二便正常，无口角流涎及四末发冷。治疗2个疗程后，患者语言清晰流利，无头晕，记忆力及精神状态较前好，睡眠佳。治疗3个疗程后，患者反应灵敏，记忆力较前好，HSD测评30分。随访半年无复发。

十一、从虚瘀论治 辨证取穴

老年性痴呆在中医属“善忘”、“痴呆”等范畴，韦思泉认为气血不足、髓海不足、痰阻血瘀为主要病因病机。认识到老年痴呆是人体衰老的征象，而气虚血瘀是人体衰老的根本。所以，应从虚、瘀辨证论治。

（1）气血不足、脑失所养型治以补益气血，开窍充脑。基本方：党参10g、白术10g、阿胶10g（烊化）、益智仁15g、黄芪15g、当归10g、淮山12g、石菖蒲20g、黑枣4枚、甘草6g。

针刺取穴：百会、神门（双）、足三里（双）、气海、四神聪。针用补法，留针20min，每天1次，10天为1个疗程。

(2) 肝肾阴虚, 肝阳上亢型治以滋养肝肾, 开窍醒脑。基本方: 天麻 12g、勾藤 15g (后)、黄芩 10g、石决明 30g (先)、杜仲 10g、枸杞子 10g、白芍 12g、石菖蒲 15g、赤芍 15g、生地 15g、牛膝 15g、酸枣仁 15g、远志 12g、甘草 6g。

针刺取穴: 百会、神门 (双)、四神聪、关元 (补)、太溪 (双、泻)、太冲 (双、泻)、三阴交 (补)。留针 20min, 每天 1 次, 10 天为 1 个疗程。

(3) 痰瘀阻络, 蒙蔽清窍治以活血通络, 豁痰开窍。基本方: 黄芪 40g、归尾 10g、川芍 10g、赤芍 10g、法夏 15g、茯苓 20g、桃仁 10g、红花 6g、胆南星 10g、竹茹 10g、地龙 10g、石菖蒲 15g、僵蚕 10g, 全虫 4g。

针刺取穴: 百会、神门 (双) 丰隆 (双); 若兼偏瘫、口眼喎斜, 可选患侧地仓、颊车、牵正、肩髃、曲池、合谷、环跳、阳陵泉、悬钟、太冲 3~5 次。针用平补平泻, 留针 20min, 每天 1 次。

在针刺取穴中, 百会、四神聪、神门是主穴。四神聪、百会均位于头顶部, 百会为“诸阳之会”, 四神聪前后两穴均在督脉循行线上, 左右两穴紧靠膀胱经上, 刺激此五穴可疏通调节人体诸多经脉, 振奋阳气, 增强其疏通调节元神之府的功效。而神门为心经之原穴, 善治各种与情志相关的疾病。

患者, 男, 67 岁, 退休教师。因善忘痴呆, 左侧肢体偏瘫半年余, 曾在外院做头颅 CT 示: 多发性腔隙性脑梗死。入院症见: 痴呆愚笨, 记忆力、计算力、定向力和阅读障碍, 二便失控, 偏瘫。查: 心肺正常, 左侧肢肌力 I 级, 左巴氏征 (+)。舌质暗淡, 苔白腻, 脉弦滑。住院后予活血通络, 豁痰开窍的方药煎服。并予针刺百会、神门 (双)、丰隆 (双) 气海及患侧肩髃、曲池、外关、环跳、阳陵泉、足三里、悬钟等穴。针用平泻平补, 留针 20min, 每天 1 次, 10 天为 1 个疗程。经上述治疗 3 个月, 患者呆滞及二便失控症状消失, 肌力恢复正常, 能正常行走, 能与人正常交谈, 计算、阅读等能力基本恢复, 第四个月后, 治愈出院。

十二、调神益智针法 化痰祛湿

血管性痴呆是最常见的老年期痴呆之一, 于颂华认为痴呆病位

虽在脑，但与脾肾虚损及气血运行失调导致的痰浊有着密切关系，临床上采用调神益智针法治疗该病疗效显著。

取穴：主穴：风池、四神聪、神庭、内关、神门、人中、前顶。
配穴：肾精亏损型加刺太溪、三阴交、然谷；痰浊蒙窍型加刺丰隆、阴陵泉、足三里。

操作：常规针刺，平补平泻，上下午各1次，每次留针30min，2周为1个疗程。

主穴取督脉的前顶、人中、神庭以补脑益智；四神聪位于脑巅，主开窍、醒神，且升阳益智；风池位于脑后属少阳，善疏风邪而清痰热，可安神醒脑而聪耳明目；内关为心包经的络穴，与神门相配具有宁心调神的作用。肾虚为本病的根本原因，补肾填精，健脑益智为其治疗原则，故肾精亏损型加刺肾经原穴太溪，以补肾填精；然谷为肾经的荥穴，针之具有滋阴清热、开窍醒神的作用。痰浊蒙窍型治疗原则为健脾益气，豁痰开窍而醒神。取丰隆、足三里，均为阳明经穴，阳明为多气多血之经，针之能补益气血；阴陵泉为脾经的合穴，与丰隆、足三里相配，则健脾益气，化痰除湿，开窍醒神。

十三、益肾醒脑针法 益肾填髓

赵建新认为中风痴呆证患者多属肾虚、痰瘀内阻，故以益肾填髓，醒脑启智，涤痰化瘀立法选穴，采用益肾醒脑针法进行治疗。

取穴：主穴用百会、肾俞、膈俞；配穴用丰隆等。对症加减：面瘫加地仓、颊车；言语謇涩加廉泉；偏瘫加外关、曲池、环跳、阳陵泉、昆仑。

操作：选用30号1.0~2.0寸不锈钢毫针，刺入深度、角度、方向视不同穴位、部位而定，得气后主穴接WQ-10C型多用电子穴位测定治疗仪，连续波，频率2~4次/s，其余腧穴进针得气后，采用平补平泻法，留针20min，每日针刺1次。

“督脉者……上至风府，入属于脑”（《难经·二十八难》），“膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额交巅。其直者，从巅入络脑”（《灵枢·经脉》），可见督脉和膀胱经与人脑的联系是最密切的。因此选用督脉的百会穴通督醒脑；肾俞、膈俞均属膀胱经，而肾俞为

肾的背俞穴，可益肾填髓充脑，膈俞为八会穴之一的“血会”，可活血化瘀。因此，选用这组穴位，以百会通督醒脑，肾俞益肾填髓充脑，膈俞化瘀祛痰。

十四、头三神为主 辨证加减

王敏认为血管性痴呆病位在脑，治疗当以“醒脑开窍”为大法，兼以调理脏腑、行气活血、化痰逐瘀、益肾填精、通络开窍为治则。

取穴：“头三神”穴，即神庭、本神、四神聪，以及百会。配穴按照中医辨证分型，虚证髓海不足配血海、悬钟；肝肾亏虚配三阴交、太溪；脾肾两虚配公孙、太溪。实证心肝火盛配太冲、神门；痰浊阻窍配丰隆、足三里；气滞血瘀配血海、太冲。

操作：主穴“头三神”穴位常规消毒后，以华佗牌1寸不锈钢毫针与头皮呈30°夹角采用连续压手式进针法，可刺入皮下1寸，以针下有松软感为宜。四神聪四穴均刺向百会穴方向。百会取29号，1寸毫针直刺，直立入穴得气即可。配穴按照虚则补之，实则泻之的原则，予以手法补泻。

以头穴“头三神”穴和百会为主穴，共八穴位于头部，寓“治病必求于本”之意，有近取头穴以达“清上”之效。“头三神”穴即神庭、本神和四神聪，此三穴均有神字，且在头部，可见与人的大脑功能神志活动关系密切，具有醒脑开窍的功效。

神庭为督脉要穴，而“督脉为阳脉之海，总督诸阳经，上额交巅上，入络脑”，有醒脑宁神的功能。本神属足少阳胆经，《经穴释义汇解》曰：足少阳阳维之会，以应脑。脑者，人之本，主神志病，故名本神，同样也有宁心安神的作用。四神聪为经外奇穴，“在百会四面，各相去同身寸一寸是穴”，采取齐向百会透刺的方法能增强安神宁心的功效。主穴百会为督脉要穴，高居头巅，为诸阳之会，善治脑疾。

根据中医辨证分型，对证配选远在肘膝以下诸穴，能激发所属经脉及脏腑，改善局部乃至相关脏腑的功能状态，使血管性痴呆患者的智力、记忆力及生活能力得以改善。从而达到调理脏腑、行气活血、化痰逐瘀、益肾填精、通络开窍、标本兼治的目的。

十五、补下清上 调神益智

根据古代文献对脑的生理、病理的论述，以及导师杨甲三教授的学术经验，刘清国认为本病的发生有3个关键的环节：①下虚：脏腑、精、气、血亏虚于下，不能上养于脑；②上实：风、火、痰、瘀袭于上；③脑神失用，“脑脏伤而神志失夺”。故采用补下清上、调神益智的治疗原则。

取穴：百会、神庭、本神、神门、列缺、照海、悬钟、三阴交、足三里、风池、风府、大椎、合谷、曲池、阳谷、太冲、丰隆。

操作：选用28~30号1.5~2寸毫针，先刺风池、风府、大椎，得气后行捻转泻法，不留针；再刺百会、神庭、本神、神门，得气后行捻转补法；再刺列缺、照海、悬钟、三阴交、足三里，得气后行捻转补法；再刺合谷、曲池、阳谷、丰隆、太冲，得气后行捻转泻法。留针30min，每隔10min行针1次，每周治疗5次。

百会、神庭、本神、神门是杨甲三教授“调神益智”的经验方。操作上，先刺风池、风府、大椎，得气后行捻转泻法，不留针，以泻除在上的风阳之邪，通络安脑；再刺百会、神庭、本神、神门，得气后行捻转补法，以调神益智；再刺列缺、照海、悬钟、三阴交、足三里，得气后行捻转补法，以补髓健脑；再刺合谷、曲池、阳谷、丰隆、太冲，得气后行捻转泻法，以逐痰化瘀。

十六、补肾为主 配对症治疗

董洪涛认为，对于老年性痴呆，无论是何种证型，一旦影响到智力，无不以肾虚为本。如《医学心悟》所言：“肾主智，肾虚则智不足。”《黄帝明堂灸经》言百会主“少心力，忘前失后，心神恍惚”。因而在临床研究中，应抓住肾虚这个主要病因，以补肾填精、益髓增智、醒脑开窍为主，对症治疗为辅。

取穴：①组：百会、大椎、肾俞、神门、内关、三阴交；②组：四神聪、风池、太溪、足三里、丰隆、太冲。随症加减：惊悸不寐者，加内关；狂躁易怒者，加间使；胸闷心悸者，加膻中；言语失利者，加廉泉；腰酸步艰者，加阳陵泉；夜尿多者，加阴陵泉；耳鸣者，加翳风、听宫；眩晕者，加印堂；便秘者，加天枢、合谷。

操作：①组取俯卧位，②组取仰卧位，两组交替选用，均取双侧穴位。其中百会与大椎、四神聪与风池给予连续波电刺激（脉冲频率为180次/min），强度以患者可耐受为度，15min后改为疏密波，以防电适应。其他穴位，得气后，稍加提插捻转，以加强针感，留针40min。每天1次，每周5次，4周为1个疗程。

百会穴位于巅顶，其深处即为脑之所在；且百会为督脉经穴，督脉又入于脑，长于益气升阳、填充髓海，而行灵机记性之功。肾俞乃肾之背俞穴，合肾经输穴太溪旨在补肾、益精、填髓。风池位于项后，与丰隆配伍可以豁痰开窍。大椎为手足三阳经与督脉之交会穴，其经皆上行于头，而督脉入络脑，取该穴可调节大脑功能，益髓开窍。三阴交为足三阴之交会穴，可调补三阴，伍胃经合穴足三里可达益肾之功，并能延缓衰老。《玉龙歌》记载“痴呆之证不堪亲，不识尊卑枉骂人，神门独治痴呆病，转手骨开得穴真。”故神门常用来治疗痴呆，且常配伍内关、太冲以宁心疏肝。选取这些穴位治疗老年性痴呆能产生较好的治疗效果。

十七、醒神开窍 补肾填精

郭萍认为痴呆的病机不外心脾两虚、肾精不足、痰阻血瘀、阴虚火旺，治疗上以益气养阴、醒脑开窍、宁心安神、益肾添精为总则。

取穴：人中、内关、四神聪透百会、劳宫、神门、三阴交、太冲、肾俞。配穴：极泉、曲池、合谷、委中、印堂、上星透百会、足三里、阴陵泉透阳陵泉、风池、太溪、丰隆。

操作：人中向鼻中膈斜刺，雀啄手法至流泪或眼球湿润为度，不留针；内关直刺0.5~1寸，捻转提插手法行针1min，出针；四神聪平刺透百会，捻转提插手法行针1min，留针20min；劳宫直刺0.3~0.5寸至全手麻胀感，不留针；神门直刺0.3~0.5寸至局部酸胀有麻电感向指端放散，不留针；三阴交斜刺用补法至下肢抽动3次为度，留针20min；太冲直刺0.3~0.8寸，局部酸胀麻电感向足底扩散，留针20min；肾俞斜刺向椎体0.3~1寸至局部胀麻感，留针20min。配穴常规针刺。上述治疗每日1次，10次为1个疗程。

百会为督脉之穴，位于巅顶，具升清阳、醒脑开窍之功；人中、

四神聪透百会可醒神开窍、熄风止痉，同为治疗主穴；内关属手厥阴心包经之络穴，可宁心安神，治疗心烦、癫狂、妄语，是治疗神志疾患的首选穴位；神门为心经之原穴，能降心火、安心神；三阴交为足太阴、厥阴、少阴之交会穴，可疏肝理气、益精填髓、通经活络，为治疗之要穴；太冲为肝经之原穴；肾俞为肾的背俞穴，可补肾滋阴、健脑益智，诸穴相配可奏醒神开窍、补肾填精、熄风通络之功。配穴可根据临床辨证分型选用。运用这一治疗方法在临床中确实有一定疗效。

沈某，女，56岁，退休工人，既往患高血压病10年，于2001年6月突发意识丧失，遗尿，偏身不遂。CT示：脑干出血，经西医保守治疗后病情稳定，遗留右侧半身不遂，语言不清，记忆力减退，思维不清，行走不能。用上述治疗方法经4个疗程后患者能自行行走，语言清晰，能背诵唐诗，思维正常。于2002年1月又复发脑出血，小面积梗死，小脑萎缩。继用上述方法治疗4个疗程后患者语言尚清晰，思维运算能力如常，遗留蹒跚步态等小脑共济失调症状。

十八、十二井 大接经

血管性痴呆属于中医“痴呆”、“呆证”范畴，一般认为由血脉瘀阻、脑神失充所致。治疗上应以活血化瘀、通络开窍为法。米建平采用大接经法治疗血管性痴呆，取得理想疗效。

操作：患者平卧放松，两位医生位于患者左右两侧，用1寸毫针，按照十二经脉流注顺序快速刺入井穴，快速捻转5~10s，不留针。虚证针刺从阴引阳，即从手太阴肺经少商穴开始，至足厥阴肝经大敦穴结束；实证针刺从阳引阴，从足太阳膀胱经至阴穴开始，至手太阳经少泽穴结束。女性患者从肢体左侧开始针刺，男性患者从肢体右侧开始针刺。

大接经法首见于《卫生宝鉴》，是专门治疗中风偏枯的一种特殊配穴方法，有“从阴引阳”“从阳引阴”两法。《灵枢·海论》云“十二经脉者，内属于府藏，外络于肢节”，是人体运行气血主要通道，井穴为五输穴之一，《灵枢·顺气一日分为四时》“病在藏者取之井”，《难经·六十八难》曰“井主心下满”，可见通过针刺井穴达到醒神开窍、疏通经络、调理脏腑之功。《灵枢·刺节真邪》篇

云：“虚邪偏客于身半，其入深，内居荣卫，荣卫稍衰，则真气去，邪气独留，发为偏枯”，本病病位在脑，基本病机乃瘀血内停，痹阻脑络，神明失养，血不能荣，故肢体偏瘫，刺十二井穴起到疏通脉络中凝滞的气血，畅通血行的作用。

十九、电针调髓海 穴取头部为主

血管性痴呆是由于脑血管因素导致脑组织损害所引起的痴呆综合征，该病患者有明显的记忆、计算、思维、定向、判断等能力障碍，病程呈阶梯样发展，彭唯娜采用电针调理髓海方法治疗重度血管性痴呆，获得满意的疗效。

取穴：上印堂、百会、风府、风池、太阳、合谷、太冲。

操作：采用华佗牌针灸针，规格为1.5寸。接G6805-2A治疗仪。患者为坐位或卧位体位，常规消毒。术者用针与头皮呈30°夹角按先后顺序斜刺入上印堂、百会0.5寸（同身寸，以下同），以针尖向鼻尖的方向刺入风府0.5寸、风池1寸，直刺太阳穴1.2寸，直刺入合谷、太冲1寸。风府、风池、合谷、太冲均用提插法，术者觉沉紧感，患者觉酸胀感；上印堂、百会刺入骨膜，用捻转法得出针感，其中百会不强求针感，针刺上印堂穴时，要求患者有重压针感。双太阳、百会、风府加电针，选用电针频率80Hz，间歇波，电流量以患者能耐受为度。每天针灸1次，每次留针30min，每周治疗5次，10次为1个疗程。

血管性痴呆属于中医呆病、痴呆、文痴、健忘、善忘、遗忘等范畴，其病位在脑。《灵枢·海论》论述：“髓海不足，则脑转耳鸣，脛酸眩冒，目无所见，懈怠安卧”。清代医家王清任谓：“脑为元神之府，灵机记性在脑不在心，”又有“年高无记性者脑髓渐空”之说。中风后气滞血瘀，脉络阻滞，髓海与脏腑之气沟通不利，五脏之气不足以养脑而致痴呆。彭唯娜以调理髓海为法，选百会、风府、风池、太阳、合谷、太冲、上印堂等穴治疗呆病。上印堂为经验穴，有镇惊清神之效，留针时间长则效果尤佳；百会、风府为督脉要穴，督脉“上额交巅上，入络脑”并总督一身之阳脉，两穴合用可醒脑开窍养髓；太阳为经外奇穴，位于头部，有养神益智之功；风池为足少阳胆经治风要穴，功能平肝熄风，合太冲、合谷以行气

活血通络。以上诸穴合用，具有调理髓海，补虚泻实之效，对重度血管性痴呆患者有明显的治疗作用。

参考文献

- [1] 姜文, 李勇. 醒脑通络针刺法治疗老年性痴呆疗效观察. 针灸临床杂志, 1998, 14 (4): 6~7
- [2] 董俊峰. 穴位注射治疗老年性痴呆症 86 例. 上海针灸杂志, 1997, 16 (3): 9
- [3] 伦新, 荣莉, 杨文辉. 头颅 CT 定位围针配合中药治疗多发梗死性痴呆的疗效观察. 中国中西医结合杂志, 2003, 23 (6): 423~425
- [4] 侯安乐, 卜渊, 周文博, 等. 药氧针刺治疗老年期痴呆 32 例临床研究. 江苏中医, 2000, 21 (1): 28~29
- [5] 赵惠, 孙忠人, 孙远征, 等. 原络配穴为主治疗血管性痴呆疗效观察. 中国针灸, 2004, 24 (8): 525~527
- [6] 石奕丽, 付如华. 针刺、叩刺、走罐综合疗法治疗血管性痴呆 43 例. 山东中医杂志, 2004, 23 (8): 479~480
- [7] 赖新生. 针刺治疗老年性血管性痴呆的疗效观察. 中国针灸, 1997, (4): 201~202
- [8] 王宁宁. 针刺治疗中风痴呆病 33 例. 陕西中医, 2002, 22 (8): 738~739
- [9] 江钢辉, 陈振虎, 赖新生. 针刺智三针和四神聪穴治疗血管性痴呆的临床研究. 广州中医药大学学报, 2003, 20 (4): 271~273
- [10] 吴迪. 针灸治疗早老性痴呆 36 例. 四川中医, 2004, 22 (3): 93~94
- [11] 韦思泉. 针药并用治疗老年性痴呆 25 例. 黑龙江中医药, 1999, (3): 57~58
- [12] 于颂华, 王春梅, 刘占芬. “调神益智”针法治疗血管性痴呆 21 例临床观察. 针灸临床杂志, 2005, 26 (6): 25~26
- [13] 赵建新, 田元祥, 程英武, 等. 益肾醒脑针法治疗血管性痴呆临床观察. 河北中医, 2000, 22 (11): 844~846
- [14] 王敏, 王敏华, 华启海, 等. 针刺“头三神”穴为主治疗血管性痴呆疗效观察. 上海针灸杂志, 2005, 24 (6): 12~14
- [15] 刘清国, 汤立新, 贺江宁. 针刺治疗多发脑梗死性痴呆 46 例临床观察. 北京中医药大学学报, 2003, 26 (2): 81~85
- [16] 董洪涛, 金渊光, 白英. 针刺治疗老年性痴呆 11 例. 上海中医药大学学

报, 2002, 12 (3): 26 ~ 28

- [17] 郭萍, 赵楠, 杨洁. 针刺治疗中风后老年性痴呆 22 例. 针灸临床杂志, 2003, 19 (7): 19 ~ 20
- [18] 米建平, 朱晓平, 樊莉, 等. 大接经法治疗血管性痴呆临床观察. 中国针灸, 2004, 24 (11): 747 ~ 749
- [19] 彭唯娜, 马晓晶, 刘志顺. 电针调理髓海方法治疗重度血管性痴呆 12 例. 针灸临床杂志, 2005, 21 (9): 34 ~ 35

【高血压病】

高血压病是一种常见的慢性疾病，全称为原发性高血压病，以安静状态下持续性动脉血压增高为主要表现。本病发病率较高，且有不断上升和日渐年轻化的趋势。本病早期有头晕、头痛、心悸、失眠、耳鸣、心烦、乏力、记忆力减退、颜面潮红或有肢体麻木等。晚期可导致心、脑、肾等脏器的病变。病因至今未明，目前认为是在一定的遗传易感性基础上由多种后天因素作用所致，与遗传、年龄、体态、职业、情绪、饮食等有一定的关系。

根据临床上的主要证候、病程转归以及并发症，本病可归属于中医“头痛”、“眩晕”、“肝风”等范畴。《素问·至真要大论》曰：“诸风掉眩，皆属于肝”，“肾虚则头重高摇，髓海不足则脑转耳鸣”。认为本病与肾阴不足、肝阳偏亢有关，多因精神因素、饮食失节等诱发。

针灸治疗该病，以平肝潜阳、祛湿化痰、滋肾柔肝、育阴助阳为主。治疗方法较多，有点刺放血、头皮针、针药并用、按摩等，有的采用特定穴，有的根据症状辨证取穴，疗效均较理想。

一、百会 - 神阙 - 涌泉 上中下相配

根据中医学的理论,刘永久对高血压症进行针灸治疗,经过多年的摸索、总结、归纳、筛选,认为百会、神阙、涌泉是治疗高血压的有效穴位。

取穴:百会、神阙、涌泉。辨证加穴:肝阳上亢加刺肝俞、太冲;肾阴不足加刺肾俞、三阴交;痰湿内盛,加刺丰隆、内关;阴阳两虚,加刺关元、气海。

操作:先刺百会,得气后,隔姜灸神阙,最后刺涌泉。每次60min,中间运针2次,隔天1次,10次为1个疗程,每个疗程之间休息3~5天。

百会别名为三阳五会、巅上、天山。本穴在巅顶,为手足三阳、督脉之会处,故有“头为诸阳之会”;穴居最高之位,四周各穴罗布有序,如百脉仰望朝会故名百会。《圣济总录》中指出:“头旋目眩,百会、风府。”神阙,属任脉,灸之可调节阴阳而达“阴平阳秘”。涌泉,别名地冲。本穴位于足底,居人体最低位,属肾经“所出为井”。《灵枢·顺气一日分四时》:“病在脏,取之井。”三穴相配,呈为一体,能平肝熄风、益气升阳、补肾益精、除湿化痰,使百脉经气充盈,汇聚成河,川流不息,冲平坎坷,洗涤污垢,并由井穴涌泉潺潺流出,从而达到治愈的目的。

二、清上补下 辨证取穴

临床上王岫采取辨证分型施针治疗高血压病,获得了较为满意的临床效果。

取穴:百会、风池、内关、三阴交。肝阳上亢型加取行间、侠溪,若肝肾阴虚明显加太冲、太溪、肝俞、肾俞;痰湿内阻型加取中脘、丰隆、头维、公孙;阴阳两虚型加关元、足三里。

操作:①采用毫针,风池穴进针1.5寸,针尖刺向对侧鼻孔方向,针感循足少阳胆经在头部由后向前窜至前额或后顶部,以沉胀为主,起针后患者感觉头目清利为佳。内关、三阴交上下交叉捻转,刺激量以患者能够耐受为度,双侧对称。随证配穴的丰隆,用泻法先提插后捻转,间歇行针。余穴宜平补平泻,得气后静止留针20~

30min, 每日1次。②采用温针灸关元、足三里。待得气后予以适当补泻手法, 留针时, 用2cm长艾炷插在针柄上点燃, 施灸3次, 燃尽后除灰取针, 每日1次(注: 实热证或阴虚热盛者不宜)。

高血压病有虚实之别: 以风、痰为主要病理变化时为实; 若气血两虚或进一步发展为阴阳双亏时为虚, 但往往虚实夹杂, 其病位多在肝、肾、脾、脑。取穴百会、风池平肝熄风, 疏泄浮阳, 安神止晕。“足厥阴肝经连目系……上出额与督脉会于巅顶”即当百会穴所在, 督脉总督诸阳, 故百会能调足厥阴和诸阳经之气, 善于清利头目、升阳益气。内关为手厥阴之络, 别起手少阳, 且通于阴维, 故内关既能维系诸阴、调和诸脏, 又能疏利厥阴与少阳之气。三阴交为足三阴经之交会穴, 可益阴、补气、化痰。四穴合用, 阴阳相应, 远近配合, 可清上补下。加之行间、侠溪泻其肝胆之热, 平逆肝胆之亢阳, 即可平肝降逆、安神止晕。

三、耳尖放血 取效迅速

高血压病是临床上最常见的心血管病之一, 其发病率高, 目前治疗的方法很多。吴广伟用耳尖放血治疗高血压病, 见效较快。

取穴: 耳尖(双)。

操作: 取患者双侧耳尖穴常规消毒后, 用三棱针或6号注射用针头点刺耳尖穴, 每侧穴位放血8~10滴, 完毕后, 再用稀释碘酒常规消毒针口。

耳与脏腑关系密切, 如《灵枢·口问》: “耳者, 宗脉之所聚也”, “耳背玉楼属肝”, 耳尖穴具有清热解毒, 消坚散结, 降血压的作用。

徐某, 女性, 49岁, 干部, 1990年6月3日就诊。患者有高血压病史2年, 血压升高时常服用复方降压素、心血康等药物治疗, 因嫌药物不良反应多, 今停药来求非药物疗法治疗, 检查血压161/101mmHg。用耳尖放血10滴, 嘱患者休息15min后复查血压, 结果血压下降为140/180mmHg。

四、独取足三里 温针降血压

黄效增运用温针灸足三里穴治疗原发性高血压病, 取得了满意

疗效。

取穴：足三里。

操作：用1.5~2寸毫针刺入足三里穴（双），令得气后在毫针上套上硬纸板（以防灼伤），然后在针柄上放艾炷如杏核大，用火点燃，每次灸3~5壮，每天1次，10天为1个疗程，疗程间休息5天。

足三里系强身健体要穴，临床体会通过针灸该穴可宣通五脏六腑，使肠胃安和，气不上逆，气血运行通畅，肝阳不致上扰。对血压、心律、血管舒缩等都有良好的双相调节作用。因此，用本法治疗原发性高血压病效果良好，对Ⅰ期、Ⅱ期患者尤为理想。加之简便易行，便于坚持，值得推广和进一步研究。

史某，女，62岁，农民，患者自1979年以来，自觉头晕头痛，面部烘热，尤其头部怕热，常用冷毛巾敷头部，血压经常在190/110mmHg左右，服用多种降压药疗效欠佳，且停药血压即升高。1990年5月11日来诊。查血压194/110mmHg，运用上法1个疗程后血压降至162/96mmHg，头晕头痛大减，面部烘热消失，2个疗程后血压降至154/90mmHg，自觉无任何不适，3个疗程后血压稳定在150/90mmHg左右，随访3年，血压正常，能参加正常家务劳动。

五、四穴相配 平肝潜阳

邢孝民采用平肝潜阳针法治疗原发性高血压，每获良效。

取穴：双侧风池、太冲、涌泉、太溪。

操作：风池穴进针1~1.5寸，手法采用捻转泻法；太冲透涌泉，手法采用捻转提插泻法；太溪进针10~15mm，手法采用捻转补法。以上诸穴均在得气的基础上留针30min，每隔10min行针1min，每天1次，15天为1个疗程。

原发性高血压当属中医的“眩晕”范畴。《素问·至真要大论》曰：“诸风掉眩皆属于肝”。风池穴为足少阳胆经穴位，与阳维脉会于此，具有调理诸阳、泻肝胆而清头目的功效；太冲为足厥阴肝经原穴、输穴，涌泉为足少阴肾经井穴，太冲透涌泉，用泻法，共奏平肝降逆之功；而太溪是足少阴肾经原穴、输穴，补之可滋阴以潜阳。故四穴配伍可止眩晕而使原发性高血压患者血压下降。

六、体针配耳压 整体调治

谢云运用体针、耳压协同作用，通过对机体、脏腑的整体调治，对原发性高血压起到较为满意的稳压效果。

取穴：体针取内关、太冲、太溪；耳穴选降压沟、心、肝、肾。

操作：①体针常规针刺后行捻转提插，泻太冲补太溪，平补平泻内关，留针 20 ~ 30min。②耳廓常规消毒，选准耳穴后，每穴用 0.5cm × 0.5cm 胶布将王不留行籽固定于耳穴上，嘱患者于针刺前后及每日 18 时左右按压耳穴 15min，直至耳廓发红发热，双耳交替，隔日贴换 1 次。

高血压病与机体阴阳平衡失调有密切关系。治以平肝潜阳，养阴固肾，协调阴阳。耳穴肝合肝经原穴太冲，耳穴肾合肾经原穴太溪，通达肝肾原气。且太溪、太冲补母泻子，达平肝潜阳、养阴固肾之功。耳穴心合心包经络穴内关，养心神、通脑窍，与肾经穴相配，水火相济，阴阳相调。

杨某，女，74 岁，退休工人。高血压病 30 年。血压最高时达 210/124mmHg，平时服复方罗布麻片、复方降压片等药物，血压可降至 161/94mmHg。1 周来，服药后出现腰酸、耳鸣、腹泻等症状，且血压忽高忽低不能控制。近 2 天内，3 次发生一过性偏身麻木，当时测血压高达 180/120mmHg，且见头晕胀痛，四肢乏力，腰膝酸软，纳可，眠差多梦，大便溏，小便可，舌质红，苔薄黄，边有瘀斑，舌底脉络暗红，脉弦细。查体：血压 158/105mmHg，心肺（-），四肢活动度可，肌力正常，生理反射存在，病理反射未引出。中医诊断：眩晕（肝肾阴虚）。西医诊断：①原发性高血压Ⅱ期。②一过性脑缺血。入院后，首先以降压为主，经用上述方法进行针刺耳压治疗后，即时血压下降至 150/95mmHg，经治 2 个疗程后，血压降至 140/90mmHg，头晕胀痛明显减轻，未再出现一过性偏身麻木，经治 3 个疗程后，血压稳定于 135/90mmHg，头晕胀痛、眠差多梦等症基本消除。3 个月后，未行降压治疗，继续观察病人病情，血压仍稳定于 135/90mmHg，1 个月无回升及下降趋势，一般情况良好，精神状况佳而出院。随访 3 个月无复发。

七、辨证分型 耳穴贴压

曾碧梅采用耳穴贴压治疗高血压，效果较好。

取穴：肝火亢盛型取肝、结节、心、角窝上、降压沟等穴，用王不留行籽贴压；阴虚阳亢型取肝、肾、交感、耳背心枕等穴，用菟丝子贴压；痰湿壅盛型取脾、三焦，耳背心、肝、肾等穴，用白芥子贴压。

操作：先将胶布剪成 $0.6\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ 小块，然后在其中中央放一粒所需药丸以备用。施治时先用 70% 酒精棉球擦净耳廓，再将胶布药丸贴压在选定穴位上，并由轻至重按压 8~10 次，使患者有酸、胀、热、痛感觉。每次贴压一侧耳，两耳交替，每周换贴 3 次。

高血压病根据其临床表现可将其归属中医学的头痛、眩晕等病范围。究其病因，或由情志所伤，肝失条达，升发太过而致肝阳上亢；或由摄生不当，肾精亏损，以致肝肾阴虚；或由饮食失宜，脾胃不健，水湿内停，聚而生痰，以致痰浊中阻，清阳不升，浊阴不降。

采用耳穴治疗，是因“耳者，宗脉之所聚也”（灵枢·口问）。耳与全身各脏腑器官组织均有密切关系，通过刺激与脏腑器官相对应的耳穴，可以调节诸脏器的功能活动，达到补虚泻实目的。治疗中发现，白芥子有发泡作用，对穴位的刺激作用强烈而持久，不论哪种证型，贴压效果均好，似乎优于王不留行籽与菟丝子。

张某某，男，51 岁，干部。1992 年 10 月 4 日就诊。患高血压病 3 年余，经常面色潮红，头痛且胀，以巅顶为甚，发怒后加重，服用多种降压药物治疗均只有短期效果。近又出现左上、下肢麻木乏力。查：面色潮红，形体肥胖，血压 185/20mmHg。舌质黯红、苔黄少津，脉弦有力。X 线胸片以及心电图检查示：左心室肥大。诊断为高血压病 II 期（肝火亢盛型）。按前法取王不留行籽贴压肝及结节等穴治疗。15 次后血压降至 150/90mmHg，症状基本消失，但仍有轻度肢麻感，继续治疗 3 次后，肢麻感消失。半年后随访，病未复发。

八、针刺扶突 调阳明气血

近几年来,李灵毅在针灸临床治疗中,发现扶突穴有明显的降压作用。

取穴:扶突(双侧)。

操作:患者正坐位,在颈部侧面,喉结旁3寸,在胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间取穴,用28号2寸毫针,取双侧扶突穴,先针左侧穴,呈45°角进针1寸深浅,针尖朝向颈根部,缓缓捻针1~3min,出现酸麻感向肩部放射,针感至手者效果最佳,留针30min,每10min行针1次,10次为1个疗程,前5次每天针灸,以后据病情隔日或隔2日针灸。

扶突穴为手阳明大肠经经穴,阳明经多气多血,高血压病多为气血上逆所致,针刺扶突穴可调节阳明经气血,以达到降压目的。又扶突穴位于颈总动脉窦附近,此处有动脉压力感受器的血管外膜下的感觉神经末梢,当针刺扶突穴时,可使压力感受器发放的神经冲动增多,而使心率减慢,外周血管阻力降低,血压下降,而达到调节血压的作用。

夏某,女,70岁。主症头晕脚软3天,既往有高血压病史5年,检查:血压200/100mmHg,心率85次/min,律齐。治疗:正坐,取扶突穴,常规消毒后,用28号2寸毫针,取双侧扶突穴,进针1寸深,针尖指向颈根部,缓缓捻针,针感至手,留针30min,每隔10min行针1次,留针过程中,感觉头部有舒适的凉爽感向下移行,取针后测血压160/80mmHg,症状消失,如此治疗4次后,血压稳定在140/80mmHg,隔2天治疗1次,共针7次后停治,1个月后复查血压130/80mmHg。

九、泻阳亢为主 阴阳虚实兼顾

原发性高血压是常见病、多发病,而且治疗不易,危害性大。冯国湘近年应用针刺开“四关”加百会穴温针灸治疗此病,取得了一些成功的经验。

取穴:合谷、太冲、百会。

操作:取“四关”穴即双侧合谷、太冲,常规消毒后选用38

号, 1.5 寸的不锈钢毫针垂直刺入, 合谷穴进针 0.8~1 寸, 太冲穴进针 0.5~0.8 寸, 均施以提插捻转泻法, 中度刺激, 以患者有明显酸胀感, 但不难受为宜。每次留针 20min, 其间每隔 5min 行针 1 次, 持续 30s。百会穴针刺时常规消毒, 选用 0.5 寸毫针垂直刺 1~2 分, 再选用市售的华佗牌艾条切成的小艾条段 (长 1.2~1.5cm), 套于针柄之上, 用火从近体端点燃, 燃完后再换 1 段, 每次共 3 段, 灸至火灭后取针, 每天 1 次。

原发性高血压以头痛、眩晕为主要症状, 中医学将其归属于“头痛”、“眩晕”等范畴进行研究诊治。该症多由肝肾亏虚、肝阳上亢等因素所致, 特点为上盛下虚、本虚标实, 而以标实为主。因此, 治当阴阳虚实兼顾, 而以泻阳亢为主。针刺开“四关”就是采用泻法针刺左右合谷、太冲 4 穴。合谷为手阳明大肠经原穴, 而阳明经为多气多血之经, 泻此穴能达到泻阳明而泻全身偏盛之气的目的; 太冲为足厥阴肝经原穴, 泻此穴能直泻肝阳而清头目、降血压, 故开泻“四关”可开通气血、上疏下导、整体与局部并重, 使气血复归平衡。百会穴位于头顶部, 为人体诸阳之会, 温针灸此穴具有调整阴阳的作用, 气血阴阳平衡协调, 则血压归于平稳正常, 头痛头晕等症状缓解而病获愈。

十、针药并用 控制血压

何添旺采用针刺和穴位贴敷治疗高血压, 获得了很好的疗效。

(1) 针刺

主穴取人迎, 用 32 号 1.5 寸毫针, 刺入 1 寸左右, 配穴取神门、三阴交, 留针 30min, 用平补平泻法, 每隔 5min 捻针 1 次。每日 1 次, 6 次为 1 个疗程。

(2) 药物贴敷

药物组成: 桃仁 24g, 杏仁 24g, 夏枯草 20g, 水蛭 6g, 糯米 2g, 白胡椒 1g。上药共研成细末, 分为 6 天量, 每晚睡前用鸡蛋清调成糊状, 贴涌泉穴, 左右交替贴药, 以胶布固定, 晨起去掉药糊, 清水洗净, 贴药处皮肤呈青紫色。连贴 6 次为 1 个疗程。血压降至正常, 可再巩固治疗 2 疗程。

针刺配合药物外敷可疏通经脉、行气活血、调脾胃、补肝肾、

理气通脉、宁心安神。涌泉穴为肾经井穴，药贴通过该穴，可行滞气、通心窍、行气活血、清泄三焦火邪，而使血压下降，控制在正常范围。

张某，男，汉族，65岁，农民。头痛，头晕2个月，在其他医院确诊为高血压，治疗1个月无效，于1997年1月5日来针灸科就诊。刻诊：头胀，头痛，晚上不能入睡，血压195/120mmHg。经针刺贴药3天，血压降至135/90mmHg，症状减轻。治疗6天后血压130/85mmHg，无头晕、心悸等症状，睡眠如常。巩固治疗15天，随访6个月未复发。

十一、辨病辨证相合 平衡阴阳

殷之放以辨证结合辨病的方法针刺治疗原发性高血压病，取得了较好的疗效。

取穴：风池、曲池、足三里、三阴交。肝阳上亢者配太冲，肝肾阴虚者配太溪，痰湿内阻者配丰隆。

操作：风池、曲池用捻转泻法为主，足三里、三阴交用平补平泻法，太冲、丰隆用泻法，太溪用补法。在肢体二侧同名穴位上施行补泻时，用双手左右对称操作。留针30min，其间运针约2min。隔日针刺1次，6周为1个疗程。

高血压病属中医“头痛”、“眩晕”等范畴，其分型多见肝阳上亢，也有部分痰湿内阻和气血不足型患者，主要病机为肝肾阴阳失调，遵循“盛则泻之，虚则补之”的基本原则，选取风池、太冲平肝潜阳通络；三阴交、太溪益肝补肾滋阴；丰隆和胃化痰利湿；曲池、足三里引血下行、舒张血管，可抑制非条件血管收缩反射，诸穴合用，辨证和辨病相结合，既能发挥中医“调整机体阴阳失调”的作用，又能改善周围动脉阻力与心排血量间的失衡，局部与整体兼顾，从而获得疗效。

十二、针药并用 调补阴阳

骆书彦用针灸结合中药对辨证为阴阳两虚型的高血压病进行治疗，取得较好的结果。

取穴：肾俞、关元、命门、太溪、太冲、太白、太渊、神门。

操作：①针刺肾俞、命门，深度1.5~2寸，加灸。②灸关元；针刺太溪、太冲（1~1.5寸）；针刺神门、太白、太渊（避开动脉），深度0.5寸左右。①、②两组交替进行，每天1次，连续针刺30天。同时合用独参汤（偏阳虚者用人参，偏阴虚者用西洋参），每日10g，煎汁，分3次口服。

因高血压病的中医病理基础是肝肾阴阳失调，西医发病特点是重要脏器的损害。综合中西医的发病特点，骆书彦认为本病阴阳两虚的根本病因是以上原因中的脏腑受损，以五脏功能减退为主，尤以肾阴阳两虚为甚。遵循“治病求本”的原则，对原发性高血压的阴阳两虚应以调补五脏来调补阴阳。调补五脏者取其原穴，即“五脏六腑之有疾者，皆取其原也”。肺原太渊亦气会，取之针刺益气生脉。针灸肾俞（足太阳膀胱经穴）、命门（督脉穴）、关元（任脉穴）以温补肾阳，培元固本。诸穴使用，调补五脏，充养肾之精气，培元以固本，达到调补阴阳的作用。独参汤益气养阴以助阳，加上上述针灸作用，其调补阴阳效力尤显，阴阳两虚诸证得以明显改善。

十三、刺方氏头穴 灵活加减

在十几年的临床实践中，方云鹏用自己发现的头皮针穴治疗高血压病数万人次。不论年龄大小，病程长短，不管是按西医诊断分期和中医分型，降压疗效均很显著，对患者的心脏、血脂的作用，对眼底的影响均有不同程度的改善，对高血压病各种症状也有明显的效果。

取穴：

（1）书写 以冠矢点（冠状缝与矢状缝交点）为顶点，向左、向右各划一条线与矢状缝成45°夹角，在此两线上距冠矢点3cm处。

（2）呼循 风池内上方，枕骨外粗隆尖下5cm旁开4cm处。

（3）思维 印堂直上3cm处。

（4）听觉 耳尖上1.5cm处。根据患者的症状，灵活配以伏象或伏脏。

操作：快速进针，不捻转，达骨膜。留针30min，中间行针1次。每日针刺1次，10次为1个疗程，连针5次，休息2天，再针5次。疗程间隔3~5天，此间停用一切降压药物及其他治疗。每次取

3~4个主穴，配穴1~2个。

张某，男，65岁，干部。1984年8月23日就诊。患高血压已10多年。经常伴有头晕头痛、失眠、心慌、耳鸣、面部浮肿，西医诊断Ⅲ期高血压。曾长期服用降压灵、罗布麻、地巴唑等药。检查：血压200/100mmHg，血液胆固醇250mg%，甘油三酯205.7mg%，心电图检查心率不齐、提示心肌劳损。中医辨证：属阴阳两虚型。取思维、呼循、听觉，配伏象背部，针刺30min后血压为180/116mmHg。以后以取思维、书写、呼循、听觉、伏象头部为主，酌配伏象背部、伏脏上焦等穴，经1个疗程的治疗，血压降为140/90mmHg，头晕头痛、心慌、失眠等症状消失，自我感觉症状很好。3个疗程结束血压一直稳定在正常范围内，诸不适症状消失。复查血液胆固醇176mg%，甘油三酯150mg%，心电图正常。后一直未服任何药物。于6个月、8个月、1年时随访复查一切正常。

十四、穴位按摩 调和阴阳

葛培基根据中医“平肝熄风”的理论，选择有关经络穴位，通过按摩手法，可以反射性地调整微血管的舒缩作用，扩张毛细血管，降低外周阻力，解除脑部小动脉痉挛，疏通气血，调和阴阳，引血下行，从而达到降压的目的。对高血压病有明显的预防和治疗作用。

穴位按摩降压法简单易学，效果明显。一般按摩后10~20min，收缩压可下降10~20mmHg，舒张压可下降5~10mmHg。坚持每天穴位按摩2~3次，可起到降压、清脑、镇痛、宽胸、安神等功效，使血压保持稳定。

操作：

(1) 按揉太阳 有疏风解表、清脑、明目、止头痛功效。以左右手指罗纹面，紧贴眉梢与外眼角中间向后约1寸凹陷处，按太阳穴，向前向后旋摩各16次。

(2) 按摩百会 有降压、宁神、清脑之功效。用左手或右手掌紧贴百会穴旋摩一周为1次，共32次。

(3) 按揉风池 有安神、清脑、除烦之功效。以双手拇指罗纹面按揉两侧风池穴，旋摩一周为1次，共32次。

(4) 摩头清脑 有舒筋通络、平肝熄风、降压、清脑之功效。

用两手五指自然分开，用小鱼际从前额向耳后分别按摩，从前至后弧线行走为1次，共32次。（包括眉冲、印堂、头维、率角、耳后降压沟等穴）

（5）擦颈降压 有解除胸锁乳突肌痉挛、降压之功效。先用左手大鱼际擦抹右颈部胸锁乳突肌、再换右手擦左颈，共32次。（包括大迎、扶突、人迎等穴）

（6）揉曲池降压 有清热、降压之功效。先用右手再换左手先后按摩肘关节、肘尖凹陷处曲池穴，左右各16次。

（7）揉内关宽胸 有舒心、宽胸之功效。先用右手大拇指按揉左手内关穴，然后用左手按揉右手内关穴，旋揉一圈为1次，左右各16次。

（8）按揉足三里 有健脾和胃、导血下和之功效。分别用左、右手拇指按揉左、右足三里，旋摩各16次。

注意事项：①按摩穴位要准确，手法要适当，以局部酸胀、皮肤微红为度。每日操作2次。要持之以恒。②如穴位处患疮疖等，待治愈后再按摩。③穴位按摩适宜于Ⅰ期、Ⅱ期高血压患者。重症患者仍须配合药物治疗。

陈某，男，52岁，工人，患高血压病已十余年。经西医诊断：Ⅱ期高血压病。最高血压184/120mmHg，头晕目眩，于1978年4月来院治疗。经采用穴位按摩降压法，头晕目眩好转。经一年多的坚持穴位按摩，血压逐渐稳定，药物已停服。

参 考 文 献

- [1] 刘永久.“上中下”3穴治疗高血压37例观察. 江西中医, 1995, 26 (4) 58~59
- [2] 王岫. 辨证分型针刺治疗高血压病95例. 中国针灸, 1996, (11): 7
- [3] 吴广伟, 林矛, 陈志斌. 耳尖放血治疗高血压306例. 上海针灸杂志, 1997, 16 (2): 21
- [4] 黄效增. 温针灸足三里穴治疗高血压病. 山西中医, 1994, (6): 38
- [5] 邢孝民, 黄志华, 房玉珍. 平肝潜阳针法对原发性高血压患者甲襞微循环的影响. 中国临床康复, 2005, 9 (7): 106~107

- [6] 谢云. 针刺耳压治疗原发性高血压病临床观察. 中国针灸, 2000, (6): 335 ~ 336
- [7] 曾碧梅. 耳穴贴压治疗高血压病 150 例临床总结. 湖南中医杂志, 1996, 12 (3): 11 ~ 12
- [8] 李灵毅. 针刺扶突穴治疗高血压病 31 例报告. 青岛医药卫生, 2002, 34 (5): 377
- [9] 冯国湘, 吴清明. 针刺开“四关”加百会穴温针灸治疗原发性高血压的临床研究. 中国针灸, 2003, 23 (4): 193 ~ 195
- [10] 何添旺. 针刺配合穴位贴敷治疗高血压 89 例. 中国针灸, 1998, (11): 678
- [[11] 殷之放. 针刺治疗高血压病疗效观察. 四川中医, 1994, (9): 52 ~ 53
- [12] 骆书彦, 金宣菊. 针灸结合中药治疗原发性高血压病 (阴阳两虚型) 30 例. 国医论坛, 2004, 19 (5): 17 ~ 18

【 癲 癇 】

癲癇，俗称羊癇风，是一种呈发作性精神异常的疾病，其特点为病人突然倒地，人事不省，全身抽搐，感觉异常或行为紊乱，常反复发作。

中医学认为，本病多由惊恐郁怒，火气挟痰，横窜经络，上蒙清窍，致使阴阳发生一时性的逆乱而成，或因外感六淫，大病亏虚，病及清窍所致，也有由于先天因素，先天肝肾阴血不足，肝气逆乱，神不守舍。以及外伤等因素。

现代医学将其分为两类：一类是原发性癲癇，病因至今尚不清楚；另一类是继发性癲癇，又名症状性癲癇，是由其他疾病引起的癲癇。

现代医学对本病尚无根治方法，长期、联合用药，其不良反应又往往令患者不能忍受。而针灸、中药等疗法，其疗效据统计与现代医学疗法的疗效相仿，且无副作用，故此具有一定的优点。

本篇收录了多位专家对该病的治疗经验，有的采用埋线法，有的采用皮内针、三棱针点刺、头皮针、小针刀等，方法多样，取穴灵活。总之，异彩纷呈，各具特色。

一、药线埋植 辨证取穴

癫痫在临床上反复发作，症状多难以控制，属疑难病，符冰利用穴位埋线，通过局麻时的封闭效应，针具刺激效应及埋线渗血的刺血效应，以及羊肠线在穴位内长久的刺激作用，对五脏六腑的功能进行调整，从而从根本上治愈疾病，符合《内经》“深纳而久留，以治顽疾”的思想。

辨证取穴：主穴：①厥阴俞透心俞；②肝俞透胆俞；③脾俞透胃俞；④腰奇穴，癫痫穴。配穴：①风痫型配风门、大椎；②食痫型配足三里、梁丘；③痰痫型配丰隆、足三里；④血瘀型配膈俞、血海；⑤先天型配肾俞、肝俞。主穴每次交替选取，配穴辨证取穴。

操作：①先将铬制00羊肠线分别剪成1.5cm、2cm、2.5cm，各剪数条浸泡于安定液中1~2h后备用。②取背部穴位时嘱患者取俯坐位，取下肢穴位时，取仰卧位。③穴位皮肤常规消毒，以1%利多卡因在穴位处分别做浸润麻醉，造成局部约0.5cm直径的皮丘。④透穴及肌肉丰厚处选取较长羊肠线，肌肉浅薄处选取较短羊肠线，将羊肠线装入经消毒的9号腰穿针（针芯尖端已磨平）前端内，背部的穴位于穴位下方向上平刺，下肢穴位于穴位处直刺，过皮下后，捻转及提插穿刺针，当出现明显针感后边推针芯边退针管，使羊肠线埋入穴位皮下，线头不得外露，消毒针孔，外敷无菌敷料，胶布固定24h，每隔2周施治1次。

穴位埋线是集多种方法、多种效应于一体的复合性治疗方法。埋线后，肠线在体内软化、分解、液化和吸收的过程，对穴位产生的生理、物理及生物化学刺激可长达20天或更长时间，其刺激感应维持时间是任何留针或埋针法所不能比拟的，从而弥补了针刺时间短、疾病痊愈差、易复发及就诊次数多等缺点。该法治疗疾病的过程，初为机械刺激，后为生物学和化学刺激，具有短期速效和长期续效两种作用方式。局麻时产生的穴位封闭效应，针具刺激产生的针刺效应和埋线渗血时起到的刺血效应，是短期速效作用；埋线时肠线在体内特殊的留针和埋针效应及组织疗效效应，又可起到长期续效作用。肠线作为异体蛋白，埋入穴位后可使肌肉合成代谢增高，能提高机体的营养代谢，亦能提高机体应激能力，促进病灶部位血

管床增加,血流量增大,血管通透性和血液循环得到改善。

足太阳膀胱经“从巅入络脑”与脑相连,与脑有密切关系。背俞穴是足太阳膀胱经经气输注于腰背部的腧穴,具有反映内脏疾病和治疗内脏疾病的特异性能。督脉是人体诸阳经之总汇,“总督诸阳”为“阳脉之海”,上通于脑,下连诸经,系精髓升降之路,与脑、脊髓、肾有密切关系,故选督脉经穴大椎、命门以及经外奇穴癫痫穴,可振奋一身阳经之气,起开窍通闭,醒神回苏之功效。配穴中选取足三里为足阳明胃经之下合穴,用以健脾胃,化食滞,消积痰,是强壮要穴之一,可以通过补后天之本而培养先天之不足,起到治病求本的作用。配穴中取风门、大椎、丰隆以豁痰熄风,开窍定痫;取膈俞、血海以活血化瘀;取肾俞、肝俞以补益肝肾,主、配穴运用得当,疗效相得益彰。

二、皮内针埋植 配以耳穴

癫痫是一种慢性脑部疾患,其特征是脑部神经元过度放电所致的突然、反复和短暂的中枢神经系统功能失常。丁习益认为癫痫是顽固性疾病,必须接受长时间治疗。为了使患者能够在此期间持续接受针刺治疗,临床上采取皮内针穴位埋植法进行治疗。

皮内针穴位埋置法:①厥阴俞(双)、膏肓俞(双)、督俞(双)、肝俞(双);②灵台、心俞(双)、脾俞(双)。皮内针留置1星期,每星期1次,两组交替使用。

耳穴贴压:皮内针治疗后发作减少或控制后,在减服抗癫痫药时使用;或病情反复,需加强针效时使用。取神门、肝、肾、皮质下、心,每周3次,两耳交替,每天2~3次,按压耳穴,每次15~20min。

皮内针埋置穴位是最轻微的刺激治疗,不产生酸胀重麻等感觉,但较有效,易为众多慢性病患者接受,在取效后,要巩固疗效,需要保持持续刺激,故不设疗程,为长期治疗一些慢性病、顽固性疾病提供了某些实践经验。

三、三棱针刺长强 通调阳气

郑作桢在临床上采用三棱针刺长强治疗癫痫,疗效显著。

治疗方法：取长强穴，嘱患者俯卧膝胸位，在其尾骨尖与肛门中间处取穴。然后予碘酒或75%酒精棉球消毒，取消毒后的三棱针刺入，沿尾骨向上直刺1.5寸，不捻针，留针3~5min出针。隔2天针1次，10次为1个疗程。每2个疗程之间停针7天。

督脉总督一身之阳，在经络循行中与脊髓、脑相联。长强穴是督脉的首穴。针刺之，能调整全身的阳气和治疗髓脑疾患，用于治疗癫痫，在治疗中发现敏感度强，其病轻，疗效好；敏感度弱，病情重，疗效差。一般在发作期间对针刺不敏感，以后随着病情好转会转趋敏感。

黄某，男，18岁。1984年6月11日诊。12岁时曾因头部受击而发癫痫，发作时昏不知人，并发出类似羊叫声，过10min左右才能苏醒。以后劳累后即频繁发作，服苯妥英钠、维生素B，有好转，1~2个月发1次。今日中午又突然昏厥不省人事，口吐涎沫，遗尿，10余分钟后苏醒。自述头部昏胀，不思饮食，全身乏力。舌淡苔薄、边有齿痕，脉象沉弦而涩。证属血盛阻络所致之癫痫。遂针刺长强，隔2天1次，连续2个疗程，未再发作。1年来随访2次，未见复发。

四、头皮针平刺 益肾健脑

李效芳在临床上采用头皮针治疗癫痫，疗效显著。

取穴：为额中带、额顶带后1/3、顶枕带中1/3为主。

操作：患者端坐，局部常规消毒后取30号毫针与头皮呈30°角快速刺入头皮下，进入帽状腱膜下层后将针体放平，继续捻转进针刺入1~1.2寸，捻转每分钟达200次，行针3min，同时嘱患者闭目，全身放松，设想有气直达患处，医者也应将注意力集中在行针的指端，有意识地将针感向患处引导，其中额中带、顶枕带中1/3由上向下刺，额顶带后1/3由前向后刺，用小幅度提插泻法，行针时用手轻叩击患者头部，留针4h，隔日1次，10次为1个疗程。

癫痫多由于肾亏脾虚、痰浊内生、上犯清窍，久而作痫，若反复发作正气渐衰，痰结日深，愈发愈频，愈频愈虚。其病位在脑，中医认为脑与督脉和足太阳膀胱经关系最为密切，额中带、额顶带后1/3、顶枕带中1/3均属督脉与膀胱经穴带，不但有镇静安神之

功,还有益肾健脑作用,且医者有意识的将针感引向患处,达到气至病所的目的,故对癫痫发作有较好地控制作用。

刘某,男,12岁,学生,1997年6月初诊。现病史:5年前因惊吓突然昏倒,不省人事,牙关紧闭,口吐涎沫,两目上翻并直视,手足抽搐,小便失禁,数分钟后恢复,以后时有发作,遇精神刺激、劳累则发作频繁,近1年来病情加重,严重时1天发作1~2次,1次持续30min左右,醒后头痛、神疲。经某省医院诊断为癫痫,服用苯妥英钠、谷氨酸等药治疗,服药期间约每周发作1~2次,因记忆力明显减退、头昏,不能坚持上课,遂停药来用针灸治疗。患者面色萎黄,神疲乏力,食欲不振,舌淡苔薄,脉弦滑无力,用上述方法治疗后精神明显好转,治疗1个疗程后,癫痫基本控制,2个疗程后,记忆力明显恢复,体质逐渐增强,可坚持上课学习,共针治3疗程,未见癫痫发作,随访半年疗效巩固。

五、发作与间歇 刺络以放血

喻喜春用刺络放血治疗癫痫,每收良效。

发作时:取百会、人中、十宣、足十二井,用细三棱针点刺挤血各0.5~1ml。如抽搐不止,在数分钟内可重复刺络,以止为度。

间歇期:以下配方任选一种。

(1) 龈交,用细三棱针点刺出血5~10滴;百会,用细三棱针点刺后挤血1ml。长强,用细三棱针点刺后挤血0.5~1ml,如挤血有困难时,可刺尾骨尖上方、腰俞穴之下,用火罐拔血1~3ml。

(2) 取百会、大椎、肝俞,皆用细三棱针,点刺3针,百会挤血0.5~1ml,大椎、肝俞各拔罐吸血3~8ml。

(3) 取百会、委中,将百会放血0.5~1ml;在委中或在腘窝找出明显络脉,刺血或抽血各10~12ml。

(4) 取承浆,用细三棱针点刺出血0.5~1ml,舌下络脉各点刺出血2~6ml。中脘、关元用细三棱针点刺后拔罐吸血各3~5ml。

间歇期每周放血2~3次,10次为1个疗程,连续治5~8个疗程。

林某,男,22岁,会计。1986年10月7日就诊。自诉15年前无明显原因的开始全身抽搐,口吐白沫,小便有时失禁,不省人事

等症状，每周发作3~10次，每次持续2~10min，缓解后头痛嗜睡。脑电图证明为癫痫大发作，CT检查颅内无占位性病变。检查：神智正常，但忧郁少言，心肺肝脾无异常，脉弦细，苔白薄，检查时该病发作，持续6min后缓解。治宜调理阴阳，平肝熄风。按配方2针刺放血，每周3次。2周后，每天发作2~4次，持续1~2min。又治8周，观察3个月，共发作5次，每次1~2min，自觉精力转佳。

六、小针刀配拔罐 辅以埋线

癫痫病是临床常见的疑难病证。孙仁平采用小针刀拔罐加埋线进行治疗，通过其产生的生物化学刺激，实现生理平衡，从而达到治疗疾病的目的。

(1) 针刀疗法

取穴：身柱、至阳、脊中、腰阳关、长强。

操作：身柱、至阳、脊中、腰阳关均向上斜刺0.5~1.0寸；长强穴紧贴尾骨前面斜刺0.8~1寸。治疗时在所取穴位上用甲紫作标记，局部常规消毒，刀口线与肌肉纵轴平行，在针刀柄上加一定压力，使皮肤形成凹陷，令病人叹气后，加压迅速刺入皮下，待得气后作纵行疏通和横行剥离，再连续顺时针方向旋转针刀3~5圈，然后摇大针孔并令患者呼气，同时缓慢挑割肌纤维并逐渐退出针刀。再用2号玻璃火罐拔施术处，吸出约1~2ml血。消毒后用创可贴固定每周1次，5次为1个疗程。

(2) 埋线法

取穴：第一次取大椎、足三里；第二次、第三次各用一侧心俞透督俞、肝俞透胆俞、肾俞透气海俞；第四次取腰奇、鸠尾；第五次取丰隆。

操作：①在穴位处用甲紫做标记，常规局部消毒。②标记处用2%利多卡因局部麻醉。③捏起两针孔之间的皮肤，用持针器夹住带羊肠线的缝针，于一侧局麻点刺入，从对侧穿出，放松皮肤，紧贴皮肤剪断羊肠线，无菌纱布块敷盖3天。每周治疗1次，与针刀疗法同步。

中医学认为该病是因脾肾湿聚成痰或情志刺激，肝郁不疏，导致肝、脾、肾等脏器失调，骤然阳升风动，痰气上涌，闭阻络窍而

致突然发病。采用丰隆、心俞透督俞、肝俞透胆俞、肾俞透气海俞行埋线术，可起到调和肝脾肾，熄风祛痰之功。身柱、至阳、脊中、腰阳关和长强穴均属督脉，督脉通于任脉，能调理一身阴阳，还具有上通元神，内和五志之效。癫痫病多为实证，针刀疗法结合火罐拔吸具有强大的泻力，因而可以迅速控制症状。鸠尾为任脉经穴，大椎是诸阳脉交会穴，配足三里有平调阴阳逆乱之功。腰奇穴是治疗癫痫的经验穴，与鸠尾配用，效果较好。

七、穴位埋线 息风涤痰

癫痫，是脑部兴奋性过高的神经元反复过度放电引起的阵发性大脑功能紊乱而产生的一组临床综合征。它具有三个特点：突然性、暂时性、反复发作。属中医学痫证范畴，其病机可概括为脏腑功能失调，经络气机逆乱，风痰上扰神明。任桂华采用穴位埋线治疗，收效较佳。

取穴：大椎、心俞、鸠尾、丰隆。

操作：用9号注射针针头作套管，28号2寸长的毫针剪去针尖作针芯，将00号已消毒的约1~1.5cm长的羊肠线放入针头内。穴位局部消毒后，术者左手拇指、食指绷紧进针部位皮肤，右手持针，刺入到所需深度，大椎直刺1寸，心俞向脊柱方向斜刺1寸，鸠尾向上斜刺1寸，丰隆直刺1.5寸，当患者出现针感后，边推针芯，边退针管，将羊肠线埋植在穴位的皮下组织或肌层内，出针后，针孔处敷盖消毒纱布，用胶布固定。每月埋线1次，3次为1个疗程。

脑为“元神之府”，与任、督二脉及足太阳膀胱经关系密切。故取督脉之大椎穴最善调节经络气机逆乱，为通络解痉之要穴；任脉之鸠尾为治癫痫之要穴，具有平衡阴阳、定痛安神之功；心俞为心之背俞穴，乃心之经气出入之所，有开心窍，宁心神之功；丰隆有和胃府、化痰浊之功；上穴同用，共奏抑制脑内兴奋灶、息风涤痰、平衡阴阳、宁神安腑之作用，这就有效地控制了癫痫的发作。在穴位埋线的治疗过程中，即包括了针刺的机械刺激作用，又因羊肠线作为一种异性蛋白，在人体内经过逐渐液化吸收，对腧穴产生一种持久而柔和的刺激作用，抑制和干扰大脑组织的异常放电，具有良性调节作用。

张某某，男，21岁，1994年3月21就诊。6岁时跌伤头部，半年后出现阵发性昏仆抽搐，且发作次数逐渐频繁，后因长期服用苯妥英钠等抗癫痫药而不能控制其发作。来诊时每月发作数次，每次发作前先大叫一声，继而倒地抽搐，双目上吊，口吐白沫，约持续1~2min才能缓解。查体：神志痴呆，头面可见多处伤痕，语言呆板，舌体胖有齿痕，苔白腻，脉滑，脑电图呈异常波形，遂按上法埋线治疗，第一次埋线后1个月内仅发作2次，连续治疗3次后再未发作，脑电图亦转正常。

八、针刺华佗夹脊 重调脏腑气机

癫痫，俗称“羊羔风”，又名痫证，是一种发作性神志异常的疾病。该病多由于痰浊壅盛，肝内风动所致，孟兰成认为治本病首先应调理脏腑气机，脏腑和顺经脉得以濡养，痰自无产生之源。

取穴：主穴为华佗夹脊穴，配穴选丰隆、风府、人中，再根据不同兼证适当配刺相应穴位。

操作：常规针刺，采取平补平泻，隔日1次，10天为1个疗程，每疗程休息3~5天再接第二疗程。

华佗夹脊穴属经外奇穴范畴，位于背部督脉两侧，又位于诸脏腑俞穴的旁侧。督脉主一身之阳，针刺华佗夹脊穴既调督脉之经气，又可调诸脏腑之气机，使得脏腑气机和顺，而痰自灭，疾自愈。配穴风府则取其既可祛风解痉，又可醒脑开窍；其余穴位可随症加减，手法选用平补平泻旨在疏通。

范某某，女，6岁。4岁时由于惊吓发病抽搐，后逐渐形成癫痫，隔3~5天发病1次，发作时无明显诱因，嚎叫一声突然跌倒，四肢抽搐，吐涎，小便失禁，苏醒后面色苍白，浑身无力，曾经中医西医等多种方法治疗效果不明显。治疗前令其停用其他治疗方法，首先针刺华佗夹脊，至上而下，依次应用平补平泻手法，捻针10min。配穴选风府、风池、丰隆、阳陵泉，行针20min，隔日1次。1个疗程后症状几乎消失，只是偶有小作，3个疗程后未再复发，随访1年基本康复。

九、针刺为主 配神阙敷贴

孙曙霞采用针刺配中药外敷贴脐治疗痫证，常收效验。

(1) 针刺疗法

取穴：发作期取水沟、腰奇、后溪；间歇期取大椎、间使、丰隆、百会。

操作：水沟以1寸毫针向鼻中膈方向刺入0.5~0.6寸，强刺激。腰奇穴以2~2.5寸毫针刺入2寸左右。后溪刺入1~1.5寸，留针至患者抽搐停止，神志清醒。中间每隔5min行提插与捻转相结合的强刺激泻法1次。间歇期诸穴以常规刺法，每天1次，10次为1个疗程，疗程间休息3~4天，连续治疗8~10个疗程。对于癫痫小发作的患者，可根据情况配合针刺发作期的穴位。

(2) 穴位敷贴

取穴：神阙。

操作：吴茱萸1.5g为细末，填入肚脐凹陷之中，上以胶布覆盖。贴敷5天后将药物去掉，用温水把肚脐洗净，休息1天，再以上法贴敷。贴敷1个月后可延长贴敷间隔时间。连续贴敷5~6个月。

癫痫多因脾胃素虚，湿痰内盛，痰邪上蒙清窍，或肝气抑郁，脏气失调，阴阳逆乱而致。督脉为阳脉之海，其循行从风府入脑，腰奇虽属奇穴，但位于督脉上，后溪通于督脉，发作时取水沟、腰奇、后溪三穴调督脉，熄风醒脑而开窍。间歇期刺大椎、百会平调阴阳之逆乱，间使系孙思邈十三鬼穴之一，化痰浊而清神志，配以祛痰要穴丰隆以治其本。

神阙穴位于中、下两焦之处，借助于吴茱萸的芳香温中，既可和中焦理脾胃以祛生痰之源，又可温化痰湿而解病本。临床发现有些患儿仅用此法不仅可有效地控制癫痫的发作，而且饮食增加，体质也得到了改善。

十、通督开窍 醒脑安神

癫痫是一种突然发作的暂时性大脑功能紊乱疾病，常反复发作。刘吉吉认为本病根本原因在于督脉功能失常，元神失守所致。采用针刺通督法治疗本病，疗效满意。

取穴：百会、风府、腰俞、后溪、申脉。随证加减：肝气郁结加行间、太冲，痰涎壅盛加丰隆、间使，心神不宁加内关、神门，妇女经期去腰俞。

操作：百会向后平刺1寸，风府直刺0.5~0.8寸；针腰俞时，先向上以45°角浅刺入皮下约2分许，然后向上平刺，深入骶管裂孔2~3寸，使针感沿督脉向上传导；后溪、申脉直刺0.3~1寸，余穴均刺1寸许，要求针后有得气感。发作时以泻法强刺激，缓解时以平补平泻法弱刺激，留针30min，间歇行针2~4次。发作期每日治疗1次，缓解期隔日1次，10次为1个疗程。

督脉与脊髓、脑密切相关，是精气上注于脑的通路，它具有督元阳、充髓海、养元神之功能。故督脉为病，则“大人癫疾，小儿惊痛”。百会位于巅顶，属督脉与足太阳经及足厥阴经之会穴，有镇静安神之功，风府位于项后，督脉上行至此而入脑，功擅醒脑开窍、祛风豁痰；腰俞属督脉而位于骶管裂孔中，具有通调督脉、镇惊止痛之功，取后溪、申脉为八脉交会穴，通于督脉，取之以激发督脉气血，调节阴阳而可开窍醒脑，安神止惊。如《拦江赋》说“后溪专治督脉病，癫狂此穴治还轻。”以上诸穴合用，共奏佳效。

十一、辨证分型 从阳引阴

殷之放运用老中医金舒白研究员之经验，宗明代高武“善用针者，从阳引阴，从阴引阳”之说，以调整阴阳为施治大法，按不同类型及其临床表现，辨证分型，在督脉经上选取主要穴从阳引阴，并根据患者情感变化，辅以心包经内关或间使穴，或再在其他有关经络的“五输”、“原”、“络”穴中各取一、二配穴以协调阴阳，补虚泻实，理气化痰，宁心安神。

(1) 痰气郁结

取穴：神聪（轻刺）、风府、内关、丰隆，痴呆加通里。

操作：神聪穴在百会穴前后左右各1寸，齐向百会穴透刺，少留针；风府穴直刺0.7~1.0寸，徐进疾出；内关穴多捻转。

本证由于心脾痰气郁结所致。故取癫证之效穴神聪穴以醒脑开窍，扬清润浊；“阳脉之海”督脉之风府穴从阳脉引泄阴邪，以调气通阳，宁神疏经，心包之络内关穴以宁心宽胸，理气化痰；胃经之

络丰隆穴和胃化痰，运脾利湿。痴呆加通里穴以定志安神解郁。

(2) 心脾两虚

取穴：风府、印堂透心区（轻刺）、内关、三阴交，幻视加睛明，幻听加听宫，幻嗅加迎香。

操作：印堂穴向下心区，宜轻宜浅。

本症由于心脾气血两虚所致。故取督脉之风府穴以通阳利气，镇惊宁神；癫证效穴印堂穴透心区以调气醒脑，宁心安神，心包之络内关穴以养心和胃，理气疏郁；足三阴之会三阴交穴以健脾疏肝，益气理血。幻视加睛明穴以明目定睛宁神；幻听加听宫穴以聪耳通窍安神，幻嗅加迎香穴以通鼻利窍散风。

(3) 阴虚火旺

取穴：印堂透心区、间使、三阴交，不寐加神门，体虚取内关（或间使穴和内关穴交替运用）。

本证由于心肝阴虚炼痰所致。故取癫证效穴印堂透心区以安神醒脑，宁心解郁；心包之经穴间使以清心除烦，祛痰镇惊。足三阴之会穴三阴交以健脾疏肝，滋阴宁神；不寐加神门穴以养心安神益阴；体虚取内关穴以养心和胃益气。

崔某，女，29岁。1985年10月19日初诊。家属陪诊：患者自幼性格内向，结婚二年未孕引起心中不悦，三日来未曾安寐，常多思心慌，坐立不安，夜寐不宁。精神病院诊断为“精神分裂症”。来诊时精神紧张，神志恍惚，悲伤欲哭面色苍白，时感心悸，胃纳尚可，二便无异，苔黄质淡，脉象细滑。证属心脾两虚，心神失养，中医诊断为“癫证”。治拟健脾养心，理血安神，取穴：风府、内关、三阴交，针刺手法以捻转补法为主，隔日治疗1次，留针30min，每10min行针1次。针刺治疗后，即停服西药，至五诊时，主诉渐清楚思维有层次，态度礼貌，尚能合作，夜寐亦安，惟时有紧张多思，苔薄质淡，脉象细濡，仍守前法。诊至第十诊，诸症明显改善，恢复工作。继续治疗1个疗程（10次）以巩固疗效。停针后二年未发。

十二、副哑门—腰奇 毫针深刺

王天才采用深刺副哑门、腰奇二穴治疗癫痫，疗效显著。

取穴：副哑门（属经外奇穴，位于项部正中线，后发际中点直下5分处， $C_2 \sim C_3$ 棘突间）、腰奇穴（属经外奇穴，位于骶部，尾骶骨尖端直上2寸，在第二、第三骶椎棘突之间）。

操作：①副哑门穴：嘱病人骑坐椅上，头部下垂，按法取穴。常规消毒，垂直进针，针尖向喉结方向由 $C_2 \sim C_3$ 棘突间深刺2~3寸，患者有肢体抽动或叫声即起针，针刺时以X线正位、侧位拍摄，证明已刺入脊髓。②腰奇穴：嘱患者俯卧床上，按法取穴，常规消毒，将皮肤用手提起，直刺3分，再沿皮往上刺2.0~3.5寸，然后大幅度捻转，患者自感酸麻感向上扩散至后头部，留针20min起针。

《内经》“督脉为病，脊强反折”。即一些惊风抽搐的疾病，源于督脉。督脉经气不通，势必造成阴阳平衡失调，因而出现颈项强直，角弓反张，甚至抽搐等症状。因此，医家治疗癫痫病针刺时多取督脉要穴风府、哑门，但这两个穴位皆是针刺禁地，深刺会发生致命、致哑的危险，浅刺又不能对中枢神经形成有效的刺激。选副哑门、腰奇深刺，安全系数高，容易形成有效刺激。

十三、独取督脉 穴分四组

脑为奇恒之腑，是一切精神活动的物质基础，督脉上通于脑，下至尾闾，系精髓升降之路，癫痫发病表现为督脉经气逆乱，波及元神之府，神明失职而出现暴仆神昏，牙关紧闭，四肢抽搐，口吐涎沫或发出怪声，所以探讨癫痫的病因、病机、治疗等方面，不能仅拘泥于痰、火、风等论点。孙书鸿以独取督脉经穴，按虚则补之，实则泻之，陷下则灸之的治疗原则来调理督脉，使清升浊降，气调髓和而收到良好效果。

选取督脉经穴四组：

一组：百会、风府、大椎。

二组：长强、腰俞、命门。

三组：人中、龈交。

四组：百会、长强。

操作：用28号针，进针得气后，一组穴位用捻转补法。二组穴位用捻转泻法，各留针30min，6次为1个疗程，停针1天继续针刺。第三组穴位，适用于病情发作时，用三棱针点刺出血。第四组

穴位,适用于体质虚弱及病程较长的患者,用灸条2支,上下对灸,灸至局部红润汗出,热透筋骨为度,每日1次,6次为1个疗程。

徐某,男,10岁,1964年8月15日初诊。患者于半年前高烧初愈,当夜11点钟其母发现患儿四肢抽搐,牙关紧闭,口吐涎沫,两目直视,呼之不应,约3~4min自然苏醒,醒后随即入睡,次日除精神不振外,别无不适,以后每日发病1~2次,严重时有遗尿,曾经某医院诊断为癫痫,服苯妥英钠、苯巴比妥以及内服中药,外用中药贴敷足心等法收效不著,查其发育营养一般,精神欠佳,四肢活动如常,脉短数无力,舌淡红,苔薄白。先取第二组穴位,进针得气后用捻转泻法,再针第一组穴位,进针得气后用捻转补法,各留针30min,经过1个疗程的针刺治疗,症状大为减轻,发作时间缩短,口吐涎沫减少,继续针刺以上两组穴位3个疗程,症状基本消失。此后隔日针灸1次,又治疗2个疗程未见发作。

参考文献

- [1] 符冰,李红.辨证取穴药线埋植治疗癫痫的临床研究.甘肃中医,2004,7(9):1~3
- [2] 丁习益.皮内针穴位埋置治疗癫痫36例.上海针灸杂志,1999,18(2):18~19
- [3] 郑作楨.三棱针刺长强穴治疗癫痫136例.浙江中医杂志,1995,(7):310
- [4] 李效芳,马志刚.头皮针治疗癫痫40例.中国针灸,2000,(8):475
- [5] 胡照明.针灸临证指南.人民卫生出版社,1991,358
- [6] 孙仁平,吴峰,邱凤翔,等.小针刀拔罐加埋线治疗癫痫病1000例体会.中国针灸,1999,(9)547~548
- [7] 任桂华.穴位埋线治疗癫痫50例.中医函授通讯,1998,17(4):37~38
- [8] 孟兰成.针刺华佗夹脊治疗癫痫的临床观察.中医药研究,1994,3:47~48
- [9] 孙曙霞.针刺配合药物贴脐治疗癫痫48例.上海针灸杂志,1997,16(1):13
- [10] 刘吉吉,王改梅.针刺通督法治癫痫36例体会.云南中医中药杂志,1994,(6):48

- [11] 殷之放. 针刺治疗癲证体会. 四川中医, 1997, 15 (3): 55 ~ 56
- [12] 王天才. 针刺副哑门、腰奇穴治疗癲病 139 例. 中国针灸, 1999, (9): 543 ~ 544
- [13] 胡熙明. 针灸临证指南. 人民卫生出版社, 1991, 367

【多动症】

儿童多动综合征又称注意力缺陷障碍多动综合征。主要临床表现为：患儿的智能正常，注意力不能集中，注意短暂，活动过多，情绪不稳定，学习困难，成绩较差。本病6~14岁儿童发病率较高，男孩为女孩的4~9倍，国内调查，约占学龄儿童的5%~10%左右。

本病的发病原因尚不明了，一般认为可能有遗传倾向。还可能与脑损伤诸如早产、中枢神经系统感染、中毒等有关。心理因素可能是诱因。中医学认为，本病由先天不足、肾精亏虚，心脾两虚、脑髓不充、肝阳上亢、元神受扰而致。

本篇收录了多位专家的治疗经验，有采用耳针、体针、火罐、头针、推拿等治疗方法进行治疗，从取穴上看，大多取头穴以及调补肝脾肾的穴位为主。针灸对本病有较好的治疗效果，在治疗期间，应帮助患儿培养良好的生活习惯，对不良行为要耐心教育，多加关怀和爱护，切忌打骂、歧视和不耐烦，以免患儿自暴自弃。学习困难者应予以指导、帮助，成绩有进步就予以表扬、鼓励，不断增强其信心。

一、针罐并用 收神制动

儿童多动症即儿童轻微脑损伤综合征，男

性明显多于女性。郅玉兰用针刺配合闪罐治疗儿童多动症，疗效肯定。

取穴：针刺取百会、四神聪、风池（电针）、三阴交（电针）。心脾两虚配神门，肾阴不足配太溪，肝阳偏亢配太冲（电针），痰火壅盛配丰隆。一次选2~3穴，轮换配取。闪罐取大椎、身柱、灵台、筋缩。心脾两虚配心俞、脾俞；肾阴不足配肾俞；肝阳偏亢配肝俞；痰火壅盛配肝俞、肺俞、脾俞。一次选4~5穴，轮换选取。

操作：针刺时多取仰卧位或仰靠坐位，头顶5穴选用0.5~1寸毫针，“飞针”刺入膻穴（即医者用带旋转手法快速准确地将短针刺入膻穴），一般进针时间在1s左右。其余穴选用1.5寸毫针，刺入膻穴1~1.5寸，留针20min。同时采用闪罐手法治疗，取中号火罐（内径4cm左右）以闪火法快速“吻”接背部膻穴皮肤后2~5s，然后立即倾斜拔起火罐，治疗膻穴可反复多次，以局部皮肤潮红发热为宜。每星期2次，8次为1个疗程（1个月）。

儿童多动症是轻微脑损伤综合征，中医学称之为“神散”，神又由心所属，心神的功能有赖于肾精的上输。而脑为元神之府，又由肾所主。郅玉兰认为要收神制动，首先要宁心安神，益肾充髓，调节心肾二脏为主。

针罐并用具有取穴少，且“飞针”进针速度快，疼痛感较小，患儿易于接受等优点。“飞针”快速刺入巅顶部的百会、四神聪，可使气血贯通上达巅顶。闪罐取穴多，刺激量大，疗效明显。

二、耳穴治疗 整体调节

张玉夫近几年来采用耳穴治疗小儿多动症取得较满意的疗效。

取穴：神门、心、脾、脑点、脑干、皮质下、肾、镇静、失眠等穴。

操作：针刺法：取双侧或单侧耳穴，每次选3~6穴，以中强刺激，留针3~7min或不留针，1~2天针刺1次，7~9次为1个疗程，疗程期间隔3~5天；耳压法：取单侧耳穴进行交替治疗，每2~3天换药1次，4次为1个疗程。配合家长诱导和启发式教育改变不良行为。

本病属中医学“神气失常”范畴。治宜养血安神、升清镇静、

调和阴阳，关键是穴准和坚持治疗。取神门、心、脾、脑干、脑点养血益阴，宁心安神；皮质下能升清利窍，有助于儿童时期的神经系统发育，调节大脑皮层的兴奋与抑制协调功能，以逐步建立新的行为；配肾、镇静、脾等穴可补益脾肾，安神宁心，调节多动、缺乏自制能力及无目的活动等症，通过诸穴刺激反射可改变既往所形成的不良动作，配合家长诱导和启发式教育以助塑造新的行为活动。

肖某，男，7岁，经常不自主挤眉眨眼，左肩关节频繁抽动，上课讲话、玩东西、撕书，影响课堂纪律，下课吵打和乱跳，不能完成家庭作业，诊为小儿多动症。经用药物治疗无显效。用耳穴探测仪找准穴位进行耳压1个疗程，患儿抽动和其他症状有明显减轻，共治3个疗程诸症消失而愈。访半年未发。

三、耳针加体针 平肝息风镇静

近年来，陈宗良采用耳穴加体针治疗儿童多动症取得了很好的疗效。

耳压：取2mm×3mm大小的胶布，粘上王不留行籽，贴在耳穴上，贴压前均用火柴头探压耳穴敏感点。若无明显的压痛点，取常规耳穴神门、心、肝、脾、脑、内分泌、肾上腺。每5天贴一侧耳部，5天后贴另一侧耳部，嘱每日自行按压耳部的穴位多次，10天为1个疗程。

体针：穴取风池（双）、太冲（双）、合谷（双）。常规针刺，每天1次，10天为1个疗程，中间休息5~7天。

多动症中医无此病名，根据临床表现类似“肝强脾弱”和肝风一证，与小儿病理特征的“肝常有余，脾常不足”的理论相吻合，因此临床中取四关穴，加风池和耳针的神门、心、肝、脾、肾上腺、内分泌等穴，以平肝息风、镇静，调节机体的平衡作用。耳穴贴压加体针治疗小儿多动症，是一种简便而有效的治疗方法，且没有毒性及不良反应作用，一般儿童都能接受治疗。但在治疗中，医生和家长必须配合心理治疗，耐心反复地进行教育，提高儿童的自信心。

李某，男，10岁，就诊时间1990年7月10日。家长代诉小孩在学校上课思想不集中，在家时东摸西动，手玩不停，乱动乱叫，上课时手不停地做小动作，老师看到他总是摇动头部，成绩很差，

要求针灸治疗。采用上法治疗 10 天后，有明显好转。摇头、手玩不停已好转，再作第三个疗程后，一切症状消失，年终学业成绩平均 70 分左右。随访几年一直正常，学习成绩优异。

四、推拿及耳穴贴敷 调阴阳

小儿多动症是一种常见的儿童心理及行为的异常，主要表现为与年龄不相称的多动、冲动、注意力分散。卓越采用推拿及耳穴贴敷治疗小儿多动症，取得较好疗效。

推拿：患儿仰卧位，医者食、中两指端按揉百会、四神聪各 1min；一指禅偏峰推法自印堂推向神庭，往返 3 次；中指指端按揉双侧太阳 1~2min；两拇指抹法自攒竹经眉上方至太阳，往返移动 5~7 次；中指端按揉气海、关元，每穴 1~2min；摩腹 5min；患儿俯卧位，捏脊 5~7 遍，拿颈项、拿肩井 1~2min。辨证取穴：肝阳偏亢加通天、风池；心脾不足加神门、内关、足三里；肾气不足加太溪、三阴交，以上各穴均用拇指端按揉法，每穴 1~2min。

耳穴贴敷：取穴：①心、肾、肝、脾、脑、内分泌、皮质下；②心、肾、肝、脾、脑、神门、交感、肾上腺。耳部常规消毒后，选用王不留行籽置于 1cm×1cm 的胶布上，并贴压在选取的耳穴上，①②组交替使用。耳穴贴敷完毕后要对贴敷处进行按压，力度不宜过大，以感到轻微疼痛、整个耳廓皮肤潮红发热为度，每日 1 次。

“阴平阳秘，精神乃治”，人体一切的生理及心理活动均是阴阳平衡的结果，“阴静阳躁”，“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”。说明若阴阳失衡，阴不制阳，动静变化失制，则可导致小儿的动静失调，阳动有余，而出现多动症状。小儿多动症的发病机制在于脏腑功能不足，阴阳失调，主要与心、肝、脾、肾四脏的功能紊乱有关，常表现为肝阳偏旺、肾气不足、心脾不足、心肝肾失调等证。卓越应用推拿疗法达到调节阴阳平衡、协调脏腑功能的作用，配合耳穴贴敷可以使治疗持久发挥作用。

五、针刺加耳穴 辨证施治

儿童多动症临床表现为智力正常或基本正常，但注意力不能集中，活动过多，情绪不稳，冲动、任性冒失、自我控制能力低，学

习成绩差，严重影响广大儿童的身心健康。刘丽采用针刺配合耳穴贴压的方法治疗本病取得了较好疗效，

针刺：主穴：百会、神庭、神门（双）。肝肾阴虚型配太溪（双）太冲（双）；心脾两虚型配三阴交（双）、足三里（双）；痰火郁结型配丰隆（双）、内关（双）。选定穴位后，常规消毒皮肤，以28号1寸不锈钢针针刺，用平补平泻法。每日1次，10次为1个疗程。

耳穴：主穴：神门、脑点、脑干、皮质下。肝肾阴虚型配肝、肾；心脾两虚型配心、脾；痰火郁结型配胃、三焦。选定穴位后，常规皮肤消毒，用0.5cm×0.5cm胶布将王不留行籽贴在上述穴位，每3天换贴1次，两耳交替。每天按压3~5次，每次2~3min，以耳廓微热、微痛为度。10次为1个疗程。

针刺百会可以平肝潜阳、健脑宁神；神庭、神门可以养心安神，针刺之可以加强百会的镇静安神作用；太溪、太冲可以滋阴降火、补益肝肾；足三里、三阴交能益气养血、安神定志；丰隆、内关能泻火涤痰、清心安神。诸穴配合，共奏调整阴阳之功。“耳者，宗脉之所聚也”，十二条经脉都直接或间接上达于耳，耳与脏腑不仅在生理功能上息息相关，而且在病理上也密不可分，选用相应的耳穴并用王不留行籽进行贴压，可以刺激中枢神经，调整大脑皮层的抑制与兴奋的平衡，加强对身体各部分的调节和管制功能，促进机体恢复阴阳平衡，阴平阳秘，疾病乃愈。

患儿，9岁，2004年5月25日初诊。活动过多，注意力不集中，任性，急躁，睡眠欠佳、多梦易醒，学习困难、成绩极差。查智力正常，舌淡苔薄白，脉细数。诊断：儿童多动症（肝肾阴虚型）。针刺取穴：百会、神庭、神门（双）、太溪（双）、太冲（双），选定穴位后，常规消毒皮肤，以28号1寸不锈钢针针刺，用平补平泻法，留针20min，每日1次。拔针后配合耳穴贴压，取穴：神门、脑点、脑干、皮质下、肝、肾，选定穴位后，常规皮肤消毒，用0.5cm×0.5cm胶布将王不留行籽贴在上述穴位，每3天换贴1次，两耳交替。嘱患者每天按压3~5次，每次2~3min，以耳廓微热、微痛为度。10次为1个疗程。治疗2个疗程后，患儿活动减少，睡眠好转，注意力较前能集中，自控能力增强，继续治疗1个疗程，

患儿临床症状、体征全部消失，学习成绩提高，随访半年无复发。

六、头针配中药 取效明显

肖达应用针药结合的方法对多动症患儿进行了治疗，取得理想疗效。

针刺：取头针的伏象头部（冠矢点前3cm）、思维（眉间直上3cm）、记忆（以人字缝尖为顶点，做两条与矢状缝成 60° 的直线，在两条直线上，距人字缝尖7cm处）、运平（以人字缝尖为顶点，作两条与矢状缝成 30° 的直线，在两条直线上，距人字缝尖5cm处）、信号（耳尖至枕外粗隆上3cm连线的中点）、呼循（枕外粗隆尖下5cm，左右旁开4cm处）、人字缝尖（正中中线枕外粗隆上约6.5cm处）、听觉（耳尖上1.5cm处）、视觉（枕外粗隆尖上2cm，左右旁开1cm处）和额五针（前额发际上2cm处，共刺5针，5针之间等距成扇行排列），伴动作协调缺陷者加书写（以冠矢点为顶点，作两条与矢状缝成 45° 的直线，在两条直线上，距冠矢点3cm处），针刺时顺毛发方向斜刺。体针取双侧风池、内关、合谷、太冲、三阴交，随症加减。以上穴位进针得气后留针30min，隔15min运针1次，每星期治疗2次，3个月为1个疗程。

中药：以养心安神，疏肝理气，补肾益精为治则，方用枕中丹和六味地黄丸加减，每日1剂。

多动症属中医学“健忘”、“失聪”范畴，本病的病机是由于心、肝、肾阴阳失调，以致阴静不足，阳动有余，临床多以虚证为主。肖达在治疗时，以取头部穴位为主，选取了颅脑各功能中枢的相应头穴，配合少量体针。诸穴相配，可改善大脑皮层的功能活动，调整大脑皮层的兴奋和抑制状态。并配以养心安神、疏肝理气、补肾益精之中药内服，可平衡脏腑的阴阳失调，增强患儿的体质。针药合用，内外同治，在功效上起到了互补和加强，因而取得了较明显的效果。

七、针刺加中药 宁心安神

小儿多动症，其发病原因医学界迄今尚无定论，有人认为与患者出生前后的轻微脑损伤、多种基因遗传以及代谢障碍等有关。张

中一采用针刺为主治疗本病疗效满意。

针刺：取穴：①百会、大椎、身柱、神道、筋缩、命门、腰奇、合谷、申脉。②印堂、鸠尾、气海、神门、阳陵泉、太冲、太溪。两组穴位交替进行，每次取1组，留针15~30min，各穴捻转运针2次，每次运针2~3min，每星期2~3次，10次为1个疗程。

耳压：取神门、心、肝、脾、肾、脑、交感，每次选3~5穴，用王不留行籽或磁珠贴压，左右耳交替。每隔2~3h掀压（以痛为度）1次，2~3天换贴，10次为1个疗程。

中药：如舌尖红，夜间盗汗，则辨为肾阴虚为主，以干菖蒲、天麻、五味子、枸杞子等合甘麦大枣汤制成“小儿智力糖浆Ⅰ号”，给予滋阴补肾，宁心安神；如面少华，纳欠佳或伴有遗尿的，则辨为肾气虚为主，以干菖蒲、天麻、焦白术、炙黄芪合甘麦大枣汤制成“小儿智力糖浆Ⅱ号”，给予益气补肾，宁心安神。糖浆制剂要求每日口服2~3次，每次10ml。

本病的发生多数为初二以下的学龄儿童，以四、五年级为多，男性较多于女性，比例为7:3。体格检查中极个别患者发现动作笨拙，精细动作不协调等轻微阳性体征，一般翻手试验、实体感、单脚跳等都正常。儿童行为评分低的（即症状较轻的）较高的（即症状较重的）治疗效果明显。对本病的治疗，家长还要配合教育训练，多给予鼓励，培养学习兴趣，切莫动不动就训斥，甚至打骂。

曹某，男，14岁，学生。原上课不专心，注意力不集中，成绩处于班级中下水平，且经常感冒，有哮喘病史。经过2个疗程的治疗，老师和家长都反映，其上课比以前专心多了，做功课比以前注意力集中，动作也要快多了，成绩和身体素质都有了提高。针药治疗后，哮喘基本上未复发。

八、头穴为主 随症加减

刘乡采用针灸疗法治疗小儿多动症，取得满意疗效。

取穴：主穴：四神针（位于百会穴前后左右各旁开1.5寸，共四针），颞三针（耳尖直上二寸为第一针，第一针水平前后各旁开1寸为第二、第三针）、脑三针（脑户、左右脑空）。配穴：心肾阴虚、神思涣散者配手智针（内关、神门、劳宫）、足躁针（足三里、

复溜、太溪)；心肝火旺、多动冲动者配手动三针(后溪、列缺、支沟)、足动三针(太冲、冲阳、飞扬)。

操作：30号1.5寸不锈钢毫针，头部平刺进针1寸左右，四肢穴位直刺常规深度，留针30min，间隔10min捻转1次，平补平泻。2周为1个疗程。主穴每次均使用，配穴视患者情况选用。

九、针药结合 补益后天

儿童多动症为一常见于儿童时期的行为障碍，主要表现为注意障碍、多动不宁、易激惹、好冲动等，并常见伴发学习、品行、抽动及一些情绪等障碍。王仲易采用针药结合的方法治疗本病取得较好疗效。

取穴：百会、四神聪、哑门、大椎、心俞、通里、照海。

操作：进针要稳、准、轻、浅、快，即持针要稳，刺穴要准，手法要轻，进针要浅而快，力求无痛；针不可提插捻转。隔日治疗1次，以3个月为1个疗程。

中药：采用自拟方健脾益气、平肝潜阳。方药组成：黄芪10g，黄精10g，茯苓10g，生龙骨10g，生牡蛎10g，钩藤10g，天麻6g，荷叶10g，陈皮10g，益智仁10g，石菖蒲6g。每日1剂，3个月为1个疗程，共治疗2个疗程

王仲易认为，本病的主要病机是脏腑阴阳失调，具体表现为脾气虚、肝阳偏亢、阴静不足、阳亢躁动。小儿素体虚弱，伤食或病后失于调摄，都易导致脾气虚弱。脾为至阴之脏，其性静，藏意，在志为思，脾虚则静谧不足，而思虑不周，言语冒失，兴趣多变；脾主运化水谷精微，脾虚则精微难化，不能充养四肢，故体瘦或虚胖；脾又为气血生化之源，脾虚则生化无源，气虚则自汗，血虚则面色无华，日久则进一步导致肝血不足，而使肝阳偏亢，出现急躁易怒，冲动任性；其舌质淡红、苔少、脉弦细、皆为脾虚肝旺之象。

针灸治疗方面，王仲易根据《内经》“阴平阳秘，精神乃治”的原则，以调整阴阳为主，达到调神志的目的。选穴多采用督脉之穴，调整阴阳、充实髓海、健脑益智；四神聪为健脑醒神之穴，其连于督脉，善调一身之阴阳，针之可熄风宁神定志；膀胱经挟脊抵腰络肾，取心俞开通心窍、镇惊安神；照海为足少阴肾经之穴，可

滋补肝肾；通里乃心经络穴，可调补心气心血，与照海相配，共奏补益心肾之功，使水火相济，心肾相交。小儿脏腑娇嫩，形气未充，故采用针法以轻浅为宜。

中药治疗方面，以调理脏腑为主，健脾益气、平肝潜阳。以黄芪、黄精、茯苓、荷叶、陈皮、益智仁健脾理脾益气；生龙骨、生牡蛎、天麻、钩藤平肝潜阳；石菖蒲开窍宁神。由于多动症的治疗是长期的过程，在选药方面，应避免常用的金石类重镇安神药物，以免造成患儿肝肾损害及蓄积中毒；也不用虫类药物搜风平肝，以免患儿对异性蛋白过敏而影响疗效。

十、综合治疗 标本兼顾

儿童注意缺陷多动障碍（俗称小儿多动症）是儿童期最常见的心理行为障碍之一，以注意力不集中，多动，参与事件的能力差为特点，14岁以下儿童的发生率约为5%~10%。张家维以头针为主，结合体针、梅花针、耳穴贴压的综合治疗方法，疗效显著。

肝肾不足型：取四神聪、率谷、脑户、神庭、内关、三阴交、太溪。手法用捻转补法，留针20min。用梅花针循经络走向，叩打背部督脉、膀胱经经脉6次，并重点叩打肝俞、肾俞。

肝郁气滞型：取四神聪、率谷、脑户、神庭、劳宫、太冲。手法用捻转泻法，留针20min。用梅花针逆经络走向，叩打双上肢心包经及手指尖。

两型均配合王不留行籽耳穴贴压，取神门、心、肝、胆、肾、脑、皮质下、交感。针刺及梅花针叩打为隔日1次，耳穴贴压每星期1次。

中药：肝肾不足型用杞菊地黄汤加减，肝郁气滞型用一贯煎加减。每天1剂。

张家维认为本病是因先天不足及后天失护所致，加上小儿“纯阳”之体及“稚阴稚阳”的生理特点，逐渐形成阴阳偏盛偏衰，导致脏腑功能失常，从而出现心神不宁、肝魂不安、脾意不周、肾志不坚的病理变化。针刺四神聪可以调整脏腑经气，填髓健脑。颞叶与学习记忆密切相关，针刺该区的率谷可以提高主动注意力，改善运动功能。脑户位于平衡区内，为督脉、足太阳之会，取之能填精

益髓,疏通脑络,改善患儿运动协调能力。用梅花针叩打背部的督脉及膀胱经,可调节中枢神经系统的兴奋与抑制过程,从而有利于改善神经介质代谢,促进神经递质传递。耳穴选用了神门、心、肝、胆、肾、脑、皮质下、交感等,这些穴位均与中枢神经系统密切相关,通过按压,能促进皮质的觉醒,调整皮质兴奋与抑制功能平衡,从而达到改善大脑皮质功能活动的目的。

在临床中发现肝肾不足型的疗效不及肝郁气滞型,另外,疗效与患者的年龄有一定关系,年龄较小的疗效较好,这可能与幼儿大脑神经尚处于迅速发育阶段,针刺介入可以发挥更大的调节作用有关,而12岁以后儿童大脑形态发育已近成人水平,因此针刺作用有所降低。

参 考 文 献

- [1] 郗玉兰. 针刺配合闪罐治疗儿童多动症的临床观察. 上海针灸杂志, 2005, 24 (7): 13~14
- [2] 张玉夫. 耳穴治疗小儿多动症的临床观察. 中医外治杂志, 1995, 2: 43
- [3] 陈宗良. 耳针加体针治儿童多动症 13 例. 江西中医药, 1995, (6) 增刊: 49
- [4] 卓越. 推拿及耳穴贴敷治疗小儿多动症临床研究. 吉林中医药, 2006, 26 (7): 50
- [5] 刘丽, 李文丽. 针刺加耳穴贴压治疗儿童多动症 48 例. 山东中医杂志, 2006, 25 (7): 466
- [6] 肖达, 袁凌松, 熊飙. 针药结合治疗儿童多动症 136 例临床观察. 上海针灸杂志, 2003, 22 (10): 13~14
- [7] 张中一. 针刺为主治疗小儿多动症 117 例. 上海针灸杂志, 1997, 16 (4): 19
- [8] 刘乡. 针刺治疗儿童多动症 86 例疗效观察. 国医论坛, 1998, 13 (2): 22~23
- [9] 王仲易, 李敏. 针药结合治疗儿童多动症临床观察. 中国中医信息杂志, 2006, 13 (6): 78~79
- [10] 李红. 张家维教授针灸治疗小儿多动症 380 例临床研究. 上海针灸杂志, 2004, 23 (8): 23